



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN NOVEMBER
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi..... 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan..... 4

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) 4

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 4

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan 4

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 6

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 13

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 13

3.3.2 Rawat Inap 16

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) 25

3.3.4 High Care Unit (HCU) 26

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 27

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 29

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 30

3.4.1 Instalasi Farmasi 30

3.4.2 Laboratorium 35

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran..... 37

3.4.4 Radiologi 39

3.4.5 Gizi 42

3.4.6 CSSD - Laundry 44

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan 48

3.5.1 SDM 48

3.5.2 MFK dan K3RS 56

3.5.3 Security 61

3.5.4 Parkir..... 65

3.5.5 Humas Marketing 65

3.5.6 Penjaminan 69

3.5.7 PIPP – MOD - MPP..... 71

3.5.8 *Cleaning Service* 80

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum..... 82

3.6 Komite dan Tim 84

3.6.1 Komite Mutu 84

3.6.2 Komite PPI 121

3.6.3 Tim PKRS..... 133

3.6.4 Tim Prognas..... 136

3.6.5 Tim PPRA..... 175

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT 181

3.7 Permasalahan Rumah Sakit 182

3.8 Profil SDM 190

Bab IV Kesimpulan dan Saran..... 195

Bab V Penutup..... 196

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan November Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



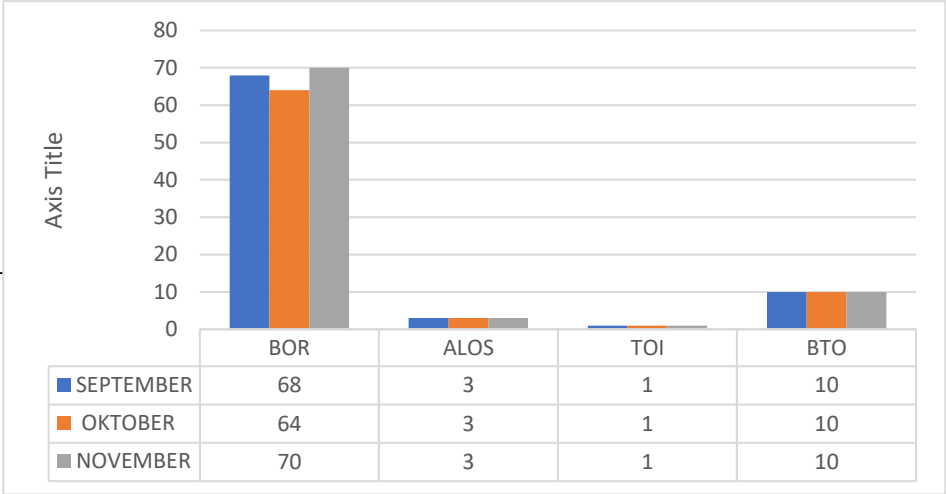
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

NO	INDIKATOR	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
1	BOR	68	64	70
2	ALOS	3	3	3
3	TOI	1	1	1
4	BTO	10	10	10

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



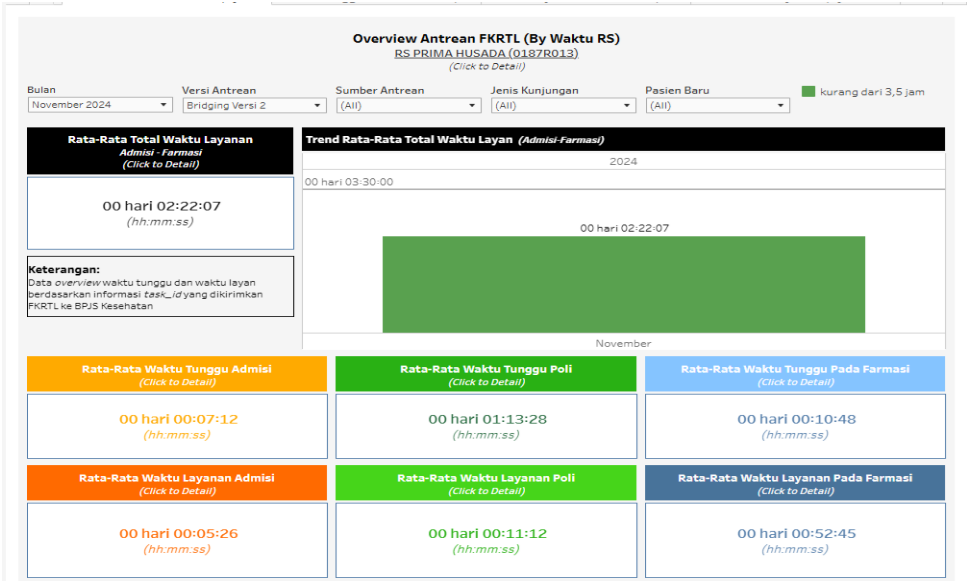
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

BOR mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 9,4% hal ini sejalan dengan kenaikan jumlah pasien yang dirawat inapkan.

ALOS masih tetap berada pada rata-rata 3 hari, yang masih berada di bawah standar 6-12 hari. Hal ini disebabkan karena pasien dominan jaminan BPJS, dimana terdapat keterbatasan plafon sehingga pasien yang sudah stabil dapat dipulangkan pada hari rawat ketiga hingga empat.

TOI masih relative sama dengan bulan sebelum-sebelumnya. BTO atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode berada pada sepuluh kali sedang standardnya yaitu 40-50 kali.

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN		BULAN (2024)			
	Waktu Rata-Rata	Rata-Rata Tahun 2023	Agustus	September	Oktober	November
1	Total Waktu Layanan	02.17.21	01.47.49	02.01.40	01.54.54	02.22.07
2	Waktu Tunggu Admisi	00.17.46	00.09.10	00.11.18	00.10.55	00.07.12
3	Waktu Layanan Admisi	00.06.31	00.08.00	00.05.00	00.05.06	00.05.26
4	Waktu Tunggu Poli	01.05.06	01.05.15	01.02.43	01.05.54	01.13.28
5	Waktu Layanan Poli	00.15.40	00.17.00	00.13.25	00.09.58	00.11.12
6	Waktu Tunggu Farmasi	00.17.05	00.13.39	00.13.45	00.10.10	00.10.48
7	Waktu Layanan Farmasi	00.49.32	01.04.36	00.56.54	00.45.19	00.52.45

Analisis :

Pada bulan November 2024, total waktu layanan mengalami kenaikan waktu dibanding bulan sebelumnya.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

NO	JENIS	Target	MAR 24	APR 24	MEI 24	JUNI 24	JULI 24	AGT 24	SEP 24	OKT 24	NOV 24
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	34.86%	37.2%	34.88%	Tidak ada	37.82%	37.72%	39.21%	41,44%	95,95%
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	94.57%	96.2%	94.62%	Tidak ada	94.9%	95.21%	95.64%	95.95%	41,44%

Analisis :

Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan (>30%) dan (>90%)

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabit

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Bimbingan Doa pada pasien IRNA	Sudah berjalan rutin 3x seminggu	Berjalan dengan baik dan respon pasien baik
2	IRNA	Senam hamil	Senam hamil berjalan rutin	-
3	IRJA	Poli Eksekutif	Terdapat penurunan jumlah pasien sebesar 31%	Pasien anak menurun karena pasien anak yang ke poli Sakura hanya pasien yang mencari dr Dicky bukan karena tertarik akan layanannya. Pasien dewasa (IPD dan Neuro) tidak tertarik pada poli Sakura karena merasa sudah cukup dengan poli regular dengan jaminan BPJS
4	IGD	Edukasi mengenai kriteria kegawatan menurut BPJS	Membuat video edukasi	Sebelumnya sudah kordinasi dengan Kabid umum, akan di TL
BIDANG PENUNJANG				
1	Depo Farmasi	1) Website Primantara	1. Presentasi MOCKUP oleh Programmer PT sudah dilakukan pada tanggal 23-09-2024 2. Proses penyelesaian oleh Programmer PT.	Dalam antrian programmer.
		2. Jasa pengantaran obat	1. Pendataan pasien masih menggunakan google spreadsheet dan kitir manual, belum ada fitur yang bridging dengan SIMRS sebagai penanda resep bahwa obat dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS.

			siap. 2. Promo Lifetime diskon 50% untuk pengguna baru berjalan mulai Bulan Desember 2024. 3. Jumlah pasien promo yang melakukan repeat order di bulan selanjutnya ada 145 dari 270 pemesan, yaitu sekitar 53%. 4. Terdapat peningkatan permintaan, Bulan November jumlah pengantaran sebanyak 1253.	
		3. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	1. TTD elektronik untuk pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. 2. TTD elektronik untuk pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien pulang rawat inap masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Dalam antrian programmer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
		4. Fitur Iterisasi pada SIMRS	1. Fitur obat iter memudahkan untuk melayani resep iterisasi. 2. Melakukan rekap target resep ITER per DPJP. 3. Rekap jumlah pasien ITER per bulan : Oktober 2024 : 134. November 2024 : 20.	Monitoring dan evaluasi sistem elektronik
		5. KPO elektronik (e-KPO)	1. Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. Pengajuan ke progamer untuk dibuatkan fitur e-	Dalam antrian programmer.

			KPO yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien. 2. DPJP bisa mengakses e-KPO di SIMRS. 3. Jumlah KPO tertinggal : 408.	
		6. Pengadaan LAF sesuai dengan pedoman dasar dispensing sediaan steril.	1. Koordinasi dengan Kains Farmasi untuk melakukan pengajuan proposal ke PT terkait pemindahan ruang LAF, yaitu rencana diajukan di Lantai Maternitas (ex IKO Covid). 2. Proposal pengajuan sudah diterima PT → ACC	Dalam proses renovasi sebagai persiapan AKRE pada akhir Tahun 2026.
		7. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	1. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga TTK kurang (jika ada staf yang sakit). 2. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. 3. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. 4. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	Monitoring dan Evaluasi

2	Gudang Farmasi	Scan Barcode	1. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT. 2. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04-10-2024. 3. Pendataan master barcode sudah diserahkan ke Programmer PT. Tindak lanjut untuk barang yang tidak memiliki barcode yaitu dibuatkan barcode internal oleh progamer 4. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia 5. Software aplikasi barcode dalam tahap dikerjakan oleh progamer	Rencana trial tanggal 16 Desember 2024.
3	Floorstok IKO	Perbaikan mutasi barang	1. Sudah dilakukan koordinasi dengan petugas IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO. 2. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan. 3. Fitur minta barang floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. 4. Sistem stok IKO sudah dikunci. 5. Ada petugas farmasi di IKO untuk monitoring stok. 6. Membuat alur dan kesepakatan terkait penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. Menggunakan tabel penggunaan isonest.	Monitoring dan Evaluasi. Supervisi Kabid.
3	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan	1. Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan	Kurang sinkron antara future

		IRNA).	IGD dan IRJA. Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024. IRNA dalam proses tahap akhir, target pada Bulan Juni 2025. 2. Melakukan pendataan fitur yang dibutuhkan pada SIMRS, lalu diserahkan kepada Programmer PT.	perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian fisioterapis di fitur rekam medis. Permasalahan E-RM dan layanan Poli yang belum masuk E-RM sudah disampaikan kepada Programmer PT sekaligus flow chart.
		2. Serah terima DRM menggunakan system digital.	Serah terima menggunakan spreadsheet (sudah berjalan).	Monitoring dan Evaluasi.
		3. Permintaan form menggunakan sistem digital.	Permintaan form dari unit menggunakan google form, sudah berjalan mulai Bulan Juni 2024.	Monitoring dan Evaluasi.
		4. Dokumentasi DRM lama	1. Melakukan scaning form kedalam SIMRS. 2. Tarikan data bisa diambil pada rekap kunjungan di SIMRS. 3. Menunggu programmer membuat fitur scanning.	Koordinasi dengan Programmer. Pengajuan ke PT.
4	Pendaftaran	1. Anjungan Pasien Mandiri.	1. Melakukan studi banding atau mencari informasi terkait penggunaan APM di RS lain. 2. Membuat flowchart dan diajukan ke Programmer PT.	Dalam proses dan diajukan ke Program Kerja Tahun 2025.
		2. Papanisasi	Memasang nama dan foto petugas admisi pada setiap loket dan harus dilakukan update tiap shift setiap hari.	Dalam proses.
4	Radiologi	1. Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil JPEG dapat diakses.	Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.	Dalam antrian programmer.

		2. Menambah jam pelayanan supaya pelayanan maksimal.	Melakukan close recruitmen untuk mengisi jam kosong pada siang hari.	Ada Sp.Rad yang akan bergabung pada awal Bulan Januari 2024
5	Laboratorium	1. Pengadaan LIS.	1. Hardware sudah terpasang di Laboratorium. 2. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor.	Dalam antrian programmer.
		2. Pengadaan BDRS.	1. Proposal dan surat permintaan pelatihan sudah dibuatkan. 2. Sudah ada daftar kebutuhan pengadaan BDRS dan sudah diajukan, menunggu penawaran. 3. Penyekatan ruangan BDRS sudah dilakukan. 4. Legalitas dibantu pengurusan oleh Legal PT. 5. Review tarif disesuaikan dengan PHS.	Progress BDRS : 1. Alat sudah datang awal Bulan November 2024. 2. KSO alat dengan PT Mutual Bahtera Santoso. 3. Alur dan SPO sudah dishare. 4. BDRS berjalan mulai 29 November 2024. Jumlah permintaan labu darah per Bulan November adalah 6. 5. 1 petugas analis sedang magang di PMI Kepanjen mulai tanggal 02 Desember 2024 selama 2 minggu. 6. Monitoring dan evaluasi.
		3. Penambahan fitur	1. Penambahan fitur upload hasil laboratorium rujukan dari luar RS. 2. Penambahan fitur centang otomatis hasil pemeriksaan yang abnormal, batas atas dan batas bawah sudah dicatat dan diajukan ke Programmer PT.	Dalam antrian Programmer PT.
6	Gizi	1. Pengaktifan Poli Gizi	1. Kolaborasi dengan	Monitoring dan

		di Rawat Jalan.	Humas&Marketing. 2. Kolaborasi dengan pelayanan antar obat (PRIMANTARA), free MCU Gizi.	evaluasi setiap bulan.
		3. MCU Gizi.	Rencana diajukan review tarif ke Keuangan PT.	Dalam Proses.
		4. Prima Healthy Meal.	Sudah pengajuan TOR ke PT.	Menunggu ACC.
7	Dapur	Perbaiki menu makanan dan plating.	1. Sudah dilakukan supervisi oleh Direktur Utama PT DPM pada hari Senin, 18 November 2024. 2. Kebijakan penggunaan alat makan dan SPO plating sudah dibuatkan sebagai pedoman penyaji dalam melakukan pekerjaan.	Monitoring dan Evaluasi.
		Menu makanan buka puasa senin-kamis.	Program PT berjalan mulai tanggal 09 Desember 2024. Yang sudah disiapkan : 1. Daftar siklus menu makanan. 2. SPO pemesanan makanan buka puasa (+). 3. Link google form untuk pemesanan (+). Kebijakan pemesanan makanan H-1 maksimal pukul 13.00 WIB.	Monitoring dan Evaluasi.
7	CSSD	1. Mengajukan mesin sterilitator (steam plasma).	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical sesuai kebutuhan sterilisasi instrument bedah syaraf.
		2. Perbaiki serah terima menggunakan digital form.	Sudah berjalan di Bulan Juli.	1. Kolom tidak terisi lengkap. 2. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.

		3. Perbaikan jam kerja	Pelayanan mulai pukul 06.30-21.00 WIB, jika ada alat yang akan disetor diatas jam pelayanan maka dilakukan pre-cleaning di unit masing-masing.	Berjalan per Bulan Desember 2024.
8	Laundry	1. Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg.	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi penggunaan mesin cuci industry utama.
		2. Membuat digital form untuk permintaan linen.	Rencana permintaan sehari 2 kali oleh unit sesuai dengan kebutuhan. Belum terealisasi.	Dalam proses.
		3. Pengadaan Bedcover untuk pasien VIP.	Rencana diajukan ulang dengan melampirkan keluhan pasien VIP.	Dalam Proses.
		4. Perbaikan jam kerja	Pelayanan ada 3 shift, shift malam dimulai pukul 22.00-04.00 WIB tanpa jam istirahat, dan memenuhi stok di unit.	Berjalan per Bulan Desember 2024.
9	Lain-lain	Rapat Bulanan masing-masing Unit dengan Kabid.	Dilakukan per Bulan November 2024. Supervisi pemahaman pelaksana tentang pedoman pelayanan, pengorganisasian, dan pelayanan sesuai dengan akreditasi. Pelaksanaan : 1. Tanya Jawab 2. Role Play	Berkala.

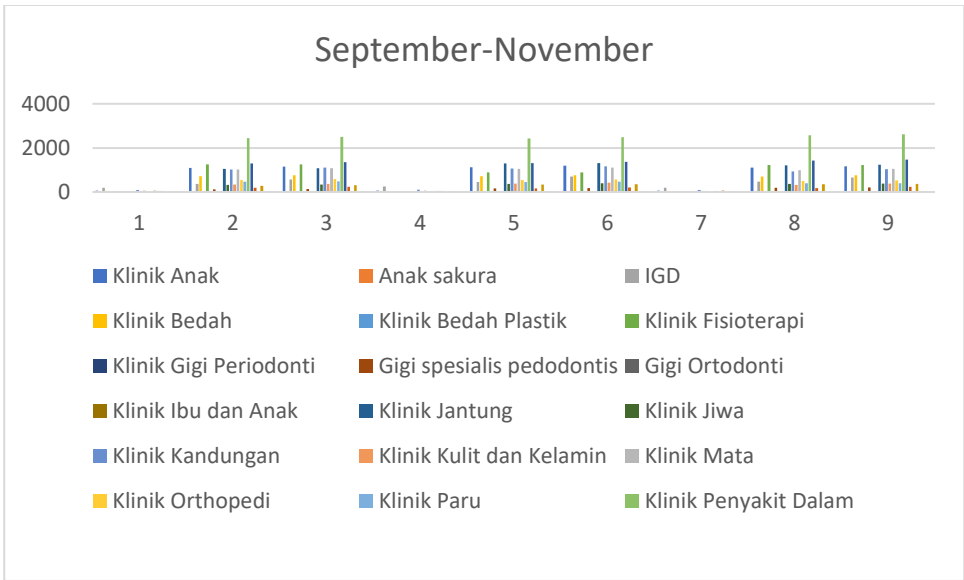
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	SEPTEMBER 2024			OKTOBER 2024			NOVEMBER 2024		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	58	1090	1148	69	1122	1191	68	1103	1171
2	Anak sakura	1	7	8	0	6	7	0	1	1
3	IGD	196	371	567	249	455	704	197	467	664
4	Klinik Bedah	44	710	754	43	715	758	51	708	759
5	Klinik Bedah Plastik	2	39	41	1	31	32	1	25	26
6	Klinik Fisioterapi	2	1257	1259	1	889	890	3	1218	1221
7	Klinik Gigi Periodonti	9	24	33	3	37	40	8	29	37
8	Gigi spesialis pedodontis	19	120	139	21	163	184	22	191	213
9	Gigi Ortodonti	5	11	16	1	10	11	3	13	16
10	Klinik Ibu dan Anak	0	15	15	0	12	12	0	8	8
11	Klinik Jantung	22	1051	1073	15	1303	1318	21	1214	1235
12	Klinik Jiwa	14	321	335	19	372	391	10	366	376
13	Klinik	97	1016	1113	104	1061	1165	94	935	1029

	Kandungan									
14	Klinik Kulit dan Kelamin	34	334	368	34	385	419	47	330	377
15	Klinik Mata	61	1024	1085	61	1054	1115	56	997	1051
16	Klinik Orthopedi	31	549	580	27	542	569	29	496	527
17	Klinik Paru	18	468	486	12	454	466	10	390	400
18	Klinik Penyakit Dalam	58	2442	2500	51	2432	2483	46	2566	2612
19	Klinik Syaraf	49	1303	1352	46	1316	1362	37	1429	1466
20	Klinik THT	49	189	238	45	168	213	57	185	242
21	Klinik Umum	15	13	28	25	20	45	13	13	26
22	Klinik Urologi	26	285	311	25	332	357	18	350	368
23	Gizi	0	0	0	2	3	5	3	11	14
24	Bedah Saraf	2	21	23	1	22	23	1	19	20
25	Obgyn Sakura	5	18	23	2	12	14	5	9	14
26	Penyakit dalam sakura	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Total		874	13274	14148	817	12678	13495	795	13077	13859



Analisis :

1. Kunjungan di bulan November naik dari bulan sebelumnya, sebanyak 9,9% dari bulan oktober 2024. Analisanya karena DPJP jarang ada yang cuti panjang, sehingga pasien kronis rutin sesuai dengan jadwal
2. Jumlah pasien terbanyak ada di Poli penyakit dalam sebanyak 2612 pasien. Kunjungan tersebut meningkat dari bulan sebelumnya sebanyak 2483 pasien, karena DPJP sudah praktek kembali dan tidak banyak pasien yang di PRB karena PRB sudah tercapai
3. Kunjungan poli gigi ortodonti masih sedikit, sebesar 16 pasien, karena hanya menerima pasien umum saja, dan tidak bisa melayani pemasangan behel atau kawat gigi. Sehingga hanya menangani kasus poli gigi non spesialis pada umumnya
4. Untuk poli pedodonti anak meningkat tiap bulannya sejak HFIS pelayanan kedokteran gigi anak di acc, bulan november, kunjungan poli gigi anak naik 7,3% dibanding bulan sebelumnya ini membuat asisten gigi kewalahan sehingga direncanakan untuk perekrutan di Januari 2025
5. Kunjungan poli eksekutif adalah 15 kunjungan. Kunjungan terbanyak adalah dari Obgyn sakura 14 pasien, Anak sakura : 1 pasien, Klinik IPD dr Zoraida, SpPD, dr Dewi, SpS dan dr Syahrir, SpN masih belum ada kunjungan bulan ini.

Rencana Tindak Lanjut :

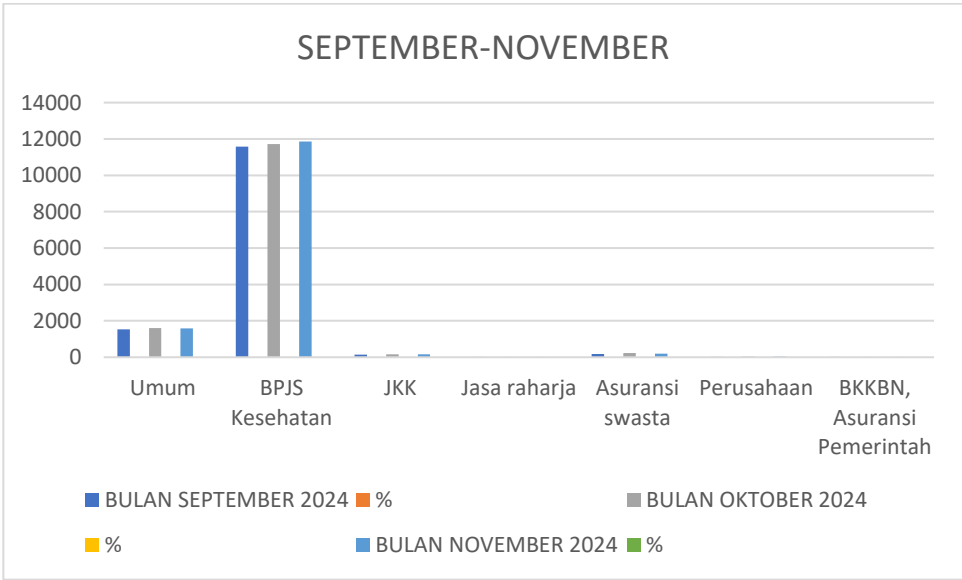
1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli sakura
2. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.

- Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
- Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
- Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
- Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.
- Sosialisasi pada komunitas pasien geriatri maupu prolanis klinis MS,bahwa dokter gigi ortodonti (perawat gigi) dan poli sakura
- Sosialisasi pada perusahaan dan stakeholder bahwa ada poli sakura yang menyediakan layanan one stop service
- Mengajukan pelayanan baru otho,bedah,uro dan kulit di Poli Sakura

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN SEPTEMBER 2024	%	BULAN OKTOBER 2024	%	BULAN NOVEMBER 2024	%
1	Umum	1536	11,38%	1601	11,38%	1584	11,43%
2	BPJS Kesehatan	11587	85,86%	11723	85,13%	11866	85,63%
3	JKK	138	1,02%	162	1,18%	162	1,17%
4	Jasa raharja	15	0,11	14	0,11%	4	0,03%
5	Asuransi swasta	184	1,36%	227	1,65%	197	1,42%
6	Perusahaan	28	0,21	39	0,28%	43	0,31%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	7	0,05%	5	0,05%	2	0,01%
	Total	13495	100%	13771	100%	13858	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :
 Kunjungan pasien bulan November 2024 berdasarkan cara pembayaran meningkat 9,9% dari bulan Oktober . Kunjungan terbanyak adalah pasien dengan penjamin BPJS Kesehatan sebesar 86,05%. Kunjungan bpjs meningkat lkarena DPJP yg off seperti dr Zoraida, SpPD dan dr. Eko, SpKFR sudah aktif kembali.

Kunjungan terendah adalah pasien Jasa raharja sebesar 0,02% (4 pasien). Kunjungan jasa raharja sedikit karena rata-rata pasien, menggunakan asuransi BPJS dikarenakan laka tunggal atau jamsostek jika pasien KLL saat berangkat/pulang kerja.

Rencana Tindak Lanjut :
 Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai

asuransi,poli bedah saraf dan poli gigi anak.bekerjama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional.

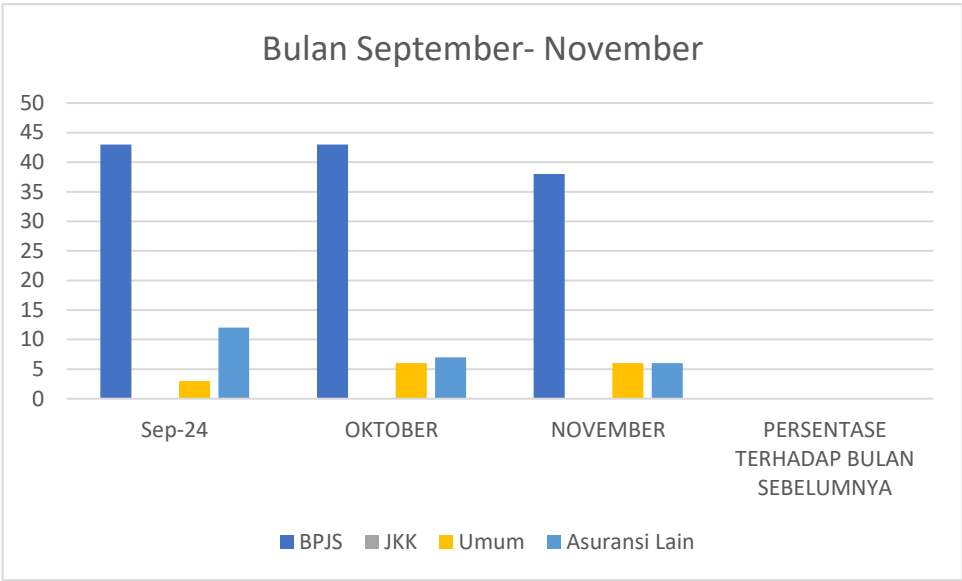
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.3.2.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2024)

NO	HAL	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	43	43	38	↓ 11,6%
2	JKK	0	0	0	0% ↓
3	Umum	3	6	6	0%
4	Asuransi Lain	12	7	6	↓ 14%
Total Pasien		47	58	50	↓ 10,7%

3.1.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (September - November 2024)



3.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	November 2024	43	6	0	7	50
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan 11,6% dari bulan oktober 2024 5 pasien di sebabkan	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan november 2024 jumlah pasien tetap di bandingkan bulan	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november tidak ada peningkatan	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir menurun untuk bulan november menurun 14% di bandingkan bulan oktober 2024 di sebabkan pasien asuransi dan jr cenderung menurun di bulan november	Total pasien bulan november 2024 menurun 10% dari bulan oktober 2024

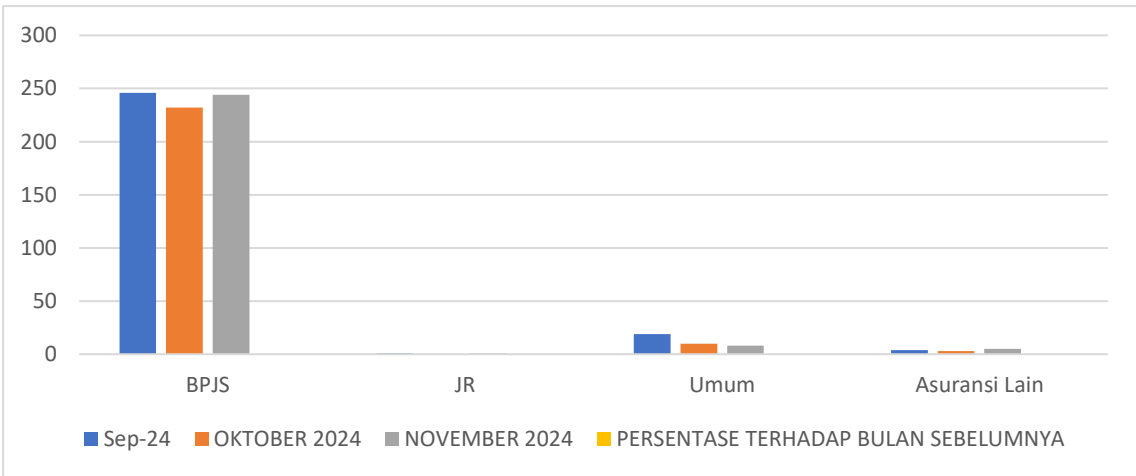
		oleh beberapa hal pasien dengan bpjs naik kelas menurun di karenakan kurangpua snya pasien dengan fasilitas vip dan vvip	oktober disebabkan kunjungan yang masuk di IGD dengan penjamin umum dan kelas VIPP sama dengan bulan sebelumnya		oleh beberapa faktor antara lain rs prima husada cenderung pasien bpjs,	
	RTL	1. Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, 2. memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti paket alat, mandi, baju pasien khusus VIP/VVIP 3. meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap 4. bekerjasama dengan marketing untuk meningkatkan pasien pasien asuransi terutama perusahaan perusahaan yang baru 5. Meningkatkan pelayanan yang lebih ekstra kepada pasien 6. Mempromosikan ruangan vip/vvip lewat sosial media				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar
(September-November 2024)

NO	HAL	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	246	232	244	↑ 5%
2	JR	1	0	1	↑ 100%
3	Umum	19	10	8	↓ 20%
4	Asuransi Lain	4	3	5	↑ 40%
Total Pasien		269	245	258	↑ 5%

3.1.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(September-November 2024)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

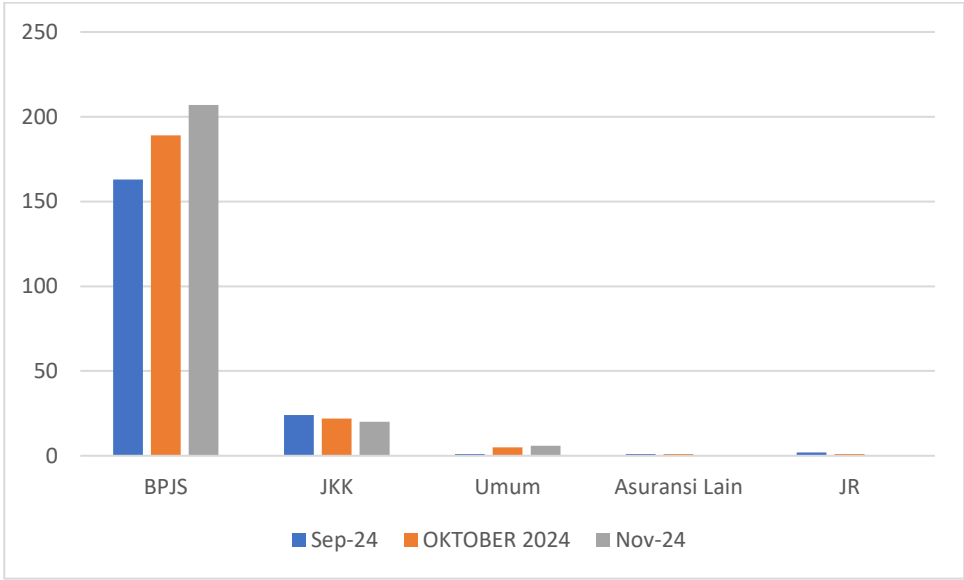
NO.	BULAN NOVEMBER 2024	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JR	ASURANSI	
1	Analisis	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november 2024 mengalami peningkatan 5% dari bulan oktober 2024 12 pasien di karena banyaknya kunjungan anak dengan diagnosa TF dan Asma karena musim hujan diawal bulan	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan november 2024 mengalami penurunan 20% dari bulan oktober 2 pasien di sebabkan oleh hampir semua kunjungan yang masuk IGD mayoritas pasien BPJS	Pasien JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november mengalami peningkatan 100% dari bulan oktober 2024 1 pasien ini di sebabkan pasien di IGD juga turun angka kecelkaan yang masuk di IGD	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november 2024 mengalami peningkatan 40% dari bulan oktober 2024 2 pasien di sebabkan kunjungan asuransi yang meningkat di bulan oktober baik rawat jalan maupun rawat inap dan kunjungan dari marketing ke perusahaan	Total keseluruhan bulan oktober mengalami penurunan 9,7% dari bulan september 2024 (24 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiapbulanya 2. Memperbaiki setiap fasilitas yang ada di unit jika ada yang rusak 3. Promosi ruangan anak lewat media sosial ,tiktok dan IG 4. Harus mempunyai program untuk tahun 2025 terutama program taman bermain anak 5. Berkoordinasi dengan Marketing untuk kunjungan ke TK atau paud tentang pelayanan gigi anak baru				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2024)

NO	HAL	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	163	189	207	↑ 9,5%
2	JKK	24	22	20	↓ 9,0%
3	Umum	1	5	6	↑ 16,6%
4	Asuransi Lain	1	1	0	↓ 100%
5	JR	2	1	0	↓ 100%
Total Pasien		191	215	233	↑ 7,72%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2024)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN Novem ber	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURAN SI	
1	Analisis capaian Novemb er 2024	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir kunjungan pasien meningkat,untuk bulan november meningkat 9,5% dari bulan oktober 2024 18 pasien di sebabkan oleh banyaknya kunjungan di IGD kelas 2 dan kelas 1	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir kunjungan pasien umum meningkat terus,untuk bulan november 2024 meningkat 16,6% dari bulan oktober ,1 pasien di sebabkan oleh kunjungan yang datang di IGD untuk pasien umum meningkat	Pasien JKK 3 dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan kunjungan untuk bulan november menurun 9,0% dari bulan oktober 2024,2 pasien di sebabkan oleh kunjungan pasien perusahaan yang masuk di IGD menurun mengakibatkan pasien rawat inap dengan penjamin JKK juga menurun	Pasien JR/Asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan november mengalami penurunan 100% dari bulan oktober 2024 sebanyak 1, untuk total pasien JR/Asuransi tidak ada, di sebabkan oleh beberapa hal antara lain pasien KLL yang di bawah ke IGD menurun,Asu ransi sendiri untuk rawat inapnya ada di kelas 1	Total pasien di lantai 2,3,dan 4 mengalami peningkatan 7,72% (18 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit				

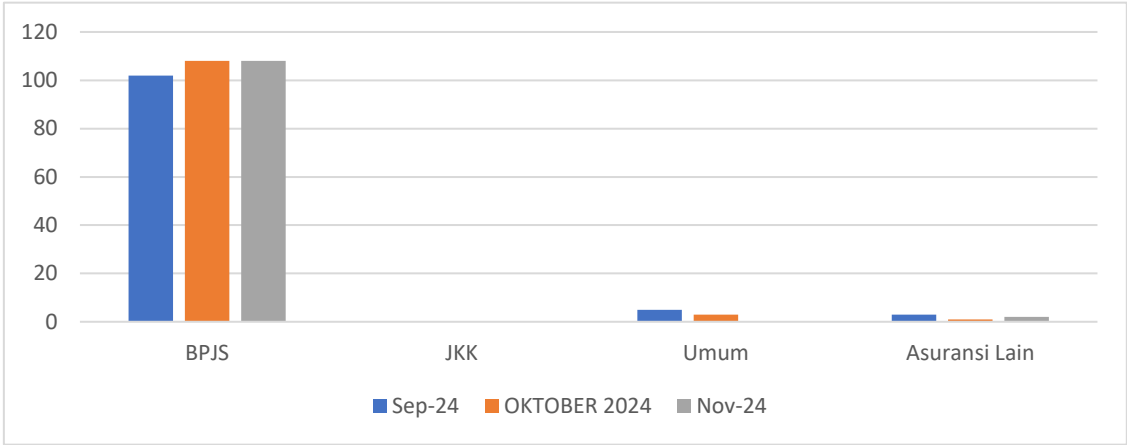
		6. Pemberian edukasi yang baik
		7. Berkoordinasi dengan bagian humas marketing untuk melakukan kunjungan di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendekatan ke HRD

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.1.2 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(September - November 2024)

NO	HAL	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	102	108	108	0%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	5	3	0	↓ 100%
4	Asuransi Lain	3	1	2	↑ 100%
Total Pasien		110	112	110	↓1,7%

3.1.1.1.3 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(September - November 2024)



3.1.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN NOVEMBER	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan november 2024 kunjungan pasien tetap di bandingkan bulan oktober 2024 disebabkan kunjungan IGD relatif meningkat tetapi meningkatn	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan oktober mengalami penurunan 66,6% (2 pasien) di bandingkan bulan september 2024, di karenakan kunjungan di IGD pasien umum tidak banyak untuk kelas 1	Pasien JKK belum ada pasien selama 3 bulan terakhir	Pasien Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november 2024 mengalami peningkatan 100% dari bulan oktober 2024 sebesar 2 pasien peningkatan pasien tersebut di sebabkan oleh kunjungan asuransi yang masuk iGD rawat inap di kelas 1, pada lantai 5c	Pada bulan november total pasien mengalami penurunan 1,7% 2 pasien di bandingkan bulan oktober 2024

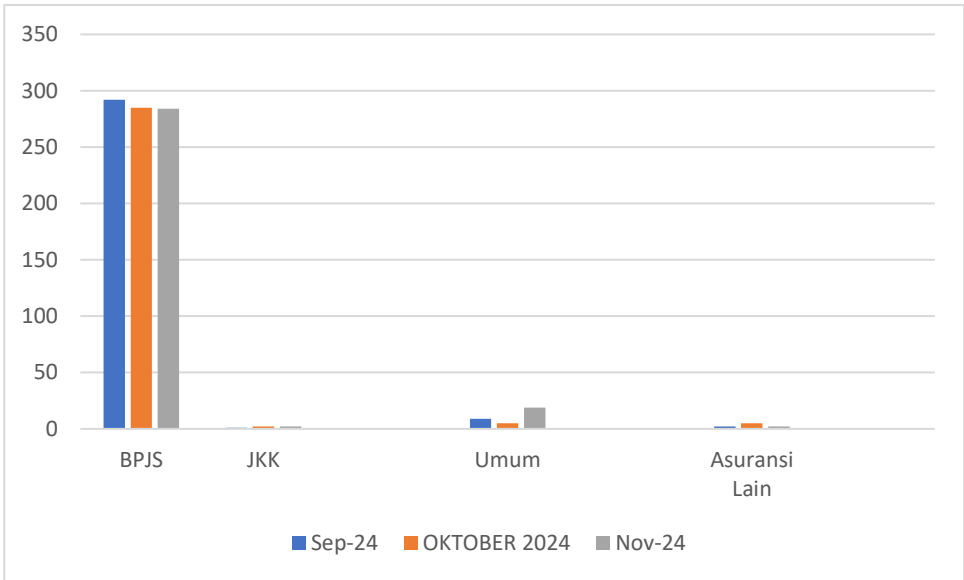
		ya di kelas 2 berbung 5c tidak ada kelas 2 sehingga meningkatn ya tidak signifikan				
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkoordinasi dengan marketing untuk selalu koordinasi dengan faskes tentang pelayanan pasien TB di rumah sakit prima husada				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.1.4 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2024)

NO	Penjamin	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	292	285	284	↓0,35%
2	JKK	1	2	2	<i>Tetap</i>
3	Umum	9	5	19	↑28%
4	Asuransi Lain	2	5	2	↓ 60%
Total Pasien		304	297	307	↑3,3%

3.1.1.1.5 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2024)



3.1.1.3.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN NOVEMBER	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir masih	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan belum stabil untuk	Total semua pasien mengalami peningkatan 3,3%

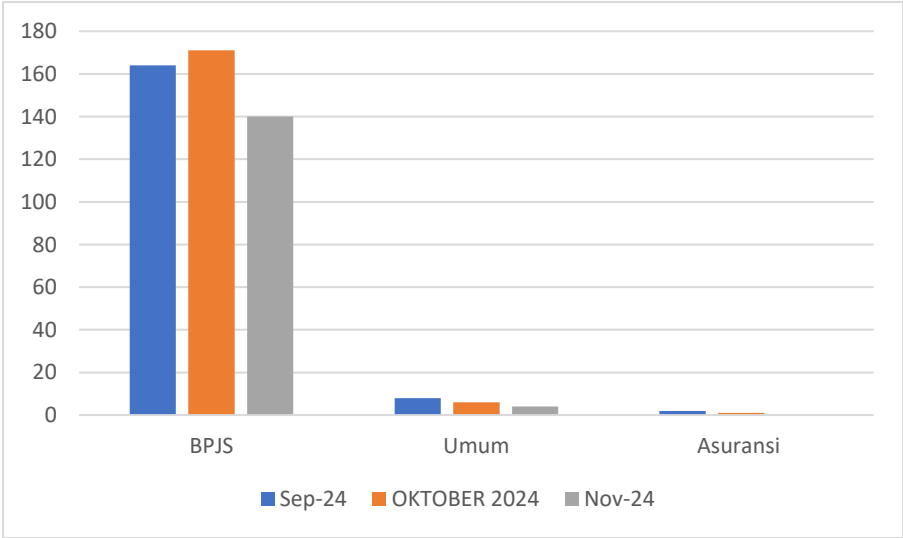
	terakhir	mengalami penurunan untuk bulan november mengalami penurunan 0,35% dari bulan oktober 2024, 1 pasien di sebabkan kunjungan kelas 3 yang masuk di IGD banyak tetapi tidak masuk di lantai 6,7 dan 8 sebagian di titipkan di lantai 2a untuk transit	naik turun untuk bulan november mengalami peningkatan yang signifikan sampai 28% dari bulan oktober 2024 ,14 pasien di sebabkan kunjungan kelas 3 yang masuk di IGD untuk pasien umum meningkat	mengalami peningkatan tetapi untuk bulan november 2024 kunjungan JKK yang masuk rawat inap kelas 3 tetap dari bulan oktober 2024 disebabkan pasien perusahaan yang masuk ke IGD sebagian besar rawat jalan,untuk rawat inap masih sedikit	bulan november mengalami penurunan 60% dari bulan oktober di sebabkan untuk pasien asuransi atau JR lebih di utamakan di kelas 1 dan 2	
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Berkoordinasi dengan bagian humas marketing untuk melakukan kunjungan di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendekatan ke HRD				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.1.6 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September - November 2024)

NO	HAL	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	164	171	140	↓ 18,1%
2	Umum	8	6	4	↓ 33%
3	Asuransi	2	1	0	↓100%
Total Pasien		174	178	144	↓ 19,10%

3.1.1.1.7 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Agustus- Oktober 2024)



3.1.1.4.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

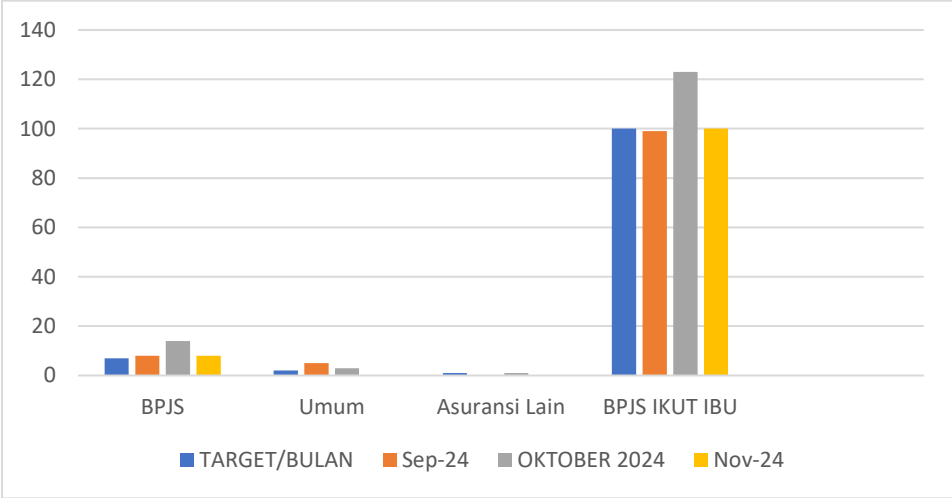
NO	BULAN	RAWAT INAP			KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian September-November 2024	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november pasien turun 18,1 % dari bulan oktober 2024 sebesar 31 pasien di sebabkan oleh angka kunjungan persalinan menurun dan di tunjang oleh angka rujukanya dari bidan bidan juga menurun	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir menurun untuk bulan november 2024 mengalami penurunan 33% dari bulan oktober 2024 sebesar 2 pasien di sebabkan jumlah pasien umum yang masuk di IGD juga menurun	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan november 2024 mengalami penurunan 100% dari bulan oktober 2024 di sebabkan oleh tidak ada kunjungan pasien persalinan di IGD	Total pasien bulan November mengalami penurunan 19% dari bulan oktober 2024 34 pasien
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan bekerja sama dengan humas marketing terutama untuk kunjungan ke bidan bidan praktek yang mempunyai BPJS	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,bekerjasama dengan humas marketing untuk posting di ig tentang pelayanan di maternitas	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,dan mengadakan corporate gatreing dengan perusahaan setiap 1 tahun sekali	

3.1.1.5 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September-November 2024)

NO	HAL	TARGET/BULAN	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	8	14	8	↓ 42,8%
2	Umum	2	5	3	0	↓ 100%
3	Asuransi Lain	1	0	1	0	↓ 100%
4	BPJS IKUT IBU	100	99	123	100	↓ 18,7%
Total Pasien		110	112	141	108	↓ 23,4%

3.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(September-November 2024)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	Total Pasien
1	November 2024	8	0	0	100	108
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november 2024 mengalami penurunan 42% dari bulan oktober 2024 sebnayak 6 pasien di sebabkan oleh kunjungan pasien yang datang dari IGD untuk melakukan persalinan menurun untuk bulan november	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan november 2024 di bandingkan bulan oktober sebanyak 3 pasien di sebabkan oleh kunjungan pasien persalinan tidak ada yang menggunkan penjamin umum,mayoritas pasien BPJS	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november 2024 mengalami penurunan 100% di abndingkan bulan oktober 2024 di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain pasien prima husada mayoritas bpjs, pasien asuransi dalam 1 tahun terakhir sangat sedikit,	Pasien BPJS ikut ibu dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november 2024 mengalami penurunan 18,7% dari bulan oktober 2024 sebanyak 23 pasien di sebabkan oleh kunjungan persalinan menurun,rujuk an dari bidan-bidan jejaring juga menurun	Total pasien dalam bulan november menurun di bandingkan bulan oktober 2024 sebesar 23,4%
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, dan berkoordinasi dengan	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing, membuat program pelayanan baru	Meningkatkan pelayanan dan koordinasi dengan bagian marketing untuk meningkatkan pasien asuransi	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya,kerjasama dengan marketing,mem buat program foto bayi dari

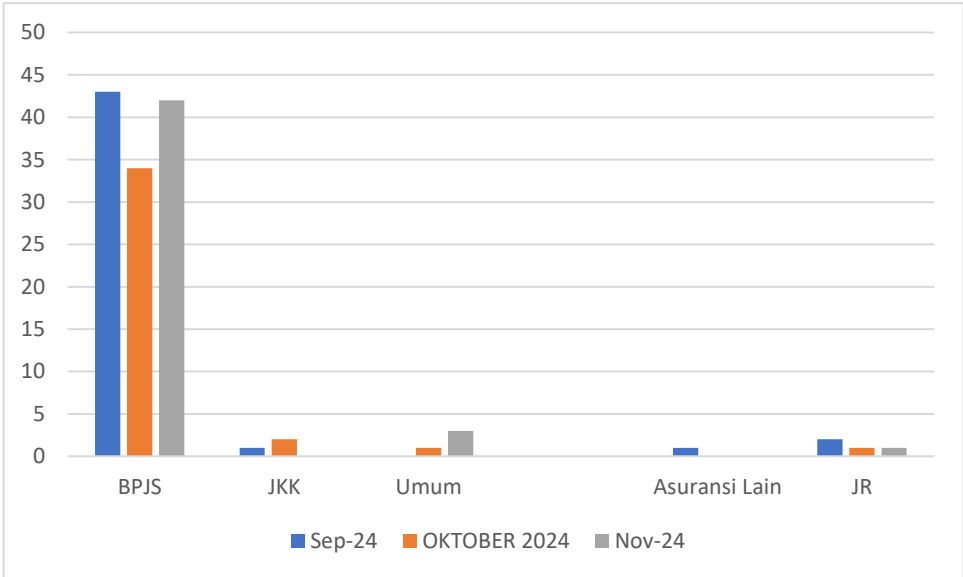
		marketing untuk menginformasikan ke bidan bidan jejaring	seperti pijat bayi sehingga menarik banyak pasien			unit neo
--	--	--	---	--	--	----------

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September-November 2024)

NO	PENJAMIN	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	43	34	42	↑ 19%
2	JKK	1	2	0	↓100%
3	Umum	0	1	3	↑ 66%
4	Asuransi Lain	1	0	0	0%
5	JR	2	1	1	0%
Total Pasien		47	37	46	↑ 19%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September-November 2024)



3.1.1.2 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN NOVEMBER	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november 2024 mengalami peningkatan 19% dari bulan oktober 2024 di	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir kunjungan di ICU meningkat untuk bulan november 2024 mengalami peningkatan 100% dari bulan oktober 2024 d	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november 2024 mengalami penurunan 100% dari bulan oktober 2024 di sebabkan karena kunjungan	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil,untuk bulan november 2024 mengalami hasil tetap dari bulan oktober 2024	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien meningkat untuk bulan november 2024 46 pasien

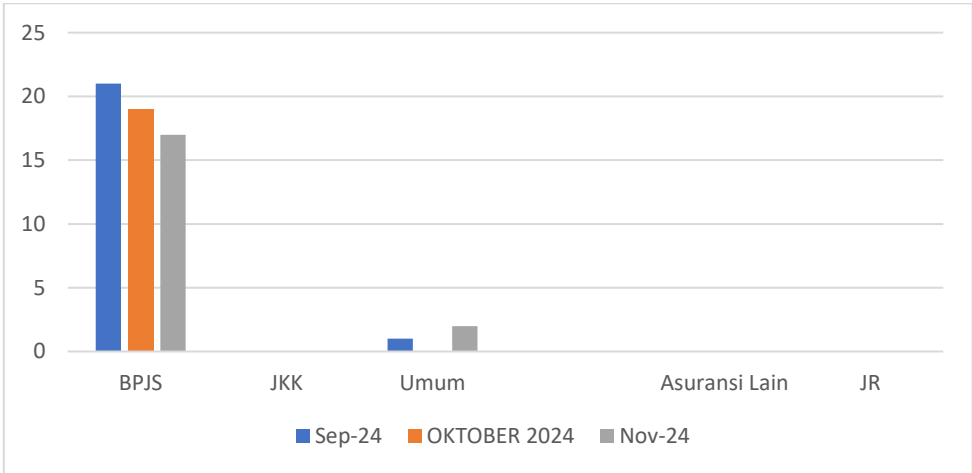
		sebabkan banyaknya kunjungan igd yang masuk igd dengan ats merah atau perlu icu dan ada beberapa pasien yang membutuhkan ventilator		IGD dengan JKK juga menurun		
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.1.2 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September-November 2024)

NO	HAL	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	21	19	17	↓11%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	1	0	2	↑ 100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	0%
5	JR	0	0	0	0%
Total Pasien		22	19	19	10%

3.1.1.3 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September-November 2024)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

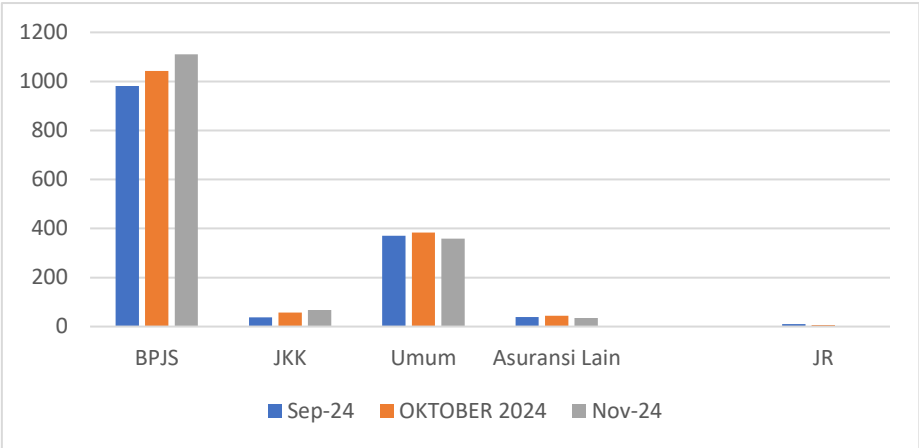
NO.	BULAN NOVEMBER	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan, untuk bulan november 2024 mengalami penurunan 11% di bandingkan bulan oktober 2024 di sebabkan oleh bebrapa hal 1. Pasien di masukan langsung ICU oleh DPJP karena membutuhk an alat seperti ventilator	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november 2024 mengalami peningkatan dari bulan oktober 100%	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum ada pasien	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien yang ada di HCU tidak ada peningkatan dengan jumlah pasien 19 sama dengan bulan oktober 2024
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.1.4 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September – November 2024)

NO	HAL	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	981	1043	1110	↑ 6%
2	JKK	38	57	67	↑ 15%
3	Umum	371	384	358	↓ 7,2%
4	Asuransi Lain	39	44	35	↓26%
5	JR	10	6	1	↓ 83%
Total Pasien		1370	1439	1571	↑ 2,35%

3.1.1.5 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September – November 2024)



3.1.3.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN NOVEMBER	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan november 2024 meningkat 6% dari bulan oktober 2024,67 pasien di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain kunjungan pasien anak karena musim awal hujan dan banyaknya demam berdarah	Kunjungan pasien UMUM 3 bulan terakhir belum stabil,untuk bulan november 2024 mengalami penurunan 7,2% dari bulan oktober 2024 di sebabkan oleh pasien yang masuk IGD mayoritas mempunyai BPJS semua, pada saat di tarik data untuk konjngan IGD pasien umum rawat jalan	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK dari 3 bulan terakhir mengalami peningkatan secara terus menerus untuk bulan november mengalami peningkatan 15% dari bulan oktober 2024 ini disebabkan oleh dr IGD yang membantu managemen untuk mencapai target kunjungan pasien JKK	Kunjungan pasien dengan jaminan JR dan asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november mengalami penurunan 28% dari bulan oktober 2024 di sebabkan oleh pasien JR dan Asuransi menurun,untuk KLL juga menurun	Total Kunjungan pasien IGD semua jaminan mengalami peningkatan di bandingkan bulan oktober 2024 2,3% (132 pasien)
2	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD dengan memperbaiki pelayanan dan mengurangi komplain serta bekerjasama dengan	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

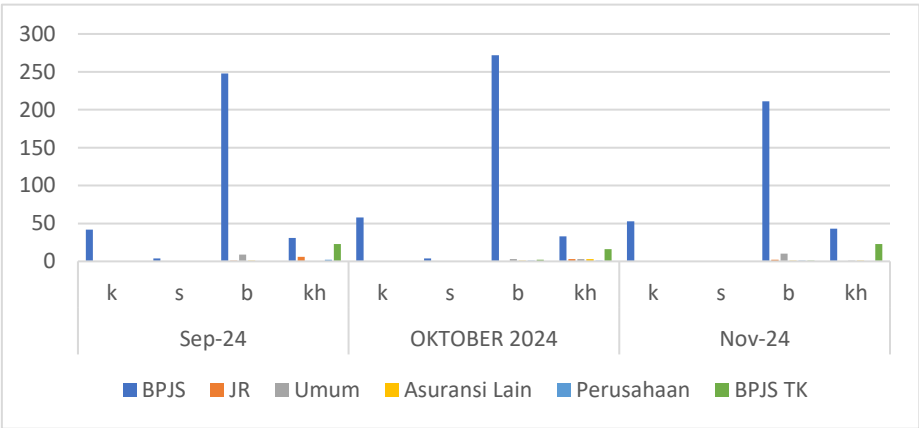
		marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang		beberapa Perusahaan Kabupaten Malang		
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.1.6 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (September- November 2024)

NO	HAL	SEPTEMBER 2024				OKTOBER 2024				NOVEMBER 2024				PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
		k	s	b	kh	k	s	b	kh	k	s	b	kh	
1	BPJS	42	4	248	31	58	4	272	33	53	0	211	43	Penurunan 13,25
2	JR	0	0	1	6	0	0	0	3	0	0	2	0	
3	Umum	0	0	9	0	0	0	3	3	0	0	10	1	
4	Asuransi Lain	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	1	1	
5	Perusahaan	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	
6	BPJS TK	0	0	0	23	0	0	2	16	0	0	1	23	
	Total Pasien	367				400				347				

3.1.1.7 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (September- November 2024)



3.1.4.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN NOVEMBER	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	PERUSAHAAN	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november 2024 mengalam i penuruna n 16% dari	Pasien BPJS TK dalam 3 bulan belum stabil untuk bulan oktober 2024 mengalami penuran 25% dari bulan oktober 2024 di sebabkan oleh	Pasien Umum operasi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november 2024 mengalami peningkata n 45% dari bulan	Pasien perusahaan dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan november 2024 mengalami penurunan 100% di bandingkan bulan oktober 2024,1 pasien di sebabkan oleh rujukan dari	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan november 2024 mengalami penurunan 33,3% di bandingkan bulan oktober 2024 di sebabkan kunjungan di IGD pasien JR dan Asuransi	Total pasien untuk bulan november 347

		bulanokto ber 2024 ,sebanyak 60 pasien di sebabkan jumlah lodingan operasi juga menurun	kunjungan dari perusahaan ke IGD tidak membutuhk an operasi sebagian pasien hanya rawat jalan di IGD	oktober 2024 di sebabkan oleh beberapa hal yaitu beberapa pasien yang tidak mempuny ai penjamin bpjs dan ada juga mengguna kan umum karena tidak bisa terkafer penjamin jasaraharj a	perusahaan yang datang ke RS Prima husada sangat sedikit	sangat minim sekali di bandingkan pasien BPJS		
2	RTL	1.Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan mengurangi pasien IDO sehingga pasien puas dengan pelayanan operasi di prima husada 2.Berkoordinasi dengan bagian marketing untuk ekspos ruangan IKO yang sudah di ganti vynil 3.Mengikuti pelatihan yang terbaru sehingga menunjang pelayanan yang terbaik di IKO 4.Berkoordinasi dengan humas marketing,terutama kunjungan ke perusahaan-perusahaan dan psc untuk mengirim ke prima husada malang 5.mengirimkan pelatihan asisten bedah saraf 6.Memberikan edukasi yang bagus untuk pasien pasien operasi						

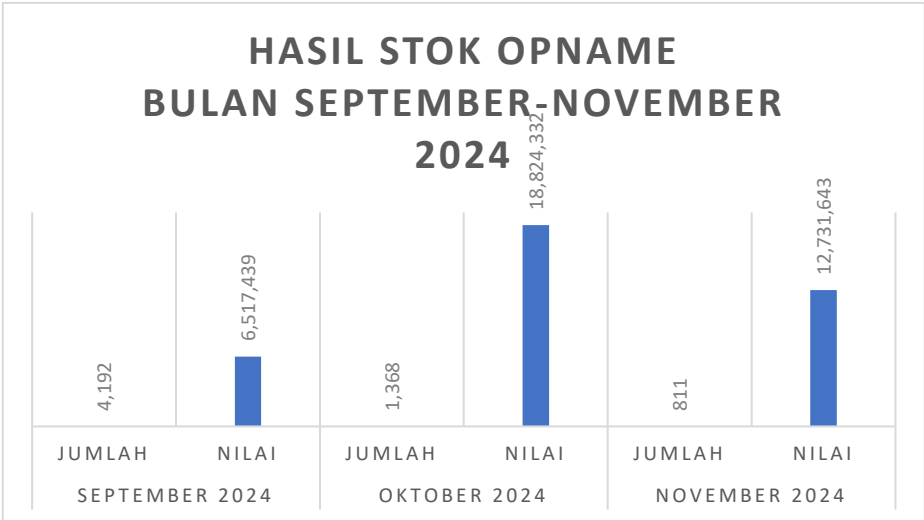
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan September-November 2024

UNIT	JUMLAH STOK	JUMLAH SEDIAAN					
		SEPTEMBER 2024		OKTOBER 2024		NOVEMBER 2024	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	Fisik	733.807	2.350.377.739	807.380	2.420.406.240	717.819	1.984.154.958
	Sistem	734.059	2.350.612.541	807.236	2.411.603.005	717.782	1.984.197.437
	Selisih	-252	-234.802	144	+8.803.236	37	-42.479
DEPO FARMASI	Fisik	141.256	513.820.725	144.667	497.691.225	142.908	492.912.632
	Sistem	136.874	508.681.432	143.338	491.060.927	142.238	486.169.397
	Selisih	4.382	+5.139.293	1.331	+6.630.304	670	+6.743.243
IKO	Fisik	2.275	99.246.881	2.304	104.523.149	2.455	99.561.444
	Sistem	2.213	97.633.933	2.411	101.132.358	2.351	93.530.564
	Selisih	62	+1.612.948	107	+3.390.792	104	+6.030.879
GUDANG RETUR	Fisik	0	0	0	0	0	0
	Sistem	0	0	0	0	0	0
	Selisih	0	0	0	0	0	0
Total Selisih		4.192	+6.517.439	1.368	+18.824.332	811	+12.731.643

4.2.1.2. Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan September- November 2024



3.2.1.2 Analisis dan Tindak Lanjut

NO	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
Gudang Farmasi : Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar -42.479, hal ini disebabkan karena :		
1.	Rak hibah jenis barang OAT dewasa, kode barang F00557 dan F00556 penyesuaian atas salah input hasil SO Bulan oktober 2024.	a) Meningkatkan ketelitian petugas dalam input stok opname. b) Meningkatkan ketelitian petugas dalam menyiapkan dan release barang di SIMRS. c) Pemasukan dan pengeluaran stok menggunakan sistem barcode. Scan barcode dalam tahap proses pengerjaan oleh Programmer PT. d) Membuat berita acara kelebihan/ kekurangan fisik sediaan farmasi. e) Melakukan penyekatan pada rak benang sesuai dengan nama, ukuran dan merk. f) Melakukan perbaikan serah terima dari Gudang dan dilakukan cek kembali antara nama, jumlah permintaan saat penataan barang di Rak Depo Farmasi.
2.	a) Terdapat selisih pada Rak ALKES, yaitu sediaan Spuit 5 cc-Gidcare dan Spuit 5 cc b) Terumo dikarenakan adanya penyiapan barang yang diberikan, Spuit 5 cc-Gidcare namun yang di release Spuit 5 cc-Terumo. c) Masker N95 selisih lebih karena permintaan BMHP sudah di release namun belum serah terima ke poli.	
3.	Rak benang kode barang F00972 BENANG T-VIO 5-0 V38-TRITON terdapat selisih kurang.	
4.	Terdapat selisih lebih fisik pada rak obat luar F04453 ZELAVELL EAR DROP-NOVELL.	
Depo Farmasi : Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +6.743.243, hal ini disebabkan karena :		
1.	Ditemukan sediaan Togistatin Ovula-Otto F00769/ Rak Suppositoria / Rp 23.444 . Hasil SO system 0 tetapi fisik ditemukan 1 pcs. Tidak terdapat kartu stock dan penempatannya jadi 1 tempat dengan vagistin Ovula, telusur sementara sediaan tersebut adalah retur dari rawat inap dengan tidak tercantum Tanggal ED dan nomer batch.	Tidak dilakukan adjustment pada kertas kerja
2.	Terdapat selisih lebih 19 flash sediaan cairan infus KCL 7.46% 25 ml-Otsuka / F00117 dikarenakan adanya barang trial KCL 7.46% 25 ml-Satoria yang diberikan ke pasien namun simpan penjualan di SIMRS.	a) Meningkatkan ketelitian petugas melayani penjualan resep jika memberikan barang trial maka tidak perlu simpan penjualan. b) Barang trial yang didapatkan langsung didistribusikan ke unit dan tidak dilakukan retur ke Depo Farmasi.
3.	Terdapat sediaan dengan selisih lebih pada rak prekursor / F00761 / Tremenza Tab / Sanbe + 77 Tablet.	Meningkatkan ketelitian petugas melakukan penjualan resep dan jumlah obat yang disiapkan.

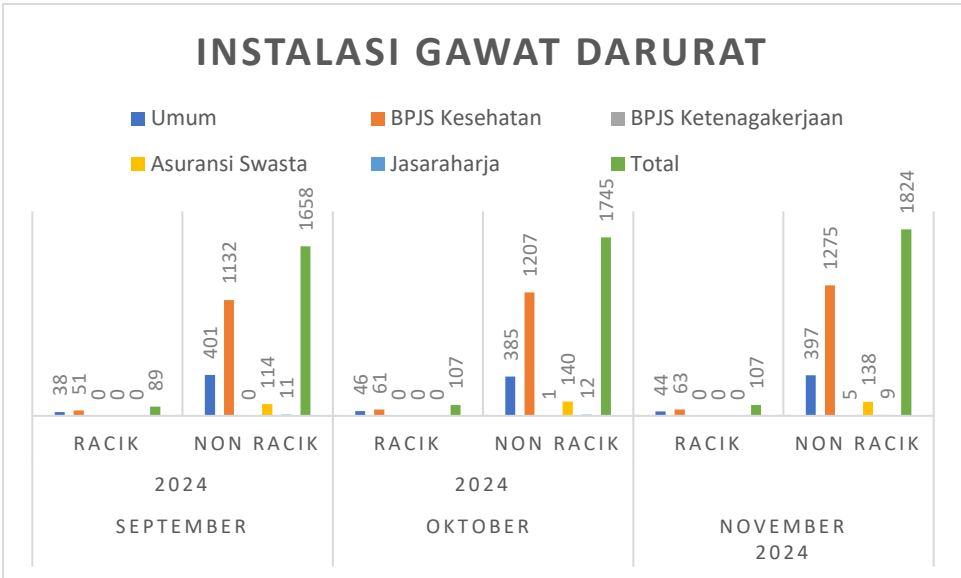
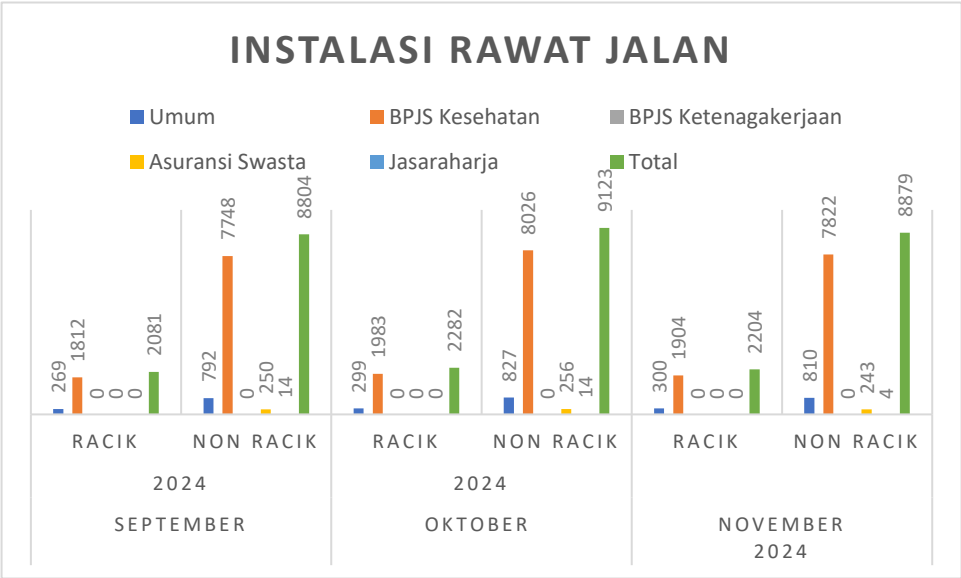
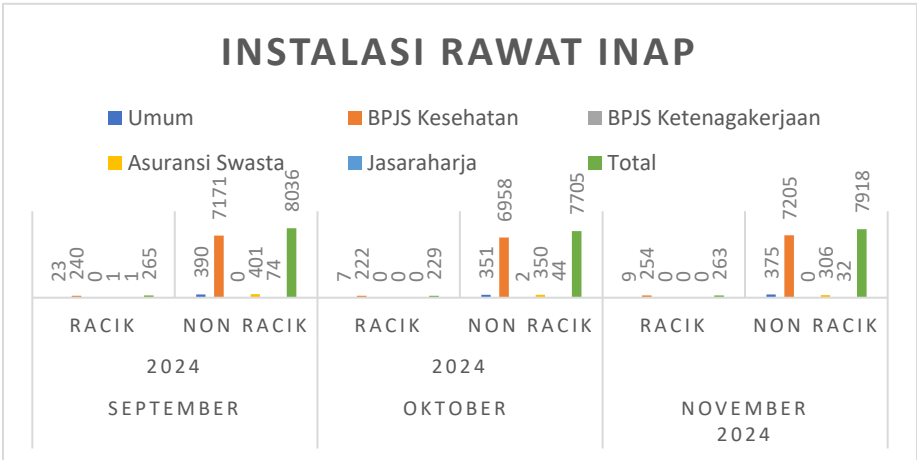
4.	Terdapat sediaan dengan selisih lebih pada fisik, rak benang kode barang 7. F00969 BENANG T-VIO 2/0 V66-TRITON. 8. F00968 BENANG T-VIO 2-0 V9-TRITON. Setelah dilakukan perhitungan ulang, ditemukan benang pada paket operasi dan buffer yang belum dilakukan perhitungan oleh unit farmasi	Meningkatkan ketelitian petugas menghitung stok di paket dan buffer stok
5.	Penempatan Buffer rak alkes tidak diperhatikan, sehingga ketika SO tidak menutup kemungkinan banyak selisih.	Penempatan buffer rak alkes ditata rapi dan terlihat jelas serta dijadikan 1 saat perhitungan SO
6.	Terdapat sediaan masker karet dengan master F02349, kondisi fisik ada 2 merek yang berbeda.	Koodinasi dengan pengadaan terkait master barang.
7.	Terdapat sediaan IV Cannula No. 22-Prodevice dengan master F01483 seharusnya kondisi fisik tidak ada, tetapi dalam system masih ada, berbanding terbalik dengan IV Cannula No. 22 - Hospitech master F01484 Secara Fisik jumlah nya lebih banyak dibandingkan jumlah dalam system, dikarenakan penjualan yang disimpan dan barang yang disiapkan berbeda	Jika ada 2 sediaan yang sama maka menghabiskan stok lama terlebih dahulu agar tidak terjadi selisih stok.
8.	Rak Generik terdapat selisih pada paracetamol tablet, dikarenakan kesalahan perhitungan saat so Bulan Oktober.	Meningkatkan ketelitian petugas saat menghitung buffer stok
Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +6.030.879 , hal ini disebabkan karena :		
1.	Masih ditemukan barang return yang tidak jadi digunakan saat operasi di tandon dalam ruang OK.	Koordinasi dengan kbid keperawatan dan karu IKO untuk menertibkan perawat melakukan retur
2.	Terdapat selisih pada sediaan sharing dose. Contoh : Isonest.	Membuat tabel penggunaan sharing dose dan dilakukan supervisi serta moneyv setiap harinya oleh Kains.
Gudang Retur Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname sudah mencapai target.		
1.	Tidak terdapat rak Gudang Retur	Sentralisasi master barang PT. DPM dan mengajukan gudang retur kembali dimunculkan.

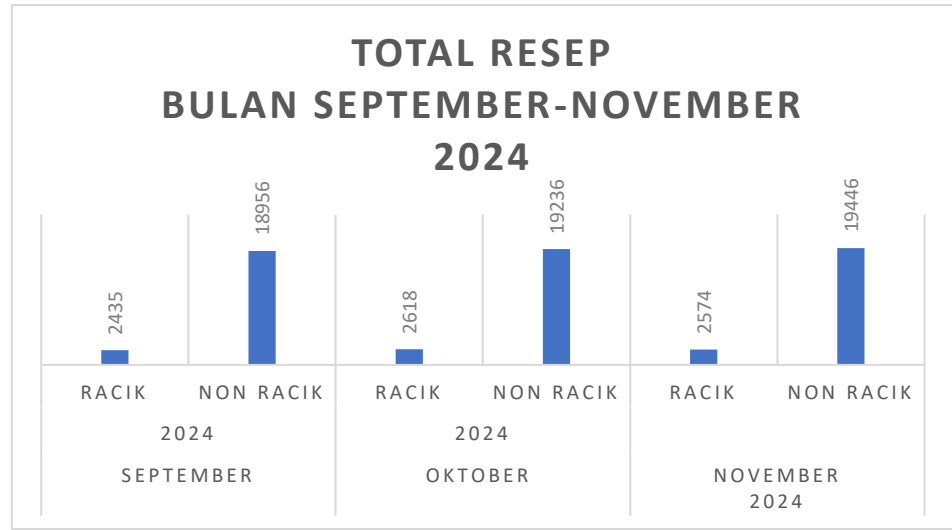
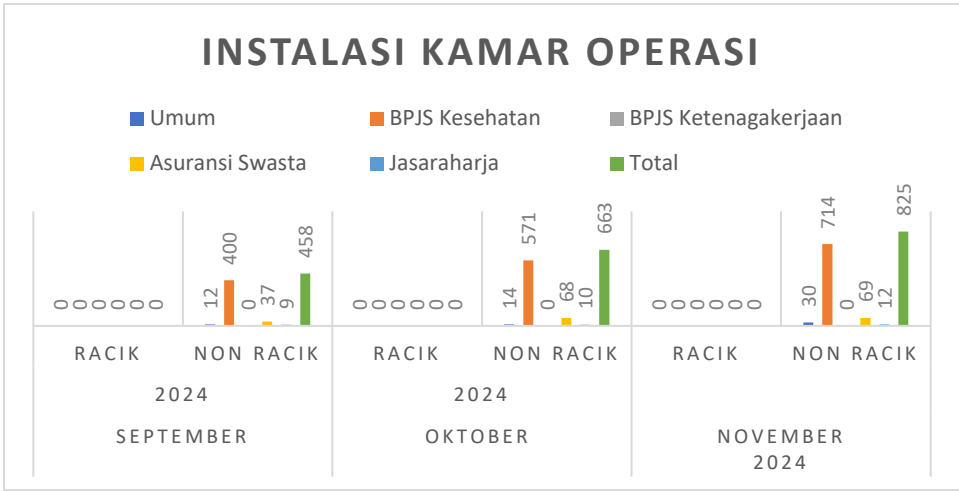
3.2.1.3 Tabel Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran September- November 2024

NO	UNIT	PENJAMIN	BULAN/JENIS RESEP					
			SEPTEMBER 2024		OKTOBER 2024		NOVEMBER 2024	
			RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
1.	IRNA	Umum	23	390	7	351	9	375
		BPJS Kesehatan	240	7171	222	6958	254	7205
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	2	0	0
		Asuransi Swasta	1	401	0	350	0	306
		Jasaraharja	1	74	0	44	0	32
Total			265	8036	229	7705	263	7918
2.	IRJA	Umum	269	792	299	827	300	810
		BPJS Kesehatan	1812	7748	1983	8026	1904	7822
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	250	0	256	0	243
		Jasaraharja	0	14	0	14	0	4
Total			2081	8804	2282	9123	2204	8879
3.	IGD	Umum	38	401	46	385	44	397
		BPJS Kesehatan	51	1132	61	1207	63	1275
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	1	0	5

		Asuransi Swasta	0	114	0	140	0	138
		Jasaraharja	0	11	0	12	0	9
Total			89	1658	107	1745	107	1824
4.	IKO	Umum	0	12	0	14	0	30
		BPJS Kesehatan	0	400	0	571	0	714
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	37	0	68	0	69
		Jasaraharja	0	9	0	10	0	12
Total			0	458	0	663	0	825
Total Resep			2435	18956	2618	19236	2574	19446

3.2.1.4 Grafik Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran September- November 2024





Analisis :

- Hasil jumlah resep selama 3 bulan mengalami peningkatan jumlah resep pada Bulan November 2024.
- Kunjungan pasien umum pada Bulan November 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Bulan Oktober 2024, dengan total resep yaitu : Bulan Oktober sebanyak 1929 resep umum dan Bulan November 2024 sebanyak 1965 resep umum. Peningkatan resep umum tidak signifikan, karena pada Bulan Agustus 2024 mencapai 2196 resep umum. Salah satu penyebabnya adalah pasien dengan kunjungan pertama menggunakan umum memilih pengurusan BPJS Kesehatan karena dijadwalkan control rutin oleh DPJP.
- Kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada Bulan November 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Bulan Oktober 2024, dengan total resep yaitu : Bulan Oktober 2024 sebanyak 19028 resep BPJS dan Bulan November 2024 sebanyak 19237 resep BPJS.
- Kunjungan pasien Asuransi Swasta dan Jasaraharja pada Bulan November 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Bulan Oktober 2024, dengan total resep yaitu : Bulan Oktober 2024 sebanyak 894 resep Asuransi Swasta dan Jasaraharja, sedangkan Bulan November 2024 sebanyak 813 resep Asuransi Swasta dan Jasaraharja. Hal ini disebabkan, kunjungan pasien rawat inap dengan penjamin jasaraharja mengalami penurunan, penyebab lainnya pasien memilih menggunakan BPJS Kesehatan sebagai pilihan utama dibandingkan Asuransi Swasta dimana benefit yang didapat sesuai dengan diagnose yang tertera pada polis asuransi, dan berkompeten selisih biaya di akhir perawatan.
- Secara keseluruhan total resep pada Bulan November 2024 mengalami peningkatan, hal ini ditunjang dengan peningkatan kunjungan pasien rawat jalan dan kunjungan pasien rawat inap.

- Secara keseluruhan total resep pada bulan November 2024 mengalami peningkatan, hal ini ditunjang dengan peningkatan kunjungan pasien rawat inap, pasien IGD dan IKO, namun pengeluaran obat pasien rawat jalan mengalami penurunan, karena target PRB dimana pasien rujuk balik ke FKTP dikarenakan pasien sudah stabil.

Rencana Tindak Lanjut :

- Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di social media RS agar kunjungan pasien meningkat.
- Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
- Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver.
- Kolaborasi dengan Petugas Pendaftaran IGD untuk menjaring pasien-pasien yang mempunyai jaminan Kesehatan lebih dari 1 untuk menggunakan asuransi swasta terlebih dulu.
- Koordinasi dengan programmer menciptakan website primantara untuk memudahkan pendaftaran pasien.
- Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
- Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru, jumlah pasien yang menggunakan layanan pengantaran obat pada Bulan November 2024, yaitu sebanyak 1253 pasien.
Terdapat 145 pasien yang mendapatkan promo di Bulan Oktober 2024 melakukan repeat order.

3.1.1 Laboratorium

3.1.1.1 Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar September-November 2024

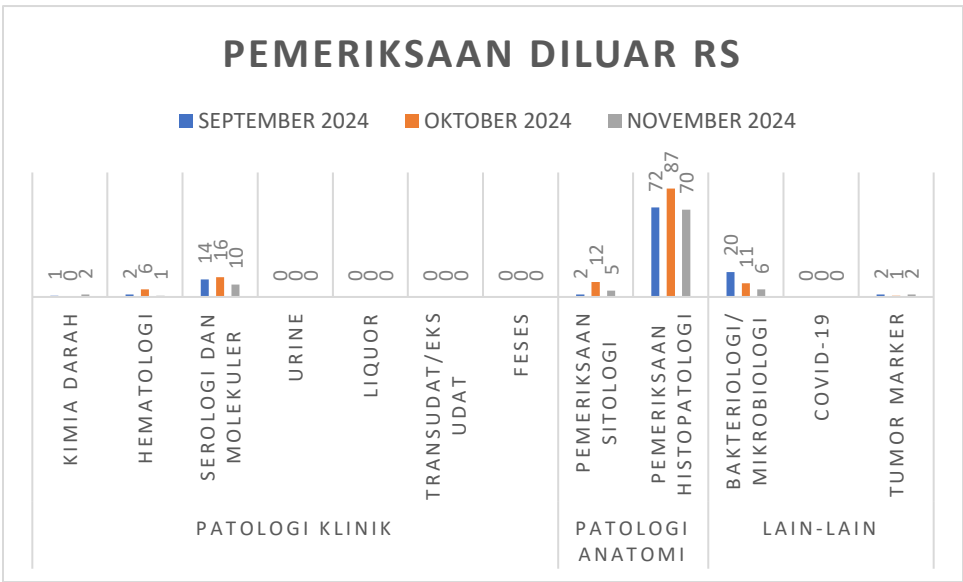
NO	JENIS PEMERIKSAAN	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
Dilakukan di Dalam RS				
1.				
	Kimia darah	5063	4568	4821
	Hematologi	2441	2581	2572
	Serologi dan Molekuler	522	536	650
	Urine	518	451	397
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	19	7	8
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	0	0	0
	Pemeriksaan Histopatologi	0	0	0
3.	Bakteriologi/Mikrobiologi	23	37	43
4.	Narkoba	21	23	14
5.	Covid-19	7	8	6
Dilakukan di Luar RS (dirujuk)				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	1	0	2
	Hematologi	2	6	1
	Serologi dan Molekuler	14	16	10
	Urine	0	0	0
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Liquor	-	-	-
	Feses	0	0	0
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	2	12	5
	Pemeriksaan Histopatologi	72	87	70

3.	Bakteriologi/Mikrobiologi	20	11	6
4.	PCR	0	0	0
5.	Tumor Marker	2	1	2
6.	Cholinesterase	0	0	0

3.1.1.2 Grafik Pemeriksaan Didalam Rumah Sakit Bulan September-
November 2024



3.1.1.1 Grafik Pemeriksaan Diluar Rumah Sakit Bulan September-
November 2024



Analisis :

- Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, rincian Bulan November 2024 yaitu :
 - Patologi Anatomi : 75 sampel
 - Patologi Klinik : 13 sampel
 - Bakteri/Mikrobiologi : 6 sampel
 - Tumor Marker : 2 sampel
- Terdapat rujukan pemeriksaan patologi anatomi pada Bulan November 2024, yaitu sebanyak 75 pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit belum memiliki Laboratorium Patologi Anatomi, ditunjang dengan meningkatnya jumlah tindakan excise yang membutuhkan pemeriksaan

- penunjang.
3. Terdapat rujukan kimia klinik, yaitu pemeriksaan CKMB. Hal ini disebabkan reagen CKMB kosong distributor dan DPJP mengharuskan pemeriksaan tersebut dilakukan, tidak bisa diganti dengan pemeriksaan Troponin I.

Rencana Tindak Lanjut

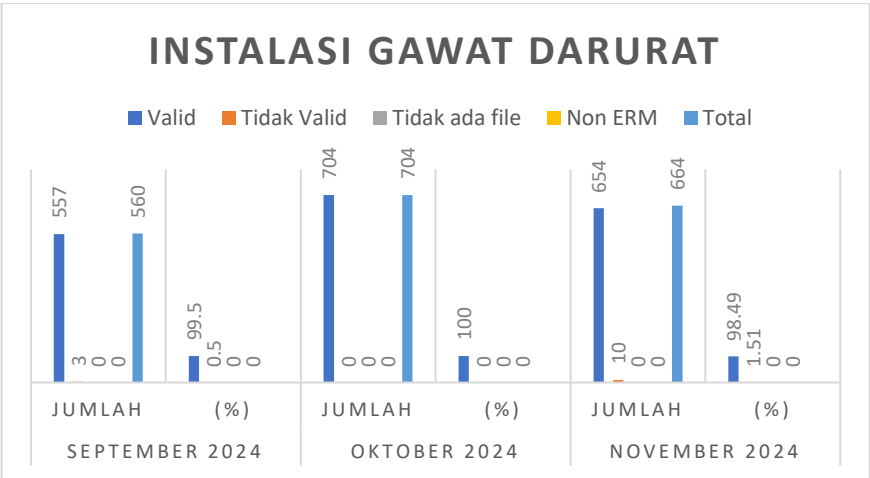
1. Perencanaan Tahun 2024 laboratorium mengadakan pengembangan pelayanan dengan mendirikan BDRS di RS Prima Husada Malang, untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu.
Progress BDRS sampai dengan menunggu alat datang dan akan mengirimkan petugas laboratorium untuk magang di PMI Kepanjen.
2. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
3. Perbaiki serah terima hasil laboratorium menggunakan system digital.
4. Melakukan pencatatan keluar masuk stok reagen pada kartu stok dan dilakukan SO.

3.1.2 Rekam Medis – Pendaftaran

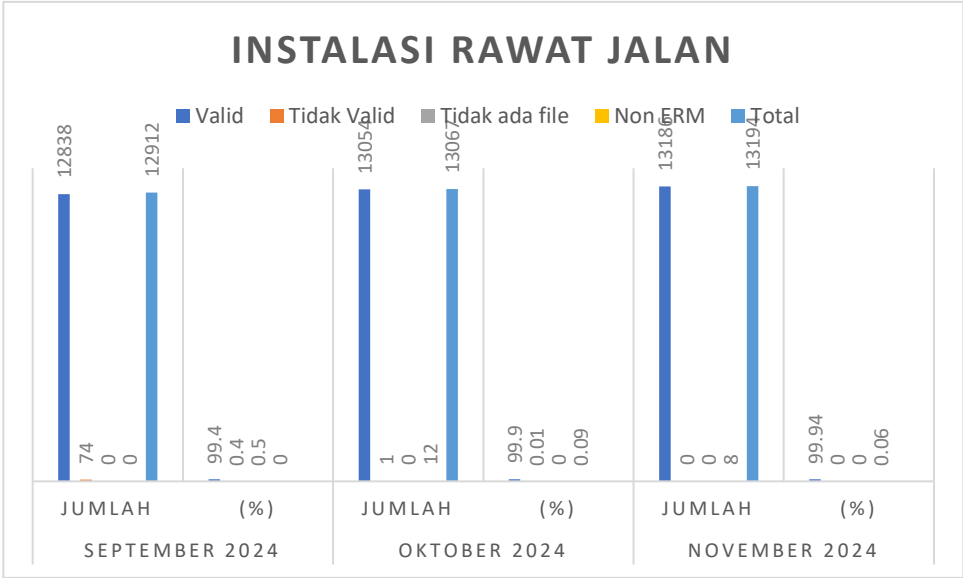
3.1.2.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan September-November 2024

NO	UNIT	KUALIFIKASI	BULAN					
			SEPTEMBER 2024		OKTOBER 2024		NOVEMBER 2024	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1.	IGD	Valid	557	99,5	704	100	654	98,49
		Tidak Valid	3	0,5	0	0	10	1,51
		Tidak ada file	0	0	0	0	0	0
		Non ERM	0	0	0	0	0	0
Total			560		704		664	
2.	IRJA/POLI	Valid	12838	99,4	13054	99,90	13186	99,94
		Tidak Valid	74	0,4	1	0,01	0	0
		Tidak ada file	0	0,5	0	0	0	0
		Non ERM	0	0	12	0,09	8	0,06
Total			12912		13067		13194	

3.1.2.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan September-November 2024



3.1.2.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan September-November 2024



Analisis :

- 1. Validasi Data E-RM di IGD sudah mencapai 98.49% dari 664 data yang diterima.
- 2. Terdapat penurunan capaian dari bulan sebelumnya, hal ini disebabkan skринing IGD tidak terbaca pada fitur e-rm di Rekam Medis.
- 3. Pada Bulan November 2024 tidak ditemukan tarikan data yang tidak ada file baik di IGD maupun di IRJA, yaitu 0%.
- 4. Masih ditemukan layanan IRJA yang belum E-RM, yaitu Poli KIA dan Poli Gizi.

Masalah :

- 1. Pengkajian awal medis gigi tidak bisa terbuka oleh rekam medis, sedangkan fitur tersebut muncul di SIMRS perawat.
- 2. Pencatatan Poli Gizi masih menggunakan lembar konsultasi manual, resiko hilang dan tidak terekap dengan baik pada system sehingga DPJP tidak bisa membaca hasil pada Billing E-RM.
- 3. Ditemukan kunjungan Poli KIA saat petugas RM melakukan review dan belum masuk kedalam E-RM.
- 4. Berikut link permasalahan yang ditemui
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455

Rencana Tindak Lanjut :

Ketidaklengkapan ERM sudah membaik dari pada bulan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan alur terkait penyetoran berkas pasien per hari, yaitu :

- 1. Alur sebelumnya perawat menyetor berkas casemix ke kasir jaminan, mulai awal Bulan Juni 2024 perawat menyetor berkas ke rekam medis untuk dilakukan cek kelengkapan ERM oleh tim rekam medis.
- 2. Petugas rekam medis menandatangani lembar casemix sebagaibukti bahwa sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap dan valid.
- 3. Setelah selesai dilakuan validasi oleh petugas rekam medis, perawat menyetorkan berkas ke kasir jaminan.
- 4. Pada akhir Bulan November 2024 casemix yang disetor sudah tidak dicetak, RS sudah menerapkan E-Casemix.

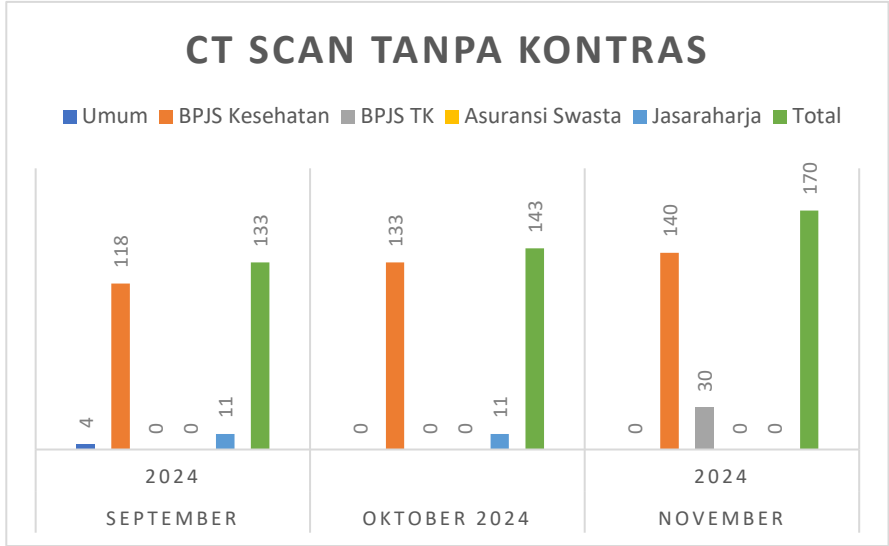
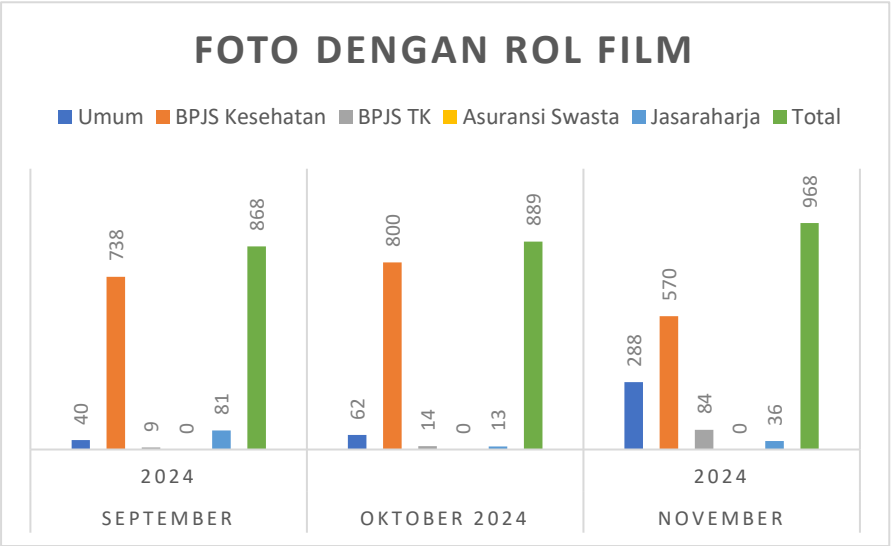
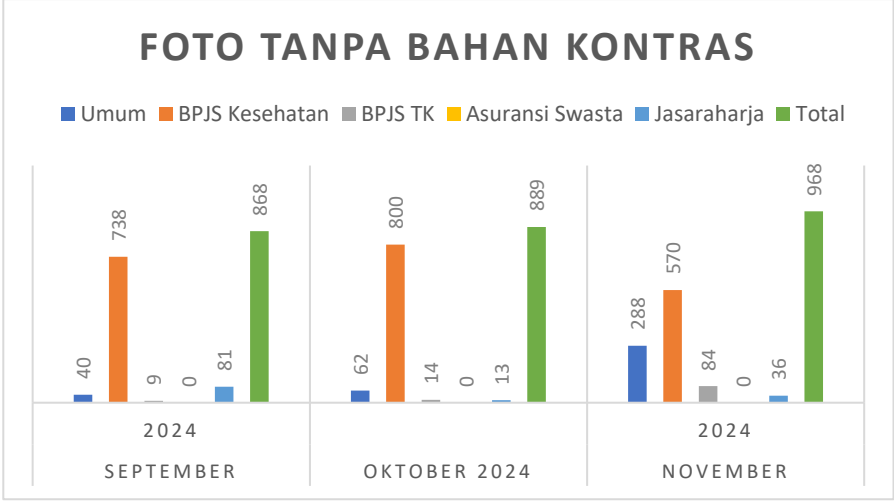
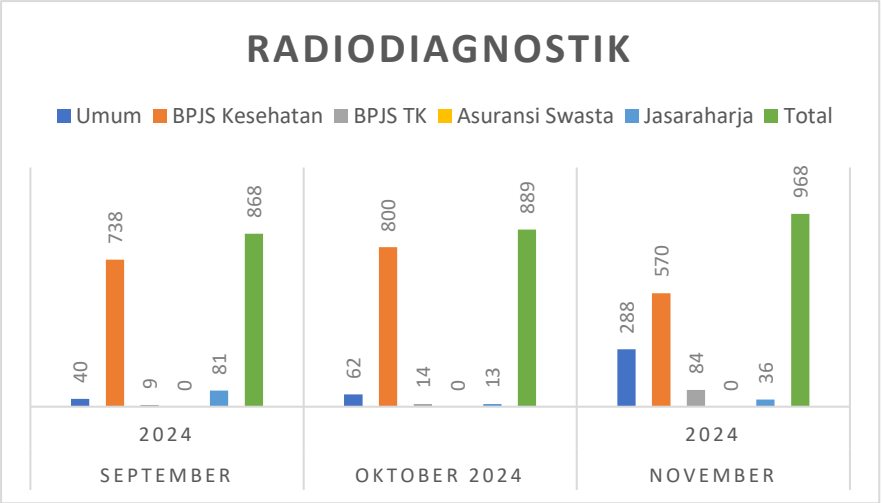
- Melakukan pencatatan kunjungan pasien harian setiap DPJP pada google spreadsheet untuk dilakukan cek kesesuaian dan kelengkapan data oleh Petugas RM dan Verifikator RS.
- Flow Chart alur pelayanan Poli Gizi sudah diberikan kepada Programmer PT.

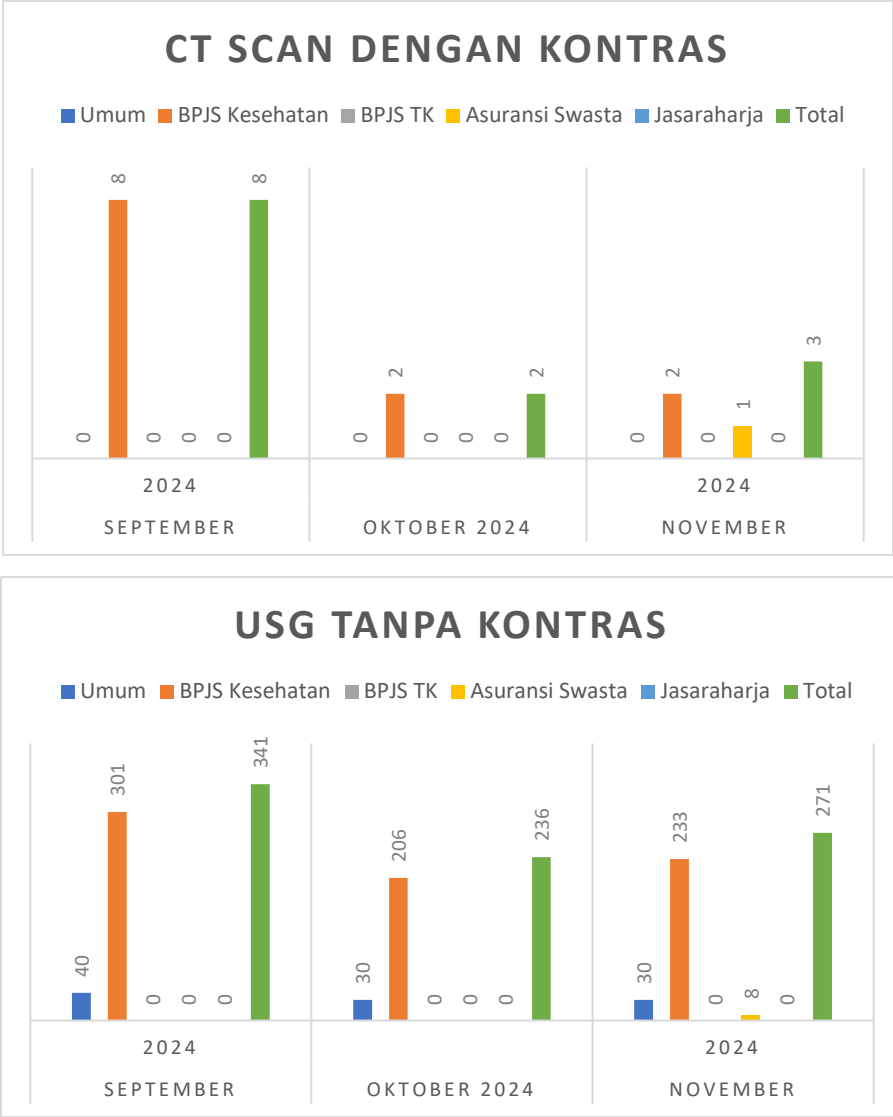
1.1.1 Radiologi

1.1.1.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi September-November 2024

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JENIS PEMBAYARAN	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1.	Radiodiagnostik	Umum	40	62	288
		BPJS Kesehatan	738	800	570
		BPJS TK	9	14	84
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	81	13	36
TOTAL			868	889	968
2.	Foto Tanpa Bahan Kontras	Umum	40	62	288
		BPJS Kesehatan	738	800	570
		BPJS TK	9	14	84
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	81	13	36
TOTAL			868	889	968
3.	Foto Dengan Rol Film	Umum	40	62	288
		BPJS Kesehatan	738	800	570
		BPJS TK	9	14	84
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	81	13	36
TOTAL			868	889	968
4.	CT Scan Tanpa Kontras	Umum	4	0	0
		BPJS Kesehatan	118	133	140
		BPJS TK	0	0	30
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	11	11	0
TOTAL			133	143	170
5.	CT Scan Dengan Kontras	Umum	0	0	0
		BPJS Kesehatan	8	2	2
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	0	1
		Jasaraharja	0	0	0
TOTAL			8	2	3
06.	USG Tanpa Kontras	Umum	40	30	30
		BPJS Kesehatan	301	206	233
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	0	8
		Jasaraharja	0	0	0
TOTAL			341	236	271

1.1.1.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi September-November 2024





Analisis :

- Pelayanan pemeriksaan dalam 3 bulan terakhir meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.
Pada 3 bulan terakhir pemeriksaan terbanyak, yaitu :
 - Radiodiagnostik : 968
 - USG Tanpa Kontras : 271
 - CT Scan Tanpa Kontras :170
- Pada Bulan November 2024 pemeriksaan Radiodiagnostik mengalami peningkatan, hal ini disebabkan ada kegiatan MCU CJH dan Karyawan Perusahaan sebanyak 34 orang.
- Terjadi penurunan pada pemeriksaan USG Tanpa Kontras, sebanyak 236 pasien dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 271 pasien dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 236 pasien atau sebesar 14%.

Rencana Tindak Lanjut :

- Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota

Malang.

- 2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
- 3. Melakukan review tarif tindakan yang dibutuhkan DPJP atau bisa dilakukan di RS, namun belum ada di Billing.

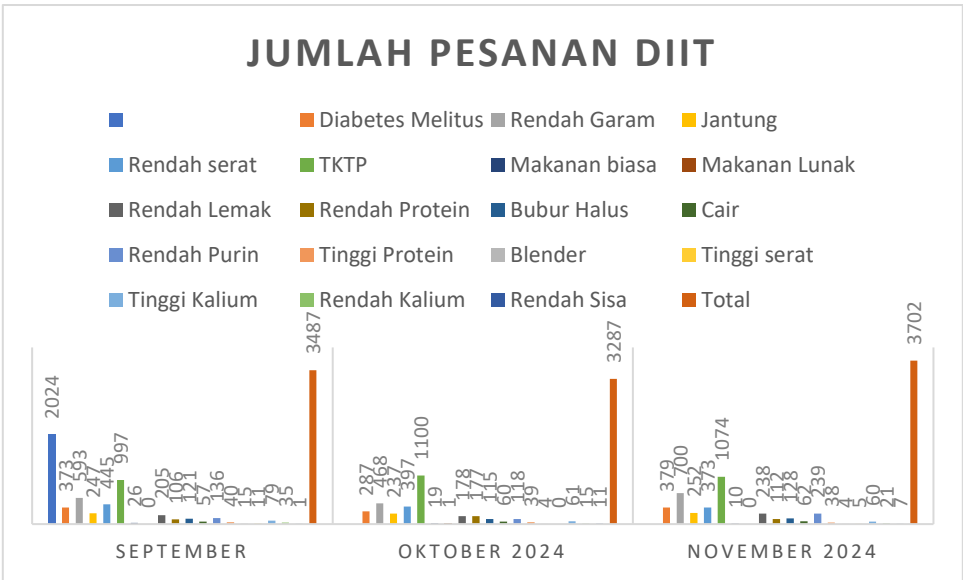
Contoh : CTA Cardiac.

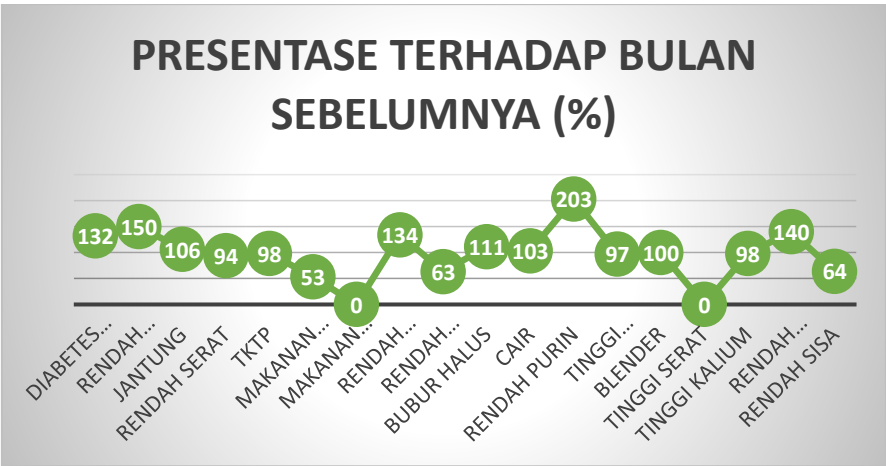
4.4.5 Gizi

4.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit September-November 2024

NO	NAMA DIIT	JUMLAH PESANAN DIIT			PRESENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024	
1.	Diabetes Melitus	373	287	379	132
2.	Rendah Garam	593	468	700	150
3.	Jantung	247	237	252	106
4.	Rendah serat	445	397	373	94
5.	TKTP	997	1100	1074	98
6.	Makanan biasa	26	19	10	53
7.	Makanan Lunak	0	1	0	0
8.	Rendah Lemak	205	178	238	134
9.	Rendah Protein	106	177	112	63
10.	Bubur Halus	121	115	128	111
11.	Cair	57	60	62	103
12.	Rendah Purin	136	118	239	203
13.	Tinggi Protein	40	39	38	97
14.	Blender	15	4	4	100
15.	Tinggi serat	11	0	5	0
16.	Tinggi Kalium	79	61	60	98
17.	Rendah Kalium	35	15	21	140
18.	Rendah Sisa	1	11	7	64
TOTAL		3487	3287	3702	113

4.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit September-November 2024





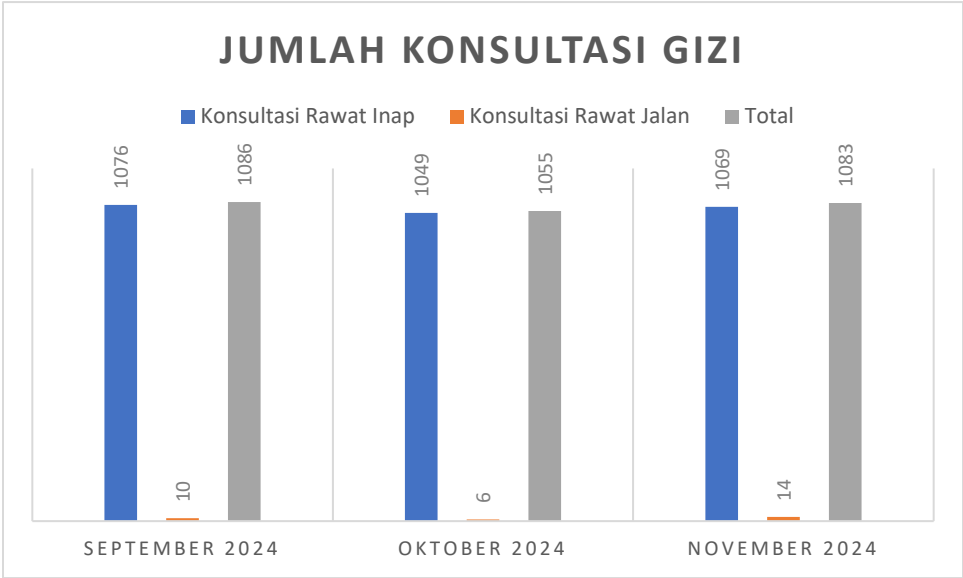
Analisis :
Dari grafik jumlah pemesanan diit diatas, jumlah pemesanan mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Jenis diit fluktuatif menyesuaikan kebutuhan pasien sesuai dengan advice DPJP dan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pasien rawat inap pada Bulan November 2024.
Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
 2. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.
 3. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai reward.

4.4.5.3 Jumlah Konsultasi Gizi September-November 2024

NO	INDIKASI	BULAN		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1.	Konsultasi Rawat Inap	1076	1049	1069
2.	Konsultasi Rawat Jalan	10	6	14
Total		1021	1086	1055

4.4.5.4 Grafik Jumlah Konsultasi Gizi September-November 2024



Analisis :

- 1. Data jumlah konsultasi gizi pada pasien rawat inap mengalami penurunan, berbanding lurus dengan penurunan jumlah kunjungan pasien rawat inap.
- 2. Data jumlah konsultasi gizi pada rawat jalan mengalami penurunan, yaitu 6 pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan dokter DPJP agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi dan lebih baik lagi jika ada dokter spesialis gizi.
- 2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan MCU Gizi.
- 3. Menjalankan Prima Health Meals.
- 4. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai reward dan menarik pasien supaya bisa merasakan layanan MCU Gizi terlebih dulu, sebanyak 10 pasien yang akan mendapatkan MCU Gizi gratis pada Bulan November 2024.

4.4.5 CSSD – Laundry

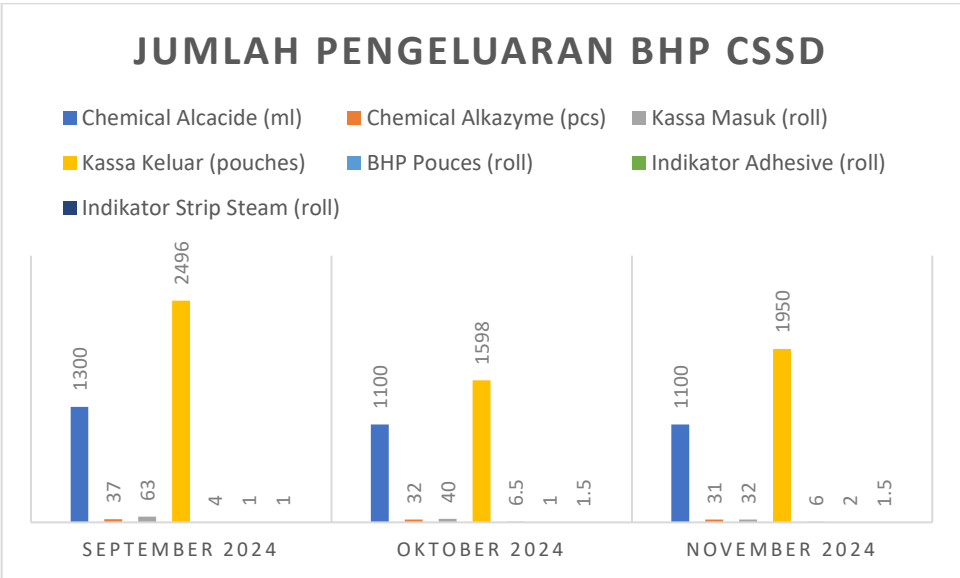
4.4.5.1 CSSD

4.4.5.1.1 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD di Bulan September-November 2024

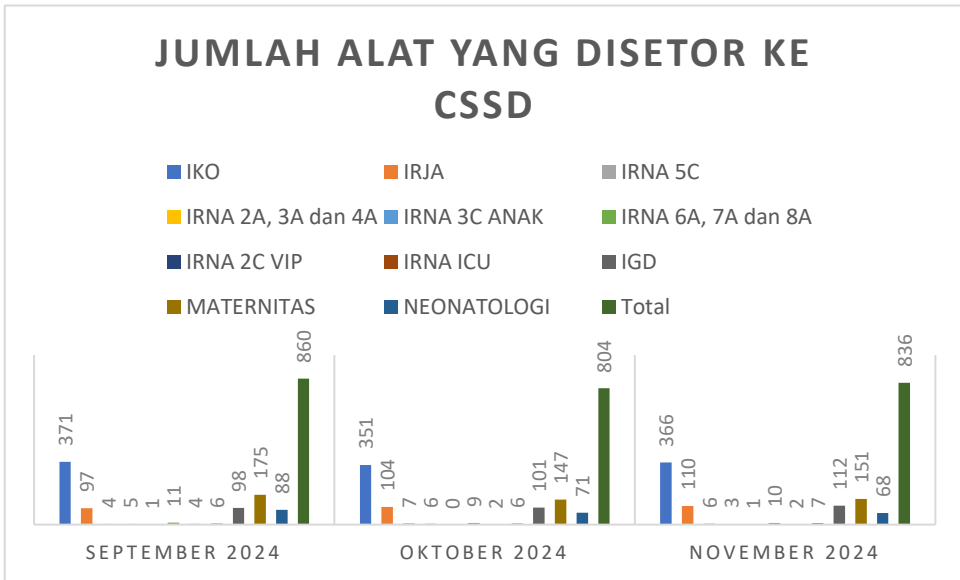
NO	HAL	BULAN		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
BHP				
1.	Chemical Alcacide (ml)	1300	1100	1100
2.	Chemical Alkazyme (pcs)	37	32	31
3.	Kassa Masuk (roll)	63	40	32
4.	Kassa Keluar (pouches)	2496	1598	1950
5.	BHP Pouces (roll)	4	6,5	6
6.	Indikator Adhesive (roll)	1	1	2
7.	Indikator Strip Steam (roll)	1	1,5	1,5
Alat yang disetor (set)				
8.	IKO	371	351	366
9.	IRJA	97	104	110
10.	IRNA 5C	4	7	6
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	5	6	3
12.	IRNA 3C ANAK	1	0	1
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	11	9	10
14.	IRNA 2C VIP	4	2	2

15.	IRNA ICU	6	6	7
16.	IGD	98	101	112
17.	MATERNITAS	175	147	151
18.	NEONATOLOGI	88	71	68
Jumlah		860	804	836

4.4.5.1.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai CSSD di Bulan September-November 2024



4.4.5.1.3 Grafik Jumlah Alat Yang disetor ke CSSD di Bulan September-November 2024



Analisis :

- Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat dalam 3 bulan terakhir yaitu sejumlah 1.088 set, diikuti dari Unit Maternitas 473 set dan IGD 311 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.
- Dengan perbaikan pencatatan menggunakan google spreadsheet data yang diambil valid, namun penggolongan kategori alat tidak seragam, seperti gunting talpus terhitung 1 alat dan set partus juga terhitung 1 alat.
- Terjadi peningkatan penggunaan alat di IRJA dan IGD, hal ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pasien JKK yang datang ke IGD dan dilanjutkan control ke Poli Spesialis.
- Terjadi peningkatan produktifitas kinerja dalam pembuatan kasa steril, hal ini

disebabkan adanya pemenuhan petugas dan pemenuhan permintaan stok Gudang Farmasi.

Rencana Tindak Lanjut :

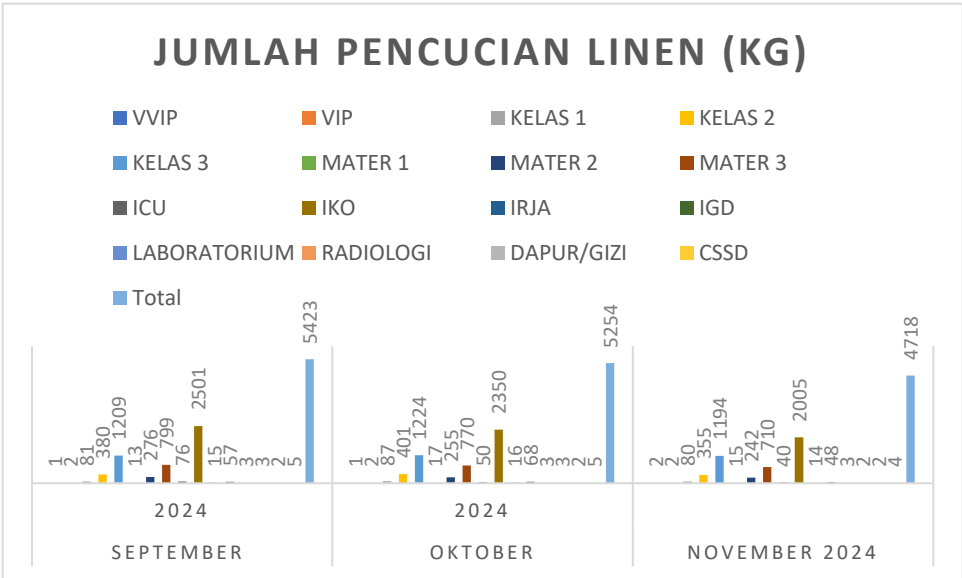
- 1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.
- 2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
- 3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.
- 4. Melakukan orientasi petugas baru di CSSD.

4.4.5.2 Laundry

4.4.5.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry Bulan September-November 2024

NO	ASAL UNIT	JUMLAH PER BULAN (KG)		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1.	VVIP	1	1	2
2.	VIP	2	2	2
3.	KELAS 1	81	87	80
4.	KELAS 2	380	401	355
5.	KELAS 3	1209	1224	1194
6.	Mater 1	13	17	15
7.	Mater 2	276	255	242
8.	Mater 3	799	770	710
9.	ICU	76	50	40
10.	IKO	2501	2350	2005
11.	IRJA	15	16	14
12.	IGD	57	68	48
13.	Laborat	3	3	3
14.	Radiologi	3	3	2
15.	Dapur/Gizi	2	2	2
16.	CSSD	5	5	4
TOTAL		5423	5254	4718

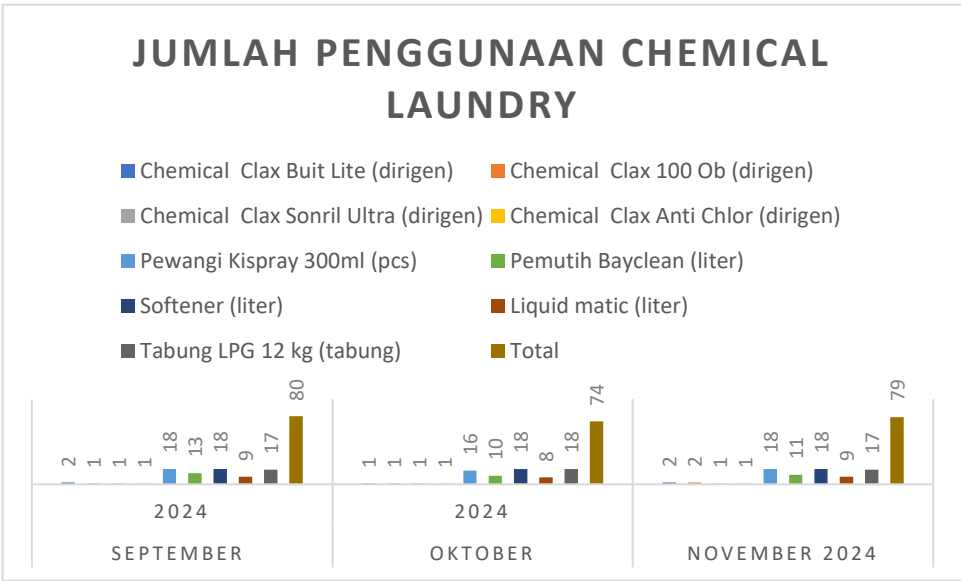
4.4.5.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Bulan September-November 2024



4.4.5.2.3 Jumlah Penggunaan Chemical Laundry Bulan September-November 2024

NO	ASAL UNIT	JUMLAH PER BULAN		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1.	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	2	1	2
2.	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	1	1	2
3.	Chemical Clax Sonril Ultra (dirigen)	1	1	1
4.	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1	1	1
5.	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	18	16	18
6.	Pemutih Bayclean (liter)	13	10	11
7.	Softener (liter)	18	18	18
8.	Liquid matic (liter)	9	8	9
9.	Tabung LPG 12 kg (tabung)	17	18	17
TOTAL		80	80	74

4.4.5.2.4 Grafik Jumlah Penggunaan Chemical Laundry September-November 2024



Analisa :

- 1. Terdapat penurunan jumlah pencucian linen dari bulan sebelumnya yaitu sebanyak 536kg, berbanding lurus dengan penurunan jumlah kunjungan pasien rawat inap, tetapi tidak sebanding dengan penggunaan chemical yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh linen kotor yang memerlukan pencucian ulang karena noda terlalu pekat.
- 2. Pada Bulan November 2024, sudah tidak ditemukan benda asing didalam linen kotor dari ruang perawatan, sehingga menjadi salah satu penyebab berkurangnya berat linen kotor yang diterima.
- 3. Pencatatan penimbangan linen menggunakan timbangan beras masih manual, resiko angka tidak terbaca dengan baik, sehingga jumlah yang dihasilkan kurang valid.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Rencana akan dilakukan permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan.
- 2. Rencana akan dilakukan pencatatan menggunakan google spreadsheet per hari nya.
- 3. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
- 4. Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.

4.5 Kinerja Umum dan Keuangan

4.5.5 SDM

3.5.1.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan Medis	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	7	7	0	7	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	S1 Apoteker	42	14	0	14	0
		S1 Farmasi		4	3	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	0	1	0
		D3 Farmasi		19	3	16	0
		SMK		4	0	8	0
		S1 Akuntansi		0	0	0	0
9	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	11	1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	0	8	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		1	1	0	0
10	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	0	1	0
		SMK		1	0	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	4	3	1	2	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	1
12	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	0	2	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	0	2	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		2	2	0	0
13	Humas & Marketng	Profesi Ners	2	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
14	ICU dan HCU	Profesi Ners	11	4	2	2	0

		D3 Keperawatan		7	0	7	0
15	IGD	Profesi Ners	26	11	1	10	0
		D3 Keperawatan		10	0	10	0
		D4 Kebidanan		3	0	3	0
		D3 Kebidanan		2	0	2	0
16	IKO	Profesi Ners	12	7	2	5	0
		D3 Keperawatan		4	1	3	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRS	S1 Tenik Elektro	6	1	0	1	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	0	3	0
19	IRJA	Profesi Ners	27	7	4	3	0
		D3 Keperawatan		15	5	10	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		4	3	1	0
20	IRNA 2C	Profesi Ners	7	4	1	3	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		2	0	2	0
21	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	20	16	1	15	0
		D3 Keperawatan		4	0	4	0
22	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	16	6	0	6	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		8	0	8	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
23	IRNA 5C Anak	Profesi Ners	9	2	0	2	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		6	0	6	0
24	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	24	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		D3 Keperawatan		12	0	12	0
25	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	0	2	0
		D3 Kebidanan		8	0	8	0
26	Neonatologi	Profesi Ners	8	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	1	4	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0

27	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		2	1	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		3	3	0	0
		SMA		1	0	1	0
28	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	10	2	0	2	0
		D3 Analis Kesehatan		8	0	8	0
29	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
30	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	4	6	0
31	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Ilmu Sosial		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	0	1	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	2	4	0
		SMK		5	0	5	0
		SMA		1	1	0	0
32	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	2	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1		1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
33	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
34	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
35	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
36	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0
37	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	0	3	0
38	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
39	Cleaning Service	SMK	45	25	5	20	0
		SMA		15	0	15	0
40	Security	SMK	12	7	4	3	0
		SMA		5	2	3	0
41	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	0	1	0
		SMA		2	0	2	0
		SMP		2	0	2	0
42	Gudang	SMP	1	1	1	0	0

	Umum						
43	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
44	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
45	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
46	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
47	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis	Pendidikan Dokter	2	2	0	2	0

	Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Spesialis					
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			459				

Keterangan :
 Pada bulan November 2024 terdapat penambahan 1 Doketr Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi baru.

3.5.1.2 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	dr. Virginia Ainurridlo Nugroho, Sp.KFR	Dokter Spesiais Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	05 November 2024	SIP Baru Profesi Dokter Spesialis
2	Bd. Deya Nahdah Amany, S.Keb	Bidan	06 November 2024	SIP Baru Profesi Bidan
3	Dia Ayu Wisnu Wardani, A.Md.Farm	Tenaga Teknis Kefarmasian	06 November 2024	SIP Perpanjangan Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian
4	Apt. Shindy Ariesta Putri Prajoko, S.Farm	Apoteker	13 November 2024	SIP Baru Profesi Apoteker
5	Fiqi Nadia, A.Md.RMIK	Perekam Medis	19 November 2024	SIP Nonaktif
6	Fiqi Nadia, A.Md.RMIK	Perekam Media	21 November 2024	SIP Perpanjangan Profesi Perekam Medis Aktif
7	Irwinda Neila Fitria, S.Tr.Kes	Terapis Wicara	21 November 2024	SIP Baru Profesi terapis Wicara

3.5.1.3 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menguhubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Gigi	1	0	1	Sulit mencari	Menguhubungi

	Spesialis Konservasi Gigi				Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	kampus dengan jurusan tersebut
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
5	Fisioterapis	5	3	2	Belum mendapatkan kandidat yang cocok	Sedang proses pemenuhan

3.5.1.4 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KET
1	01 November 2024	Orientasi Khusus	Dimas Guntur Sujud	SMK	Cleaning Service	01 November 2024	-
2	05 November 2024	Orientasi Khusus (Dokter Spesialis)	dr. Virginia Ainurridlo Nugroho, Sp.KFR	Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	05 November 2024	Mulai praktik pada 03 Desember 2024
3	25 November 2024	Orientasi Khusus	Mokhamad Nadhif Darmawan	SMK	Umum Security	25 November 2024	-
4	28 November 2024	Orientasi Khusus	Niken Nul Arafah, A.Md.Bns, S.Ak	S1 Akuntansi	Kasir	28 November 2024	-

Keterangan :

Pada bulan November 2024 terdapat orientasi khusus staf da dokter spesialis baru

3.5.1.5 Diklat

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS DIKLAT	JUDUL DIKLAT	SASARAN	KETERANGAN	RTL
1	22 November 2024	Diklat Internal	Diklat Drill Emergency Maternal Neonatal &	Bidan RS Prima Husada	Kegiatan diklat terakhir	-

3.5.1.6 Evaluasi Kinerja Staf

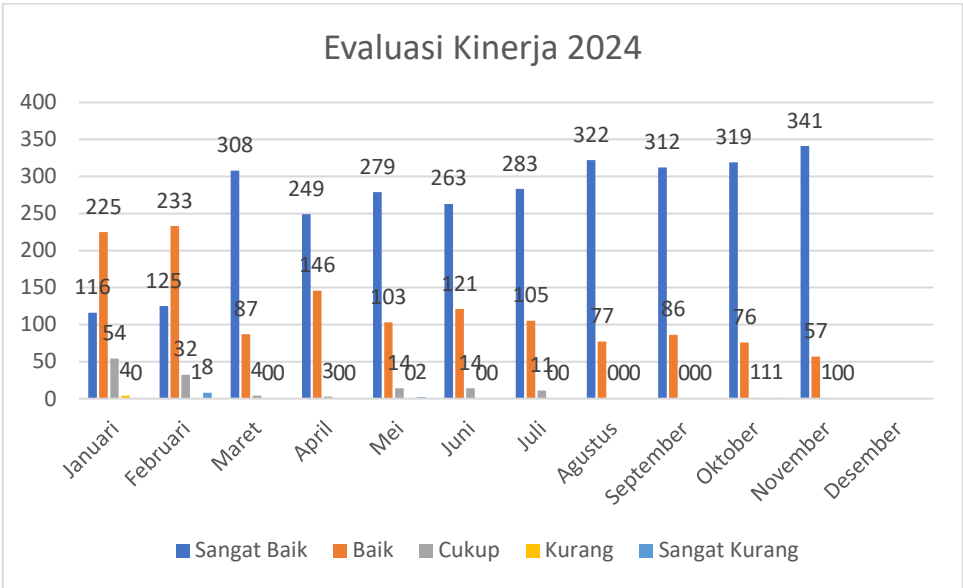
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			BAIK	JELEK	SB	B	C	K	
1	Manajemen	Umum	12 staf	0 staf	10	2	0	0	Unit Manajemen RS Prima Husada secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Asuransi Center	Umum	11 staf	0 staf	10	1	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	IRNA 2C	Umum	7 staf	0 staf	7	0	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			BAIK	JELEK	SB	B	C	K	
4	IRNA 3C Anak	Umum	16 staf	0 staf	15	1	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	IRNA 234A	Umum	19 staf	0 staf	16	3	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	IRNA 5C	Umum	9 staf	0 staf	8	1	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	IRNA 678A	Umum	24 staf	0 staf	23	1	0	0	Unit IRNA 678A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Maternitas	Umum	12 staf	0 staf	12	0	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	Neonatologi	Umum	8 staf	0 staf	7	1	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	IGD	Umum	25 staf	0 staf	23	2	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	ICU dan HCU	Umum	12 Staf	0 staf	10	2	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	IKO	Umum	12 staf	0 staf	12	0	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	Gizi	Umum	17 staf	0 staf	17	0	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	Farmasi	Umum	43 staf	0 staf	22	21	0	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	Laboratoriu m	Umum	10 staf	0 staf	10	0	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	Radiologi	Umum	6 staf	0 staf	6	0	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	Rekam Medis	Umum	10 staf	0 staf	8	2	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	Pendaftaran	Umum	18 staf	0 staf	12	6	0	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			BAIK	JELEK	SB	B	C	K	
									penilaian kinerja umum.
18	CSSD dan Laundry	Umum	10 staf	0 staf	10	0	0	0	Unit CSSD & Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	Keuangan dan Akuntansi	Umum	11 staf	0 staf	7	4	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	PIPP	Umum	6 staf	0 staf	6	0	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	Cleaning Service	Umum	45 staf	0 staf	38	7	0	0	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IT SIMRS	Umum	3 staf	0 staf	2	1	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	IPSRS	Umum	6 staf	0 staf	4	2	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Gudang Umum	Umum	2 staf	0 staf	1	1	0	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Driver	Umum	5 staf	0 staf	5	0	0	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Security	Umum	12 staf	0 staf	12	0	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	IRJA	Umum	31 staf	0 staf	28	3	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis : Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode November 2024.

3.5.1.5.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



Analisis :
Peningkatan pada kategori “sangat baik”, dari bulan sebelumnya

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 - 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 - 3. Mempertahankan staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.7 Konseling

3.5.1.7.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2024

NO	JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Konseling	0	13	11	12	5	2	8	20	2	0	0

Analisis :
Tidak ada konseling di bulan November

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.2 MFK dan K3RS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

NO	KET	TARGET	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Capaian Maintenance	90%	93,94	90,91	79.41	70.59	88.24	82.85	45,71%	94,73%	97.43%

TOTAL ALAT (MAINTENANCE)	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Oktober	267	187	70.03%
November	268	194	72.38%

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Oktober	12
November	20

Analisa :
 Pada bulan ini, capaian maintenance meningkat dari beberapa bulan sebelumnya. Jumlah alat yang termaintenance 194 dari 187. Beberapa factor yang menyebabkan fluktuatif antara lain : alat medis masih dipakai oleh pasien, ruangan atau unit masih ada tindakan pasien, perbantuan perbaikan alat medis klinik Mutiara sehat.

Rencana Tindak Lanjut :
 Koordinasi dengan PT untuk ATEM sesuai ABK

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

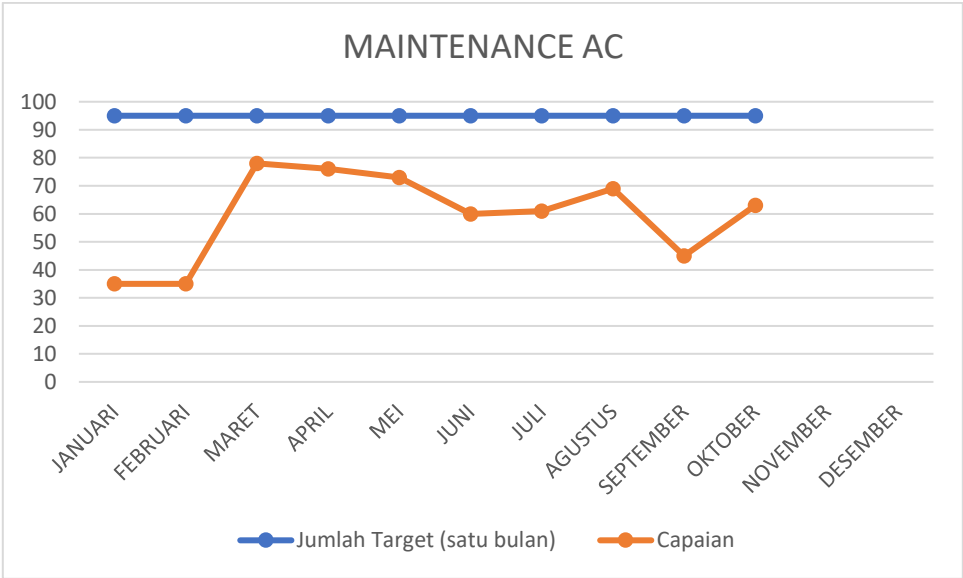
3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

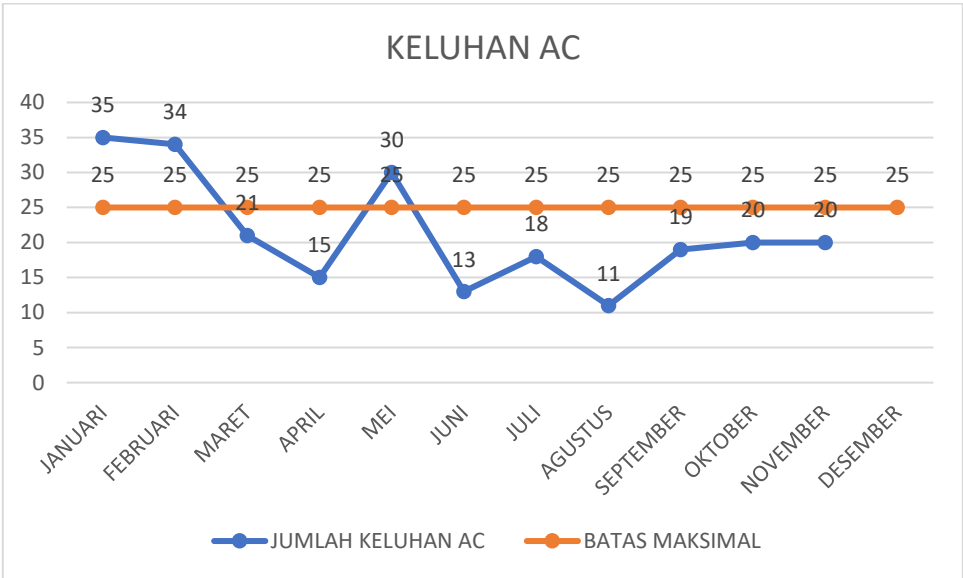
NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	95	54	57%	Belum Mencapai Target
2	Februari	95	69	73%	Belum Mencapai Target
3	Maret	95	94	99%	Belum Mencapai Target
4	April	95	61	64%	Belum Mencapai Target
5	Mei	95	94	99%	Belum Mencapai Target
6	Juni	95	89	94%	Belum Mencapai Target
7	Juli	95	60	63%	Belum Mencapai Target
8	Agustus	95	69	72%	Belum Mencapai Target
9	September	95	45	47%	Belum Mencapai Target
10	Oktober	95	63	66%	Belum Mencapai Target

11	November	95	36	39%	Belum Mencapai Target
----	----------	----	----	-----	-----------------------

3.5.2.2.1.2 Grafik Target Capaian Maintanance AC



3.5.2.2.1.3 Grafik Keluhan AC Split dari Unit



Analisis :
 Terjadi kenaikan pemeliharaan AC pada bulan Oktober menjadi sebesar 66%, karena
 Di bulan ini tidak terlaui banyak perbaikan utilitas, Karena banyak ruangan (pasien kosong) sehingga dapat melakukan pemeliharaan, Karena kunjungan DPJP sering kosong sehingga dapat melakukan pemeliharaan

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi terutama terkait sistem pencatatan dan target perbulan.

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
9	September	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
10	Oktober	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
11	November	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.5.2.2.4.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	3x/bulan	2x/bulan	67%	Sudah mencapai target
4	April	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
9	September	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
10	Oktober	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
11	November	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 3x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target. Berdasarkan hasil supervisi, petugas sudah berkeliling dan melakukan dokumentasi.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

November 2024							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	keterangan	pengiriman	
01/11/2024	1497	1250	247	MMHG			
02/11/2024	1250	1019	231	MMHG			
03/11/2024	1019	709	310	MMHG	sebelum pengisian		
03/11/2024	709	3665		MMHG	setelah pengisian	2956	
04/11/2024	3665	3545	120	MMHG			
05/11/2024	3545	3260	285	MMHG			
06/11/2024	3260	3037	223	MMHG			
07/11/2024	3037	2780	257	MMHG			
08/11/2024	2780	2556	224	MMHG			
09/11/2024	2556	2355	201	MMHG			
10/11/2024	2355	2045	310	MMHG			
11/11/2024	2045	1844	201	MMHG			
12/11/2024	1844	1655	189	MMHG			
13/11/2024	1655	1512	143	MMHG			
14/11/2024	1512	1222	290	MMHG	sebelum pengisian		
14/11/2024	1222	3085		MMHG	setelah pengisian	1863	
15/11/2024	3085	2888	197	MMHG			
16/11/2024	2888	2626	262	MMHG			
17/11/2024	2626	2480	146	MMHG			
18/11/2024	2480	2344	136	MMHG			
19/11/2024	2344	2166	178	MMHG			
20/11/2024	2166	1897	269	MMHG			
21/11/2024	1897	1644	253	MMHG			
22/11/2024	1644	1474	170	MMHG			
23/11/2024	1474	1260	214	MMHG			
24/11/2024	1260	1144	116	MMHG			
25/11/2024	1144	974	170	MMHG			
26/11/2024	974	683	291	MMHG	sebelum pengisian		
26/11/2024	683	3230		MMHG	setelah pengisian	2547	
27/11/2024	3230	3055	175	MMHG			
28/11/2024	3055	2897	158	MMHG			
29/11/2024	2897	2625	272	MMHG			
30/11/2024	2625	2397	228	MMHG			
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			6466	MMHG			
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						4410	MMHG
Rata-rata penggunaan oksigen per hari			445.33333 MMHG				
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						2940	MMHG

Analisis :

Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Pemeliharaan IPAL	1x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.7 Filter Air

3.5.2.2.7.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	OKT	NOV
1	Pemeliharaan filter air	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Pemeliharaan lift	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.9 UPS

1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Pemeliharaan UPS	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

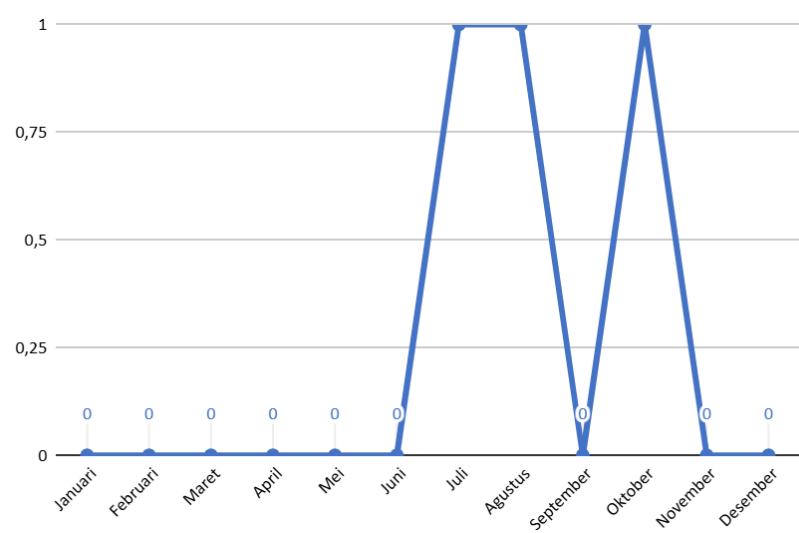
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang

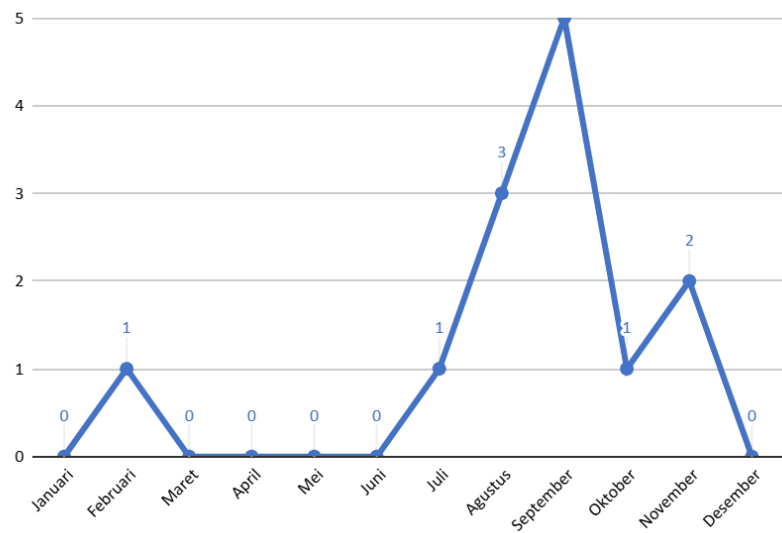


ANGKA KEJADIAN KEHILANGAN BARANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
-	-	-

3.5.3.3 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	0	1	0	0	0	0	1	3	5	1	2

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



ANGKA KEJADIAN BARANG BERPOTENSI HILANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
28 – 11 – 2024	Telah ditemukan kontak mobil merek Daihatsu di meja pendaftaran central terkondisikan di pos security IGD	Telah di ambil oleh pemilik
31 – 11 – 2024	Telah ditemukan hp milik pasien di pendaftaran central terkondisikan di pos security poli	Telah di ambil oleh pemilik

Analisis :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

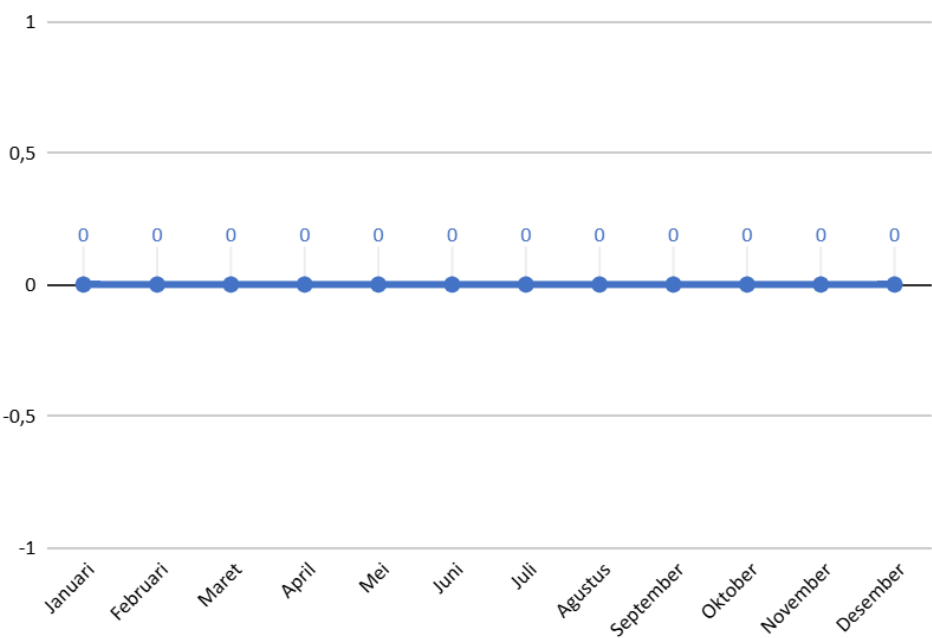
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan



Analisis :

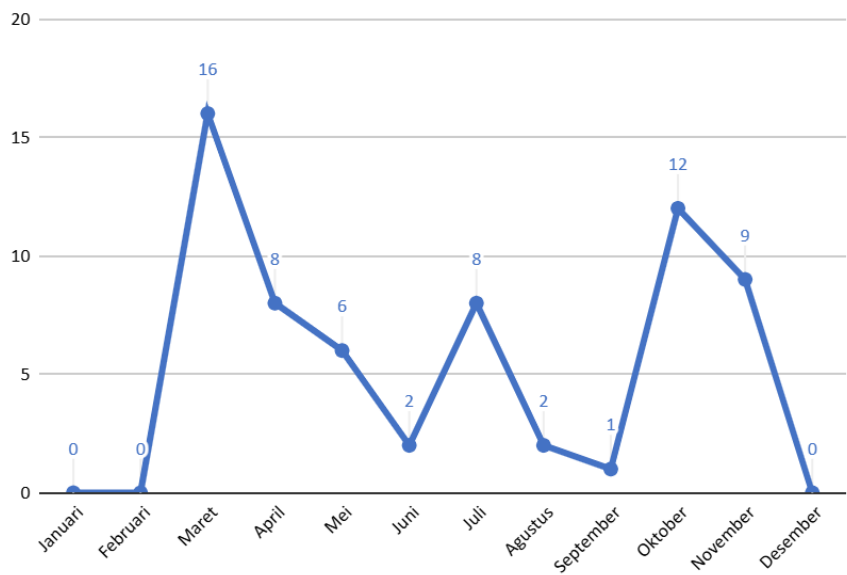
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusuhan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	Tidak tercatat	Tidak tercatat	16	8	6	2	8	2	1	12	9



Analisis :

Angka kejadian merokok mengalami kenaikan pada bulan ini. Beberapa faktor yang mengakibatkan:

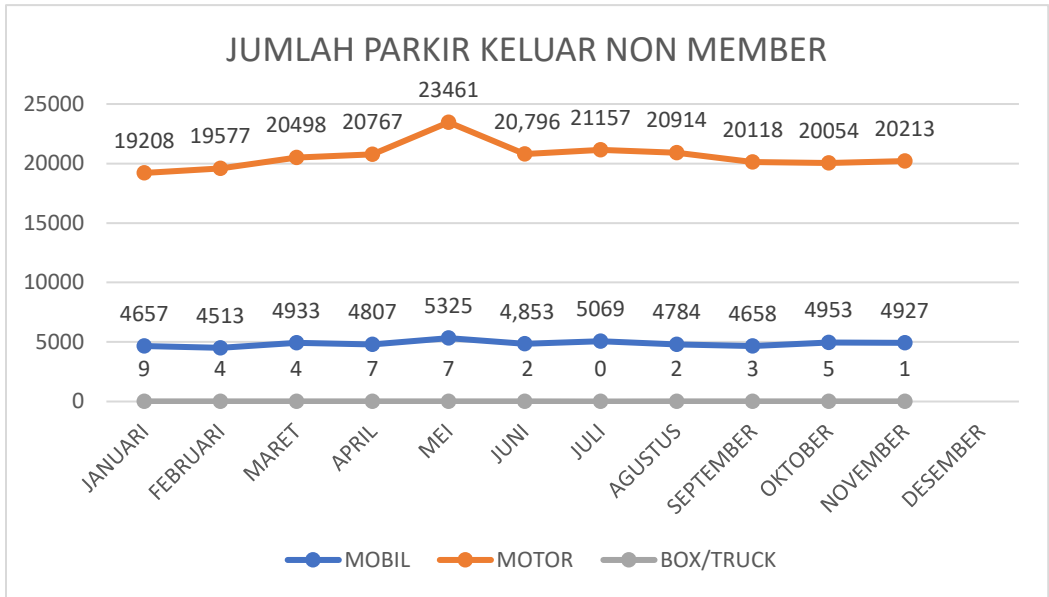
- 1. Karakter pasien berbeda-beda setiap bulannya
- 2. Tanda dilarang merokok tidak terlihat dengan baik
- 3. Ruang dibelakang Samator menjadi tempat yang tertutup untuk istirahat dan merokok

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :

Peningkatan jumlah parkir, mengikuti fluktuatif pasien rumah sakit bulan November 2024.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

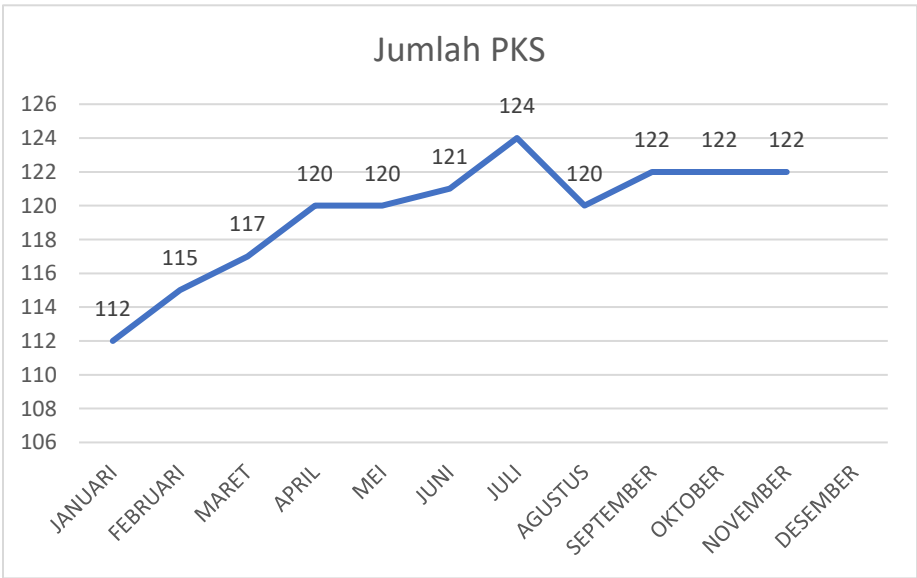
3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Tabel Jumlah PKS-IKS Aktif

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Jumlah PKS IKS AKTIF	112	115	117	120	120	121	124	120	122	122	122

3.5.5.1.2 Grafik Jumlah PKS – IKS



3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Bulan November 2024

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Pesta Pora Abadi	Review pihak kedua	-
2	PT Tentrem Sejahtera	Review pihak kedua	-
3	PT Ustegra	Review pihak kedua	-
4	PT Randi Cones Indonesia	Review pihak kedua	-
5	PT Kharisma Selaras	Review pihak kedua	-
6	RS Universitas Brawijaya	Review ulang oleh RSUB	Ada beberapa notice terkait kesepakatan
7	PT New Minatex	Review pihak kedua	-
8	CV Barokah Plywood	Review Pihak Kedua	-
9	PT Indostar Building Material	Review Pihak kedua	-
10	PT Enak Jaya Makmur (Enak Eco)	Review Pihak kedua	-
11	PT Indonusa Algaemas Prima	Review Pihak Kedua	-
12	PT Duta Kharisma Sentosa	Review Pihak Kedua	-
13	PT Mahadaya Karya Sentosa	Review Pihak Kedua	-
14	PT Bangun Sarana Wreksa	Review Pihak Kedua	-
15	Rajawali Plastik	Review Pihak Kedua	-
16	PT Indonesian Tobacco	Review Pihak Kedua	-

Analisis :

- 1. Pada bulan Oktober, PKS baru dengan instansi lain masih dalam progress
- 2. MOU masih dalam tahap review oleh pihak kedua

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua
- 2. Mengajukan surat permohonan PKS kepada Instansi Perusahaan, BPM, DPM, Klinik kesehatan, yang belum bekerjasama dengan RS Prima Husada Malang

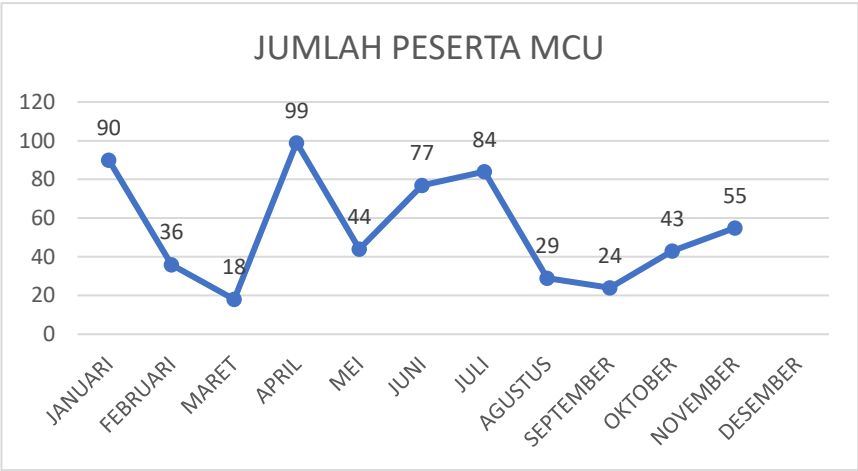
3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Tabel Jumlah Peserta MCU

NO	BULAN	JUMLAH PASIEN	REVIEW
1	Januari	90	Analisis : Berdasarkan data tersebut, jumlah pasien Medical Check Up meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Review hasil kunjungan dengan PDSA Plan 1. Meningkatkan kunjungan ke Perusahaan 2. Mempromosikan program MCU 3. Mereview tarif/biaya pemeriksaan Do 1. Mempromosikan program MCU setiap kali melakukan kunjungan ke instansi Perusahaan
2	Februari	36	
3	Maret	18	
4	April	37 62 Free	
5	Mei	37 7 (PT Indonesian Marine)	
6	Juni	50 8 (PT Magicsoft Technology Indonesia 19 (BBIB)	
7	Juli	46	

		38 (PT Indonesian Marine)	2. Koordinasi dengan bagian keuangan terkait review tarif MCU agar bisa bersaing dengan vendor lain Study 1. Harga MCU mempengaruhi jumlah kunjungan MCU. 2. Perusahaan memilih harga MCU paling murah diantara vendor. 3. Banyak perusahaan memilih MCU yang ditawarkan secara gratis dari klinik rekanan BPJS kesehatan karena hanya sebagai syarat pemenuhan dari Disnaker terkait kesehatan karyawan. Action 1. Pengajuan MCU ke berbagai Perusahaan untuk calon karyawan baru dan ke Institusi Pendidikan untuk calon Mahasiswa baru 2. Review harga pemeriksaan khusus untuk MCU
8	Agustus	29	
9	September	24	
10	Oktober	43	
11	November	25 37 (PT Citra Karya Dinamika) 13 (PT KTG)	

3.5.5.2.2 Grafik Jumlah Peserta MCU



3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Jumlah Kunjungan	6	10	19	4	7	17	16	4	4	1	0

3.5.5.2.3.2 Grafik Jumlah Kunjungan Marketing Eksternal



Analisis :
Penurunan kunjungan berkurang karena focus marketing pada followup dan maintenance mitra melalui jarak jauh.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala.

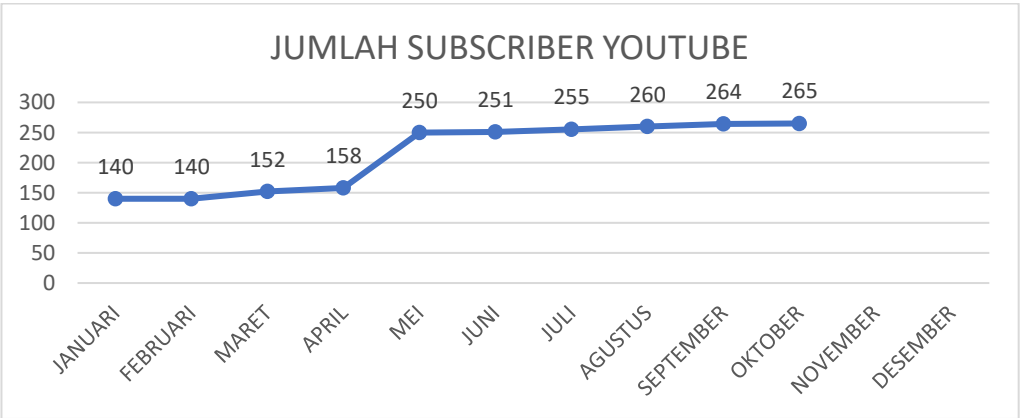
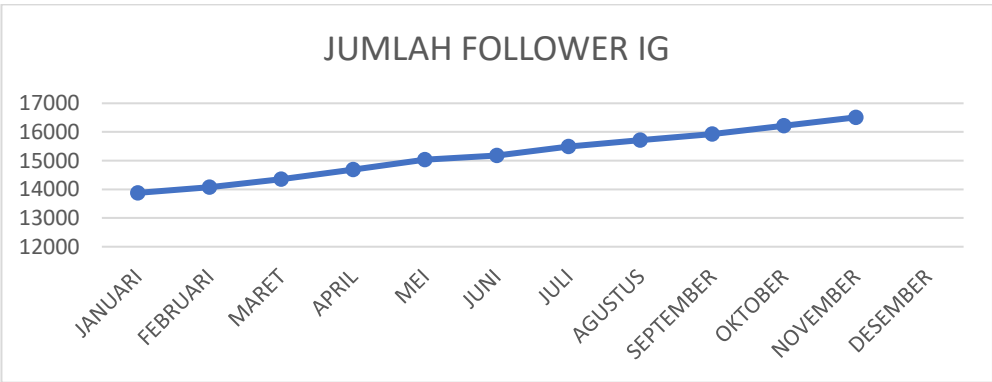
3.5.5.2.4 Digital Marketing

3.5.5.2.4.1 Tabel Follower Media Sosial yang Dikelola RS Prima Husada Malang

BULAN	FOLLOWER			UNFOLLOW		
	INSTAGRAM	OUTUBE	TIKTOK	INSTAGRAM	YOUTUBE	TIKTOK
Januari	13877	140	-	265	0	-
Februari	14076	140	-	22	0	-
Maret	14353	152	-	22	0	-
April	14692	158	-	18	0	-
Mei	15034	250	-	29	0	-
Juni	15181	251	-	31	0	-
Juli	15493	255	-	13	0	-
Agustus	15716	260	-	8	0	-
September	15931	264	65	30	0	-
Oktober	16218	265	121	23	0	0
November	16510	273	143	15	0	0

Analisis :

- Digital marketing untuk mengelola Youtube belum ada masih menjadi satu di PT.
- Follower Instagram meningkat karena tim PKRS aktif melakukan upload dan promosi di media sosial.
- Akun baru Tiktok RSPH membantu dalam digital marketing



3.5.6 Penjaminan

3.5.6.1 Piutang

3.5.6.1.2 Tabel Piutang BPJS Kesehatan (FPK dan Pengajuan Reguler November 2024

REKAPITULASI FPK BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	TARIF FPK/ PENGAJUAN	TGL FPK	TGL BAYAR	REALISASI PEMBAYARAN	SELISIH AUDIT DAN ADM BANK	SALDO PIUTANG FPK
PELAYANAN 2023							
							-
1	OBAT KRONIS SEPT 23	435.837.336	18.01.2024	29.01.2024	435.837.336		-
2	FPK REG UTAMA DES 23	6.189.055.000	18.01.2024	29.01.2024	6.189.055.000		-
5	FPK 'OBAT KRONIS OKT 23	493.809.876	18.02.2024	26.02.2024	493.809.876		-
6	FPK LUPIS NOV 23 AMBULANCE	6.650.000	22.02.2024	28.02.2024	6.650.000		-
7	FPK LUPIS NOV 23 ALKES	6.215.000	22.02.2024	28.02.2024	6.215.000		-
8	FPK LUPIS DES 23 AMBULANCE	7.210.000	22.02.2024	28.02.2024	7.210.000		-
9	FPK LUPIS DES 23 ALKES	6.710.000	22.02.2024	28.02.2024	6.710.000		-
10	FPK OBAT KRONIS NOV 2023	465.212.636	21.03.2024	01.04.2024	465.212.636		-
11	FPK PEND DES 23	607.514.500	06.03.2024	18.03.2024	607.514.500		-
12	FPK OBAT KRONIS DES 2023	469.804.704	25.03.2024	03.04.2024	469.804.704		-
13	FPK OBAT KRONIS Pend Des 23	10.367.860	08.05.2024	20.05.2024	10.367.860		-
PELAYANAN 2024							
1	FPK Januari 2024	7.006.082.092	18.02.2024	28.02.2024	6.967.698.792	38.383.300	-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	6.015.000	20.03.2024	16.04.2024	6.015.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	12.485.000	20.03.2024	16.04.2024	12.485.000		-
	FPK OR Januari 2024	516.543.814	08.05.2024	20.05.2024	516.543.814		-
	FPK Pending Januari 2024	468.390.779	08.05.2024	20.05.2024	468.390.779		-
2	FPK Februari 2024	7.215.241.743	20.03.2024	28.03.2024	7.215.241.743		-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	7.740.000	20.03.2024	16.04.2024	7.740.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	3.795.000	20.03.2024	16.04.2024	3.795.000		-
	FPK OR Februari 2024	498.722.702	08.05.2024	20.05.2024	498.722.702		-
	FPK PEND REGULER FEBRUARI	373.212.100	10.06.2024	19.06.2024	373.212.100		-
	FPK PEND II FEB 2024	58.112.500	09.07.2024	17.07.2024	58.112.500		-
3	FPK Maret 2024	7.372.267.949	26.04.2024	08.05.2024	7.350.598.749	21.669.200	-
	FPK AMBULANCE MARET 24	5.280.000	14.06.2024	10.06.2024	5.280.000		-
	FPK ALKES MARET 24	3.465.000	14.06.2024	10.06.2024	3.465.000		-
	FPK OR MARET 24	471.764.386	15.07.2024	22.07.2024	471.764.386		-
	FPK PEND MARET 2024	383.291.100	09.07.2024	17.07.2024	309.918.000	73.373.100	-
	FPK PEND MARET 2 2024	90.791.600	20.08.2024	29.08.2024	90.791.600		-
4	FPK April 2024	6.926.723.374	20.05.2024	29.05.2024	6.901.742.874	24.980.500	-
	FPK OBAT KRONIS APRIL 2024	477.096.910	26.07.2024	05.08.2024	477.096.910		-
	FPK AMBULANCE APRIL 24	3.270.000	14.06.2024	10.06.2024	3.270.000		-
	FPK ALKES APRIL 24	3.630.000	14.06.2024	10.06.2024	3.630.000		-
	FPK Pending April 2024	289.580.800	07.08.2024	19.08.2024	289.580.800		-
	FPK Pending II April 2024	125.899.300	10.09.2024	18.09.2024	125.899.300		-
	FPK Pending III April 2024	4.353.500	10.10.2024	21.10.2024	4.353.500		-
	FPK Obat Pend April 2024	5.989.571	06.09.2024	17.09.2024	5.989.571		-
5	FPK MEI 2024	7.537.333.400	23.06.2024	01.07.2024	7.493.109.800	44.223.600	-
	FPK OBAT KRONIS MEI 2024	487.109.484	26.07.2024	12.08.2024	487.109.484		-
	FPK Alkes Mei 2024	3.465.000	24.07.2024	07.08.2024	3.465.000		-
	FPK Ambulance Mei 2024	5.145.000	24.07.2024	07.08.2024	5.145.000		-
	FPK Obat Pend Mei 2024	10.593.498	06.09.2024	17.09.2024	10.593.498		-
	FPK PEND MEI 2024	334.480.400	23.09.2024	30.09.2024	296.561.200	37.919.200	-
	FPK PEND II MEI 2024	67.517.700	05.11.2024	13.11.2024	67.517.700		-
6	FPK JUNI 2024	6.959.035.980	24.07.2024	31.07.2024	6.868.943.180	90.092.800	-
	FPK Alkes Juni 2024	8.470.000	24.07.2024	07.08.2024	8.470.000		-
	FPK Ambulance Juni 2024	6.945.000	24.07.2024	07.08.2024	6.945.000		-
	FPK Obat Kronis Juni 2024	468.625.741	15.09.2024	23.09.2024	468.625.741		-
	FPK Pending I Juni 2024	406.675.400	15.11.2024	25.11.2024	406.675.400		-
	FPK Pending Obat Kronis Juni 2024	10.909.672	15.11.2024	25.11.2024	9.479.776	1.429.896	-
7	FPK JULI 2024	7.160.148.298	20.08.2024	29.08.2024	7.122.971.498	37.176.800	-
	FPK Alkes Juli 2024	6.655.000	25.09.2024	09.10.2024	6.655.000		-
	FPK Ambulance Juli 2024	8.085.000	25.09.2024	09.10.2024	8.085.000		-
	FPK Obat Kronis Juli 2024	498.756.047	24.10.2024	04.11.2024	490.002.657	8.753.390	-
8	FPK Reguler Agustus 2024	6.671.460.900	25.09.2024	02.10.2024	6.662.482.200	8.978.700	-
	FPK Alkes Agustus 2024	6.160.000	25.09.2024	09.10.2024	6.160.000		-
	FPK Ambulance Agustus 2024	6.510.000	25.09.2024	09.10.2024	6.510.000		-
9	FPK Reguler RI September 2024	4.225.116.643	22.10.2024	28.10.2024	4.219.384.343	5.732.300	-
	FPK Reguler RJ September 2024	2.700.053.100	31.10.2024	13.11.2024	2.692.209.100	7.844.000	-
10	FPK Reguler Oktober 2024	7.115.971.438	21.11.2024	28.11.2024	7.115.971.438		-
11	Reguler November (Belum FPK)	7.348.141.700					7.348.141.700
	Pengajuan						-
		93.081.495.533			85.332.797.047	400.556.786	7.348.141.700

3.5.6.1.3 Tabel Saldo Pending BPJS Kesehatan

REKAP KLAIM DAN PENDING BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	JENIS	JML KLAIM	FPK	Tidak Layak	JML PEND	% PEND
1	JUNI 24	RJ	11.090	11.090	4	-	0,0%
		RI	1.024	1.004	-	20	2%
2	JULI 24	RJ	12.691	12.682	-	9	0,1%
		RI	995	924	-	71	7%
3	AGT 24	RJ	12.179	12.158	2	21	0%
		RI	951	873	-	78	8%
4	SEPT 24	RJ	11.573	11.447		126	1%
		RI	1.011	922		89	9%
5	OKT 24	RJ	11.710	11.379	3	331	3%
		RI	997	929		68	7%

3.5.6.1.4 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG														
PERIODE 2024														
									Y	Z	AA	AB	AC	
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
		a	b	(a-b-c= d)	e	f	(e-f=g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total
PERIODE NOVEMBER 2024 :														
1	Asuransi	291.035.104	174.705.430	112.587.976	143.560.041	31.246.971	111.444.520	224.032.496	196.103.182	1.976.383	1.423.855	2.476.336	22.052.740	224.032.496
2	Perusahaan	279.079.301	114.552.189	164.527.113	46.047.266	1.056.874	44.990.392	209.517.505	141.964.698	29.935.442	2.063.692	7.200.732	28.352.941	209.517.505
3	Mandiri Inhealth	71.785.821	4.159.306	67.519.865	36.067.773	-	36.067.773	103.587.639	103.215.600	-	-	-	372.039	103.587.639
4	Jasa Raharja	52.563.073	-	52.563.073	54.214.405	-	54.214.405	106.777.477	106.777.477	-	-	-	-	106.777.477
5	BPJS Ketenagakerjaan	1.635.455.335	941.978.430	693.502.961	749.270.303	-	749.270.303	1.442.773.264	1.436.954.137	497.635	513.240	305.957	4.502.294	1.442.773.264

Keterangan :

1. Cut Off Piutang per 30 November 2024 saldo akhir Rp 1.442.773.264
2. Piutang Asuransi dan Perusahaan sudah bersurat :
PT Asuransi BRI Life -> Proses Pengajuan ke bagian finance
PT Karya Bina Sentausa -> Diajukan Pembayaran Tgl 23-12-2024 (PIC Ibu fitri dan pak Edwin)
CV Ngalah Barokah Jaya -> Diajukan Pembayaran Desember (PIC ibu Silvia)
PT Zurich Insurance -> Email Surat dan konfirmasi PIC Pak Harrison
3. Daftar Pembayaran piutang asuransi non BPJS :

Asuransi	205.952.401
Perusahaan	115.609.063
Mandiri Inhealth	4.159.306
Jasa Raharja	-
BPJS Ketenagakerjaan	941.978.430
	1.267.699.200

3.5.6.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
1.	Potensi kunjungan Fragmentasi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Indikasi pasien Rawat inap kasus diagnosa TF	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Pasien Rujuk klaim Rawat Jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

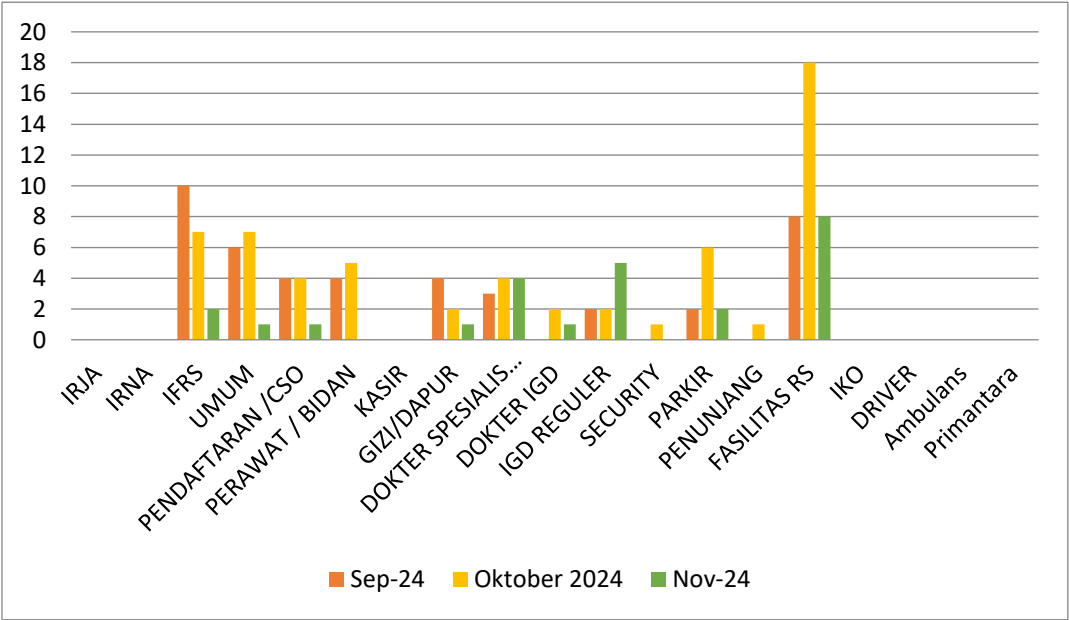
3.5.7 PIPP – MOD – MPP

3.5.7.1 Laporan Komplain Pasien

3.5.7.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan November 2024

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1.	IRJA	0	0	0
2.	IRNA	0	0	0
3.	IFRS	10	7	2
4.	UMUM	6	7	1
5.	PENDAFTARAN /CSO	4	4	1
6.	PERAWAT / BIDAN	4	5	0
7.	KASIR	0	0	0
8.	GIZI/DAPUR	4	2	1
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	3	4	4
10.	DOKTER IGD	0	2	1
11.	IGD REGULER	2	2	5
12.	SECURITY	0	1	0
13.	PARKIR	2	6	2
14.	PENUNJANG	0	1	0
15.	FASILITAS RS	8	18	8
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	0	0	0
Total		43	40	25

3.5.7.1.2 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit November 2024



Analisis :

Jumlah pasien complain selama Bulan November 2024 mengacu pada complain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

1. Jumlah complain Pada bulan November 2024 menurun dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan September 2024 sebanyak 43 kasus complain pada bulan oktober 2024 turun menjadi 40 kasus Sedangkan pada bulan November 2024 turun mejadi 25 kasus
2. Komplain terbanyak pada bulan November 2024 yaitu dari Fasilitas RS sebanyak 8 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
3. Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 5 jenis complain dengan rincian :
 - 1) Fasilitas RS sebanyak 3 kasus yang meliputi :
Kasur tempat melahirkan keras dan sempit, Dikamar mandi sediakan tong sampah dan gantungan baju, kamar pasien kelas 1 TT 1 orang,
 - 2) Parkir sebanyak 2 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir yang meliputi :
Keluar masuk parkir pasien harusnya pembayaran 1 kali saja. Tiap kali keluar harus bayar foto kopi juga sulit, Perluas area parkir.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan November 2024

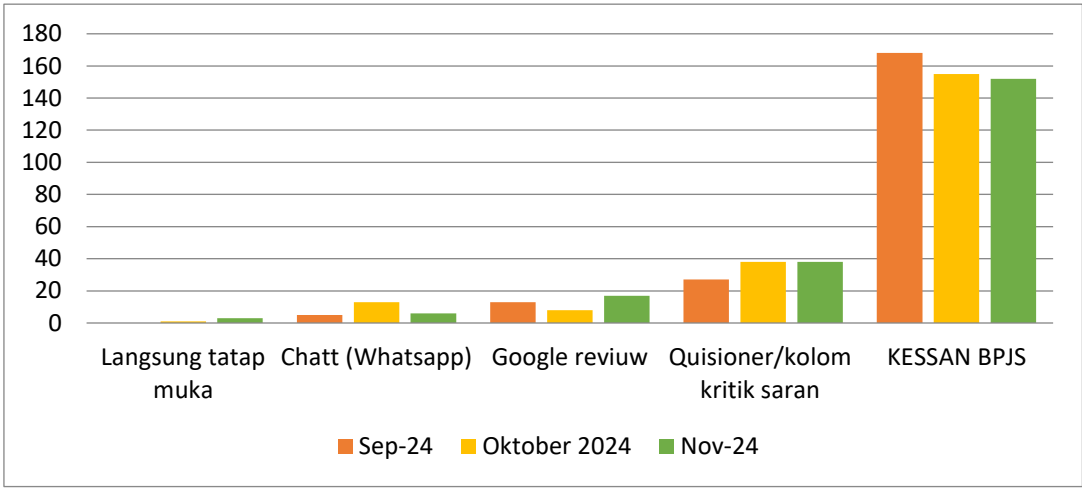
NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1.	Langsung tatap muka	0	1	3
2.	Tidak Langsung :			
	a. Chatt (Whatsapp)	5	13	6
	b. Google review	13	8	8
3.	Quisioner/kolom kritik saran	27	38	17
4.	KESSAN BPJS	168	155	152

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

NO	KETERANGAN	BINTANG 1	BINTANG 2	BINTANG 3	BINTANG 4	BINTANG 5
1.	KESSAN BPJS	0	1	1	28	122

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan November 2024



Analisis :
Pada bulan November 2024 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 17 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari google rewiuw sebanyak 8 kasus, WA sebanyak 6 dan tatap muka sebanyak 3 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :
Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan November 2024

NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	WAKTU TANGGAP		WAKTU PENYELESAIAN		< 3 HR MANAJERIAL RS	7 HR KE PT
		STANDARD < 5 ‘	PENCAPAIAN (DARI WAKTU TOTAL DIBAGI JML KOMPLAI ATAU RATA2 WAKTU TANGGAP)	STANDARD < 60 ‘	PENCAPAIAN		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	0	0	0
					100%		
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	0	0	0
					100%		
3.	Google rewiuw	100%	100%	100%	13	0	0
					100%		
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	12	0	5
					65%		35%
5.	KESSAN	100%	0	100%	155	0	0
					100%		

Analisis :
Waktu tanggap dan penyelesaian complain pasien pada bulan November 2024 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Kuisisioner dengan capaian 65%hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung

diselesaikan seperti fasilitas RS dan parkir yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 5 jenis komplain dengan rincian :

- 1) Fasilitas RS sebanyak 3 kasus yang meliputi :
Kasur tempat melahirkan keras dan sempit, Dikamar mandi sediakan tong sampah dan gantungan baju, kamar pasien kelas 1 TT 1 orang,
- 2) Parkir sebanyak 2 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir yang meliputi :
Keluar masuk parkir pasien harusnya pembayaran 1 kali saja. Tiap kali keluar harus bayar foto kopi juga sulit, Perluas area parkir

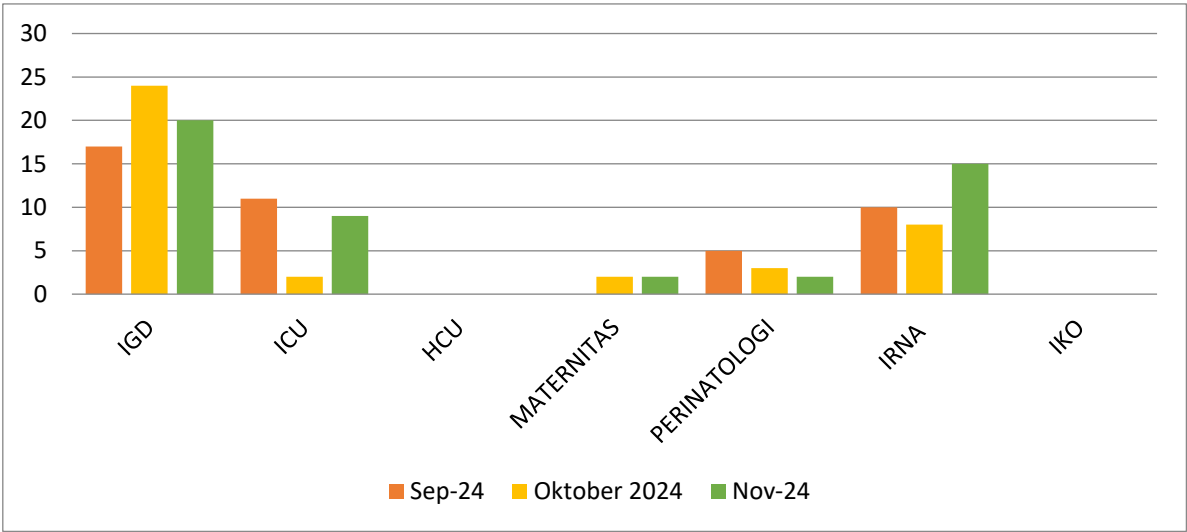
Rencana Tindak Lanjut :

Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan November 2024

NO	UNIT PERUJUK	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1.	IGD	17	24	20
2.	ICU	11	2	9
3.	HCU	0	0	0
4.	MATERNITAS	0	2	2
5.	PERINATOLOGI	5	3	2
6	IRNA	10	8	15
7	IKO	0	0	0
Total		41	43	39

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan November 2024



NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAVON HABIS
1	Ny. Dia Yuni Nur Muflikha	MTS	G2p1Abo uk. 36-37mgg dengan KPD, Fetal distress, tali pusat menumbung	dr. Aida Sp.OG	RSSA	SC Cito karena anestesi tidak tersedia	2	tidak
2	Ny. Minarti	ICU	ACUTE PERITONISITI, POST OP LAPARATOMY	dr. Zaki Sp.B	RSUD Dr. Soetomo Surabaya	Pro Venti	8	Tarif rs : 14.896.860 Plavon : 6.274.500 Minus : 8.622.360
3	Ny. Durotul Hamidah	IGD	Ca mammae dex general weakness dt low intake, AKI dd CKD, Candidiasis oral, leukositosis dt Ca mammae	dr. Zora Sp.PD	RST Dr Soepraoen	Perawatan lanjutan untuk Ca mammae (jika diperlukan mastectomy/ kemoterapi?)	1	Tarif : 1.573.893 Plavon : 1.483.900 Minus : 89.993
4	Muhammad Zainuri	IRNA	Necrotizing fascitis regio pedis sin, ulkus DM, CKD, Sepsis, RBBB	dr. Anton Sp.B raber dr. Ardhanj Sp.PD , K - GH	RSSA	Multicomplicated case	2	tidak
5	Ny. Lasiah	IRNA	CVA Infark, AF, LV Failure, MS Moderater, MR Mild	dr. Farid Sp.,S konsul dr. ira Sp.JP	RS Lavalette	Pro Unit Stroke	4	tidak
6	Ny. Nyami	IRNA	AKI st II-III, chushing syndrome, urate nephrolithiasis, DM type II, paraparase inferior	dr. Ardhi Sp.PD	RSSA	Pro HD	5	tidak
7	Tn. Salamun Bambang	IRNA	Paraplegi inferior susp spondilitis TB dd Tumor Maligna + Susp Septic	dr. Syahrir Sp.S raber dr. Andy Sp.P konsul dr. Eko Sp.KFR	RSSA	Injeksi streptomycin dan tata laksana lebih lanjut	5	Tarif rs : 8.028.821 Plavon : 4.838.400 Minus : 3.190.421
8	An. Ari Raesya Putra	IRNA	Sindrom Nefrotic	dr. Fiona Sp.A	RSSA	Pro Konsultan nefro anak	2	tidak
9	Ny. Sianah	IRNA	Fr Kompresi V lumbal 1	dr. Farid, Sp. S konsul dr. Oka, Sp. OT Konsul dr. Edi, Sp. U	RSSA	Pro MRI	4	tidak
10	Ny. Rifa Kumala	ICU	Susp Urosepsis, hidronephrosis post URS, DJ Stent, AKI dd CKD Efusi Pleura dex/ sin, DM type II	dr. Pradana Sp.U konsul dr. Zora Sp.PD konsul dr. Ira Sp.JP, konsul dr. Elvi Sp.P	RST Dr Soepraoen	Pro Backup HD	5	Tarif rs : 15.967.291 Plavon : 6.894.200 Minus : 9.073.091
11	Tn. Tamrun	IRNA	Ruptur ureter + COPD	dr. Pradana Sp.U	RSSA	Pro Sistografi atau ststostomy	2	tidak
12	Ny. Sunarsih	IGD	CKD, Abd pain dd gerd, leukositosis, general weakness	dr. Heri Sp.PD	RSSA	Pro HD	2	tidak
13	Tn. Achmad Syaichu	IGD	STEMI	dr. Yoga Sp.JP	RS Persada	Pro PCI	1	tidak
14	Tn. Sanaji	IGD	Nausea Vomiting, anemia, CKD. DM Type 2	dr. Ardhi Sp.PD	RS Lavalette	Pro HD	2	tidak
15	by. Ny. Ridianda	NEO	HMD, BBLR, NKB	dr. Dicky, Sp. A	RSSA	apnea periodic	3	tidak
16	Tn Moch Riduwan	IRNA	STEMI INFERIOR RECENT ON SET,	dr. Mira Sp JP	RS UMM	Primary PCI	2	tidak

			HHD, PVC, DRUG INDUCED, TROMBOSITOPENIA DD ITP, CAD POST PCI					
17	Tn Durai	ICU	Hydrosefalus, cos, ich cerebelum, HT	dr. Fachri Sp BS	RSSA	Pro Evakuasi ICH	4	tidak
18	Ny. Eni Susanti	IRNA	Cholelithiasis, Abdominal pain, Susp. Ileus	dr. Ardhi Sp. PD konsul dr. Anton Sp. B	RS Lavallete	Rujuk bedah digestif pro tindakan operasi	4	tidak
19	DIDIK ISMANTO	IGD	CA Paru	dr Elvi, Sp.P	RS Karsa Husada	Rujuk pro tatalaksana CA	2	tidak
20	MARETA SAFITRIANA	MTS	G2 P1001 AB0 UK 20-22 MGG DG VOMITING+DF	dr. Aida Sp.OG konsul dr.Ardhi Sp.PD	RSSA	perawatan intensif	3	tidak
21	Susianah	IGD	DOC Geriatric syndrome ec CVA infark 2nd attack	dr. Ardhanay sp.pd konsul dr. Farid sp. S	RSJ Lawang	Rujuk pro penatalaksanaan geriatric problem dengan TS Sp.PD-KGer	1	tidak
22	Tn. Sugini	IRNA	CVA Infark	dr. Farid sp. S	Karsa Husada Batu	Rujuk pro Stroke Unite	4	tidak
23	Tn. Muhammad Aziz Ghofur	IRNA	KAD	dr. Heri sp.pd	RSSA	Rujuk pro endoscopy	4	tidak
24	Tn. WARIMAN	IGD	CVA ICH 49 cc, HT	dr. Farid, Sp. S	RSUD Bangil	Rujuk pro evakuasi hematome	2	tidak
25	Ny. Titin sumarlin	ICU	CKD stg 5	dr. Ardhanay, Sp.PD, KGH	RSUB	Pro HD	3	tidak
26	Sdr. Michael Theodorus	IGD	CKR 435 dd SDH Frontal Sinistra	dr. Anton, sp.B	RS Premier Surabaya	Rujuk pro Bedah saraf (APS)	2	tidak
27	Ny. Aseh	ICU	CVA ICH 23 cc	dr. Farid, Sp. S	RST Dr Soepraoen	PRO evakuasi hematome	4	tidak
28	Ny. OEMI PALOEPI	IGD	Fr. Inter Trochanter + Osteoporosis.s	dr. Kuntadi, Sp. OT	RSSA	PRO TINDAKAN LEBIH LANJUT (TERKAIT ALAT)	2	tidak
29	Tn. Ngatemin	ICU	Post DOC, DM Hiperglikemia, COPD AE, AKI, HT	dr. Andy Sp.P k/ dr. Heri Sp.PD k/ dr. Farid Sp.S k/ dr. Yoga Sp.JP	RS Lavalette	Pro tindakan lebih lanjut (terkait alat)	2	tidak
30	Tn. Moch Abdul Jalal	ICU	CVA Emboli dd trombosis luas OH 2, STEMI anterior , Hiperglikemia dt DM type 2, AKI, Leukositosis, Hiponatremia	dr. Fahimma Sp.S k/ dr. Mira Sp.JP k/ dr. Ardhani Sp.PD	RSUD Dr. Iskak Tulungagung	Pro PCI	2	tidak
31	Ny. Sumiati	IRNA	CVA Infark, Hemiparase sin	dr. Farid Sp.S konsul dr. Eko Sp.KFR	RS Lavalette	Pro Unit Stroke	4	tidak
32	Ny. Ida Rusiyani	IGD	CA Ovarii susp megh syndrome, Acites	dr. Aida Sp.OG konsul dr.Ardhi Sp.PD	RSSA	Pro Penanganan lebih lanjut	2	tidak
33	NY Sumiati	IGD	Acute on CKD	dr Ardhi, Sp.PD	RSUD Lawang	PRO HD	1	tidak
34	NY Mutmainah	IGD	Chest pain dt stemi anterior recent onset dg bradikardia	dr. Yoga, Sp. JP	RS UMM	Pro PCI	1	tidak
35	Sdr. Gigih	IGD	CF Patella Nondisplaced + Joint	dr. Oka, Sp. OT	RS Ubaya	APS	1	tidak

			Effusion					
36	Tn. SOEASMONO	IGD	ADHF	dr Yoga, Sp.JP	RS Lavaletter	Pro PCI	2	tidak
37	Tn. ADITYA REZA RENANDO	IGD	SUSP SJS DD ERITEMA MULTIFORME	dr. Vita, Sp. KK	RSSA	Ruang isolasi kulit	2	tidak
38	Ny. siti khoiriyah	ICU	status epileptikus, Susp CVA Infark 3rd attack, HT	dr. Dewi, Sp. S	RSSA	pro stroke unit	2	tidak
39	sdr. IMAM ABDUL HALIM MAHMUD	IGD	COR 456 + Multiple Vulnus Laceratum Parietalis Sinistra, Fingertip Injury, Multiple Vulnus Excoriatum	dr. Fachri Sp BS	RSUD Bangil	Pro joint op	1	tidak
40	M. RIVANDA DWIPA NUGRAHA	IGD	OF H7 SUSP TF dd DF, B24	dr. Ardhi, Sp. PD	RS Lavalette	Pro pengobatan ARV	2	tidak
41	Ny. MARSİYAH	IRNA	Acites dengan Riwayat post op laparatomy, Sirosis Hepar	dr. Zaki, Sp. B	RSSA	Pro Tatalaksaana lanjutan dan post op dari sana	3	tidak
42	By. Ny. Anggreani Puspita Rosalinda	NEO	RDS DD HMD, Premature, BBLR	dr. Fiona Sp.A	RS Lavalette	pro surfaktan dan perawatan lebih lanjut	2	tidak
43	SDR. RISIKI BAYU ANSHORI	IGD	susp appendicits akut, atelektasis paru D	dr. Anton, Sp. B	RSSA	Perawatan lebih lanjut	2	tidak
44	Ny. Maisaroh	IGD	Doc ec susp cva infark dd hemoragic	dr. Farid Sp. N	RSSA	Pro stroke unit	2	tidak
45	TN. RIFAI	IGD	CVA ICH PONS, HT EMERGENCY	dr. Dewi Sp. S	RS Lavalette	Pro stroke unit	2	tidak
46	TN. KUSENAN	ICU	ADHF, AF RVR	dr. Mira Sp. Jp	RS Lavalette	PRO CVCU	2	tidak
47	TN. SUKEMI	IRNA	NSTEMI, ADHF, CAD POST PCI	dr. Mira Sp. Jp	RSSA	PRO PCI	5	tidak
48	TN. SUJAI	IRNA	BPH POST TURP	dr. Pradana Sp. Uro	RSSA	Pro Evakuasi Clot	5	tidak

Analisis :

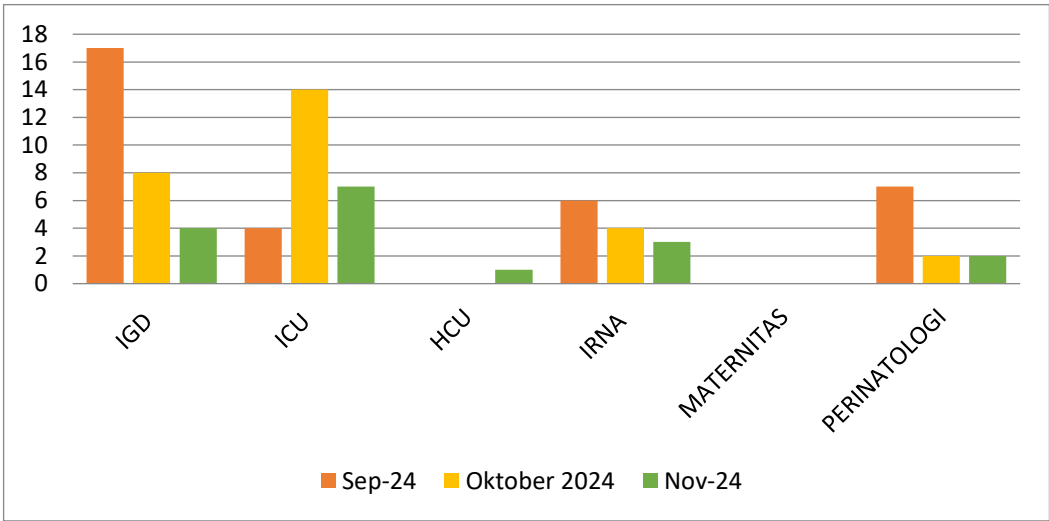
- Terjadi penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan Novembr 2024, pada bulan agustus 2024 sebanyak 43 pasien pada bulan agustus sebanyak 39 pasien Sedangkan pada bulan oktober 2024 sebanyak 48 pasien
- Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Pro ventilator dan perawatan lama = 1
 - Pro PCI = 6
 - Pro CVCU = 1
 - Pro stroke unit = 5
 - Pro HD = 6
 - Pro Bedah digestif = 1
 - MRI
 - Pro bedah saraf lanjutan
 - Membutuhkan alat khusus
 - Membutuhkan pengobatan ARV
- Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya bulan Oktober 2024 terdapat 2 pasien dengan jumlah total minus : Rp. 5.031.012 Sedangkan pada bulan Novemver sebanyak 4 pasien dengan jumlah total minus : Rp.12.263.512

Rencana Tindak Lanjut:

- Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan November 2024

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1.	IGD	17	8	4
2.	ICU	4	14	7
3	HCU	0	0	1
4.	IRNA	6	4	3
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	PERINATOLOGI	7	2	2
Total		31	34	28



NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP
1	Ny. Mahmudah	ICU	CVA ICH	dr. Fahimma Sp.N
2	By. Ny. Firda	NEO	BBLASR	dr. Andira
3	By. Ny. Rizqi Maulana Noor	NEO	Imatur BBLASR	dr. Ratih Sp.A
4	Tn. Ramli	ICU	Pneumonia, spetic condition, TB on Therapy, Respiratory Failure	dr. Andy Sp.P raber dr. Robby Sp.An
5	Tn. Sugianto	HCU	COPD, Anemia	dr. Andy Sp.P konsul dr. Mira Sp. JP konsul dr. Heri Sp. PD
6	Ny. MAIMUNAH	ICU	Shock septic	dr. zora sp PD
7	Tn. SUHARTO	ICU	DOC	dr. Syahrir Sp.S Raber dr. Ardhi sp PD konsul dr. Robby Sp.An
8	Tn Durai	ICU	Hidrocephalus	dr Fachri, Sp.BS
9	Tn. CHAMIM	IRNA	Susp. TB Relaps, DM type 2, Hiperkalemia, CKD, Decomp	dr. Elvi Sp. P Konsul dr Ardhany Sp. PD Konsul dr Ira Sp. Jp
10	Tn KITONO	IRNA	PNEUMONIA, Odinofagia ec faringitis akut, 3. Parotitis epidemika	dr. Ardhany, Sp. PD. KGH
11	Tn. Matari	IGD	Hipoglikemia, CKD, Selulitis	dr. Ardhi, Sp. PD
12	Tn. Agus Sugiatno	IRNA	DM Hiperglikemia, Pneumoni	dr. Heri, Sp. PD konsul

				dr. Andi, Sp. P
13	Ny. Mudah	ICU	Syok Condition, Septic Shock	dr. Heri, Sp. PD Raber dr. Elvi, Sp. P
14	Ny. Umi Kulsum	IGD	DOC e.c Susp CVA 2nd Attack	dr. farid, Sp. N
15	Tn Muhari	ICU	ARDS, COPD, HT, azotemia	dr. Andy, Sp. P
16	An. REIHAN TRI RINALDI	IGD	DSS	dr. Andira
17	Ny. NURYATIN	IGD	1. DOC e.c Syok condition dd syok cardiogenic	dr.Hery SP.PD

Analisa :

- Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan November 2024 sebanyak 17 pasien
- Jumlah terbanyak yaitu dari ICU : 7 pasien, IGD sejumlah 4 pasien, IRNA 3 pasien, dan Neonatologi sebanyak 2 pasien.
- Pada bulan November 2024 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 0 kasus.
- Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

1.5.7.1 Laporan MPP

1.5.7.1.1 Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
1	Usia lanjut	370	317	237
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastropik	723	560	454
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	0	0	0
4	Perkiraan biaya tinggi	132	77	68
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	40	17	3
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	0	0	0
7	Potensial komplain tinggi	58	9	10
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	756	719	569
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya	105	60	49
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	1011	834	633
11	Berpotensi masalah hukum	0	0	0
12	Naik kelas pelayanan	40	36	24
13	Lain - lain	79	74	59

1.5.7.1.2 Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN LAIN-LAIN (PERMASALAHAN CARA BAYAR)	BULAN / JUMLAH		
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
1	Habis PKS	11	12	9
2	BPJS status Denda	30	7	23
3	BPJS status Premi	7	6	7
4	BPJS status Denda dan Premi	12	32	6
5	BPJS staus Usia lebih dari 21 tahun	0	4	0
6	BPJS status keluar atas kemauan sendiri	4	3	0
7	BPJS status penangguhan pembayaran	0	1	2
8	Rencana pengurusan BPJS	3	0	0
9	BPJS status tidak ditanggung	3	5	7
10	BPJS tidak aktif akhir bulan	6	4	5
11	BPJS peralihan Mandiri ke PBI	3	-	-

1.5.7.1.3 Kelengkapan pengisian Form A-B dan Dischard Planning Bulan November 2024

NO	NAMA PETUGAS	FORM MPP	DISCARD PLANING
		JUMLAH	JUMLAH
1	Wiwit Indah Yanti, S. Kep, Ns	637	283

3.5.8 Cleaning Service

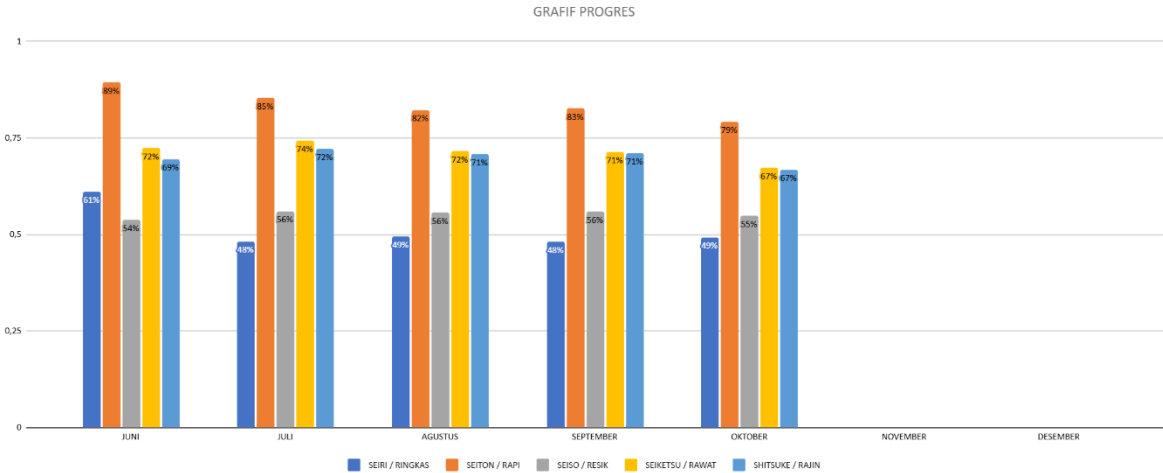
3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

SEIRI / RINGKAS	DESKRIPSI
Penempatan Alat Kebersihan di Janitor	Alat kebersihan ditempatkan dan ditata dengan rapi di Janitor. Namun bagi ruangan yang tidak memiliki Janitor, peralatan kenbersihan ditempatkan ppada suatu tempat tertentu dalam kondisi bersih dan rapi
Penempatan alat kebersihan di Trolley	Alat kebersihan ditempatkan dan ditata dengan rapi di Trolley. Namun bagi ruangan yang tidak memiliki Trolley, peralatan kebersihan ditempatkan pada suatu tempat tertentu dalam kondisi bersih dan rapi
Kondisi bak pembersih / kereta peras	Kondisi bahan pembersih yang ada di bak pembersih / ketreta peras tidak kotor. Maksimal 2x penggantian. Jika sebelum 2x sudah kotor amaka harus diganti. Pel harus dalam kondisi bersih
SEITON / RAPI	
Kerapian baju petugas CS	CS menggunakan baju sesuai seragam dengan rapi dan bersih
Penggunaan ID card	CS Menggunakan id card sesuai aturan
Penanganan sampah Medis dan Non Medis	
Penempatan sampah medis dan nonmedis	tempat sampah diberi kantong plastik sesuai warna dan fungsinya. Sampah medis dan nonmedis tidak boleh tercampur.
Penempatan plastik	Tempat sampah dilapisi kantong plastik sesuai jenis limbah, tidak penuh, tidak kotor, tidak ada sampah berceceran
SEISO / RESIK	
Lantai	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, tidak bau, nat lantai bersih, dan sudut lantai harus bebas noda.
Langit – Langit / Plafon	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Kaca Luar – Dalam	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, bebas noda, dan mengkilap.
Jendela / Tralis	Jendela / tralis bersih, tidak berdebu, dan tidak bernoda.
Tirai (vertical blind, gordyn)	Bersih, tidak berdebu, tidak kotor, dan rapi.
Lampu	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Saklar & stopkontak	Tidak berdebu, tidak bernoda, dan tidak basah.
Sarana pemadam kebakaran	Bersih, tidak berdebu, tidak kotor, dan tidak digunakan untuk menyimpan barang.
Objek Berbahan Stainless	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, tidak berminyak, dan tidak ada lawa – lawa.
Dinding	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.

Wastafel dan eye wash	Pembuangan mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada bercak air disekelilingnya, tidak bau, kering, kaca cermin bersih, bening, tidak berdebu, tidak bernoda, kran tidak berkarat, tidak basah, dan tidak kusam.
Kamar Mandi	Kebersihan dan bau
Ruangan	Tidak bau amis, pesing, dan anyir.
Plafon/langit-langit	Bebas dari kotor, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Kasa nyamuk	Bersih, tidak bernoda, tidak ada lawa – lawa, dan tidak berdebu.
Dinding Keramik	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, dan nat dinding bersih.
Closed	Mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada percakan air disekelilingnya, dan tidak bau.
Kran	Tidak berkarat, tidak basah, dan tidak kusam.
Pintu	Bersih, tidak ada noda, dan mengkilap.
Urinoir	Bersih, tidak ada noda, tidak bau, dan tidak berkarat.
Bak Mandi	Tidak menguning karena lumut, tidak kotor, dan tidak ada jentik.
Ember dan Gayung	Bersih dan tidak berlumut.
Lantai	Bersih, tidak ada debu, tidak ada sampah, tidak bau, dan sudut lantai harus bebas noda.
Keset	Tidak berdebu, tidak basah, tidak bau, dan tidak ada sampah.
Tempat Sampah	Dilapisi kantong plastik sesuai jenis limbah, tidak penuh (terisi kurang dari 2/3 bagian), tidak kotor, dan tidak ada sampah berceceran
Tangga	Bersih dan bebas sawang
Railing	Tidak berdebu, tidak ada noda, dan bila diusap tidak membekas.
Lantai (anak tangga & Bordes)	Tidak berdebu, tidak ada sampah, tidak basah, dan tidak bau.
Dinding	Tidak berdebu, tidak ada noda, dan tidak ada bercak.
Plafon	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Lift	Lantai dan dinding tidak berdebu, tidak bernoda, mengkilat, harum, dan sudut lantai harus bebas noda.
Dek Level	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa / sampah / daun kering.
Pagar	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Spoel hock/Dapur	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Pembersihan Tempat Sampah / Trolly	Pembersihan tempat sampah / trolly dilakukan secara rutin, kondisi tidak berdebu, dan ada jadwal pembersihannya juga.
SEIKETSU / RAWAT	
Poles lantai di ruangan	Sudah dilakukan dan/atau dijadwalkan poles lantai, baik basah dan atau kering maksimal 1x/bulan
Pemakaian APD	APD masker, sepatu, sarung tangan
Penandaan alat kebersihan	Hijau strip 1 (-) : kantor, Hijau strip 2 (=) : dapur, Biru (selasar), kuning (r. perawatan/pelayanan, merah : kamar mandi
Kebersihan Diri Petugas	Pakaian bersih, Badan bersih, Tidak berbau tidak sedap
SHITSUKE / RAJIN	
Kompetensi CS Memperagakan Cuci tangan dengan benar	Dapat mempraktekan lengkap sesuai SOP cuci tangan

Kompetensi CS dalam menanggapi response keluhan	Segera di TL dan dilaporkan dalam grup
Kompetensi CS dalam mengikuti arahan kordinator	Segera di TL dan dilaporkan dalam grup

JENIS	TARGET	CAPAIAJUNJUN	CAPAIAJULI	CAPAIAJAGUSTUS	CAPAIAJSEPTEMBER	CAPAIAJOKTOBER	CAPAIAJNOVEMBER
SEIRI / RINGKAS	30	61%	48%	49,38%	48%	49,3%	46%
SEITON / RAPI	40	89%	85%	82,21%	83%	79,2%	84%
SEISO / RESIK	330	54%	56%	55,67%	56%	54,8%	58%
SEIKETSU / RAWAT	40	72%	74%	71,51%	71%	67,2%	71%
SHITSUKE / RAJIN	60	69%	72%	70,74%	71%	66,9%	72%



Analisis :
 Produktifitas Unit CS dalam penilaian ini masih fluktuatif namun tidak signifikan.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

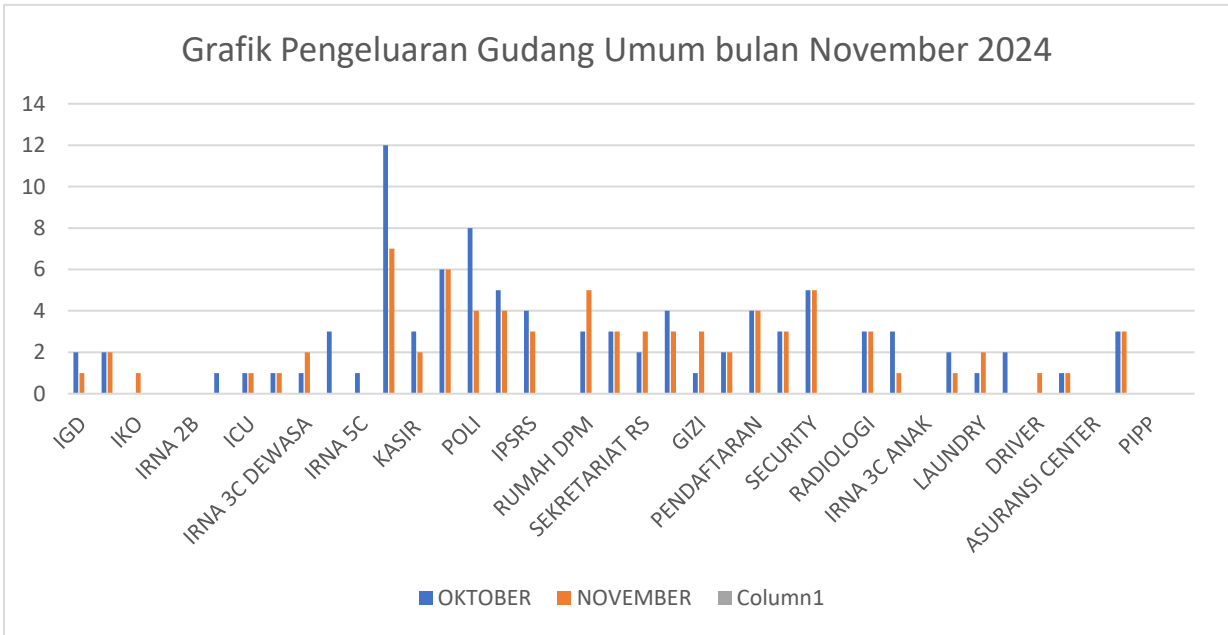
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		OKTOBER	NOVEMBER	
1	IGD	2	1	↓-100%
2	MATERNITAS	2	2	↓0%
3	IKO	0	1	↑0%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	1	0	↓0%
7	ICU	1	1	↓0%
8	IRNA 3A	1	1	↑0%
9	IRNA 3C DEWASA	1	2	↑5%

10	IRNA 4C+4A	3	0	↓0%
11	IRNA 5C	1	0	↓0%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	12	7	↓-71,42%
13	KASIR	3	2	↓-50%
14	DAPUR	6	6	↓ 0%
15	POLI	8	4	↓-100%
16	CLEANING SERVICE	5	4	↓-25%
17	IPSR	4	3	↓-33,33%
18	GUDANG FARMASI	3	5	↑40%
19	RUMAH DPM	3	3	↑0%
20	SEKRETARIAT PT	2	3	↑33,33%
21	SEKRETARIAT RS	4	3	↑-33,33%
22	CSSD	1	3	↑0%
23	GIZI	2	2	↑0%
24	REKAM MEDIS	4	4	↑0%
25	PENDAFTARAN	3	3	↓0%
26	DEPO FARMASI	5	5	↓0%
27	SECURITY	0	0	↓0%
28	LABORATORIUM	3	3	↓0%
29	RADIOLOGI	3	1	↓-100%
30	FISIOTERAPI	0	0	↓0%
31	IRNA 3C ANAK	2	1	↓-50%
32	NS NICU	1	2	↑50%
33	LAUNDRY	2	0	↑-100%
34	LANTAI 6A,7A,8A	0	1	↑100%
35	DRIVER	1	1	↓0%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	3	3	↓0%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang



Analisis :
Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara Sehat dan dapur,poli

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
 - 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
 - 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.6 Komite dan Tim

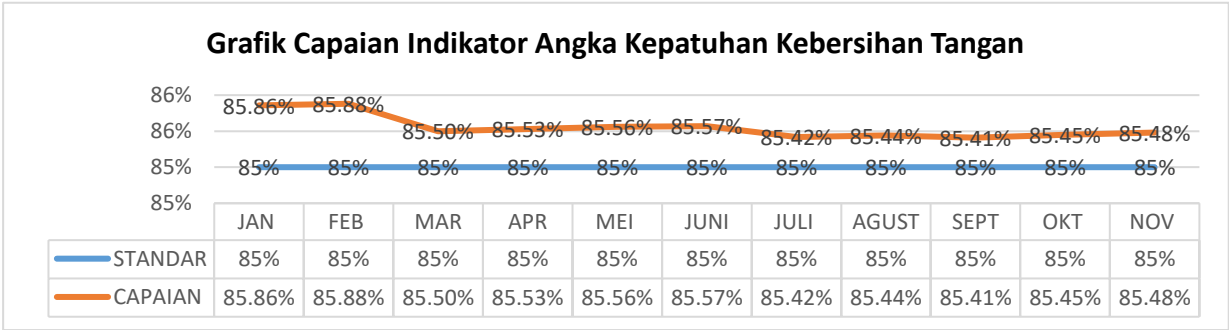
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

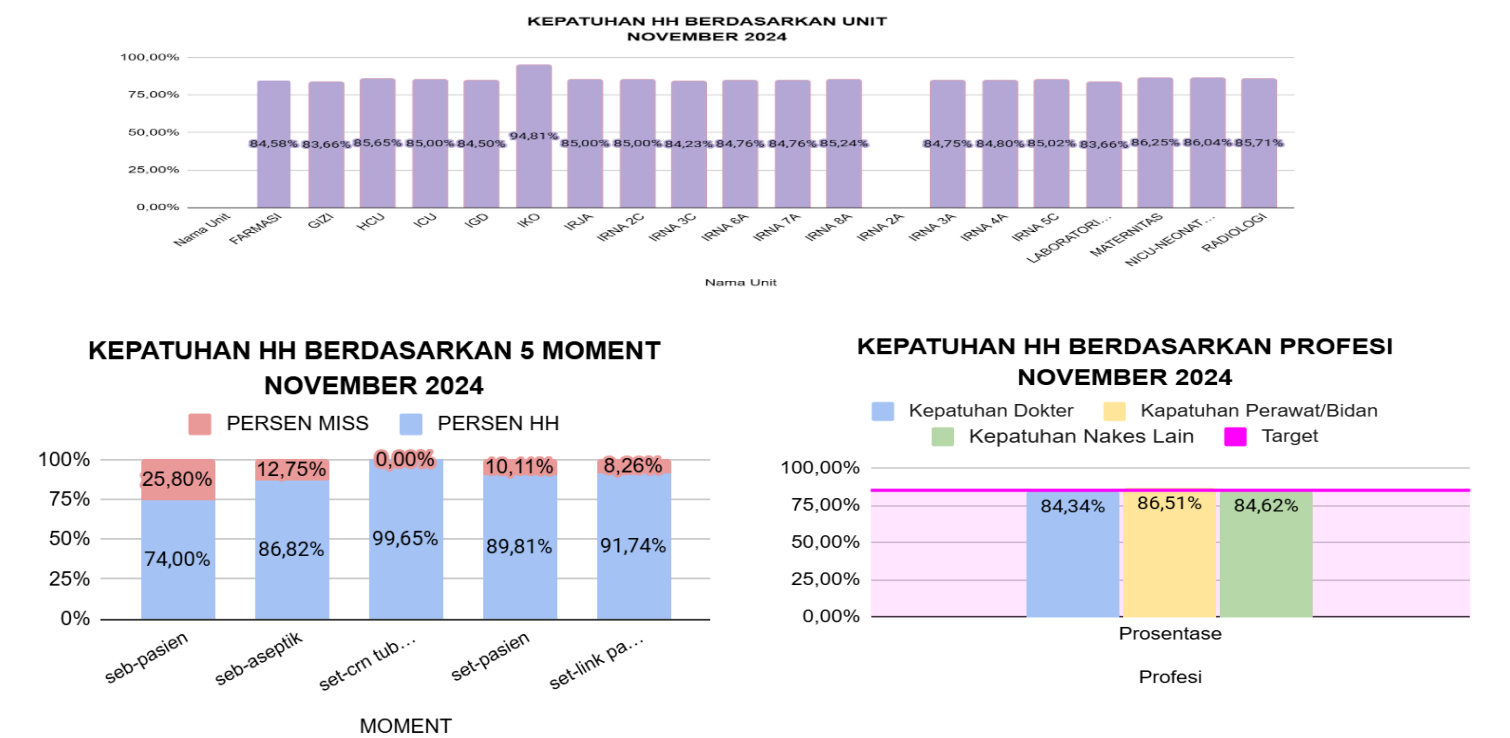
NO	JUDUL	STAND	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agust '24	Sep '24	Okt '24	Nov '24
INDIKATOR MUTU NASIONAL													
1	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,8 6%	85,88 %	85,5 %	85,53 %	85,56 %	85,57 %	85,42%	85,44%	85,41%	85,45%	85,48%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,0 4%	93,15 %	93,3 %	93,52 %	93,73 %	93,8%	93,92%	93,24%	92,15%	92,21%	92,77%
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,9 %	81,2 %	98,78 %	100%	99,99 %	99,95 %	99,93%	99,96%	99,99%	99,98%	99,99%
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	95,2 %	91,7 %	95,74 %	52,7 %	63,8 %	72,8%	80,97%	85,74%	88,65%	82,77%	74,14%
6	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	76,1 9%	79,08 %	79,28 %	78,06 %	76,32 %	78,47 %	78,3%	79,04%	77,89%	74,83%	79,77%
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	98,6 9%	98,8 %	98,46 %	97,5 %	98,9 %	99,69 %	100%	100%	100%	97,91%	98,22%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	63,8 %	71,62 %	67,56 %	66,7 %	100%	92,5%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	98,4 7%	97,47 %	99,54 %	99,67 %	95,86 %	96,51 %	98,64%	98,72%	95,94%	95,92%	99,68%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100 %	93,15 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	100 %	91,89 %	99,63 %	99,82 %	99,63 %	100%	100%	99,38%	99,81%	99,7%	99,91%

3.6.1.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

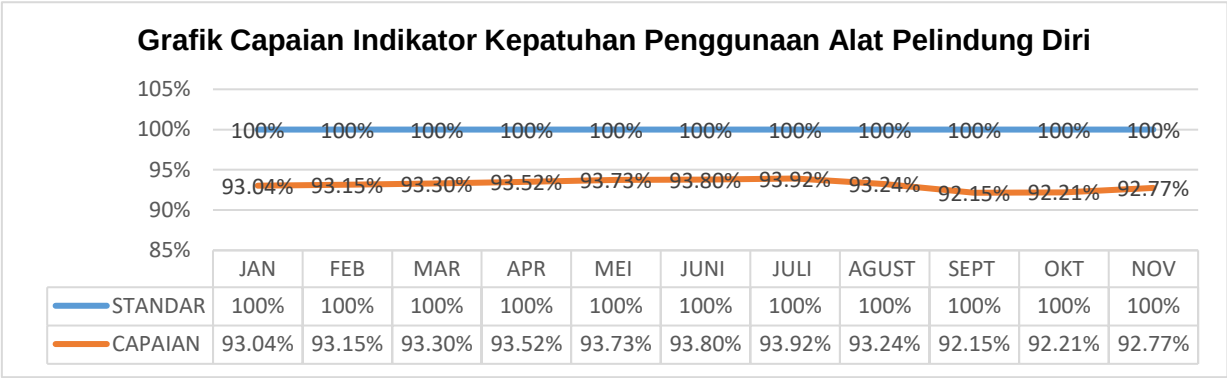


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	1. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan.\ 2. Memberikan proses pembelajaran dengan membuat video pendek edukasi cuci tangan supaya lebih mudah untuk mengingat. 3. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 4. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,48%. Jika dilihat berdasarkan profesi, masih ditemukan prosentase di bawah standart yaitu pada profesi dokter (84,34%) dan nakes lain (84,62%) dimana berdasarkan 5 moment cuci tangan, kebanyakan dari petugas tidak melakukan moment sebelum kontak dengan pasien (74%). Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena persepsi yang salah dan kurangnya kesadaran petugas terkait pentingnya kebersihan tangan seperti pada profesi dokter yang lebih memilih untuk memakai sarung tangan (handscoon) namun juga melakukan cuci tangan dengan handrub yang tidak efektif jika masih memakai handscoon.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan



3.6.1.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

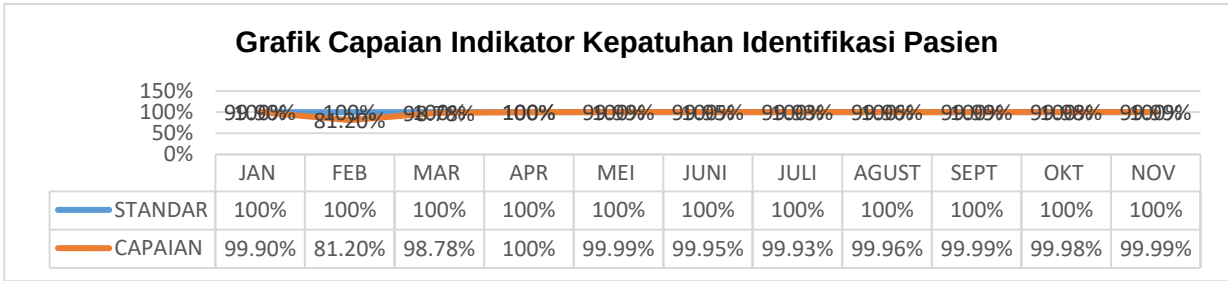
3.6.1.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dOkter. 6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 92,77% meningkat dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, ketidakpatuhan paling banyak masih pada petugas penunjang pelayanan seperti pengolah makanan yang jarang menggunakan masker dengan benar, namun dari pihak penyaji makanan sudah mulai tertib memakai APD dengan benar. Dari petugas perawatan pasien, masih ditemukan perawat yang akan melakukan rawat luka tidak menggunakan handscoon steril (hanya handscoon bersih yang disemprot alcohol). Selain itu, ketidakpatuhan masih ada pada beberapa DPJP yang egois memakai APD untuk keselamatan sendiri tidak memperhatikan keselamatan pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya.	1. Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. 2. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 3. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 4. Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 5. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 6. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

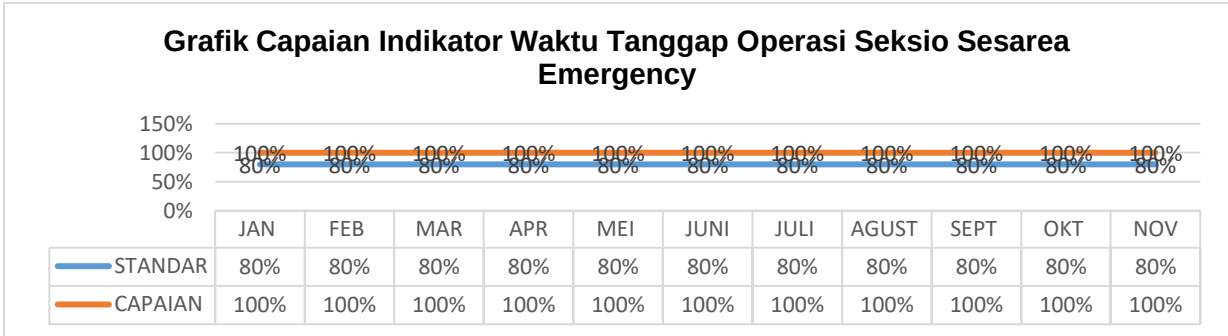
3.6.1.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei hingga November capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar, perawat dan petugas farmasi yang salah memberikan obat, petugas primantara yang salah dalam pengantaran obat serta kesalahan pemberian obat karena dOkter IGD mengganti resep dan tidak melakukan konfirmasi pada farmasi. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

3.6.1.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

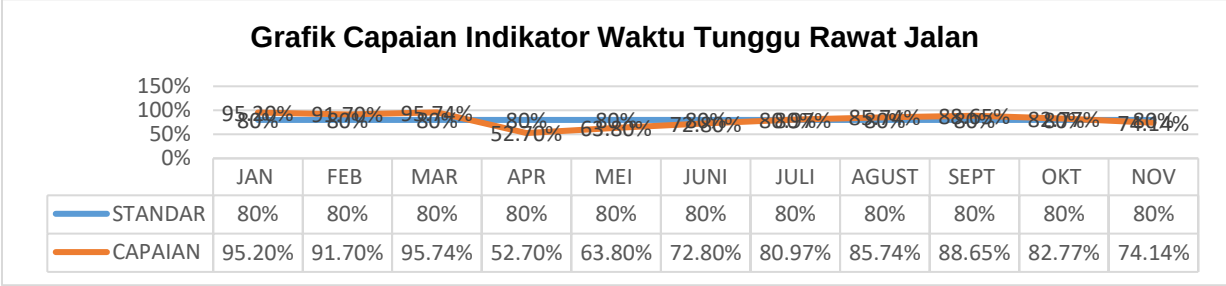


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase waktu tanggap operasi seksio sesarea emergency pada bulan Januari hingga November tahun 2024 juga capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea Emergency telah mencapai standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan Desember.

3.6.1.1.1 Waktu Tunggu Rawat Jalan

3.6.1.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator waktu rawat jalan hingga mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang sering datang terlambat.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga November tahun 2024 belum mencapai standart, hasil tersebut sesuai dengan hasil supervisi dan juga keluhan terkait keterlambatan dokter untuk praktek poli. Berdasarkan hal tersebut, mutu melakukan penilaian dengan observasi langsung dan juga mengevaluasi keterlambatan DPJP.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA
Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	Waktu tunggu rawat jalan <80%	Mengevaluasi dpjp yang sering terlambat dan juga memberikan teguran melalui komdik dan kabit pelayanan		Manajemen RS
					WAKTU
					7. Satu bulan

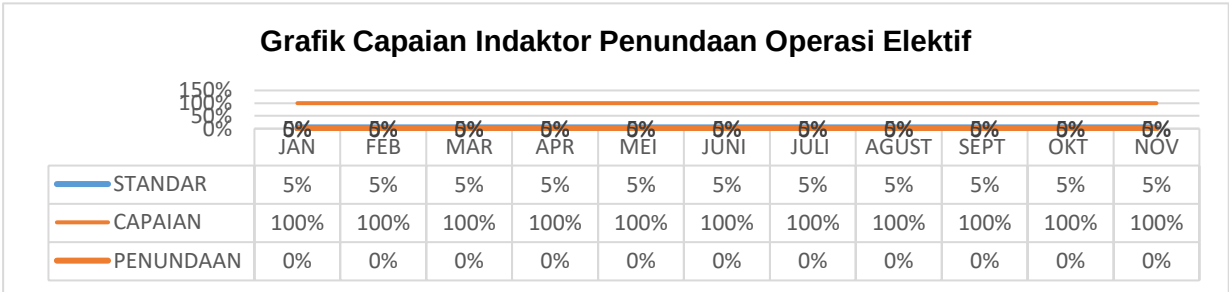
Rekap Data Dokter Terlambat November 2024

NO	NAMA DPJP	JUMLAH JAM PRAKTEK SESUAI JADWAL	JUMLAH KEHADIRAN	JUMLAH IJIN TIDAK PRAKTEK /TIDAK HADIR	PRESENTASI KEHADIRAN	TERLAMBAT	TIDAK TERLAMBAT	% TERLAMBAT
1	dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP	20	20	0	0,00%	19	1	95,00%
2	dr. Rossy Zaki,Sp B	15	15	0	0,00%	14	1	93,33%
3	dr. Miryanti, Sp.JP	25	25	0	0,00%	23	2	92,00%
4	dr Titok Hariyanto, Sp.,M	29	29	0	0,00%	25	4	86,21%
5	dr. Ratih Kusumawardhani, SpA,M.Biomed	12	11	1	8,33%	9	2	81,82%
6	dr. Nurhadi Sp.M	50	48	2	4,00%	38	10	79,17%
7	dr Iwan, SpB	13	13	0	0,00%	7	6	53,85%
8	dr. Andy, Sp. P	20	19	1	3,45%	10	9	52,63%
9	dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp. N	29	29	0	0,00%	13	16	44,83%
10	drg. ega lucida Sp.Perio	13	10	3	23,08%	4	6	40,00%
11	dr. Fahimma, Sp. N	8	8	0	0,00%	3	5	37,50%
12	drg. Bhakti Sp.Ortho	17	16	1	5,88%	5	11	31,25%
13	dr. Meyrna, Sp.THBKL	13	11	2	15,38%	3	8	27,27%

14	dr. Fachriy Balaffif, SpBS	8	5	3	37,50%	1	4	20,00%
15	dr. Huda Sp.KJ	26	25	1	3,85%	13	13	52,00%
16	dr. Zoraida Dwi W, Sp. PD	29	25	4	30,77%	4	21	16,00%
17	Dr. dr. M Kuntadi .Sp.,OT, MMR	13	13	0	0,00%	2	11	15,38%
18	dr. Dwi Nurwulan Sp.KK	29	22	7	24,14%	3	19	13,64%
19	dr. Nimim, SpTHTBKL	37	25	12	32,43%	3	22	12,00%
20	dr I Gede Made Oka Rahaditya SpOT	13	12	1	7,69%	1	11	8,33%
21	dr. Edi Wibowo, SpU	12	12	0	0,00%	1	11	8,33%
22	dr Pradana Nurhadi Sp.U	13	13	0	0,00%	1	12	7,69%
23	dr Heriyatmo SpPD	25	25	0	0,00%	1	24	4,00%
24	dr Humaira Rahma, SpOG	36	36	0	0,00%	1	35	2,78%
25	dr. Eko N, Sp. KFR	50	46	4	8,00%	1	45	2,17%
26	dr Arianto Prabowo SpOT	8	6	2	25,00%	0	6	0,00%
27	dr Rudi, SpOG	5	0	5	100,00%	0	0	0,00%
28	dr Aida Musyarofah SpOG	20	20	0	0,00%	0	20	0,00%
29	dr Sigit Wahyu Jatmiko, Sp BP-RE.MM	4	4	0	0,00%	0	4	0,00%
30	dr. Catur Elvi, Sp.P	8	8	0	0,00%	0	8	0,00%
31	dr. Dewi Maharani, Sp. S	20	19	1	5,00%	0	0	0,00%
32	dr. Ardhi Bustami. Sp.PD	23	22	1	4,35%	0	22	0,00%
33	dr. Didit Roesono, SpKJ	36	33	1	2,78%	0	12	0,00%
34	dr Akhmad Syahrir, Sp. N	26	24	2	7,69%	0	0	0,00%
35	dr. Dicky Faturrachman,Sp.A	29	28	1	3,45%	0	0	0,00%
36	dr. Fiona Paramita Sp.A	20	18	2	10,00%	0	0	0,00%
37	dr Anton Setiadi SpB	47	47	0	0,00%	0	47	0,00%
38	dr. Ira Setya Waty, Sp.JP	8	8	0	0,00%	0	8	0,00%
39	dr. Andi Abdillah, SpB	8	8	0	0,00%	0	8	0,00%
40	drg. Ajeng Sp.KGA	21	20	1	4,76%	0	20	0,00%
41	dr. Adya Sp.DV	51	30	5	9,80%	0	12	0,00%

3.6.1.1.2 Penundaan Operasi Elektif

3.6.1.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



Analisa Capaian :

Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari – November tahun 2024 diketahui capaian telah mencapai standart 0%, hal ini kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan Desember.

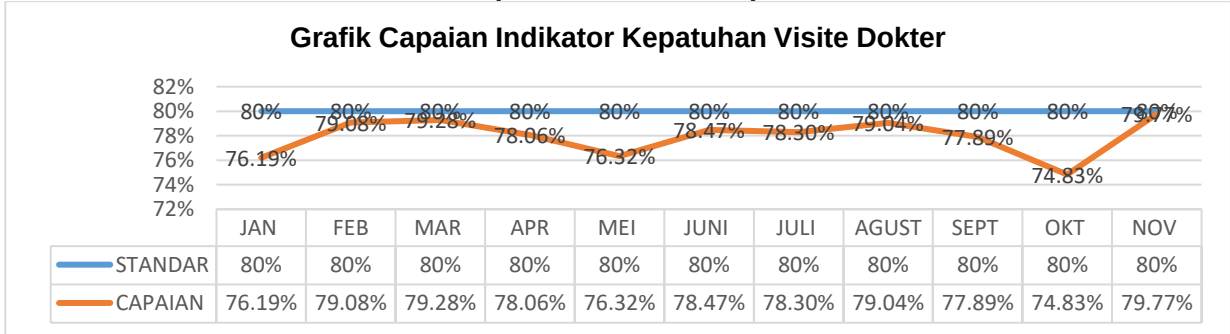
Tindakan Operatif Berdasarkan SMF

NO.	DESKRIPSI	JUMLAH
1.	Bedah Umum:	
	Excisi	24
	Debridement Necrotomy	22
	Appendectomy	8
	Herniotomy	8
	Laparatomy	7
	Hemoroidectomy	6
	Biopsi	5
	Linfadenectomy	5
	Repair	2
2	Obgin	
	SC	54
	Laparatomy	4
	Histectomy	1
	Marsupialisasi	1
	Oovorectomy	1
	Salpingoovorectomy	1
3	Orthopedi	
	Orif	16
	Remove Implant	10
	Repair	12
	Close Reduction	13
	Debridement	7
	Oref	1
	Excisi	1
	Arthroplasty	1
	Release	1
4	Urologi	
	URS	20
	TURP	13
	URS + Aff Sten	6
	Vesicolitotripsi	3
	ESWL	3
	Internal Uretrotomi	1
	Meatotomy	1
	Chordectomy	1
	Orchidopexy	1
	Excisi	1
5	Bedah Plastik	
	Repair	8
	Debridement	4
	Skin Graft	3
	Remove Ach Bar	2

6	Mata	
	Phaco	44
	Extirpasi+Graft	3
	Excisi	5
7	THT	
	Tonsilectomy	3
8	Kulit dan Kelamin	
9	Bedah Syaraf	
	Excisional Debridement	2
	Repair	2
	Craniotomy+evakuasi ICH+EVD	1
	Burrhole	1

3.6.1.1.3 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

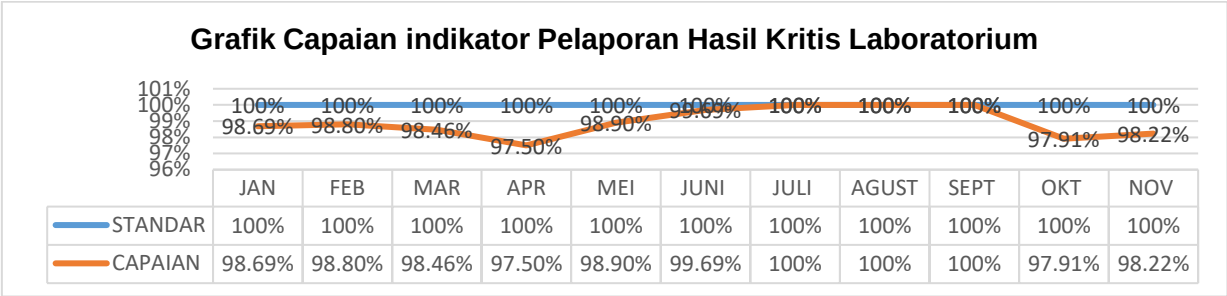
3.6.1.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dOktter pada bulan Januari hingga November tahun 2024 belum mencapai standart. Dari hasil supervisi didapatkan nya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS lain karena RS Prima Husada tidak memiliki Dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr, dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. DOKter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu)				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Follow up penerimaan dokter tetap Rumah Sakit Prima Husada Malang	Manajemen RS	Satu bulan

3.6.1.1.4 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

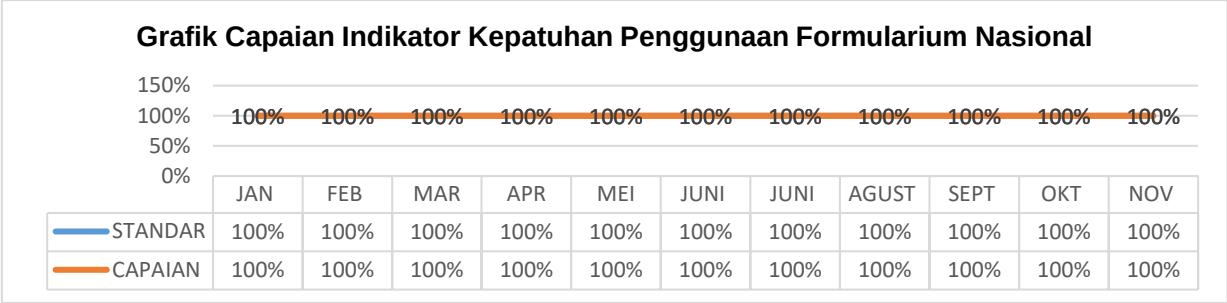
3.6.1.1.8.1 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024 masih belum mencapai standart. Capaian meningkat pada bulan Juli hingga September, pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Juli hingga September telah mencapai standart 100% tetapi menurun di bulan Oktober menjadi 97,91% dan meningkat kembali di bulan November menjadi 98,22%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor 2. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang tercatat dalam CPPT 3. Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	1. Komite mutu 2. Kepala instalasi laboratorium	Satu bulan

3.6.1.1.5 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

3.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

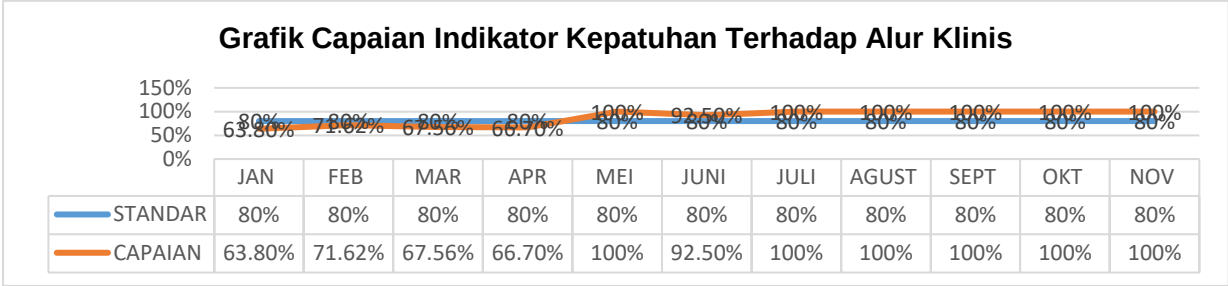


Analisis Capaian :

Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari – November tahun 2024 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan Desember.

3.6.1.1.6 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

3.6.1.1.10.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis hingga mencapai standart 80%.					
DO	Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat dianalisa.					
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator kepatuhan terhadap alur klinis masih belum stabil. Masih ditemukan profesi yang tidak memberikan asuhan sesuai dengan CP yang telah disepakati.					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	Capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standart 80%.	Melibatkan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat dianalisa.		Komite mutu	Satu bulan

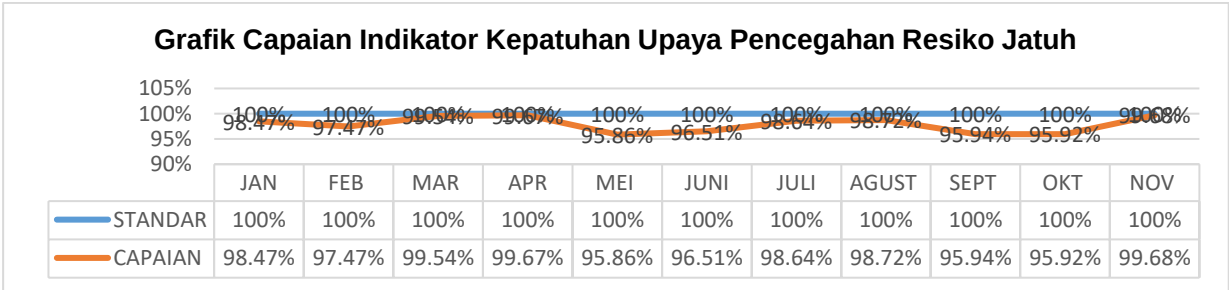
Daftar Clinical Pathway

DIAGNOSA	JUMLAH	PATUH	TIDAK PATUH
DF			
CVA Infark			
Gastritis			
Batu Ureter			
DM			
GEA			
CHF			

FAM			
TB Paru			
HT			
CA Mammae			
HIV			
STEMI			
NSTEMI/UAP			
Pneumonia			
Sectio Caesarea	24	24	0
Partus Normal	37	37	0
Jumlah	61	61	0

3.6.1.1.7 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

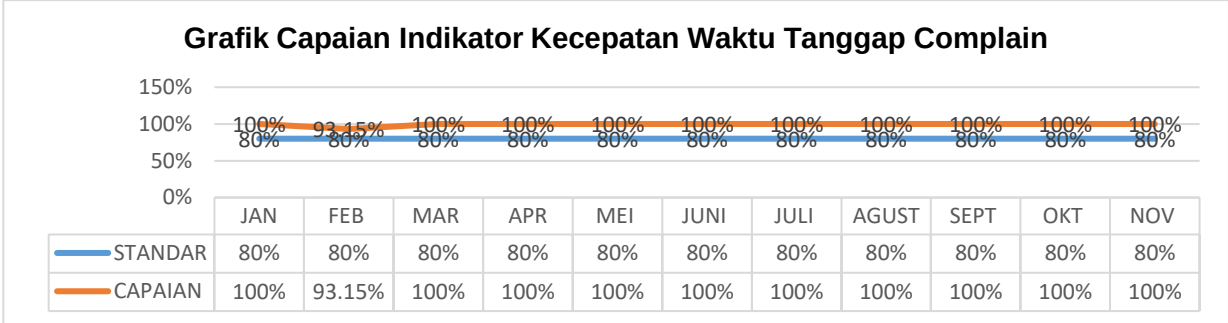
3.6.1.1.11.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga November tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu <u>memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi. Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan pada 21 keluarga pasien ditemukan hasil bahwa 16 keluarga pasien mengatakan tidak menerima KIE dari perawat ruangan mengenai upaya pencegahan resiko jatauh.</u>				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	Meningkatkan supervisi guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

3.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Analisis
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase kecepatan waktu tanggap komplain pada bulan Januari tahun 2024 capaian telah mencapai 80%. PIPP dan bidang terkait telah menanggapi complain kurang dari 5 menit . Pada bulan Februari capaian menurun menjadi 93,15% tetapi masih diatas standart, pada bulan Maret hingga November capaian kembali meningkat menjadi 100%.

Distribusi Laporan Komplain Pasien per unit bulan Oktober 2024 di RS Prima Husada Malang

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1.	IRJA	0	0	0
2.	IRNA	0	0	0
3.	IFRS	10	7	2
4.	UMUM	6	7	1
5.	PENDAFTARAN /CSO	4	4	1
6.	PERAWAT / BIDAN	4	5	0
7.	KASIR	0	0	0
8.	GIZI/DAPUR	4	2	1
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	3	4	4
10.	DOKTER IGD	0	2	1
11.	IGD REGULER	2	2	5
12.	SECURITY	0	1	0
13.	PARKIR	2	6	2
14.	PENUNJANG	0	1	0
15.	FASILITAS RS	8	18	8
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	AMBULANS	0	0	0
19.	PRIMANTARA	0	0	0
Total		65	43	40

Analisis :
Jumlah pasien komplain selama Bulan November 2024 mengacu pada komplain pasien. Asal komplain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

- Jumlah complain Pada bulan November 2024 menurun dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan September 2024 sebanyak 43 kasus complain pada bulan oktober 2024 turun menjadi 40 kasus Sedangkan pada bulan November 2024 turun mebjadi 25 kasus
- Komplain terbanyak pada bulan November 2024 yaitu dari Fasilitas RS sebanyak 8 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.

3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 5 jenis complain dengan rincian :
- a) Fasilitas RS sebanyak 3 kasus yang meliputi :
 Kasur tempat melahirkan keras dan sempit, Kamar mandi sediakan tong sampah dan gantungan baju, kamar pasien kelas 1 TT 1 orang,
 - b) Parkir sebanyak 2 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir yang meliputi :
 Keluar masuk parkir pasien harusnya pembayaran 1 kali saja. Tiap kali keluar harus bayar foto kopi juga sulit, Perluas area parkir

Rencana Tindak Lanjut:
 Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

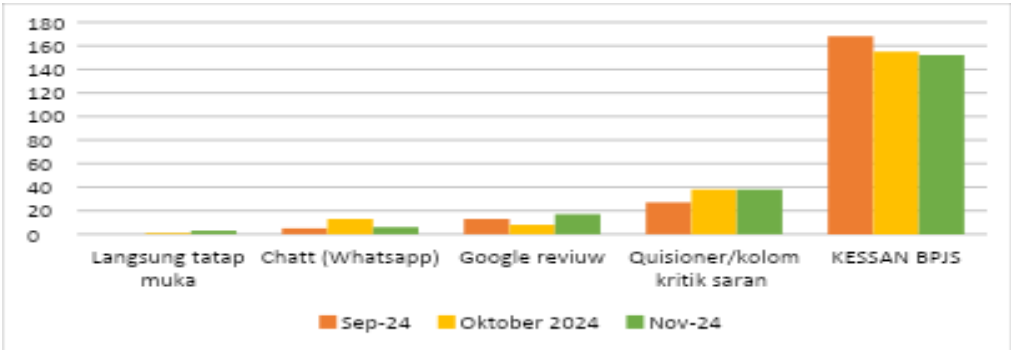
Media yang digunakan Pasien Komplain bulan November tahun 2024 di RS Prima Husada Malang

NO	JENIS PASIEN COMPLAIN	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1.	Langsung tatap muka	0	1	3
2.	Tidak Langsung :			
a	Chatt (Whatsapp)	5	13	6
b	Google rewiuw	13	8	8
3.	Quisioner/kolom kritik saran	27	38	17
4.	KESSAN BPJS	168	155	152

Rincian KESSAN November 2024

1.	KESSAN BPJS	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5
		0	1	1	28	122

Grafik Media yang digunakan Pasien Komplain bulan November tahun 2024 di RS Prima Husada Malang



Analisa :
 Pada bulan November 2024 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 17 kasus komplain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari google rewiuw sebanyak 8 kasus, WA sebanyak 6 dan tatap muka sebanyak 3 kasus.

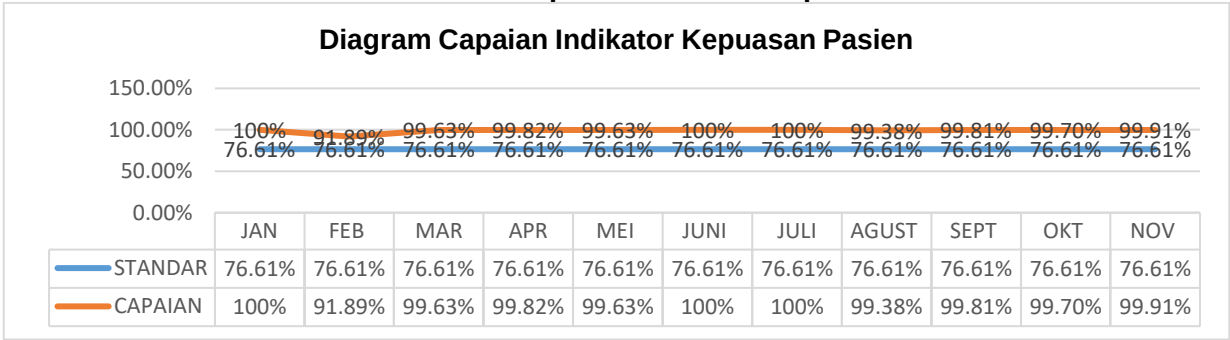
Rencana Tindak Lanjut:
 Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

Waktu tanggap dan penyelesaian complain di RS Prima Husada Malang Bulan November 2024

NO	JENIS PASIEN COMPLAIN	WAKTU TANGGAP		WAKTU PENYELESAIAN		< 3 HR IANA JERIAL RS	7 HR KE PT
		STANDARD < 5 '	PENCAPAIAN (DARI WAKTU TOTAL DIBAGI JML KOMPLAI ATAU RATA2 WAKTU TANGGAP)	STANDARD < 60 '	PENCAPAIAN		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	0	0	0
					100%		
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	0	0	0
					100%		
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	13	0	0
					100%		
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	12	0	5
					65%		35%
5.	KESSAN	100%	0	100%	155	0	0
					100%		

3.6.1.1.9 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.13.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis :
Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa persentase kepuasan pasien pada bulan Januari hingga November tahun 2024 sudah mencapai standar. Dari 229 pasien yang mengisi kuesioner survey kepuasan pasien, hanya 1 pasien yang menjawab tidak puas akasn keseluruhan pelayanan.

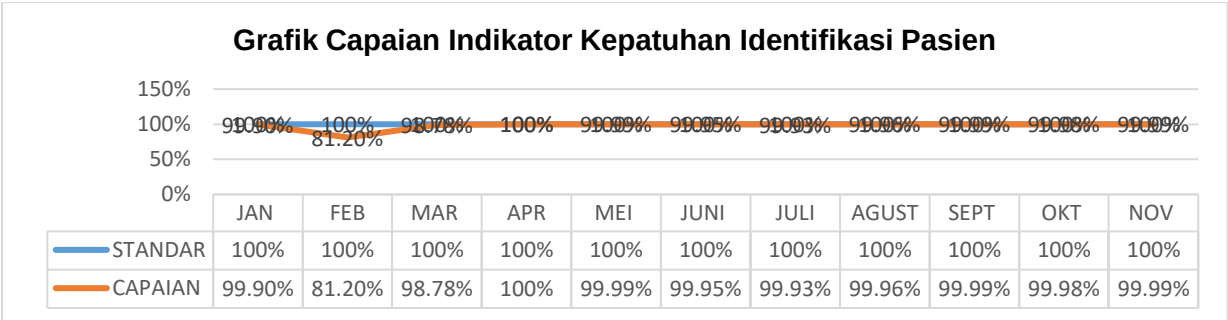
3.6.1.2 Indikator Mutu Prioritas

3.6.1.2.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUS T '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,9%	81,2 %	98,78 %	100%	99,99 %	99,95 %	99,93 %	99,96 %	99,99 %	99,98 %	99,99%
2	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	85,86%	85,88 %	85,5 %	85,53 %	85,56 %	85,57 %	85,42 %	%	85,41 %	85,45 %	85,49%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	98,47%	97,47 %	99,54 %	99,67 %	95,86 %	95,51 %	98,64 %	98,72 %	95,94 %	95,92 %	99,68%

3.6.1.2.1.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

3.6.1.2.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

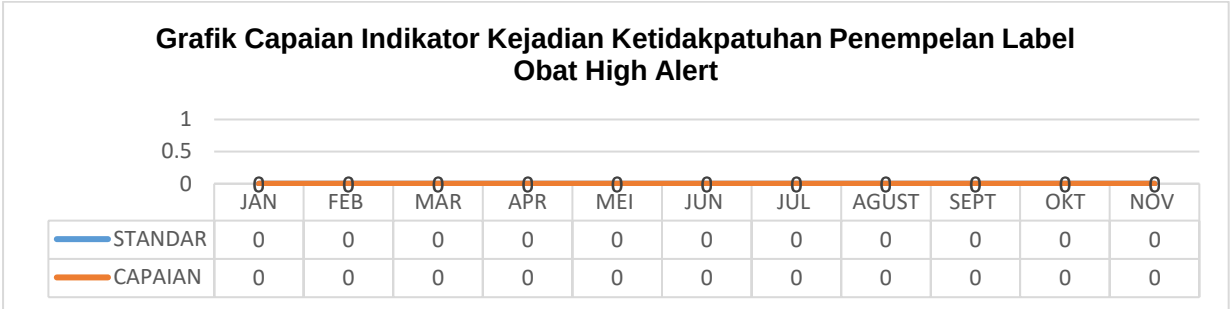


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	8. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 9. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 10. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei hingga November capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar, perawat dan petugas farmasi yang salah memberikan obat, petugas primantara yang salah dalam pengantaran obat serta kesalahan pemberian obat karena dOKter IGD mengganti resep dan tidak melakukan konfirmasi pada farmasi. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

			tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat		
--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.1.2 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

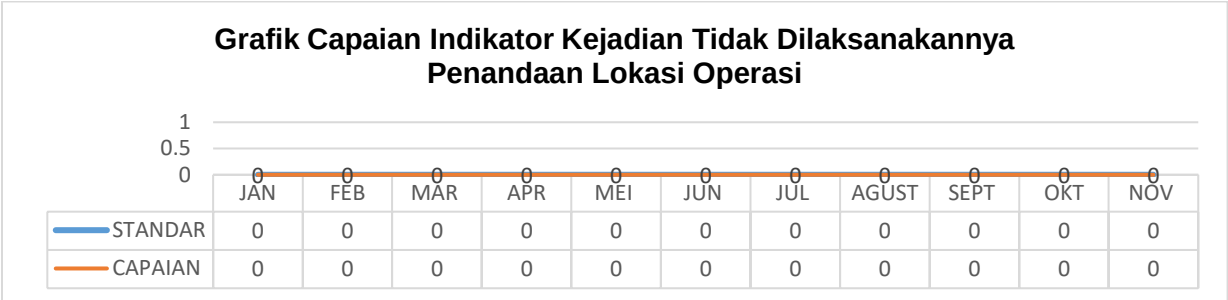
3.6.1.2.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Analisis
 Berdasarkan data diatas, dapat diketahui persentase ketidakpatuhan penempelan label obat high alert pada bulan Januari hingga November tahun 2024 telah mencapai standar. Hasil tersebut sesuai dengan hasil supervisi pada unit rawat inap, di semua unit rawat inap tidak ditemukan obat obat haigh alert yang tidak berlabel.

3.6.1.2.1.3 Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

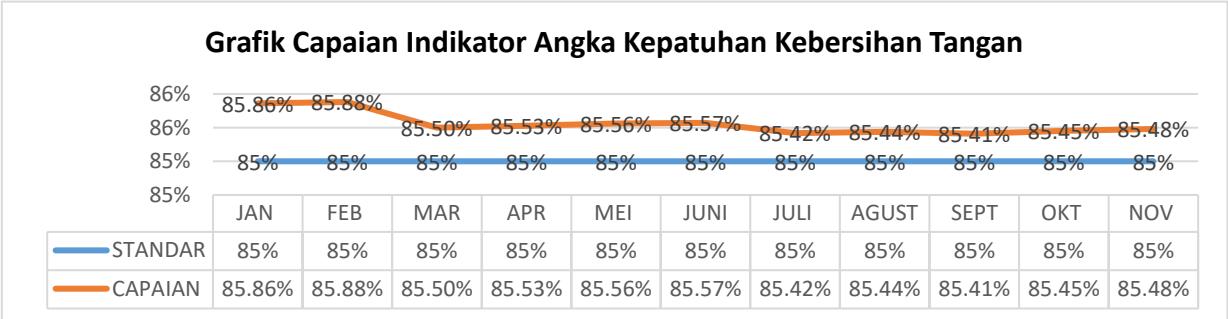
3.6.1.2.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi



Analisis :
 Berdasarkan data diatas dapat diketahui persentase tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi pada bulan Januari hingga September tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.2.1.4 Kepatuhan Kebersihan Tangan

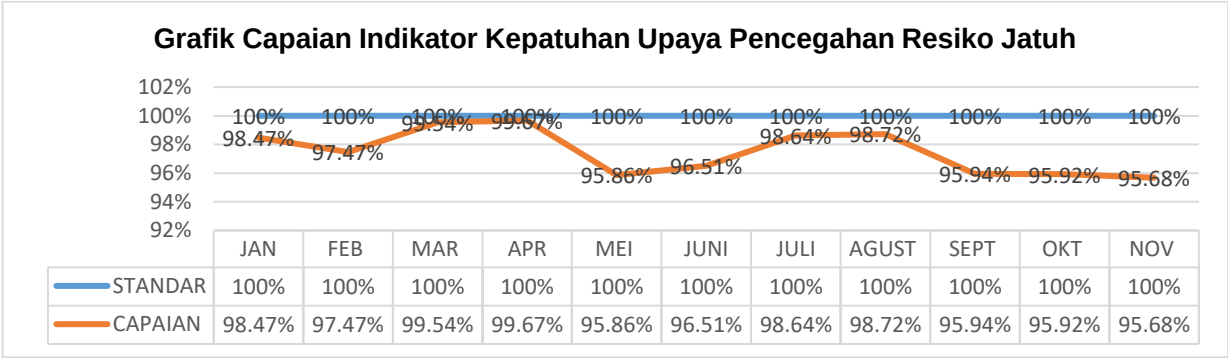
3.6.1.2.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	5. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan.\n 6. Memberikan proses pembelajaran dengan membuat video pendek edukasi cuci tangan supaya lebih mudah untuk mengingat.\n 7. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan.\n 8. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.\n 9.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,48%. Jika dilihat berdasarkan profesi, masih ditemukan prosentase di bawah standart yaitu pada profesi dokter (84,34%) dan nakes lain (84,62%) dimana berdasarkan 5 moment cuci tangan, kebanyakan dari petugas tidak melakukan moment sebelum kontak dengan pasien (74%). Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena persepsi yang salah dan kurangnya kesadaran petugas terkait pentingnya kebersihan tangan seperti pada profesi dokter yang lebih memilih untuk memakai sarung tangan (handscoon) namun juga melakukan cuci tangan dengan handrub yang tidak efektif jika masih memakai handscoon.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.2.1.5 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.2.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



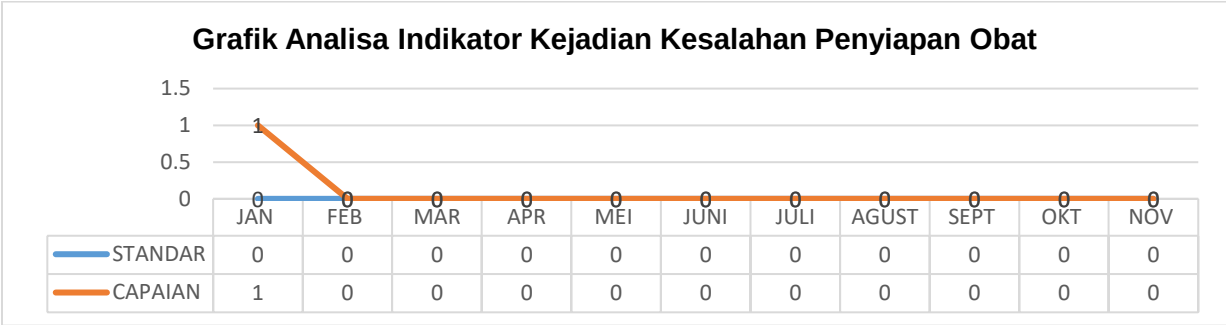
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga November tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu <u>memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi. Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan pada 21 keluarga pasien ditemukan hasil bahwa 16 keluarga pasien mengatakan tidak menerima KIE dari perawat ruangan mengenai upaya pencegahan resiko jatauh.</u>				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	Meningkatkan supervisi guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu bulan

3.6.1.2.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEPT '24	OKT '24	NOV '24
1.	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81 %	69,59 %	73,43 %	79,11 %	78,13 %	74,88 %	71,82 %	72,73 %	76,95 %	74,36 %	70,72 %
4.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48 %	50,77 %	56,18 %	61,29 %	58,52 %	54,92 %	50,64 %	53,25 %	59,94 %	50,92 %	49,00 %
5.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2
6.	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2
9.	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.6.2.1 Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat

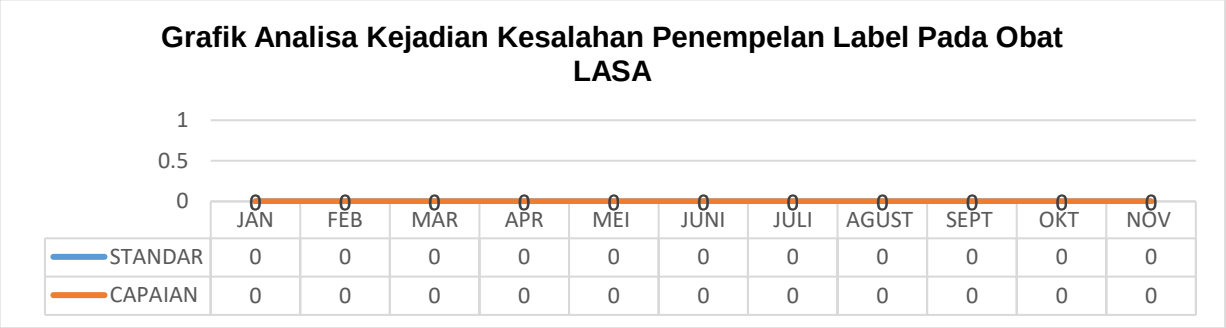
3.6.2.1.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat yang pada bulan ini telah mencapai standart.				
DO	11. Melakukan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan 12. Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat 13. Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa kesalahan pemberian obat masih terjadi pada bulan Januari tahun 2024. Kesalahan pemberian obat terjadi karena petugas tidak teliti dalam melakukan penyiapan obat. Pada bulan Februari hingga November tahun 2024 diketahui tidak ada kejadian kesalahan penyiapan obat.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahan kan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Mempertahank an capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	1. Meningkatkan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan 2. Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat 3. Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.2.2 Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA

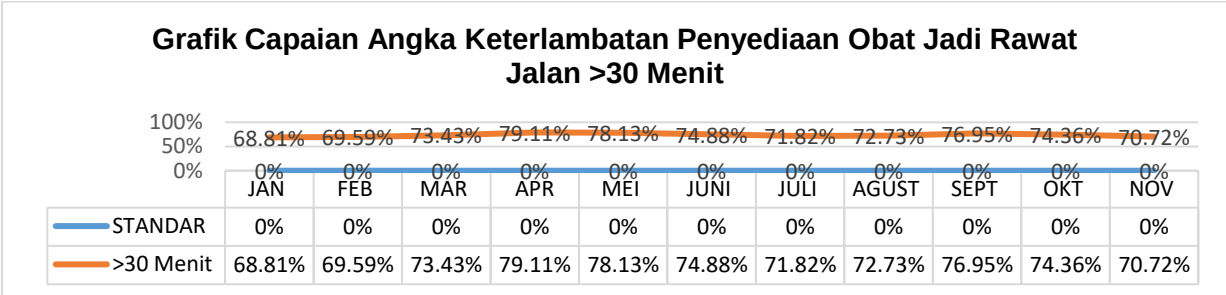
3.6.2.2.1 Grafik Analisa Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA



Analisis Capaian :

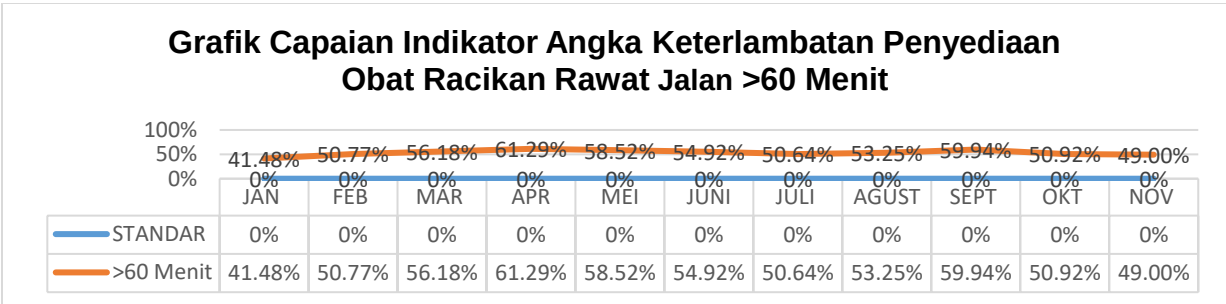
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan tidak ditemukan kejadian kesalahan penempelan pada obat LASA pada bulan Januari hingga November tahun 2024.

3.6.2.3 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit
3.6.2.3.1 Grafik Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit



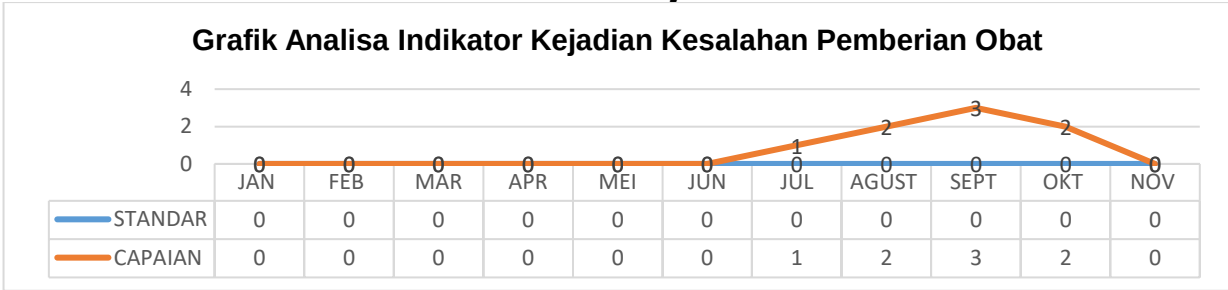
PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat jadi rawat jalan >30 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena petugas farmasi seringkali melakukan klik selese obat tdak realtime ketika obat selesai atau klik obat selesai dilkaukan ketika 5 atau 10 resep selesai dikerjakan.				
ACTION/R TL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambat an penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Mengurangi angka keterlambata n penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 30 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.2.4 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit
3.6.2.4.1 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat racikan rawat jalan >60 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena petugas farmasi seringkali melakukan klik selese obat tdak realtime ketika obat selesai atau klik obat selesai dilkaukan ketika 5 atau 10 resep selesai dikerjakan.				
ACTION/R TL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.2.5 Kejadian Kesalahan Pemberian Obat
 3.6.2.5.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Pemberian Obat

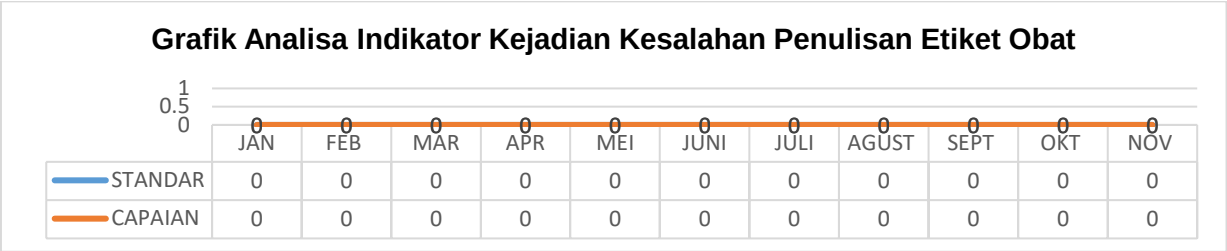


PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kejadian kesalahan pemberian obat hingga mencapai standart yaitu 0 kejadian				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien yang mendapatkan resep 2. Melakukan rapat berasama kepala instalasi farmasi guna melakukan supervisi terkait kepatuhan identifikasi pasien dalam proses pemberian obat.				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa selama bulan Januari hingga Juni tahun 2024 tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat. Pada bulan Juli tahun 2024 ditemukan 1 kejadian kesalahan pemberian obat, pada bulan Agustus ditemukan 2 kejadian kesalahan pemberian obat ,pada bulan September terjadi 3 kejadian kesalahan pemberian obat, bulan Oktober terdapat 2 kejadian kesalahan pemberian obat dan dibulan November ini tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat. Kesalahan pemberian obat disebabkan karena petugas tidak teliti muali proses penyiapan hingga pemberian obat ke pasien.				
ACTION/R TL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka kejadian kesalahan pemberian obat	Mengurangi angka kejadian kesalahan pemberian obat	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit .	1. Meningkatkan ketelitian Diklat khusu petugas primantara 2. Meningkatkan ketelitian dan Diharapakn perawat poli juga membantu DPJP untuk	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

			melakukan pengkajian sehingga dapat mengingatkan ketika DPJP ada kesalahan ketika input e resep		
--	--	--	---	--	--

3.6.2.6 Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat

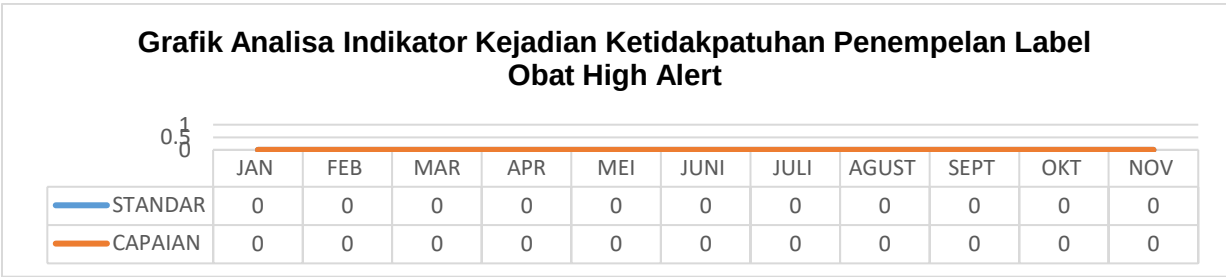
3.6.2.6.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat



Analisis:
 Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian kesalahan penulisan etiket obat sejak bulan Januari hingga November tahun 2024.

3.6.2.7 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label *Obat High Alert*

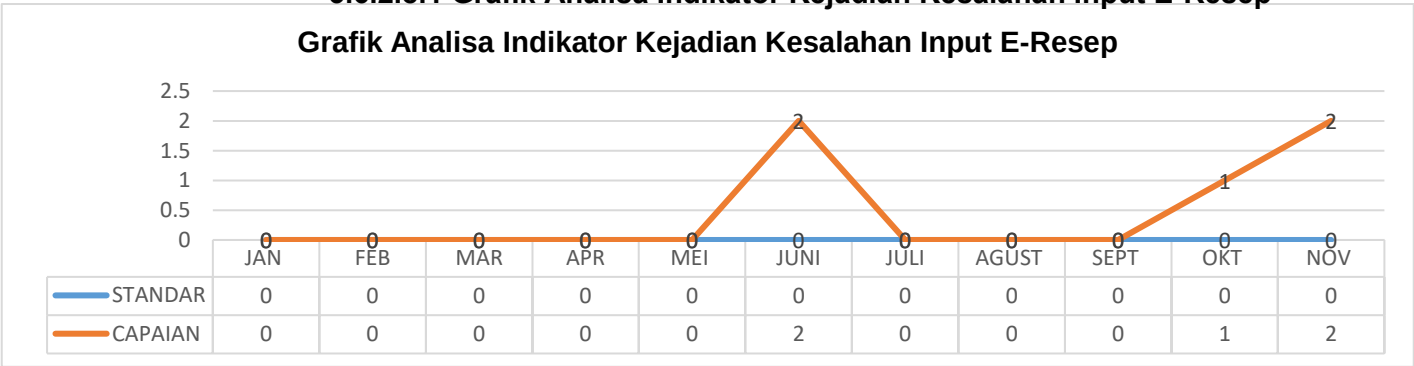
3.6.2.7.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Analisis:
 Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert sejak bulan Januari hingga November tahun 2024

3.6.2.8 Kejadian Kesalahan Input E-Resep

3.6.2.8.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Input E-Resep

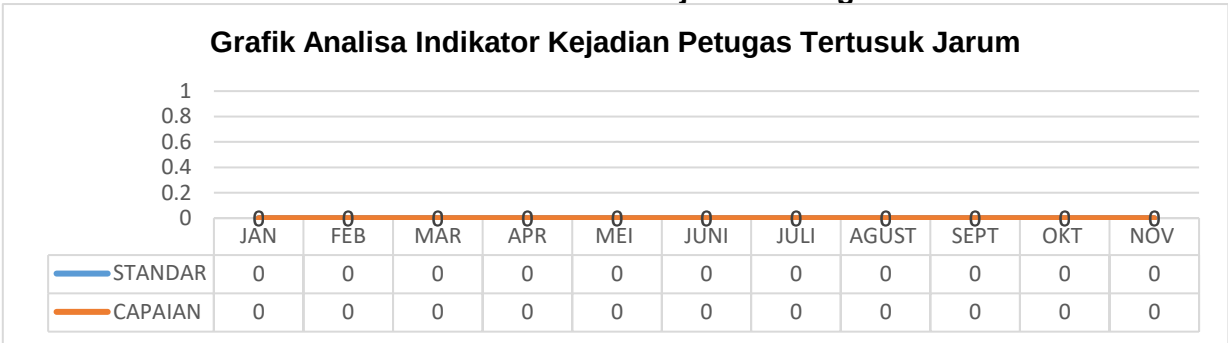


Analisis :
 Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa terdapat kejadian kesaalahan input e-resep pada bulan Juni, Oktober dan November. Kejadian kesalahan input e-resep disebabkan karena DPJP seringkali menyalin resep pasien dari kunjungan sebelumnya.

PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kejadian kesalahan input e-resep hingga mencapai standart yaitu 0 kejadian				
DO	1. Meningkatkan ketelitian ketika menginput e-resep 2. Perawat poli membantu melakukan pengkajian sehingga dapat mengingatkan DPJP ketika memberikan obat				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa terdapat kejadian kesaalahan input e-resep pada bulan Juni, Oktober dan November. Kejadian kesalahan input e-resep disebabkan karena DPJP seringkali menyalin resep pasien dari kunjungan sebelumnya.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka kejadian kesalahan input e-resep	Mengurangi angka kejadian kesalahan input e-resep	Tidak ada kejadian kesalahan input e-resep	1. Meningkatkan ketelitian ketika menginput e-resep 2. Perawat poli membantu melakukan pengkajian sehingga dapat mengingatkan DPJP ketika memberikan obat	DPJP	Satu bulan

3.6.2.9 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

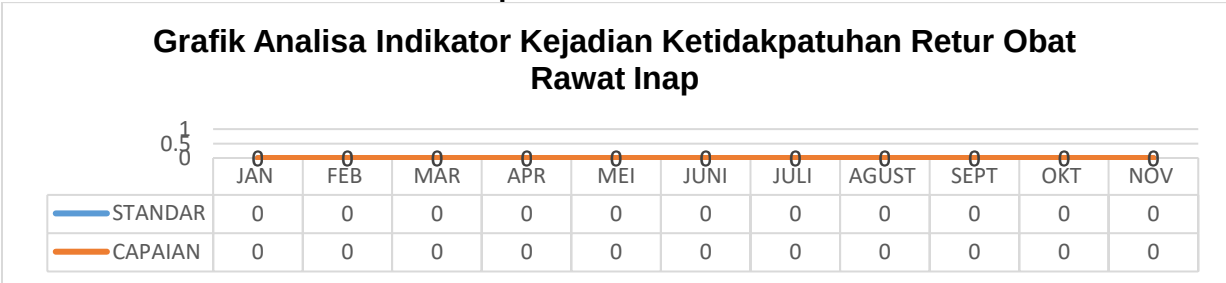
3.6.2.9.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



Analisis:
 Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert sejak bulan Januari hingga November tahun 2024.

3.6.2.10 Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap

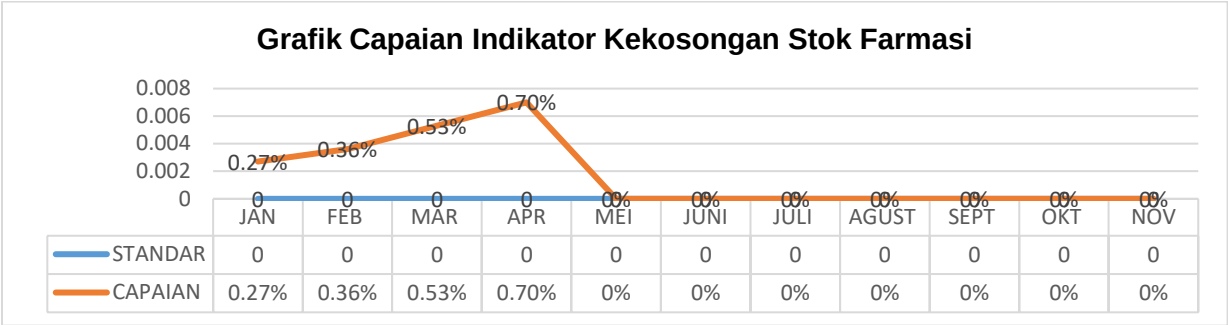
3.6.2.10.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap



Analisis :
 Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan input e-resep pada bulan Januari hingga November tahun 2024.

3.6.2.11 Kekosongan Stok Sediaan Farmasi

3.6.2.11.1 Grafik Capaian Indikator Kekosongan Stok Farmasi



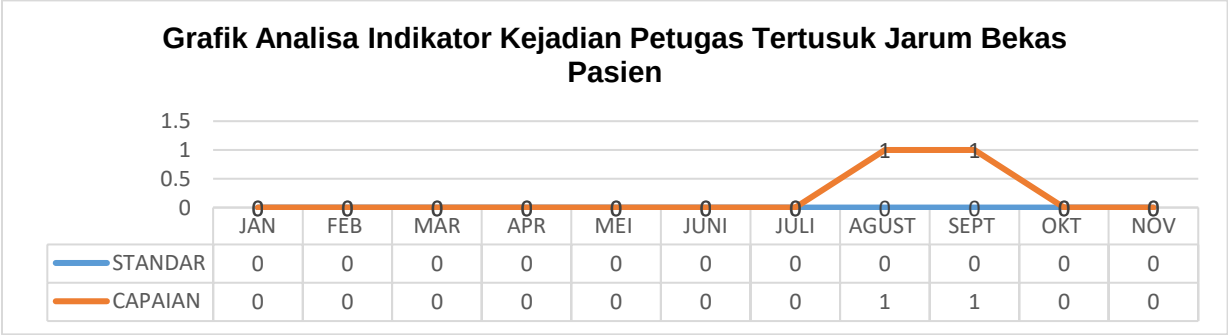
PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kekosongan stok farmasi				
DO	Melakukan Analisa perhitungan waktu pengajuan hingga barang datang dengan kebutuhan, sehingga petugas dapat memperkirakan sediaan yang harus segera diinput pada pengadaan.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui masih terjadi kekosongan stok farmasi pada bulan Januari hingga April. Pada bulan Mei hingga November masih ada kekosongan obat teratasi dengan adanya substitusi sehingga tidak mengganggu pelayanan. Kekosongan obat farmasi disebabkan karena : 1. Barang yg sudah dipesan di pbf belum dikirim karena : - Barang sedang kosong distributor - Sp yg dikirim ke salesman belum terinput di data pemesanan pbf 2. Barang memang sedang kosong nasional karna bahan baku tidak ada 3. Human eror, bisa jadi terselip di defecta jd belum minta ke pengadaan 4. Barang yg awalnya slow moving, tiba2 jd fast moving. Banyak dipakai oleh dpjp ybs, padahal sebelumnya jarang sekali 5. Ada barang tertentu yg sedang dilakukan penyesuaian harga bpjs jadi belum bisa di jual oleh pbf				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Tidak ada kekosongan stok obat di farmasi	Memperbaruhi surat perjanjian kerjasama yang berisi tentang ketepatan waktu pengiriman obat setelah gudang farmasi order.	1. Kepala Instalasi farmasi 2. Pengadaan Farmasi PT	Satu bulan

3.6.2.11.2 Manajemen Resiko

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.6.2.11.2.1 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

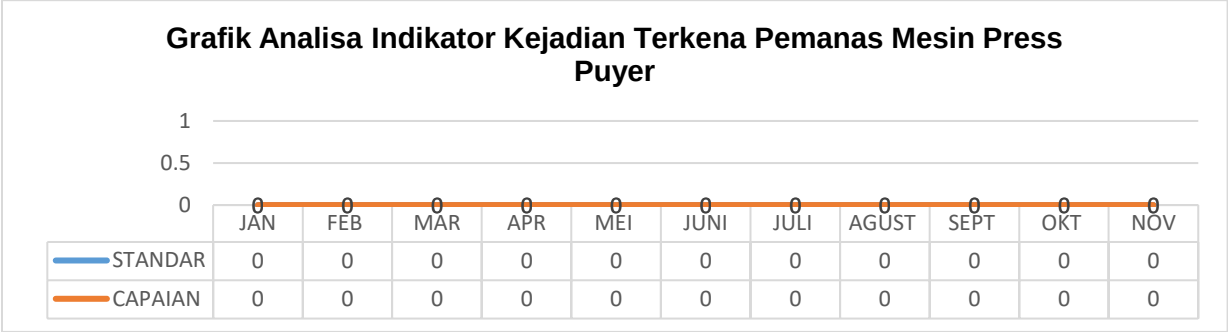
3.6.2.11.2.1.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).				
DO	1. Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM. 2. Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. 3. Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. 4. Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan Agustus terdapat 1 kejadian petugas tertusuk jarum dan pada bulan September terdapat 1 kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	1. Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien. 2. Supervisi petugas terkait pembuangan jarum bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.2.11.2.2 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

3.6.2.11.2.2.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Analisis:
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga bulan November tahun 2024.

3.6.2.12 Mutu Unit

3.2.1.3.1 Instalasi Gawat Darurat

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	96,25 %	100%	100%	100%	100%	97,35 %	100%	100%	100%	96,69 %
2.	Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD	0%	0%	0,17 %	0%	0,28 %	0,15 %	0,67 %	0,15 %	0,29%	5,2%	5,87%	5,87%
3.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,08 %	91,35 %	100%

	Jatuh												
4.	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,7%	0,85 %	0,61 %	0,73 %	0,5%	2,61 %	1,62 %	1,82%	2,82%	1,82%	4.1%
5.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergenci	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.2.1.3.1.1 Kunjungan IGD

NO.	STATUS PASIEN	JUMLAH PASIEN				
		UMUM	BPJS KES	BPJS TK	JASA RAHARJA	ASURANSI SWASTA
1	Rawat Jalan	316	274	49	0	23
2	Rawat Inap	42	836	18	1	12
3	Rujuk	1	19	1	0	1
4	Meninggal	1	4	0	0	0

1.2.1.3.1.2 Data Pasien Pulang Atas Permintaan Sendiri

01/11/2024	1	DAFFA RADITYA FABIAN	L	19 THN	038826	BPJS	TF	LAIN - LAIN
04/11/2024	2	FIRDA PUSPITA SARI	P	23 THN	222010	BPJS	INPARTU	LAIN - LAIN
06/11/2024	3	MUHAMMAD AZKA PUTRA	L	5 TH	222157	UMUM	KDK	EKONOMI
06/11/2024	4	KHOLILUR ROHMAN	L	33 THN	222178	UMUM	VULNUSS LACERATUM R/ PARIETAL D	EKONOMI
06/11/2024	5	DALILA ATHIRA	P	2THN 8BLN	190358	UMUM	VOMITING	EKONOMI
06/11/2024	6	SIPRIANU DJI	L	48 THN	222146	UMUM	GEA	ALASAN PRIBADI (MAU RJ DULU)
06/11/2024	7	OCTAVA BHAKTI NUSANTARA	L	26 THN	091967	UMUM	FEBRIS	EKONOMI
7/11/2024	8	SUMADI	L	45 THN	093667	BPJS	VULNUSS PUNCTUM EC DURI IKAN	
7/11/2024	9	FATHUR ROHMAN	L	19 THN	222224	UMUM	CKR + VULNUSS LACERATUM	EKONOMI
7/11/2024	10	MUHAMMAD ARJUNA PUTRA PRADANA	L	13 THN	222192	ASURANSI	COLIC ABDOMEN	ALASAN PRIBADI
8/11/2024	11	ALMIERA ATAYA SOFYAN	P	7 THN	101153	BPJS	DF	ALASAN PRIBADI (MAU RJ DULU)
09/11/2024	12	ZHEAN AXELLE DEVIANDRA	P	1 TH 7BLN	208244	BPJS	FEBRIS	LAIN - LAIN
09/11/2024	13	SUJIATI	P	73 THN	192380	BPJS	SUSP CF FEMUR	PENGOBATAN ALTERNATIF
10/11/2024	14	M SOPI'I	L	56 TH	222301	UMUM	CKR 456	EKONOMI
10/11/2024	15	MAHDI ZAIN ASYRAF	L	1 TH 7 BLN	195267	BPJS	VULNUSS APPERTUM	LAIN - LAIN
12/11/2024	16	HENDRO PRASTOWO	L	59 THN	141556	UMUM	DISLOKASI CLAVICULA (D)	EKONOMI
12/11/2024	17	ABDULLAH ABIL	L	8 THN	222443	UMUM	CORPAL COIN ILEUM	EKONOMI

		AHMAD						
13/11/2024	18	ANNUROH ASRIFAH	P	25 THN	203458	BPJS	DF	MAU RJ DULU
15/11/2024	19	NURUL FATIKHA	P	20 THN	154513	UMUM	FEBRIS	MAU RJ DULU
15/11/2024	20	MUHAMMAD AKHADUL MAHABBAH	L	3 THN	193064	BPJS	VULNUSS APP LABIA ORIS	ALASAN PRIBADI
16/11/2024	21	MOCHAMAD HAFIT IMAM SYAFI'I	L	19 THN	222630	BPJS	FINGER TIP INJURY	ALASAN PRIBADI
17/11/2024	22	NABILUL IRSYAD	L	15 YHN	223058	UMUM	CF MID RADIUS ULNA DEXTRA	EKONOMI
17/11/2024	23	AKHTAR MUMTAZ ALVARENDRA	L	1 THN 10 BLN	191243	BPJS	CKR 456	ALASAN PRIBADI
17/11/2024	24	AHMAD RASYA DWI KRISNA	L	17 THN	222644	BPJS	COMBUSTIO GR 2B 2% ELBOW SINISTRA	LAIN - LAIN
18/11/2024	25	FITRIYAH	P	32 THN				EKONOMI
18/11/2024	26	DIAN DIRJA RAMADDANI	L	14 THN	222708	UMUM	TUMOR OTAK	EKONOMI
19/11/2024	27	ALYA NURUL SABYAN	P	1 THN	222782	BPJS	FEBRIS	MAU RJ DULU
20/11/2024	28	SYAMSUL ISLAM	L	69 THN	222794	UMUM	FR. TIBIA FIBULA 1/3 PROXIMAL	EKONOMI
20/11/2024	29	DJUHER EFENDI	L	70 THN	092133	UMUM	DM HIPERGLIKEMIA + ADHF	EKONOMI
22/11/2024	30	PAISRI	P	51 THN	222905	UMUM	DM HIPERGLIKEMIA	EKONOMI
24/11/2024	31	AMEERA ZOYA ANNAILA	P	2 THN	187807	UMUM	BRONCHOPNEUMONIA	ALASAN PRIBADI
24/11/2024	32	MUWAFFAQ	L	24 THN	222987	UMUM	CF MANUS (S)	JARAK RS
25/11/2024	33	AHMAD CHOIRUL MUHSININ	L	17 THN	223032	UMUM	PF DIGOTI 3 MANUS SIN	EKONOMI
27/11/2024	34	ALFA YUDHA PRATAMA	P	13 THN	223106	UMUM	CF CRURIS SIN	DIBAWA KE RST
27/11/2024	35	MUHAMMAD RAFASYA ARSYAKA	L	1TH 7BLN	196208	UMUM	SUSP PNEUMONIA	EKONOMI
29/11/2024	36	SULISTIYANINGSIH	P	26 THN	212664	UMUM	CONTUDO MUSCLE	EKONOMI
29/11/2024	37	ELSA OSALITA	P	23 THN	223173	UMUM	EDH OCCIPITAL	EKONOMI
30/11/2024	38	ALFIYA	P	29 THN	093205	JKK	VULNUSS LACERATUM DIGITI 1 PEDIS SIN	ALASAN PRIBADI

1.2.1.3.2 IRNA 2A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%					97,64 %	100%	100%	-	-	-	-
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%					45,54 %	76,92%	90%	-	-	-	-
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%					-	-	-	-	-	-	-

4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%					100 %	100%	100%	-	-	-	-
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%					0%	0%	0%	-	-	-	-
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%					100 %	100%	100%	-	-	-	-
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%					100 %	100%	100%	-	-	-	-

3.2.1.3.2 IRNA 2C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	93,41 %	100%	97,22 %	100%	100%	100%	100%	100%	94,32 %	90,91 %	96,63 %
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	80%	73,53 %	74,84 %	73,57 %	73,23 %	62,6 %	62,6 %	62,6%	81,55 %	66,94 %	80,67 %
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,8 %	100%	95,93 %	100%	93,75 %	100%	100%	100%	87,5%	95,6%	96,12 %
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	1,03 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	94,7 %	100%	100%	97,14 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49 %	86,36 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.3 IRNA 3A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	93,1 8%	89,4 %	91,28 %	80,29 %	87,79 %	91,45 %	86,99 %	84,21 %	82,22 %	86,5%	89,87 %
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	98,61 %	100%	100%	97,41 %	97,12 %
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,75 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	84,9 6%	87,65 %	82,43 %	83,94 %	89,17 %	91,45 %	93,15 %	92,11 %	86,67 %	87,73 %	85,09 %
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.4 IRNA 4A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	94,84 %	78,2 3%	86,54 %	86,84 %	89,19 %	95%	95%	92,86 %	90,16 %	86,36 %	85,15 %
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	71,83 %	97%	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100%	%	80,20 %
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,85%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	90,7 5%	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.5 IRNA 3C ANAK

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100 %	100 %	100 %	100%	97,4 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0,37%	0%	0,39 %	0%	0,94%	0,43%	0,42%	0,41%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
7.	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.6 IRNA 5C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	62,07 %	66,86 %	64,86 %	55,35 %	67,48 %	67,48 %	66,67 %	68,42 %	75,76 %	59,24 %	74,87 %
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,33 %	100%	100%	100%	100%

5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,54 %	0,55 %	0,74 %	0%	0%	0%	0%	0,52%	0,52%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	99,13 %	97,75 %	93,02 %	96,38 %	95,58 %	95,58 %	94,59 %	96,33 %	95,99 %	93,56 %	97,38 %
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.7 IRNA 6A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,71 %	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	61,11 %	79,63 %	84,92 %	83,21 %	82,79 %	76,47 %	71,01 %	79,69 %	77,27 %	76,54 %	84,09 %
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,39 %	100%	89,52 %	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,7%	3,57 %	3,85%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.8 IRNA 7A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	97,92 %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	58,2 2%	76,67 %	75%	84,56 %	76,74 %	63,78 %	72,73 %	72,44 %	69,54 %	65,79 %	91,26 %
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,6 7%	100%	100%	100%	97,12 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0,7%	0%	0,9%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100 %	86,52 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	91,09 %	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.9 IRNA 8A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100 %	92,2 1%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	54,39 %	78,4 9%	81,4 5%	84,56 %	71,76 %	75,9 3%	82,14 %	89,23 %	90,14 %	96,55 %	76,92 %
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	99,1 5%	100 %	100%	96,72 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100 %	98,9 1%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.10 ICU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '23	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	98,2 %	100%	100%	100%	100%	100%	98,5%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	98,7 %	100%	100%	94,4 %	98,8%	97,2%	100%	96%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%											
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	81,8 %	92,53 %	86%	90,4 %	100%	100%	80%	90,2%	73,7%	85,96 %	100%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	83,33 %	100%	100%	100%
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU.	100%	100%	100%	100%	100%	90,7 %	95,4 %	94,4 %	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-	0%	0%	1,3%

3.2.1.3.2.11 HCU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-				
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	96,3 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk HCU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.12 IRJA

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,7 5%	100 %	95,7 1%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tunggu rawat jalan	≥80%	95,2 %	91%	95,7 4%	52,7 %	63.8 %	72,8 %	80,9 7%	85,74 %	88,65 %	82,77 %	74,14 %
3	Ketepatan Waktu Jam Praktek Dokter	100%	84,4 2%	82,3 5%	84,0 4%	84,0 4%	70,0 4%	81,7 2%	81,7 2%	81,88 %	81,79 %	58,67 %	53,12 %
4	Angka rujukan horizontal FKRTL	0%	0%	0%	0%	0%	37,0 3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.13 Maternitas

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	99,44 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,63 %	100%	94,67%	100%	100%	100%
6	Kejadian keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Kejadian perdarahan post partum	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
10	Kejadian partus lama	0	1	0	0	0	0	3	4	1	0	1	2
11	Kejadian eklamsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian pre eklamsi	0	3	1	0	0	0	0	0	4	5	7	4
13	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Angka ketidaklengkapan 10T pada ANC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	3,82 %	0,83%	3,6%	8,49%	6,41%	5,69%	10,85 %	11,38%	5,77%	15,49%	11,54%
16	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	3,82 %	0,83%	3,6%	8,49%	6,41%	5,69%	10,85 %	11,38%	5,77%	15,49%	11,54%
17	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0,73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,54%	0%

3.2.1.3.2.14 NICU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥80%	85,92 %	90,63 %	84,72 %	90,8%	84,82 %	82,35 %	88,79 %	81,01%	84,81%	93,75%	78,48%
5	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	4,17%	3,26%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kematian Bayi	0%	0%	0%	0%	0%	3,7%	1,28%	4,55%	0%	7,41%	3,57%	2,94%
7	Kejadian tidak dilakukannya IMD (inisiasi menyusui dini) pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.15 IKO

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	Kejadian konversi tindakan anestesi dari local/regional ke general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kejadian tidak dilaksanakannya asesmen pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian tidak dilaksanakannya pemantauan diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian tidak lengkapnya asesmen pra bedah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidaklengkapan formulir penandaan pasien operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Angka ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC (indikator baru 2024)	0%	0%	0%	23,08 %	0%	0%	20,3 %	20,96%	23,81%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.16 Laboratorium

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,48 %	97,5%	98,9%	99,68 %	100%	98,03%	100%	97,91%	98,22%
3	Kejadian Pengulangan Phlebotomi Saat Sampling	0	3	2	4	2	2	12	15	11	4	7	8
4	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium >140 menit (Indikator baru 2024)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.17 Radiologi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,54 %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	3,72 %	3,61 %	2,65 %	3,81 %	3,81 %	1,63 %	0%	0%	0%	0%	0%
3	Kejadian Ketidapatuhan persiapan pasien USG (Indikator baru 2024)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.1.3.2.18 Gizi

NO	JUDUL	STA ND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,7 6%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
3	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian Pasien Tidak Mendapat Makan	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0

3.2.1.3.2.19 Farmasi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	70,26 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81 %	69,59 %	73,43 %	79,11 %	78,13 %	75,45 %	71,82 %	71,82%	76,95%	74,36%	71,13%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48 %	50,77 %	56,18 %	61,29 %	58,52 %	54,92 %	50,64 %	50,64%	59,94%	50,92%	49,00%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.20 Pengadaan Farmasi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.21 PPI

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,24%	0,8%	0,27%	0 %	0,24 %	0 %	0,25 %	0,52%	0,54%	0,25%	0,28%
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	1,27‰
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,28%	0,22%	0,4%	0,25%	0,34%	0,15%	0,15%	0,04%	0,15%	0,08%	0,11%
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53 %	85,62%	85,62%	85,42%	%	%	85,45%	85,48%
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,04%	93,05%	93,3%	93,52%	93,73%	93,73%	93,92%	93,24%	92,15%	92,21%	92,77%
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan	100%	91,91%	92,09%	92,22%	92,29%	92,19%	92,19%	92,18%	92,07%	91,94%	91,99%	91,6%

	Non Infeksius di Unit Pelayanan												
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

3.2.1.3.2.22 PIPP

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV' 24
1	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	93,15 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepuasan Pasien	76,61%	100%	91,89 %	99,63%	99,82 %	99,63 %	99,63 %	99,63 %	99,38%	99,81%	99,38%	99,91%
5	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	86,94 %	75,31 %	57,76%	52,92 %	55,36 %	55,36 %	43,54 %	38,63%	44,13%	36,01%	27,91%

3.2.1.3.2.23 SDM

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	98,99 %	98,97 %	99,14 %	98,76 %	95,9%	98,93 %	98,96 %	99,62%	98,66%	98,61%	98,64%
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	3,32%	3,34%	2,97%	14,3%	4,12%	5,09%	3,88%	3,48%	3,48%	3,54%	5,69%

3.2.1.3.2.24 Rekam Medis

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Angka Kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap	0%	-	-	96,65 %	93,04 %	94,08 %	93,81 %	93,56 %	92,8%	91,52%	91,6%	92,43%
3.	Kejadian pen pada SIMRS dalam upaya menunjang pelayanan rekam medis rekam medis elektronik (Indikator baru 2024)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	0%	0%	7,06 %	9,44 %	7,88%	5,68 %	4,56 %	5,91%	8,35%	7,07%	7,16%

3.2.1.3.2.25 Keuangan

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Angka keterlambatan pembayaran klaim	0%	7,7%	6%	3,86%	10,98 %	1,57%	0,78%	0,81%	1,1%	0,9%	0,54%	0,76%
2	Kejadian piutang umum atas permintaan sendiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Angka keterlambatan pembayaran klaim BPJS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.26 K3RS

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.27 Asuransi Center

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Angka pending klaim BPJS	0%	1,07%	1,04 %	0,78 %	0,97 %	0,87%	0,62%	0,89%	0,26%	0,26%	0,45%	3,14%
2	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	1,69%	1,04 %	2,17 %	1,66 %	2,55%	1,66%	1,31%	2,21%	2,21%	1,71%	2,04%
3	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	9,73%	0,57 %	0,44 %	0,42 %	0,47%	0,46%	0,55%	0,26%	0,26%	2,01%	0,29%
4	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0

3.2.1.2.28 IPSRS

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	100%	91%	89%	89,47 %	91,67 %	91,67 %	91,84 %	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.29 UMUM

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	3	7	4	3	6	6	2	2	3	2	7
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	11	4	5	2	4	5	9	6	1	4	4

JUDUL MUTU	NOVEMBER
Pengajuan barang ke Pengadaan	surat permintaan pembelian
Keterlambatan barang datang	7 .Aitem *Pot Urin * Botol pum *Jaket primantara *Masker koki *Amplop kaca *Jas Hujan *Box countener
Ketidak patuhan jadwal pengambilan barang(barang tidak di ambil	2 UNIT *Neonatalogi tgl 4 *3c anak tgl 4

3.2.1.3.2.30 Cleaning Service

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	0,25%	1,67 %	29,17 %	28,95 %	91,6 7%	3,45 %	8,7 %	18,75 %	0%	0%	8,77%

3.2.1.3.2.31 Kesekretariatan

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 5 setiap bulannya	0%	34,21 %	0%	20,69 %	78,38 %	48,72 %	26,67 %	36,59 %	42,5%	40%	29,27 %	55,32 %
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	25%	100%	62,5 %	71,83 %	56,25 %	41,67 %	0%	68,75 %	31,25 %	30,77 %	28,57 %
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	65%	-	60,71 %	86,21 %	22,73 %	17,86 %	0%	12,82 %	33,33 %	28%	39,39 %

3.2.1.3.2.31 Laundry

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	0%	5,2%	1,95 %	4,19 %	1,35 %	1,48%	0,96 %	2,42%	2,29%	4,5%	2,25%
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.33 CSSD

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kejadian instrument kurang	0	1	0	1	1	1	1	2	1	0	3	1

3.2.1.3.2.34 Humas dan Pemasaran

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '34	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Angka kunjungan rawat inap >80 pasien perhari	0%	99,17 %	90,88 %	100%	100%	100%	98,65 %	99,64 %	99,8%	100%	99,4%	99,84 %
2	Angka kunjungan rawat jalan >300 pasien perhari	0%	93,71	100%	92,82 %	92,82 %	91,73 %	87,44 %	94,21 %	92,72 %	90,69 %	93,3%	92,77 %

3.2.1.3.2.35 IT

NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Respontime penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	96,97 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.36 Kamar Jenazah

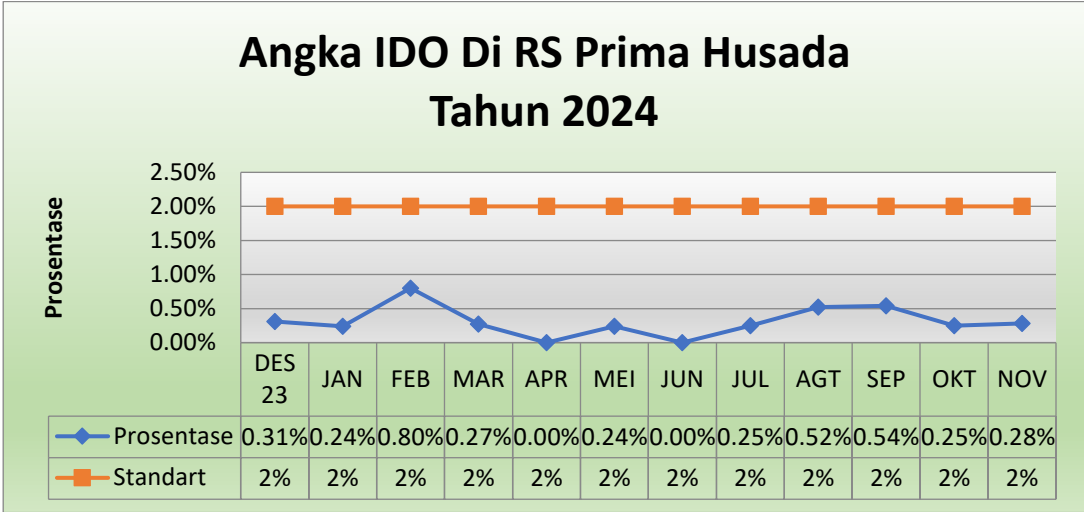
NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24	OKT '24	NOV '24
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.6.3 Komite PPI

3.6.3.5 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

3.6.3.5.1 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

3.1.1.1.1 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO):

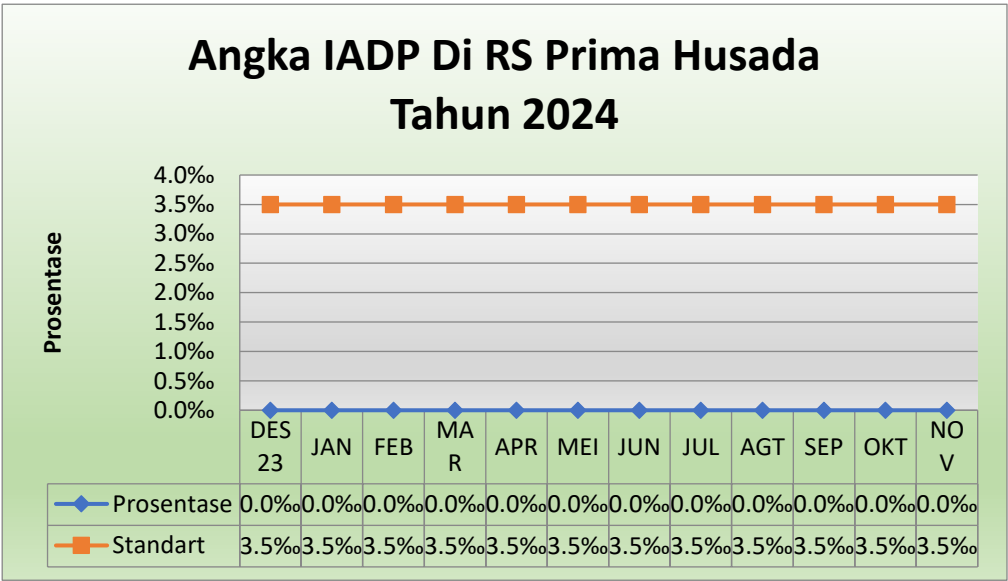


Analisa	Dari grafik diatas diperoleh data terdapat sedikit peningkatan angka infeksi daerah operasi pada bulan ini jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu mencapai 0,28%. Namun jika dilihat dari jumlah insidennya masih tetap sama terdapat 1 laporan kasus IDO yang ditemukan pada pasien post SC (PEB+prolong fase laten). Dari hasil assesmen pasien diperoleh data bahwa pasien berusia 16 tahun dan mengalami tensi tinggi dan leukosit sebelum operasi sudah mulai naik yaitu 11.210. Selain itu pasien sebelum melakukan operasi juga tidak sempat melakukan mandi menggunakan sabun/antiseptic. Pada saat operasi, pasien bersamaan dengan pasien bedah lain namun berbeda ruang operasi. Pasien tidak dilakukan rawat luka pasca operasi dan dilakukan rawat luka pertama kali pada saat kontrol 1 di poli obgyn dan ditemukan luka mengeluarkan nanah. Pasien sudah dilakukan edukasi perawatan saat dirumah. Dikarenakan usia pasien yang terlalu muda dan mengalami kondisi eklamsi sangat rentan sekali terjadi infeksi luka operasi. 
Masalah saat ini	1. Pasien dengan kondisi klinis khusus, perlu mendapatkan perhatian lebih terutama pasien post SC anak 1 dengan usia yang masih terlalu muda, edukasi pada proses perawatan ibu sendiri dan bayinya saat dirumah sangat penting, karena dapat berpengaruh pada proses penyembuhan luka.
Permasalahan sebelumnya	2. Kondisi terdapat penyakit penyerta (anemia & leukositosis) sangat berisiko tinggi terjadi infeksi luka operasi, edukasi perawatan pasien di rumah belum dilakukan maksimal karena pasien masih tidak banyak bergerak.
Tindakan yang dilakukan	1. Lebih sering melakukan evaluasi langsung terkait kebersihan kamar operasi. 2. Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO sesuai di ruang perawatan pasien. 3. Melakukan evaluasi proses edukasi pada pasien post operasi dengan memastikan pemahaman dari pasien/keluarganya, terutama terkait perawatan saat di rumah dan lebih menekankan pada keluarga yang tinggal serumah dan yang membantu kebutuhan ADL ibu dan bayi. 4. Memberikan masukan pada bidan yang merawat pasien pre-operasi untuk tetap melakukan mandi antiseptic, bisa hanya dengan diseka sebelum dilakukan operasi saat keadaan urgent.

Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Lanjutkan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan pasien di rumah	Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	Pasien post operasi.	1. Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. 2. Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik) 3. Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. 4. Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama pada ibu muda yang baru memiliki anak.	1. Perawat /Bidan 2. Karu 3. IPCLN/IPC�	Satu bulan
Memastikan bundle IDO berjalan dengan baik.	Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	Pasien operasi	1. Melakukan monitoring status kesehatan pasien yang akan dilakukan operasi. 2. Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. 3. Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi risiko infeksi. 4. Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik)	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPC�	Satu bulan

3.6.1.1.2 IADP

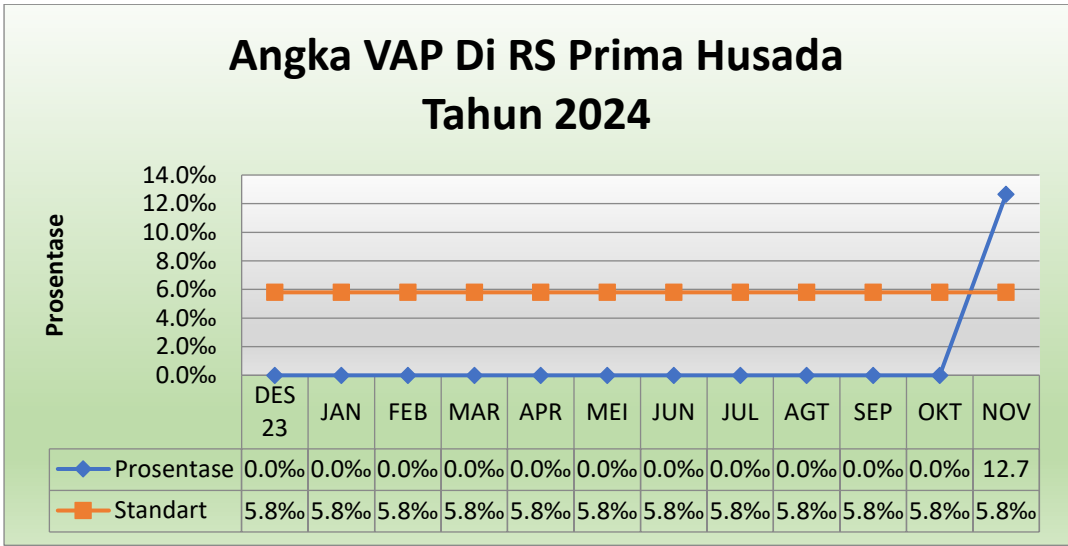
3.6.1.1.2.1 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 79 hari total lama pemasangan CVC pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. 2. Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Melakukan monitoring 5. perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCN	Satu bulan

3.6.1.1.3 VAP

3.6.1.1.3.1 Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)

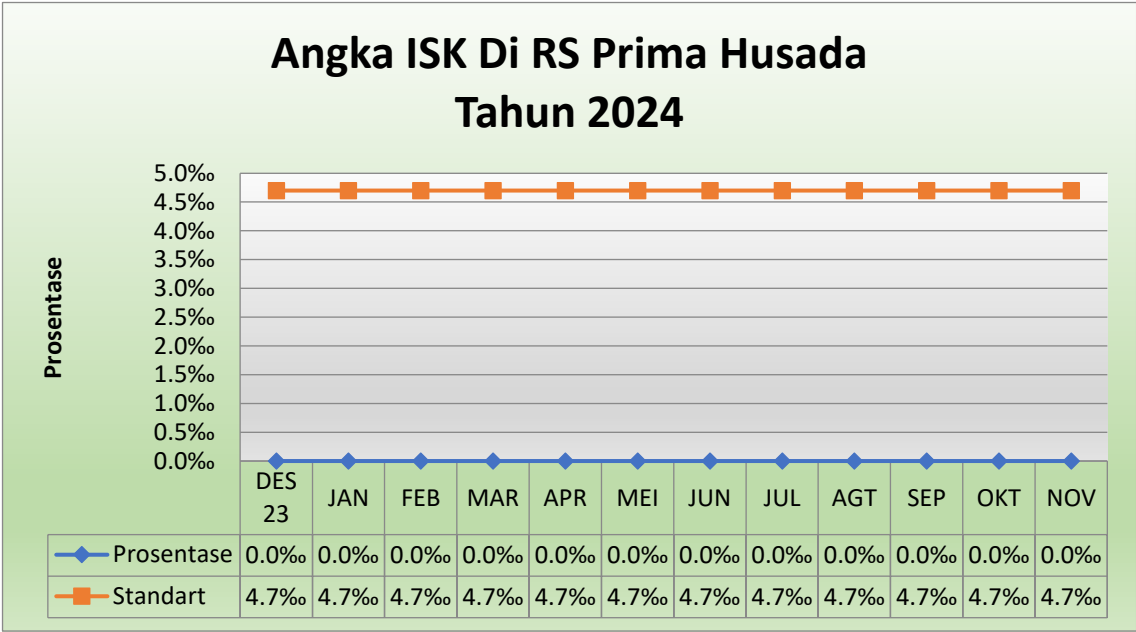


Analisa	Pada bulan ini ditemukan 1 kasus VAP pada 79 hari lama pemasangan ventilator. Dari hasil analisa, pasien mengalami gejala demam dan produksi secret purulen. Saat dilakukan rontgent thorak didapatkan hasil bacaan Pneumonia (lesi baru), leukosit juga mengalami peningkatan (11.020), fiO2 60% (kurang dari 250%) dan saat dilakukan pengecekan prepareate gram didapatkan bakteri coccus gram positif. Dari hasil monitoring audit bundle, pada pasien ini jarang sekali dilakukan oral hygiene, dengan ditandai mukosa bibir pasien yang kering. Untuk tindakan suction sudah rutin dilakukan sebanyak 3x sehari setelah dilakukan terapi nebulasi. Suction yang digunakan juga sudah menggunakan closed suction				
Masalah saat ini	Oral hygiene belum dilakukan dengan baik dan rutin.				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. 2. Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. 3. Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. 4. Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. 5. Koordinasi dengan kabid keperawatan untuk mewajibkan & menertibkan oral hygiene setiap 4 jam sekali pada seluruh pasien yang terpasang ventilator mekanik dan mendokumentasikan pada Askep atau CPPT.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

			6. Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.		
--	--	--	--	--	--

3.6.1.1.4 ISK

3.1.1.1.4.1 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)

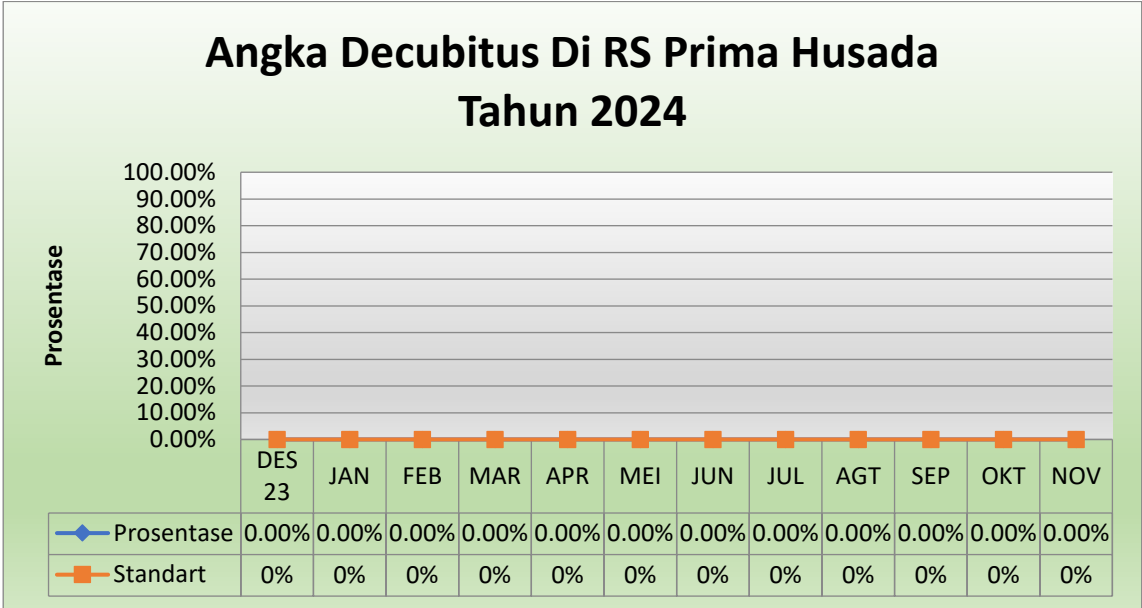


Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1032 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Pasien yang terpasang kateter	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi,	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

			pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.5 Decubitus

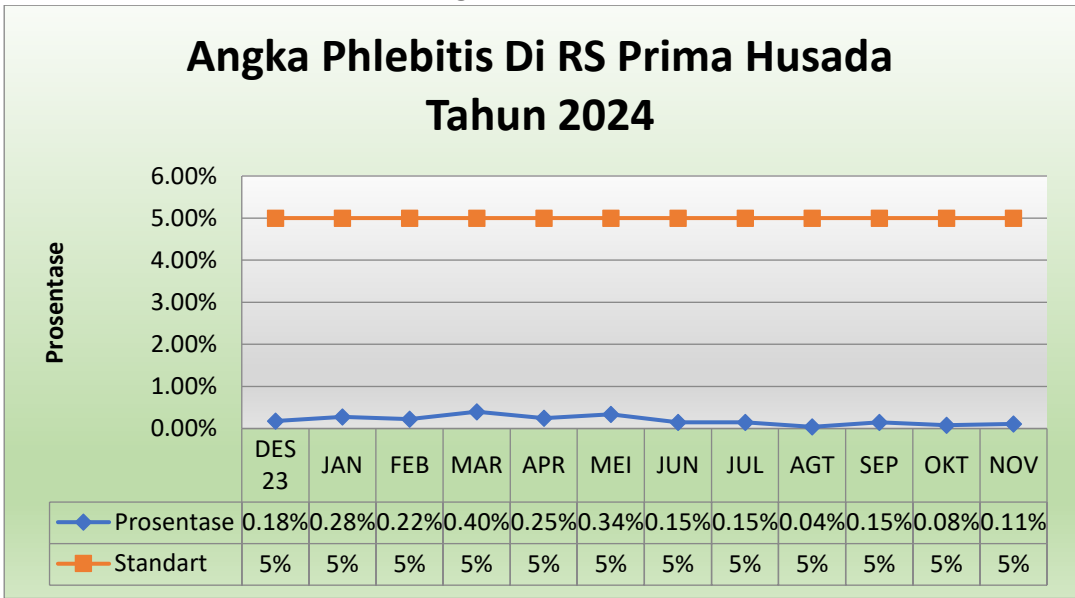
3.1.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 6 pasien tirah baring lama.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi decubitus				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi decubitus				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 4. Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan

3.6.1.1.6 Phlebitis

3.6.1.1.6.1 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

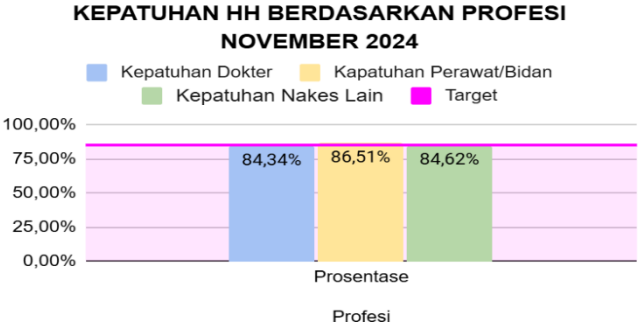
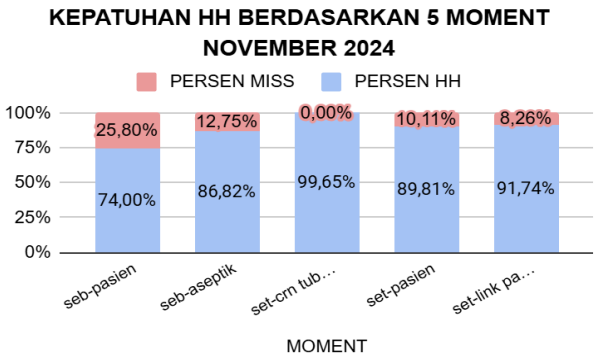
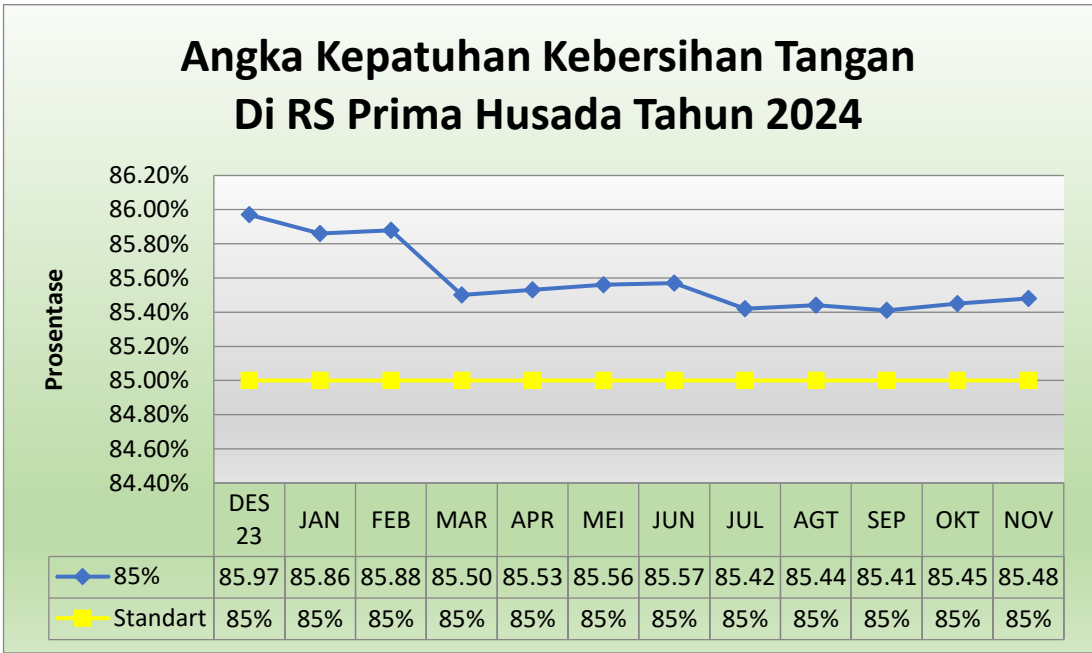


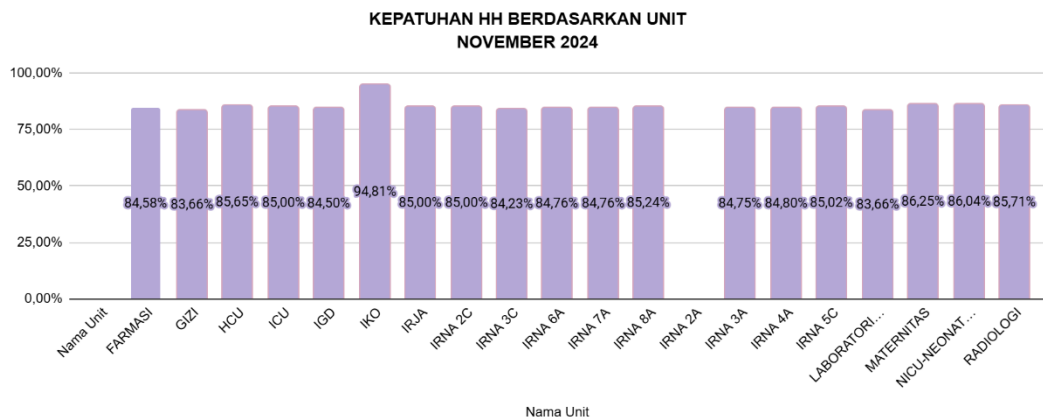
Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2691 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,11%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh, 2 pasien yang mengalami phlebitis karena mendapat cairan infus pekat NS 3% karena kondisi perbaikan elektrolit dan drip amiodaron pada D5%. 1 pasien lainnya hanyamendapat terapi antibiotic biasa, namun Lokasi pemasangan infusnya berada pada area bekas tusukan sebelumnya yang pembuluh darahnya pecah saat dipasang infus. Dari 5 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis), namun pada saat monitoring di ICU menemukan 1 pasien infusnya slong dan perawat tidak tahu.				
Masalah saat ini	1. Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, meskipun sediaannya sudah berupa cairan infus 500 ml, namun karena pemberiannya rutin untuk menaikkan kadar elektrolit s.d normal dan penggunaan cairan D5% yang juga pekat dan sangat beresiko phlebitis. 2. Pemilihan Lokasi tusukan infus juga mempengaruhi resiko phlebitis. 3. Kontrol tetsan infus belum dilakukan dengan baik.				
Permasalahan sebelumnya	1. Penggunaan antibiotik pekat menimbulkan resiko phlebitis tinggi, proses penyuntikan yang cepat juga menyebabkan mudah phlebitis. 2. Penggunaan cairan pekat seperti NS 3% yang meskipun sediaannya sudah berupa cairan infus 500 ml, namun karena pemberiannya rutin untuk menaikkan kadar elektrolit s.d normal masih beresiko tinggi phlebitis.				
Tindakan yang dilakukan	1. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan atau tetesan terlalu cepat karena jika yang dimasukkan adalah cairan pekat dapat beresiko tinggi phlebitis, termasuk juga pada tetesan infus biasa untuk menghindari infus slong. 2. Menganjurkan perawat untuk memilih iv canula yang sesuai dengan kebutuhan pasien (lihat besarnya pembuluh darah & rencana pengobatan yang akan diberikan, usahakan menggunakan iv canula ukuran besar). 3. Menganjurkan perawat untuk melakukan pemilihan Lokasi tusukan infus yang tepat, tidak mendekati area bekas tusukan yang pecah atau yang menghalangi tindakan lainnya. 4. Mengajarkan perawat saat memberikan obat injeksi dengan melancarkan aliran infus dan mengusap aliran infus pada pasien dengan alkohol swab untuk melancarkan dan mengurangi nyeri.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	1. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. 2. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. 3. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. 4. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 5. Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. 6. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
---------------------------------------	---	-----------------------------	---	--	------------

3.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

3.6.1.1.7.1 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)

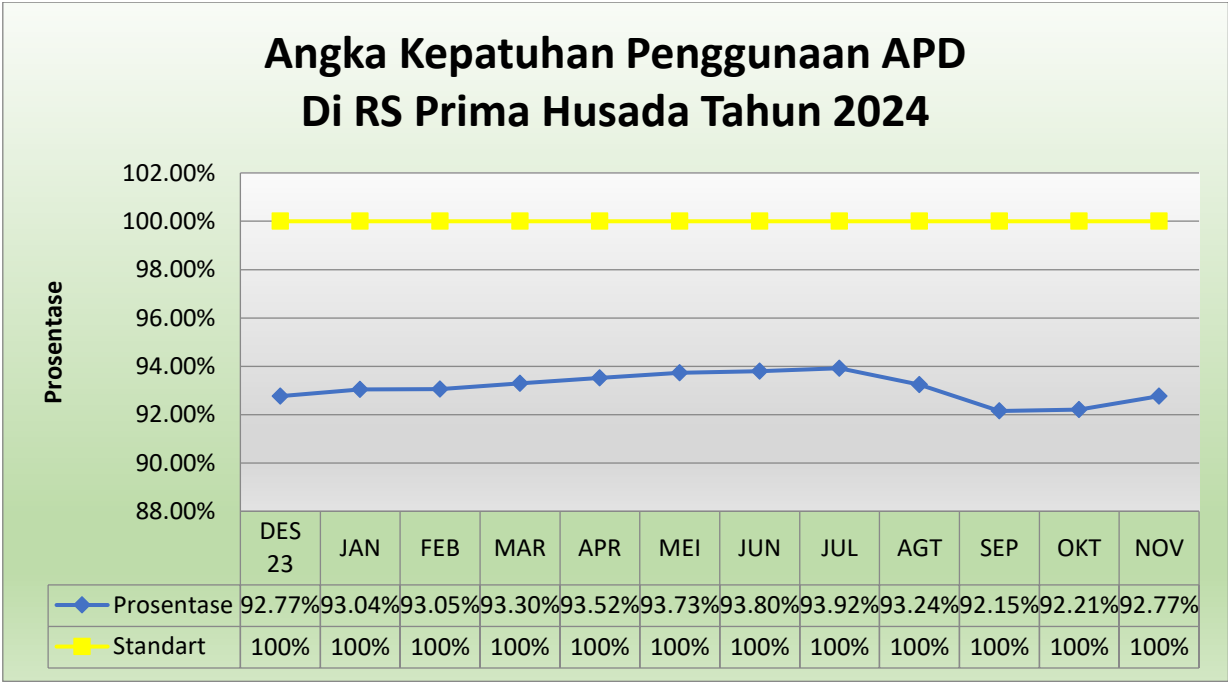




Analisa	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,48%. Jika dilihat berdasarkan profesi, masih ditemukan prosentase di bawah standart yaitu pada profesi dokter (84,34%) dan nakes lain (84,62%) dimana berdasarkan 5 moment cuci tangan, kebanyakan dari petugas tidak melakukan moment sebelum kontak dengan pasien (74%). Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena persepsi yang salah dan kurangnya kesadaran petugas terkait pentingnya kebersihan tangan seperti pada profesi dokter yang lebih memilih untuk memakai sarung tangan (handscoon) namun juga melakukan cuci tangan dengan handrub yang tidak efektif jika masih memakai handscoon.				
Masalah saat ini	Kurangnya kesadaran petugas terhadap pentingnya cuci tangan dan persepsi kebersihan tangan yang salah.				
Permasalahan sebelumnya	1. Petugas paham terkait 5 momen cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien. 2. Penggunaan APD berlebihan (handscoon) menyebabkan petugas malas melakukan cuci tangan, bahkan ada yang handrub dengan memakai sarung tangan.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. 3. Memberikan proses pembelajaran dengan membuat video pendek edukasi cuci tangan supaya lebih mudah untuk mengingat. 4. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



Analisa	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 92,77% meningkat dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, ketidakpatuhan paling banyak masih pada petugas penunjang pelayanan seperti pengolah makanan yang jarang menggunakan masker dengan benar, namun dari pihak penyaji makanan sudah mulai tertib memakai APD dengan benar. Dari petugas perawatan pasien, masih ditemukan perawat yang akan melakukan rawat luka tidak menggunakan handscoon steril (hanya handscoon bersih yang disemprot alcohol). Selain itu, ketidakpatuhan masih ada pada beberapa DPJP yang egois memakai APD untuk keselamatan sendiri tidak memperhatikan keselamatan pasien.				
Masalah saat ini	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi.				
Permasalahan sebelumnya	1. Ketidakpatuhan masih dilakukan oleh petugas dapur (pengolah makanan), yang tidak tertib memakai masker. 2. Ketidakpatuhan pemakaian APD juga masih dilakukan oleh DPJP dimana masih menggunakan APD lengkap saat hanya visite pasien saja.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). 5. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. 2. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 3. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 4. Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

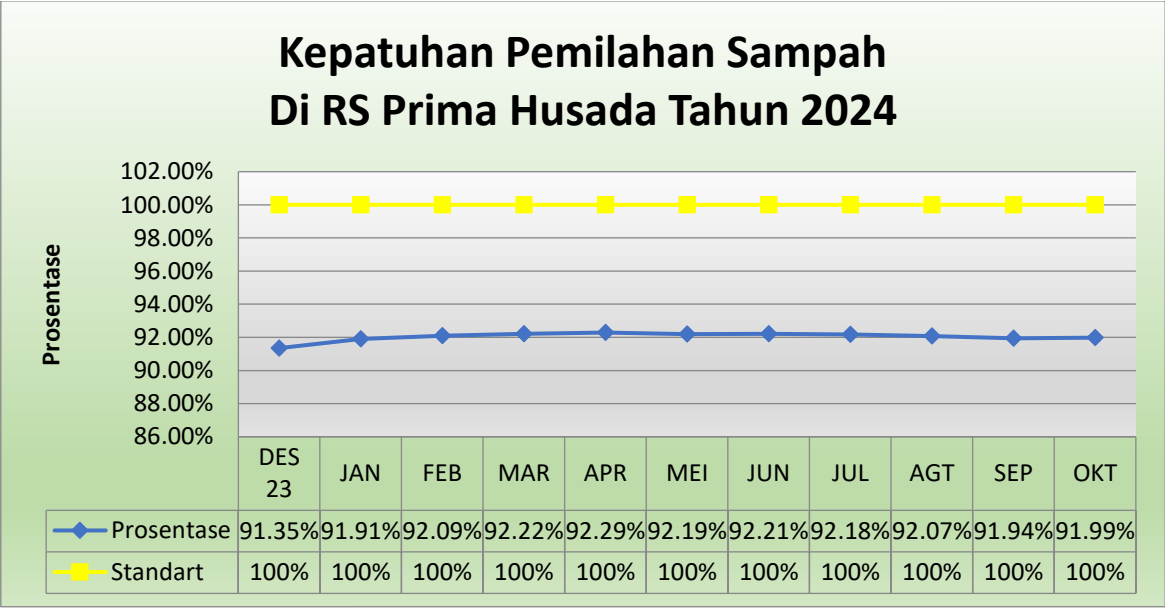
			5. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 6. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.9

Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius

3.6.1.1.9.1

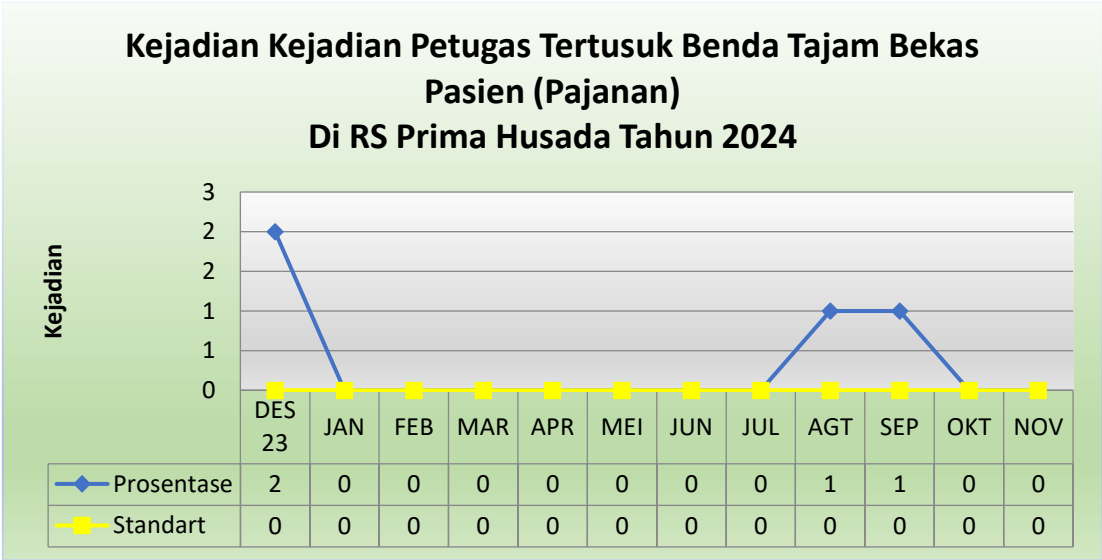
Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



Analisa	Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 91,60%, sedikit menurun dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas yang tidak melakukan pemilahan dengan baik saat melakukan tindakan seperti pada ruangan ICU yang membuang sampah bungkus alkes jadi satu pada kresek kuning. Selain itu, di ruangan lain juga ditemukan sampah bungkus spuit terkadang dibuang di safety box juga dengan jarumnya.				
Masalah saat ini	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius.				
Permasalahan sebelumnya	Kebiasaan malas petugas membuang isi cairan di botol infus saat tidak ada yang mensupervisi dan beranggapan jika sampah plastik bungkus alkohol swab kecil tidak akan menambah berat timbangan sampah.				
Tindakan yang dilakukan	1. Mengajukan menyiapkan kresek hitam dan kresek kuning pada saat akan melakukan tindakan yang sekiranya akan menghasilkan banyak sampah non infeksius dan infeksius. 2. Memberikan proses pembelajaran langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera mengajukan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar. 3. Melakukan monitoring pemilahan sampah saat melakukan tindakan. 4. Melakukan supervisi pada tempat sampah yang ada di unit-unit. 5. Menjelaskan terkait proses pembayaran saat membuang sampah infeksius pada pihak ke-3 tergantung dari berat timbangan sampah, untuk menyadarkan bahwa kesalahan pembuangan sampahnya dapat merugikan rumah sakit.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan edukasi ulang pada staf tentang pemilahan sampah. 2. Berikan proses pembelajaran pada petugas unit saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera mengajukan untuk membenarkan bila memungkinkan. 3. Sampaikan kesalahan pembuangan unit pada kepala unit dan IPCLN unit dalam forum rapat PPI maupun grup WA. 4. Saran memindahkan sampah infeksius yang ada di area umum. 5. Ingatkan terkait aturan pembuangan cairan infus pada wastafel/spoelhoek sebelum membuang botolnya.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam

3.6.1.1.10.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



Analisa	Tidak ditemukan kejadian pajanan.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi pajanan				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi pajanan				
Tindakan yang dilakukan	1. Tetap mewajibkan penggunaan safety box pada troli tindakan saat melakukan tindakan dengan langsung membuang limbah benda tajam yang dihasilkan. 2. Menganjurkan kepala ruang & PJ shift untuk juga mengoperkan ruangan dan troli tindakan dalam keadaan bersih setiap pergantian shiftnya. 3. Melakukan monitoring pemilahan sampah saat melakukan tindakan. 4. Melakukan monitoring recapping tutup jarum, dimana 5 dari 8 petugas yang diamati tidak one hand saat melakukan recapping, 3 diantaranya melakukan one hand namun saat merasa tidak diawasi kembali tidak melakukan one hand.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan proses pemilahan sampah yang benar dan pengelolaan benda tajam yang baik.	Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. 2. Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. 3. Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. 5. Monitoring teknik recapping tutup jarum.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

NO	UNIT	TARGET	SEP	OKT	NOV	%	MANDOK	KETERANGAN
1	IRNA 2C	8x/Bulan	100%	75%	100%	Tercapai	Ada	
2	ICU HCU	8x/Bulan	0%	100%	0%	Menurun	Ada	
3	IRNA 3C	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
4	MATERNITAS	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
5	PERINATOLOGI	8x/Bulan	100%	100%	75%	Menurun	Ada	
6	IRNA 5C	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	

7	IRNA 2A,3A,4A	8x/Bulan	100%	75%	75%	Tetap	Ada	
8	IRNA 6A,7A,8A	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
9	IGD	8x/Bulan	75%	100%	50%	Tidak tercapai	Ada	
10	FARMASI	8x/Bulan	75%	75%	75%	Tetap	Ada	
11	GIZI	8x/Bulan	25%	100%	100%	Tercapai	Ada	
12	IRJA	8x/Bulan	100%	100%	75%	Menurun	Ada	
13	PPI		100%	100%	100%	Tercapai	Ada	

Analisis : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan November mengalami penurunan bulan November , kinerja produktivitas saat ini kembali menjadi 80.7% diakibatkan unit Irna 2,3,4A, Irna 2C DAN Farmasi belum mencapai target edukasi kelompok

Rencana Tindak Lanjut : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan Desember.

3.6.3.2 KIE Individu

NO	UNIT	TARGET	SEP	OKT	NOV	%	KETERANGAN
1	IRNA 2C	100%	100%	100%	100%	100%	
2	ICU HCU	100%	100%	100%	100%	100%	
3	IRNA 3C	100%	100%	100%	100%	100%	
4	MATERNITAS	100%	100%	100%	100%	100%	
5	PERINATOLOGI	100%	100%	100%	100%	100%	
6	IRNA 5C	100%	100%	100%	100%	100%	
7	IRNA 2A,3A,4A	100%	100%	100%	100%	100%	
8	IRNA 6A,7A,8A	100%	100%	100%	100%	100%	
9	IGD	100%	100%	100%	100%	100%	
10	FARMASI	100%	100%	100%	100%	100%	
11	GIZI	100%	100%	100%	100%	100%	
12	IRJA	100%	100%	100%	100%	100%	

Analisis : Hasil Edukasi individu unit pada bulan oktober tercapai 100%, terbukti dalam lembar edukasi kolaborasi DRM telah terisi.

Rencana Tindak Lanjut : -

3.6.3.3 Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Edukasi (DRM) Edukasi

NO	LEMBAR DRM	JML SAMPLE	KELENGKAPAN		ISI BENAR	VERIFIKASI KE PASIEN	KET
			YA	TIDAK			
1	General Consent	30	30	0			Seluruh DRM telah terisi.
2	SBAR di IGD	30	30	0	YA	YA	Seluruh DRM SBAR Terisi Lengkap
3	Perencanaan Edukasi / Rencana Asuhan	30	3	27	Benar Tidak		Pengsian perencanaan edukasi kodingnya tidak sesuai, 27 drm pada perencanaan edukasi tidak tertulis nama petugas dan pasien atau keluarga pada ttd
4	Pengkajian Kebutuhan KIE	30	30	0	YA	YA	
5	KIE Informed Consent	30	23	7			Pada TTD Petugas tidak

							tertulis nama Irna dan Tidak tertulis nama pasien/keluarg a pada TTD
6	CPPT	30	30	0	YA	YA	
7	Ringkasan Pasien Pulang	30	30	0			Seluruh DRM terisi lengkap
8	Discharged Planning	10	5	5	YA	YA	50% Discharged Planning terisi tetapi tidak terintegrasi pada Pendokumenta sian di DRM Edukasi Kolaborasi
9	Edukasi kolaborasi	30	20	10			Disetiap unit ditemukan 2 DRM yang tidak lengkap yaitu kekurangan nama jelas pada petugas yang memberikan edukasi dan verifikator dilakukan oleh petugas itu sendiri bukan KARU
11	KIE Menjelang Akhir Kehidupan (Pada Pasien yang mau meninggal)	1	0	1			Perencanaan edukasi AS Menjelang akhir kehidupan tidak terdokumenta sikan pada drm
12	Form AMA	1	1	0			Form AMA Terisi lengkap di DRM Unit Maternitas (3 edukasi ada pernyataan tulis tangan)
13	KIE Pre OP di Lembar Pre OP	6	6	0			Pre dan post op terisi lengkap

3.6.3.4 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	SEPT	OKT	NOV	%	MANDOK	KET
Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya						

Perempuan		wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	100%	Ada	
General Meeting Karyawan	1x/2Bulan			100%			Terlaaksana	
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.5 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

NO	UNIT	TARGET	SEP	OKT	NOV	%	MANDOK	KETERANGAN
1	PONEK	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
2	HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
3	STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
4	KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
5	TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	

Analisis

: Penanggungjawab PROGNAS Inaktif selama Tahun 2024 tidak melakukan kegiatan edukasi kelompok

Rencana Tindak Lanjut

: Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat menghidupkan kembali kegiatan PROGNAS

3.6.4 Tim Prognas

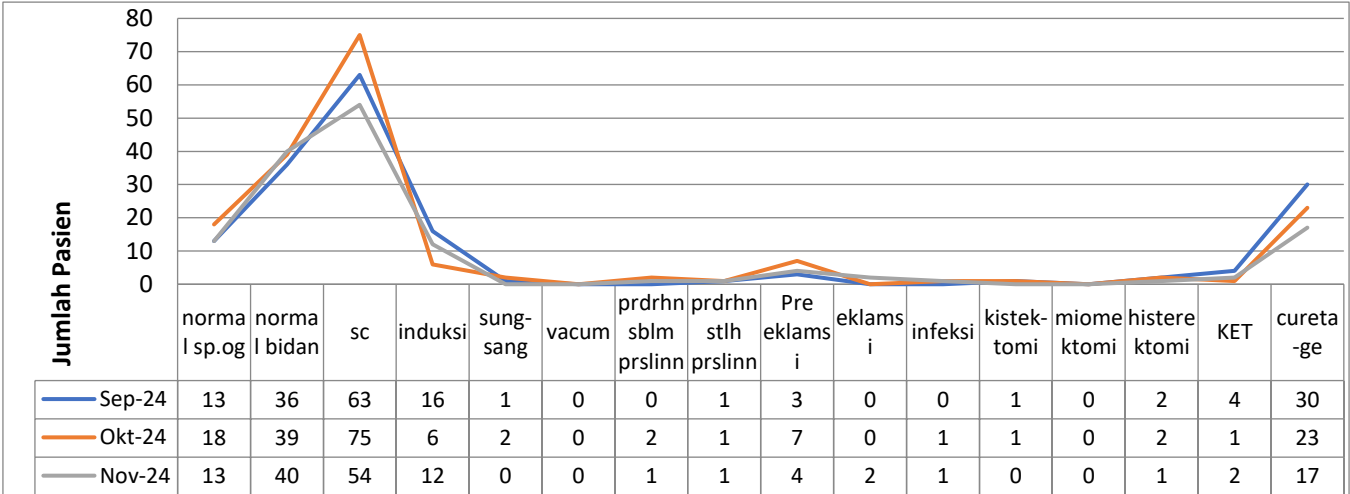
3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek November 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEP 2024	BULAN OKT 2024	BULAN NOV 2024
1				
	a. Persalinan Normal Sp. OG	13	18	13
	b. Persalinan Normal Bidan	36	39	40
	c. <i>SectioCaesaria</i>	63	75	54
2				
	a. Induksi / Drip	16	6	12
	b. Sungsang	1	2	0
	c. Vacuum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	2	1
	b. Perdarahan setelah Persalinan	1	1	1
	c. Pre Eklamsi	3	7	4

4	d. Eklamsi	0	0	2
	e. Infeksi	0	1	1
	a. Curretage	30	23	17
	b. Kistektomi	1	1	0
	c. Miomektomi	0	0	0
	d. Histerectomy	2	2	1
	e. KET	4	1	2

1.6.2.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :

- Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan November 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 54 pasien. Dan untuk persalinan normal ditolong dokter pada bulan November 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 13 pasien. Sedangkan persalinan yang ditolong oleh bidan sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 40 pasien. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
- Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
- Tidak ada persalinan dengan sungsang pada bulan November, sedangkan pada bulan Oktober terdapat 2 pasien, dan 1 pasien pada bulan September 2024. Untuk persalinan dengan vacuum pada bulan September sampai dengan November 2024 tidak ada.
- Induksi Persalinan pada bulan November mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 12 pasien
- Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan November menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 4 pasien. Dan ada kejadian eklamsi pada bulan November yaitu 2 pasien
- Jenis pelayanan curretage di bulan November menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 23 pasien. *Curretage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted

ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

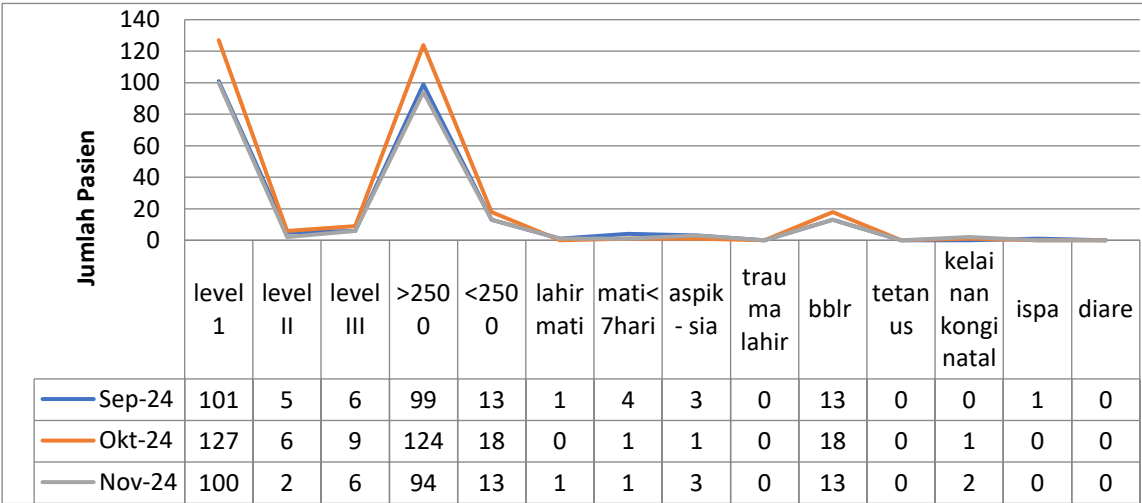
- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- 2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.6.4.1.2 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.2.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek Oktober 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEP 2024	BULAN OKT 2024	BULAN NOV 2024
1				
	a. Level 1	101	127	100
	b. Level II	5	6	2
	c. Level III	6	9	6
2				
	a. ≥ 2500 gram	99	124	95
	b. ≤ 2500 gram	13	18	13
3				
	a. Kelahiran Mati	1	0	1
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	4	1	1
4				
	a. Asphyxia	3	1	3
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	13	14	13
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	1	1	2
	f. ISPA	1	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.2.1.2.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :

- 1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan November 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 100 bayi. Dan pada level 2 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 2 bayi. Sedangkan pada level 3 juga menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 6 bayi.
- 2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan November 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya tetap sebanyak 94 bayi.
- 3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan November 2024 juga menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 13 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
- 4. Kasus BBLR pada bulan November 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 13 bayi.
- 5. Ada 1 kasus kelahiran mati pada bulan November dan September, sedangkan pada bulan Oktober tidak ada.
- 6. Kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan November dan Oktober ada 1 kasus kematian bayi, dan 4 bayi pada bulan September

Rencana dan Tindak Lanjut

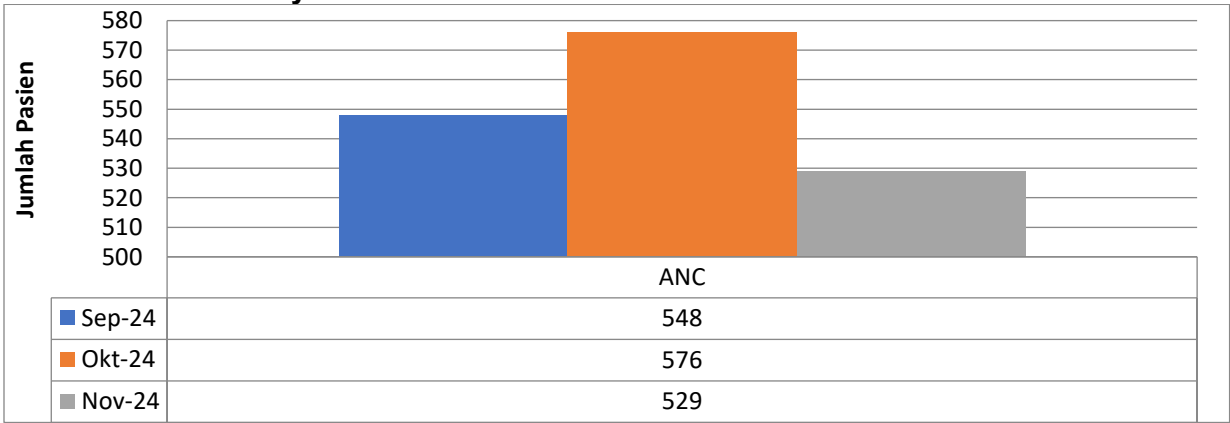
- 1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

3.6.2.1.2.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)

Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponek November 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN SEP 2024	BULAN OKT 2024	BULAN NOV 2024
1	ANC	548	576	529

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :

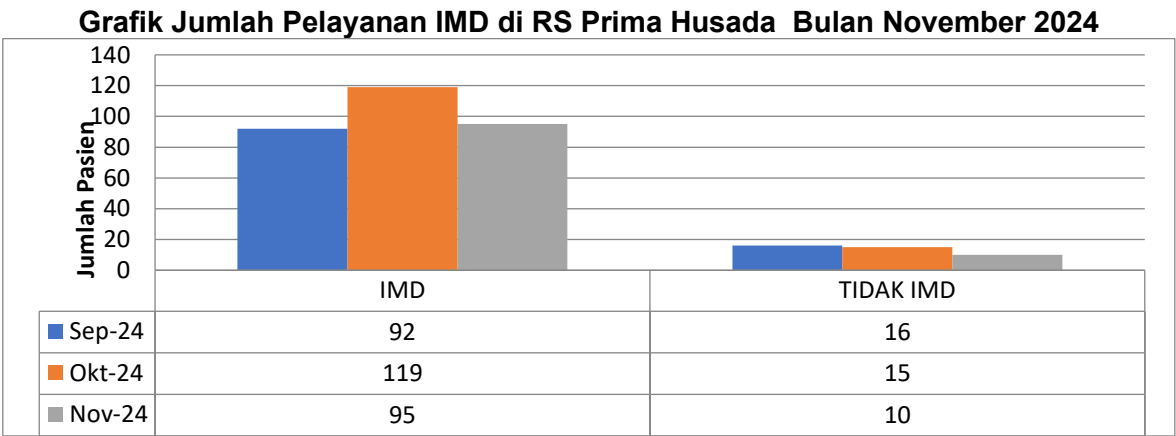
Pelayanan ANC pada bulan November 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 529 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.6.1.2.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) November 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024
1	IMD	92	119	95
2	Tidak IMD	16	15	10



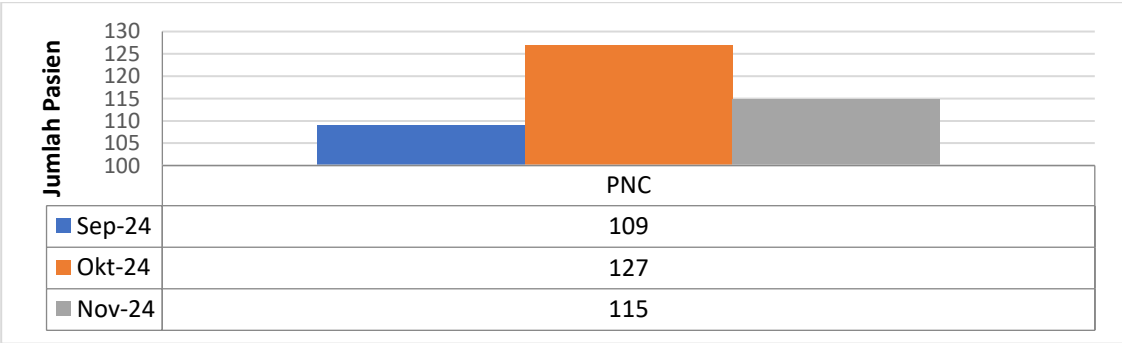
- Analisis :**
- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan November 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 95 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
 - 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan November 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
 - 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atau tidak.

3.6.1.2.5 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek November 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024
1	PNC	109	127	115

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :

Pelayanan PNC pada bulan November 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 115 kunjungan.

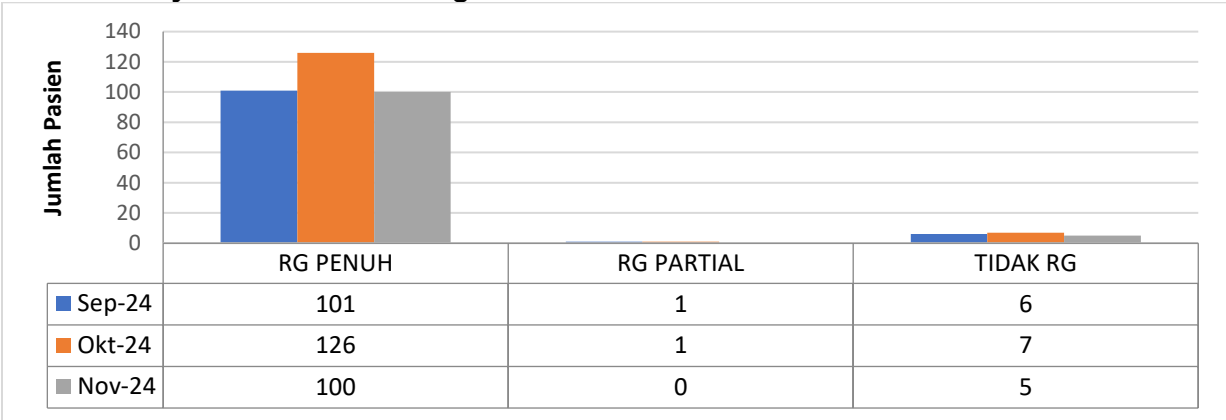
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek November 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024
1	Rawat gabung penuh	101	126	100
2	Rawat gabung partial	1	1	0
3	Tidak Rawat gabung	6	7	5

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :

- Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan November 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 100 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan November menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 5 bayi.
Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan.

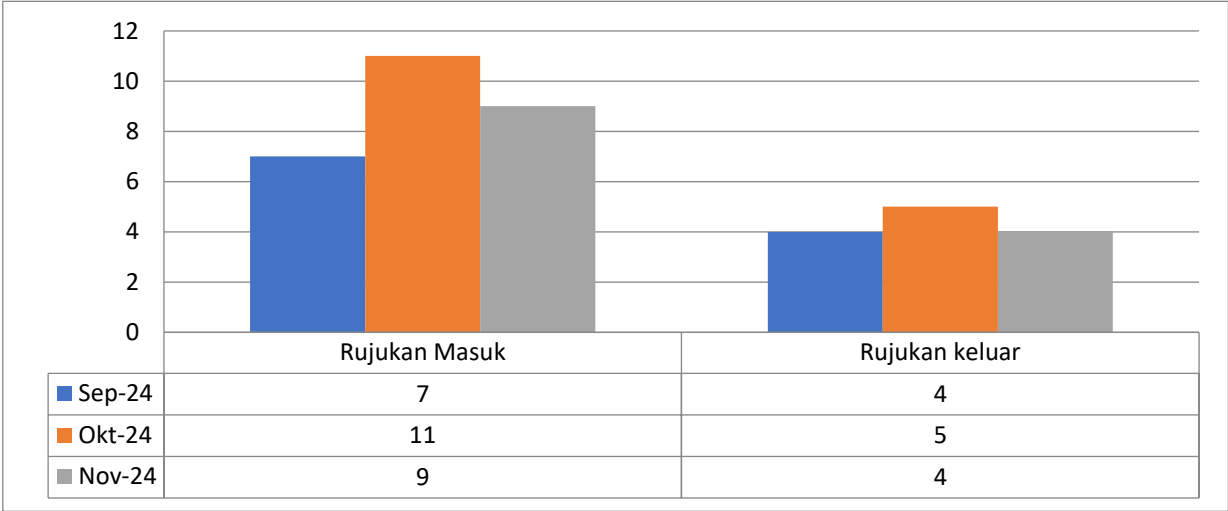
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponek November 2024

NO	RUJUKAN	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024
1	Rujukan Masuk	7	11	9
2	Rujukan keluar	4	5	4

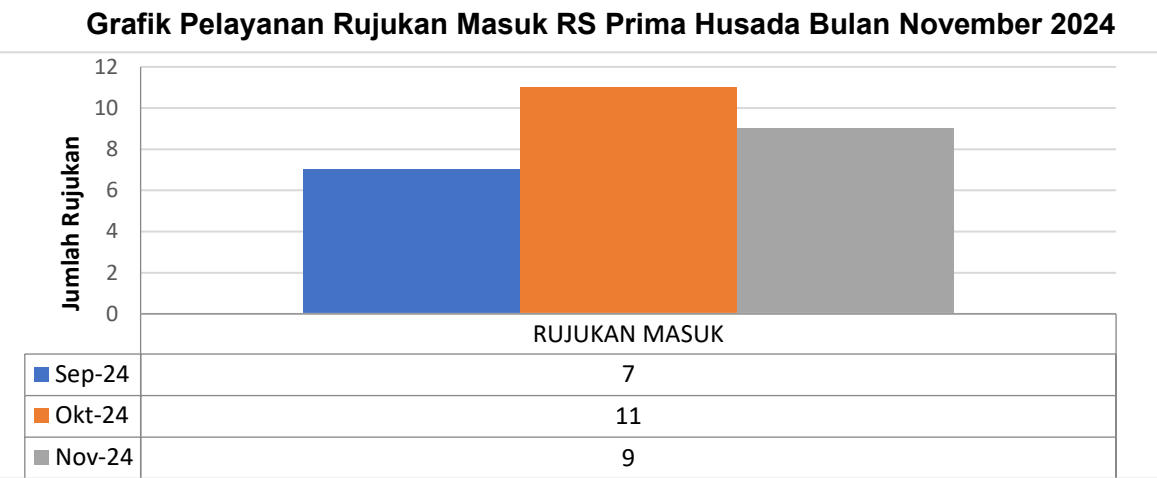
Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan November 2024



3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponpek November 2024

BULAN SEPTEMBER 2024		
1	G3 P2002 Ab000 UK 20-22 mgg dg PPI	BPM Tri W
2	G3 P2002 Ab000 UK 38-39 mgg dg KPD	Poskesdes Langlang
3	G1 P0000 Ab000 UK 38-40 mgg dg KPD	PMB Indi
4	Intrauterin Abnormal Bleeding +anemia	Klinik Tirta Husada
5	G3 P2002 Ab000 UK 38-40 mgg dg BSC	PMB Indi
6	Abortus inkomplit	Klinik Rawat Inap Muslimat
7	G3 P2002 Ab000 UK 33-34 mgg dg PPI + Gemeli + BSC	RS Permata Bunda
BULAN OKTOBER 2024		
1	G1 P0000 Ab000 uk 10-12 mgg dengan Abortus Inkomplit	Bidan Tri Widiyawati
2	G1P0000 Ab000 uk 16-18 mgg dg Mola Hidatidosa	Bidan Tri Widiyawati
3	G1 P0000 Aboo uk 36-37 minggu dg Kifa	Pkm Tumpang
4	G2 P1001 Aboo uk 20-22 minggu + Missed Abortion	Bidan Zeni Dwi
5	P3 P2002 Ab000 uk 38-39 mgg dgn Kala 2 + Bsc	Bidan Herawati
6	G2 P1001 Ab000 uk 34-36 mdg PPI + BSC	RSUD Lawang
7	HPP a/i Retensio Plasenta + Ruptur Derajat 3	Bidan Munawaroh
8	G2 P1001 Ab000 uk 42-43 mgg dg Post Date + PER + KIFL	Bidan Wahyu
9	P2002 Ab000 dg Post Partum + HPP + Anemia	Bidan Tri Widiyawati
10	P3003 Ab000 dengan Retensio Plasenta	PKM Singosarei
11	G4 P3003 Ab 0 uk 37-38 mgg dgn KIFL + PE	Bidan Lilik Agustina
BULAN NOVEMBER 2024		
1	G3 P1001 AB100 UK 10-12 Mgg dg Abortus Inkomplit	Bidan Tri Widiyawati
2	G2P1001AB000 UK 41-42 Mg Dg K1FA + Post date	Bidan Fitri Dwi

3	G1P000 ABOO UK 34-36 Mgg + KPD JAM 03.00	Bidan Dilla Sobirin
4	G1 P0000 AB000 UK 30-31 Mgg Dg PPI	Bidak Titik Sunariyarti
5	G1P0000AB000 UK 39-40 Mgg + Kala 2 Lama	PKM Ardimulyo
6	G1P000 ABOO 40-41 Mgg + Prolong KIFL	Bidak Titik Sunariyarti
7	G2 P1001 AB000 UK 39-40 Mgg DG BSC 5 TH + KIFL	Bidan Nurul Ismawati
8	G1P0AB0 UK 37-38 MGG DG PE	Bidan Nuiana
9	G1 PO AB 0 UK 30-32 Mgg Dg KALA 2 + PPI Primi Muda	Bidan Tri Widiyawati



Analisis :

Jumlah rujukan masuk pada bulan November 2024 menurun menjadi 9 rujukan, sedangkan pada bulan Oktober 11 rujukan dan September yaitu 7 rujukan masuk

Rencana dan Tindak Lanjut

Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

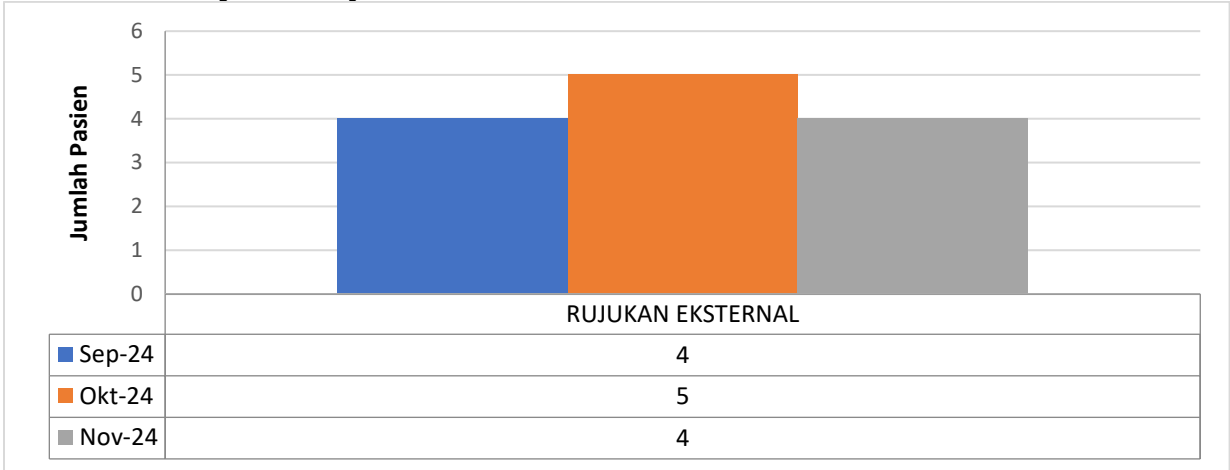
3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar

Tabel Rujukan Keluar Ponек November 2024

BULAN SEPTEMBER 2024		
1	Neonatal pneumonia dd MAS, Susp PJB kritis dd PPHN, Asfiksia	RS Saiful Anwar
2	BBLR + obs distress nafas + neonatal pneumonia dd RDS Ok labiognatopalatoschizis	RS Soepreoen
3	RDS Ok HMD dd neonatal pneumonia	RS Soepraoen
4	Susp PPHN	RS Saiful Anwar
BULAN OKTOBER 2024		
1	NP-SC + BBLR + Obs distress nafas ok neonatal pneumonia dd RDS + Labiognatoplatoschizis	RS Saiful Anwar
2	Neonatal Pneumonia, NEC, Feeding problem of newborn, Na-SC	RS Soepraoen
3	Post Op Histerektomi H6 a/I Myoma Uteri + Anemia Gravis Berulang + Sepsis + Joundice	RS Saiful Anwar
4	NP-SP, BBLSR, Neonatal Pneumoia dd RDS, Apneu of Prematurity + Feeding Difficulty, Hematom Regio Cruris Dextra	RS Lavalette
5	G1 P0000 Ab000 Uk 8-10 mgg dg HEG + Colic Abdomen + Hipokalemi	RS. Saiful Anwar
BULAN NOVEMBER 2024		

1	G2P10AB0 UK 36-37 mgg dg KIFL + KPD + Tali Pusat Menumbang + Fetal Distress	RS Saiful Anwar
2	G2P1001 ABOO UK 21-22 mgg + HEG + DF	RS Saiful Anwar
3	NKB + BBLR +ASFIKSIA	RS Saiful Anwar
4	NKB + BBLR + TTNB	RS Lavalette

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :

Pada bulan November ada 4 pasien yang dirujuk keluar, sedangkan pada bulan Oktober terdapat 5 pasien dan bulan September ada 4 pasien.

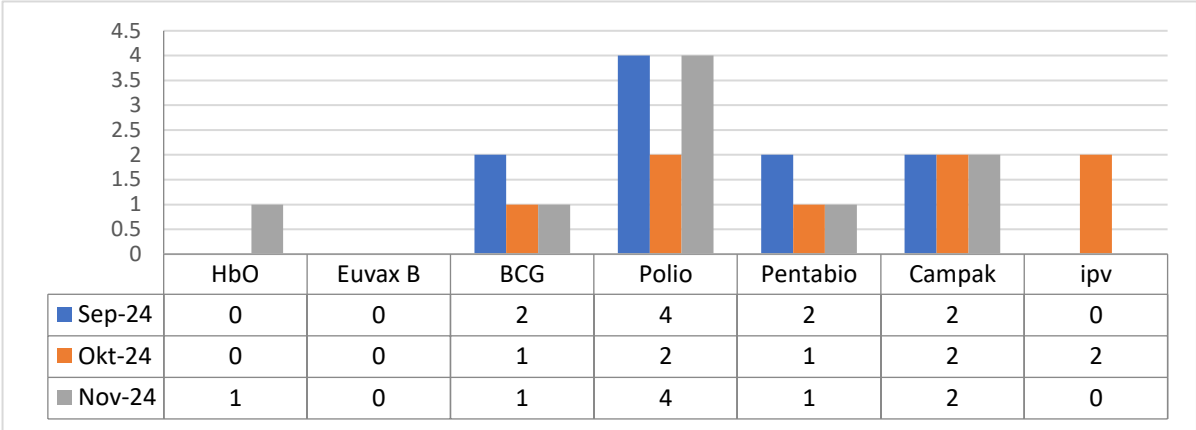
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek November 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024
1	HbO	0	0	1
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	2	1	1
3	Polio	4	2	4
4	Pentabio	2	1	1
5	Campak	2	2	2
6	IPV	0	2	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode November 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
2. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Oktober dan September 2024 tidak ada, sedangkan pada November 2024 sebanyak 1 bayi. Hal ini dikarenakan ketidaktersedianya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, bayi yang baru lahir diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan November dan September tidak ada, sedangkan pada bulan Oktober sebanyak 2 bayi.
4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan November dan Oktober 2024 senbanyak 1 bayi, sedangkan pada bulan September sebanyak 2 bayi
5. Pada periode September sampai dengan November 2024 bayi yang melakukan imunisasi Campak yaitu 2 bayi
6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan November 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 4 bayi
7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan November dan Oktober 2024 sebanyak 1 bayi

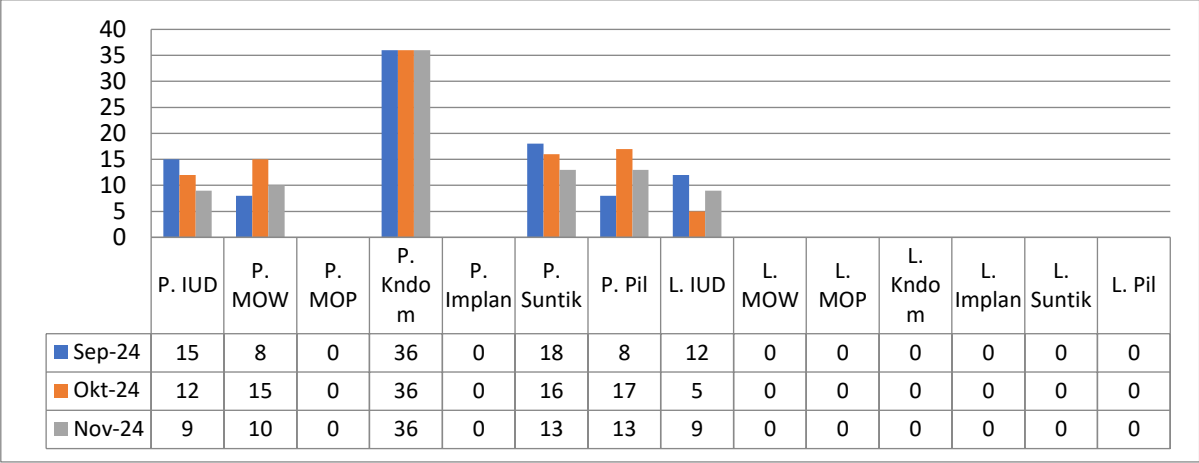
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponek November 2024

NO	JENIS	JUMLAH PASANG			JUMLAH LEPAS		
		BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024
1	IUD	15	12	9	12	5	9
2	MOW	8	15	10	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	36	36	36	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	18	16	13	0	0	0
7	Pil	8	17	13	0	0	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2024



Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan November menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 9 akseptor yang terdiri dari 9 akseptor IUD Nova T dan tidak ada akseptor IUD copper T
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan November 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan September sampai dengan November sama yaitu 36 pengguna
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan November 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 13 pengguna
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan November 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 13 penggunaan

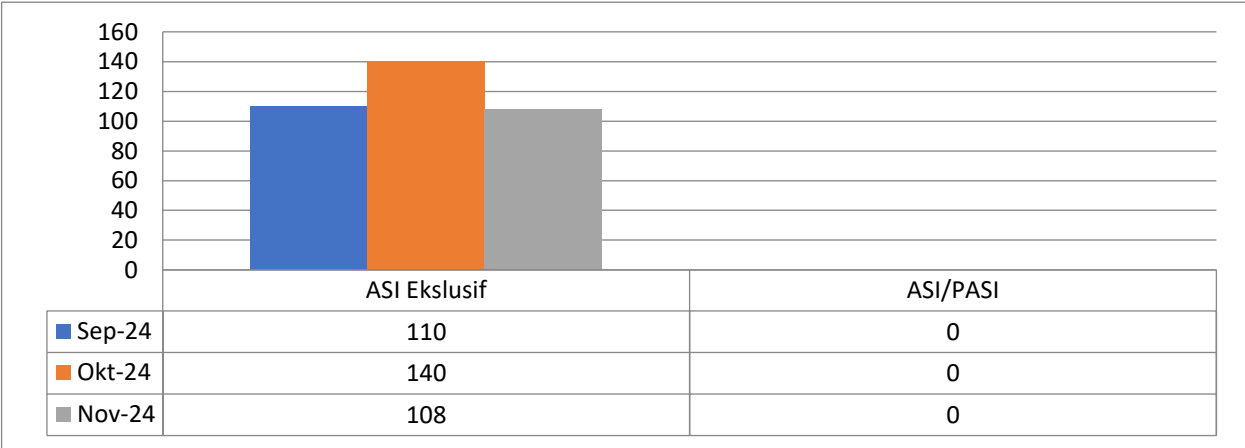
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Ponek November 2024

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024
1	Asi eksklusif	110	140	108
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :

- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan November 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 108 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

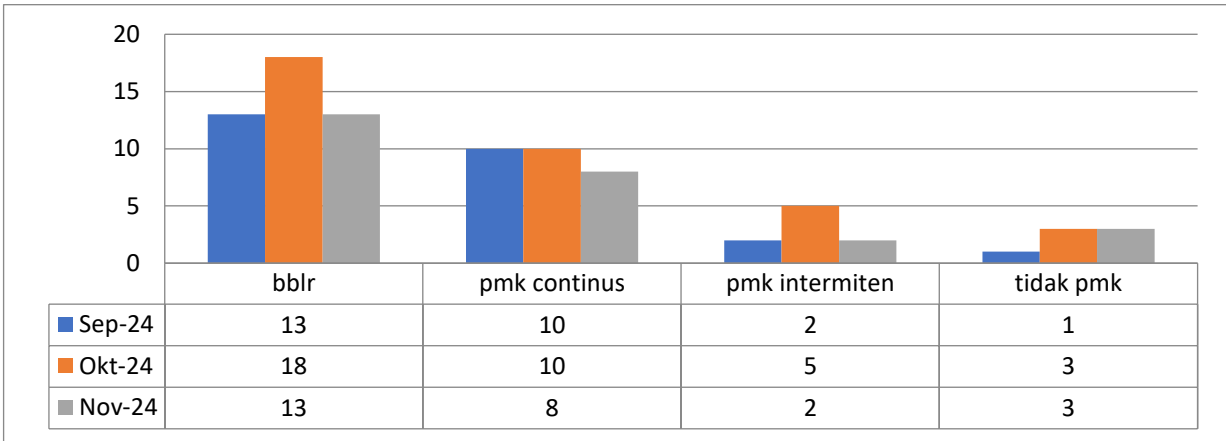
Rencana dan Tindak Lanjut :

Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponok November 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024
1	Bayi BBLR	13	18	13
2	PMK continuos	10	10	8
3	PMK Intermiten	2	5	2
4	Tidak PMK	1	3	3

Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan November 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi, sedangkan pada bulan Oktober 5 bayi dan 2 bayi pada bulan September
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan November 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 8 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4. Dan ada 3 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan November dan Oktober 2024. Hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK atau bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

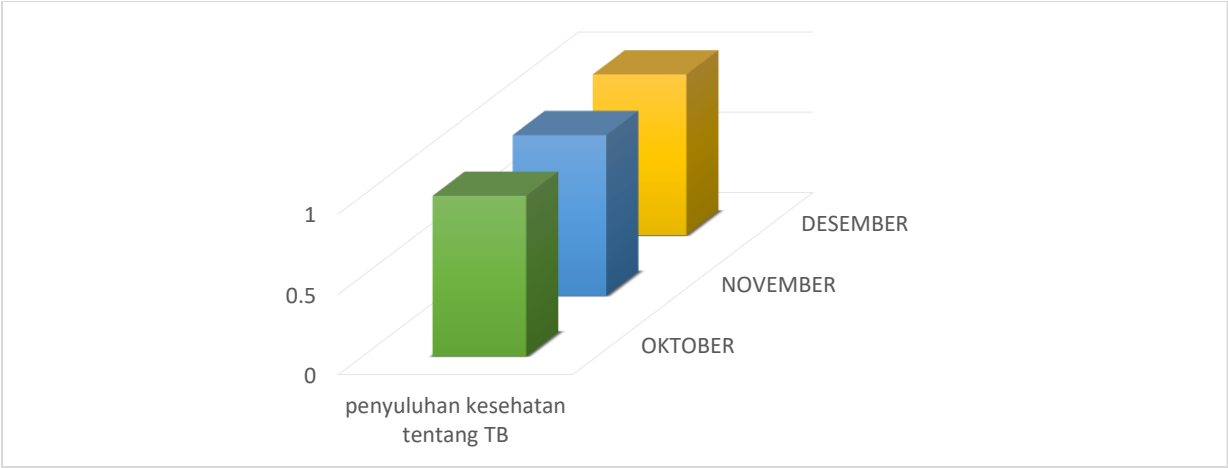
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1	1	

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



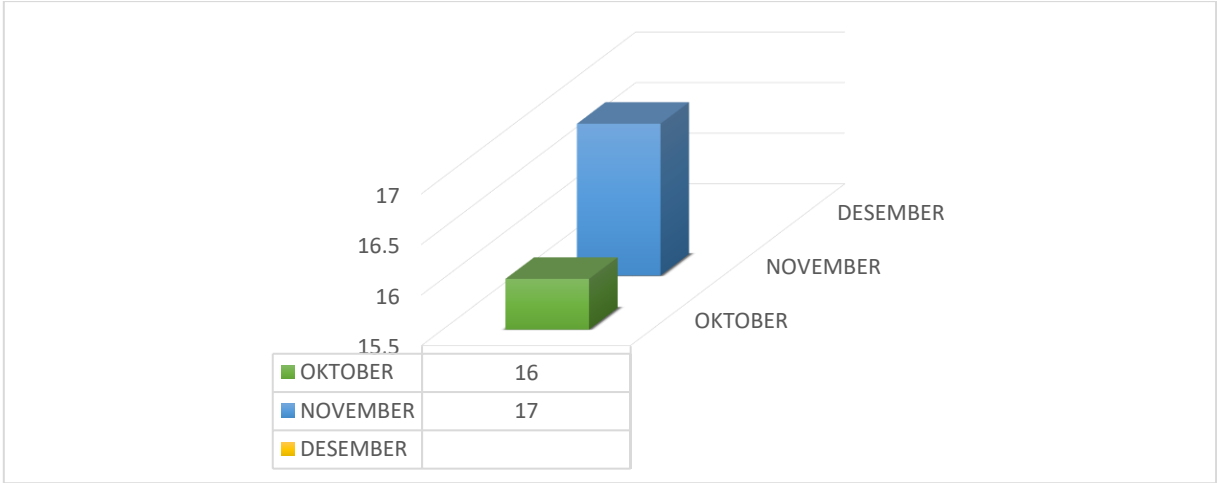
Analisis:
Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

Rencana dan Tindak Lanjut:
Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pemberian Masker	16	17	

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Oktober 2024 terdapat 16 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 2. Pada bulan November 2024 terdapat 17 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

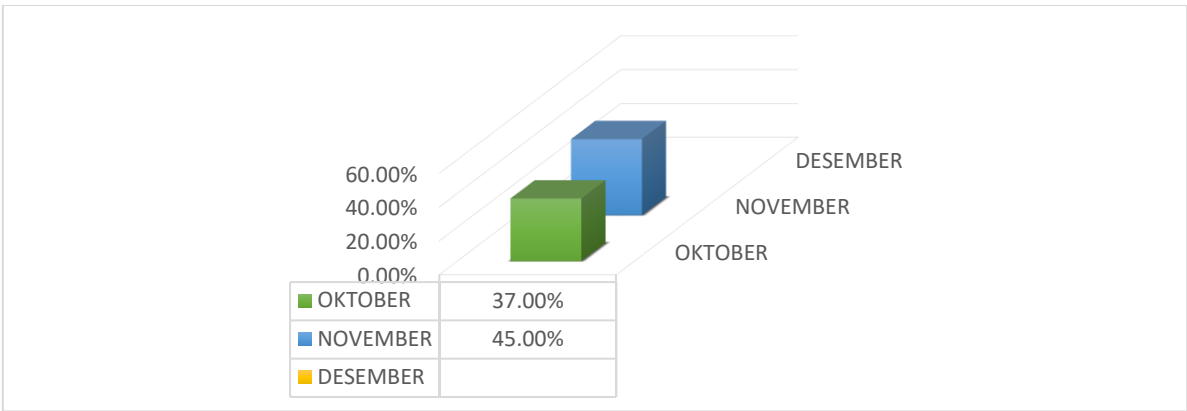
Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	37	45	

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan OKTOBER 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 37
- 2. Pada bulan NOVEMBER 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 45

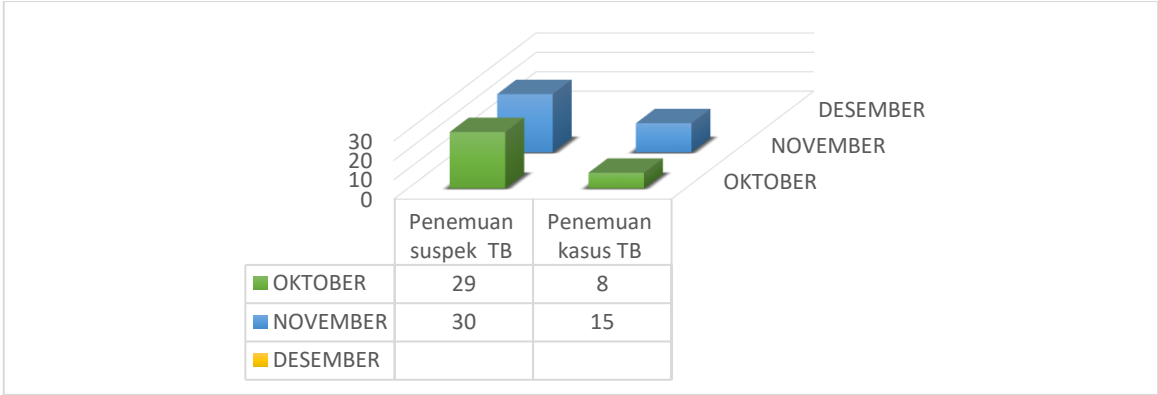
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Penemuan suspek TB	29	30	
2	Penemuan kasus TB	8	15	

Grafik Penemuan Kasus TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Oktober 2024 terdapat 29 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 8 pasien
- 2. Pada bulan November 2024 terdapat 30 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 15 pasien

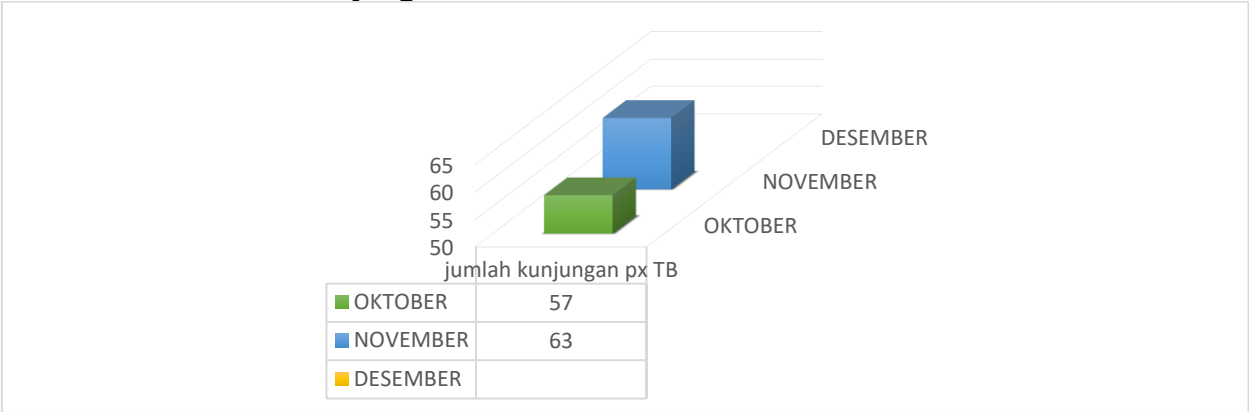
Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	57	63	

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis:

- 1. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Oktober 2024 di poli pasien TBC mencapai 57 pasien.
- 2. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan November 2024 di poli pasien TBC mencapai 63 pasien.

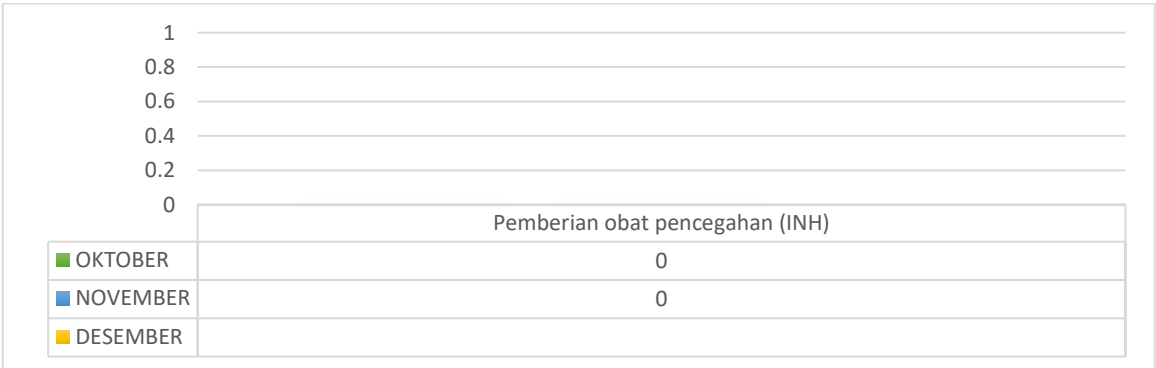
Rencana dan Tindak Lanjut :

Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	

Grafik Pemberian Obat Pencegahan di Rumah Sakit Prima



Analisis :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
- 2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pemberian imunisasi BCG	1	1	

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada



Analisis :
1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Oktober
2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan November

Rencana dan Tindak Lanjut :

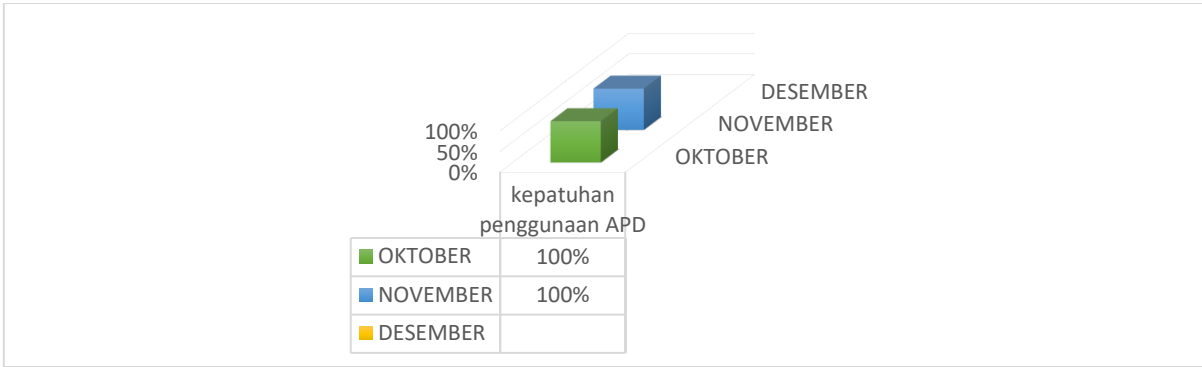
- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG

2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulany

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada



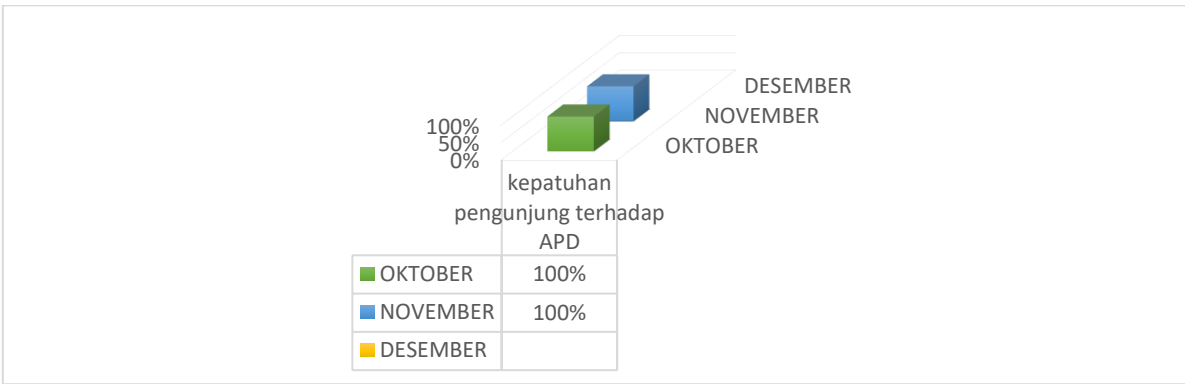
Analisis :
Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD di RS Prima Husada



Analisis:
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

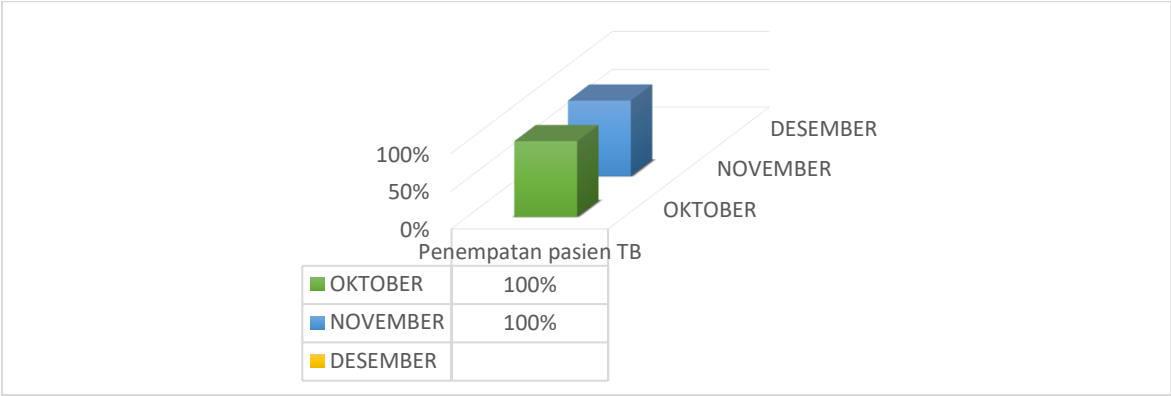
Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada

pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Penempatan pasien TB	100%	100%	

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2024



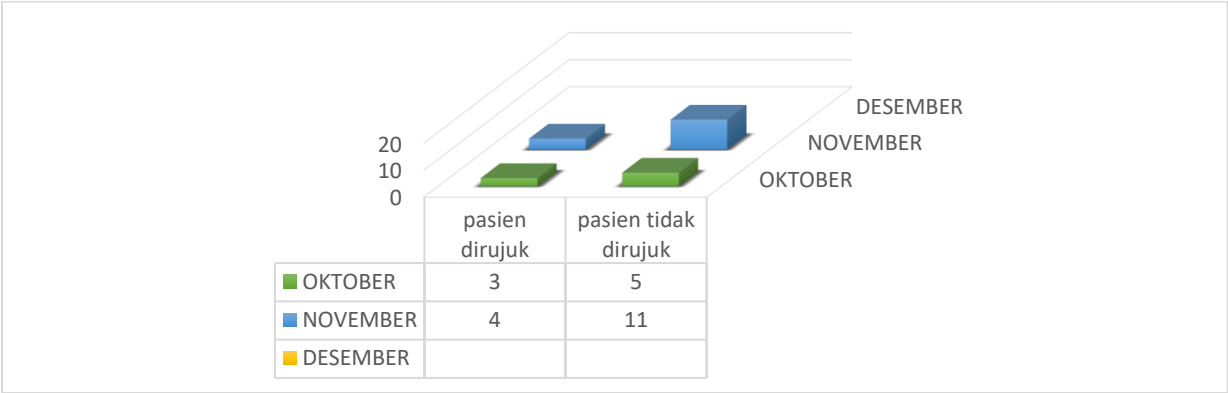
Analisis:
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pasien TB yang dirujuk	3	4	
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	5	11	

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

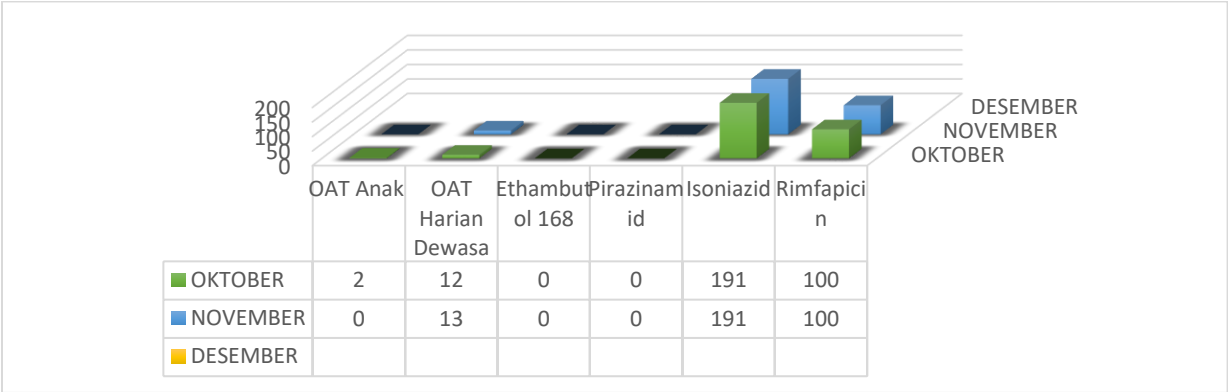
1. Pada bulan Oktober 2024 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
2. Pada bulan November 2024 terdapat 4 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	OAT Anak	2	0	
2.	OAT Harian Dewasa	12	13	
3.	Ethambutol	0	0	
4.	Pirazinamid	0	0	
5.	Isoniazid	191	191	
6.	Rimfapicin	100	100	

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



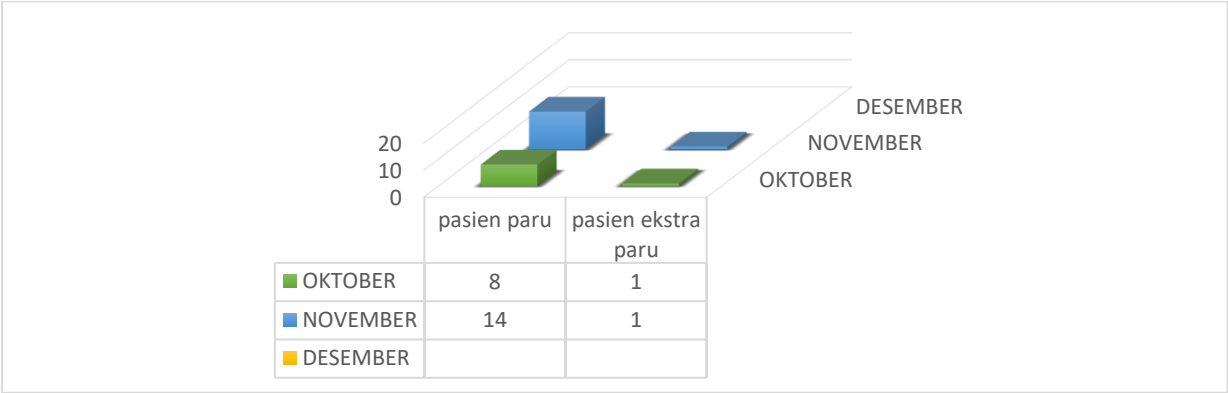
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pasien paru	7	14	
2.	Pasien Ekstra paru	1	1	

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



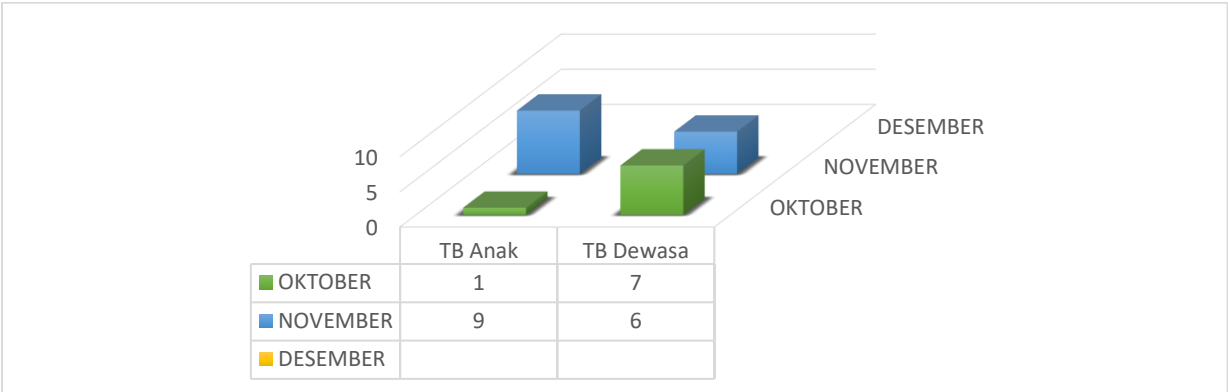
Evaluasi :
1. Pada bulan Oktober 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru
2. Pada bulan November 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama.

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Pasien Anak	1	9	
2.	Pasien Dewasa	7	6	

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



- Analisis :**
- 1. Pada bulan Oktober terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 7 pasien
 - 2. Pada bulan November terdapat 9 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 6 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P	Tn. P	V		

3.	Dr. Yunita, Sp. P	Ny. S	V		

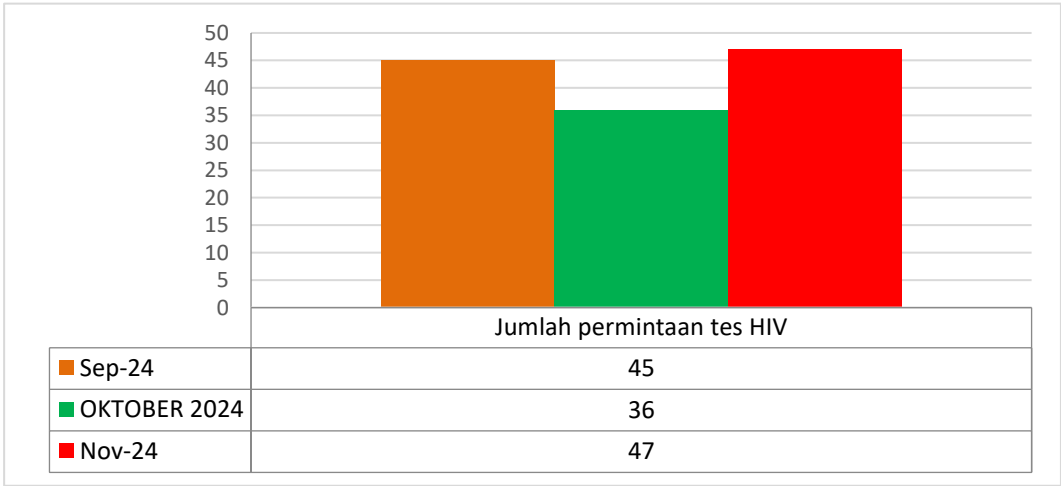
Analisis :
Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1	Permintaan Test HIV	45	36	47

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan November 2024



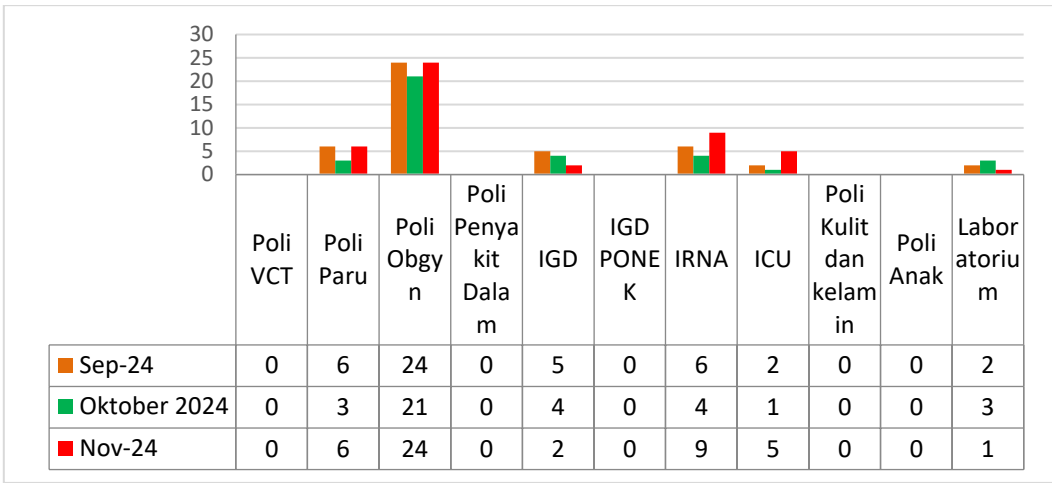
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan November 2024 sebanyak 47 pemeriksaan, Pada bulan oktober 2024 sebanyak 36 pemeriksaan, pada bulan September sebanyak 45 pemeriksaan.
Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.1.2.3.1. Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	6	3	6
3	Poli Obgyn	24	21	24
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	0
5	IGD	5	4	2
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	6	4	9
8	ICU	2	1	5
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	2	3	1

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan November 2024



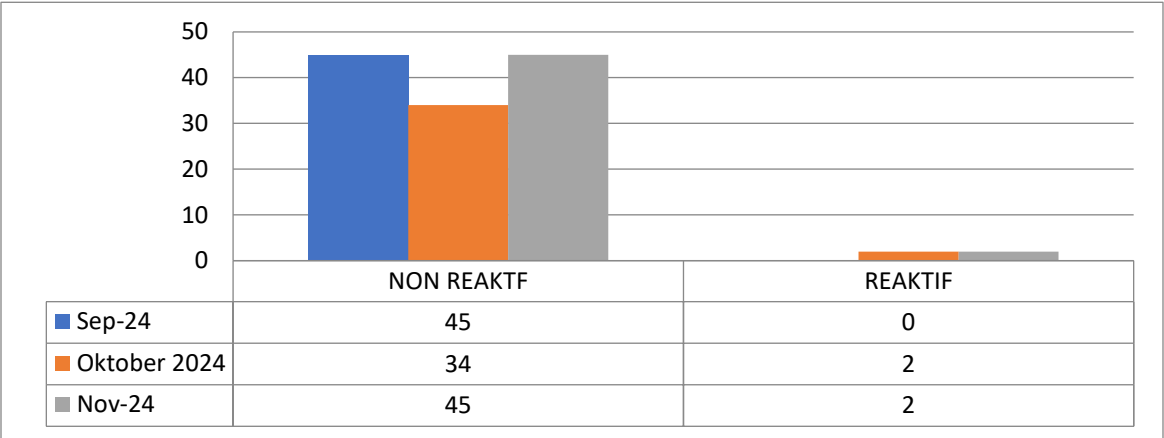
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan September 2024 sebanyak 24 pasien, pada bulan otober 2024 sebanyak 21 pasien Sedangkan pada bulan November 2024 sebanyak 24 pasien
Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1	Non Reaktif	45	34	45
2	Reaktif	0	2	2

Grafik Status HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan November 2024



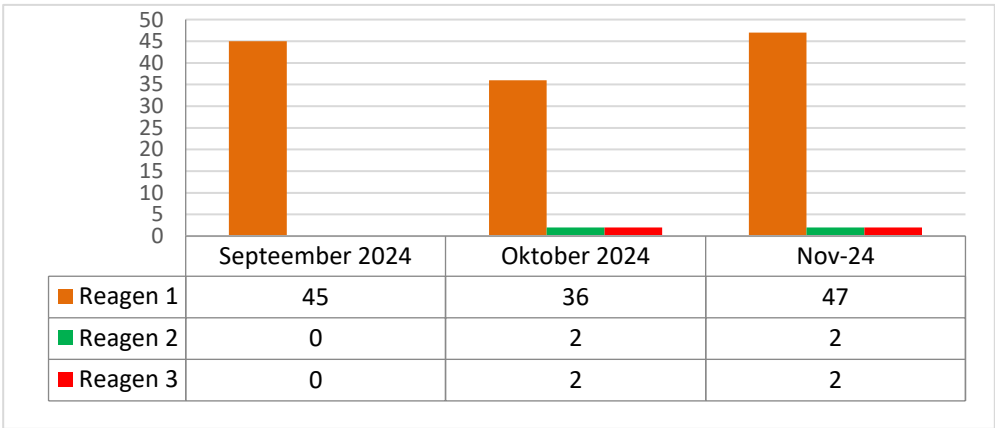
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan November 2024 sebanyak 2 kasus dari rawat inap.

Rencana Tindak Lanjut :
Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.1.2.3.3 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1	Reagen 1	45	36	47
2	Reagen 2	0	2	2
3	Reagen 3	0	2	2

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan November 2024



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan November 2024 memakai reagen 3 Dikarenakan ada pasien dengan hasil reaktif sebanyak 2 pasien. Pada Bulan Oktober 2024 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien dengan hasil reaktif sebanyak 2 pasien. Pada bulan September 2024 pemakaian reagen sampai dengan reagen 1 dikarenakan pada bulan September 2024 tidak ditemukan pasien dengan HIV reaktif.

Rencana Tindak Lanjut :

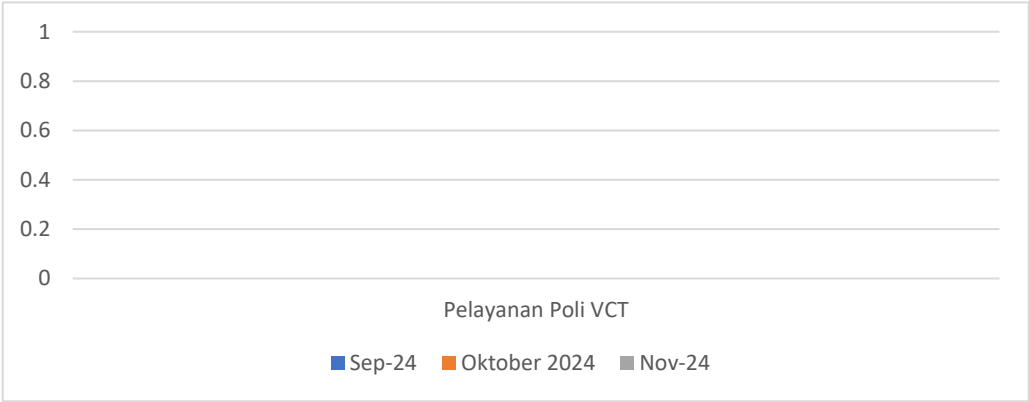
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.

Tetapi apabila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.1.2.3.4 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

**Grafik Pelayanan Poli VCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan November 2024**



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

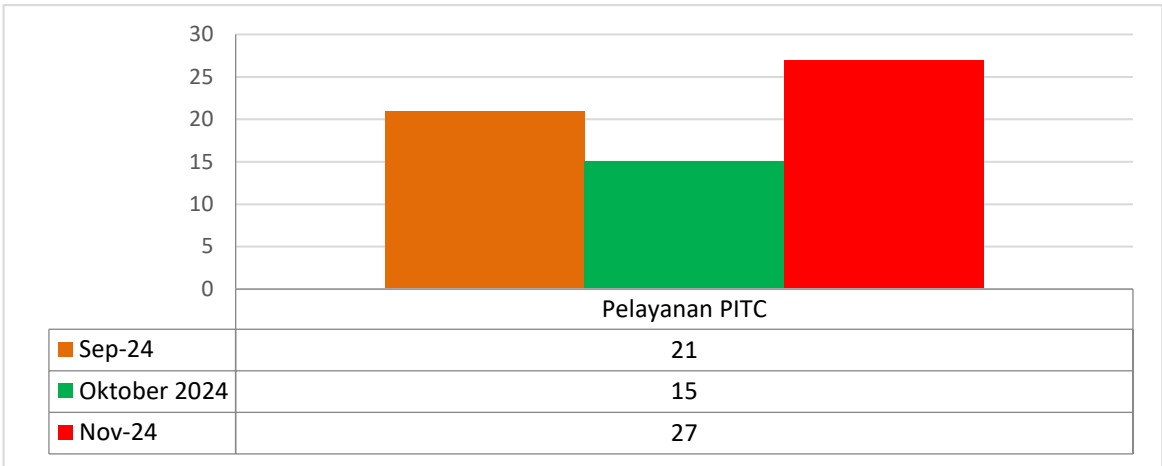
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.1.2.3.5 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1	Pelayanan PITC	21	15	27

Grafik Pelayanan PITC Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan November 2024



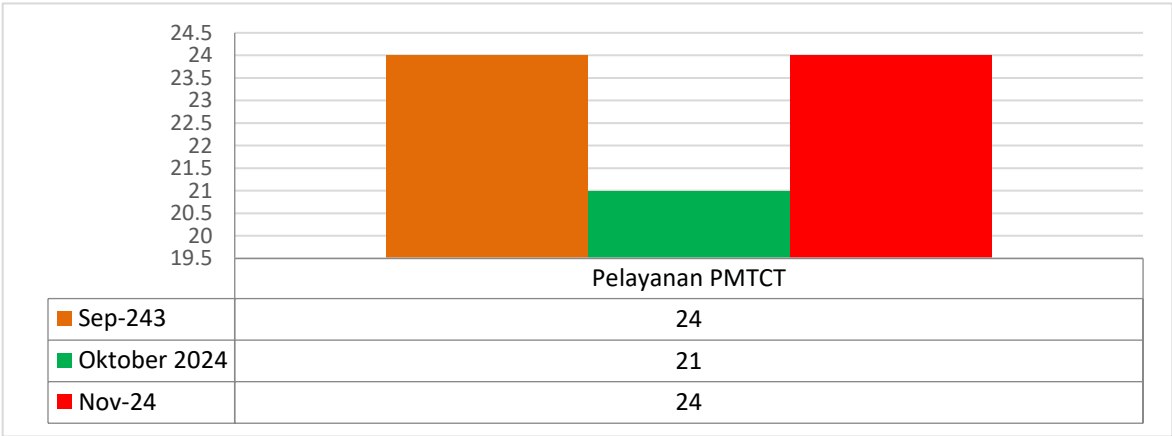
Analisis :
Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan September sebanyak 21 pasien. pada bulan oktober 2024 sebanyak 15 pasien. Sedangkan pada bulan November sebanyak 20 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan peningkatan terkait penjarangan pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.1.2.3.6 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1	Pelayanan PMTCT	24	21	24

Grafik Pelayanan PMTCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan November 2024



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan september 2024 sebanyak 24 pasien. pada buan oktober 2024 sebanyak 21 pasen. Sedangkan pada bulan November sebanyak 24 pasien.
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan

PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

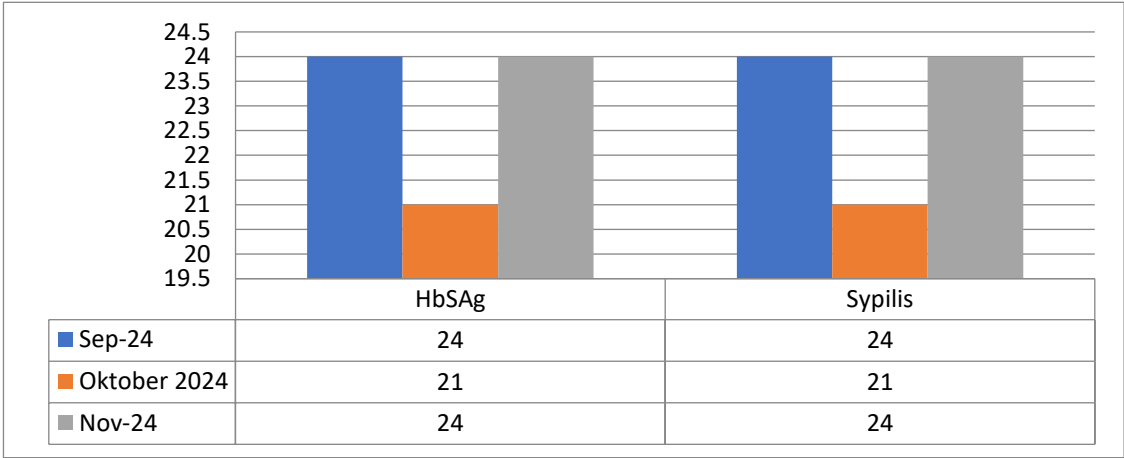
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari Dinas Kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.1.2.3.7 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1	HbSAg	24	21	24
2	Sypilis	24	21	24

**Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
di Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2024**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan September 2024 sebanyak 24 pasien. pada bulan oktober 2024 sebanyak 21 pasien. Sedangkan pada bulan Oktober sebanyak 24 pasien Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak lanjut :

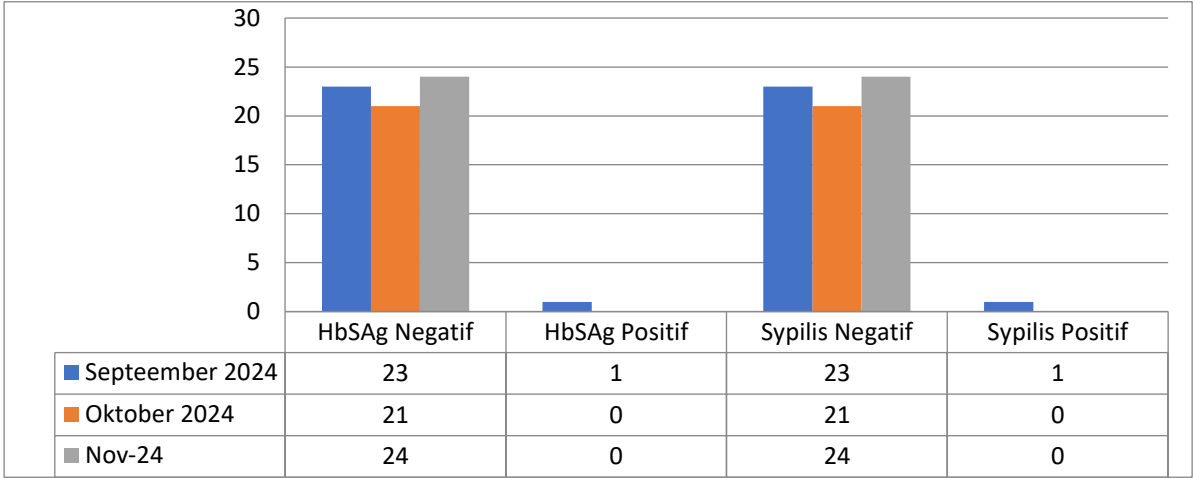
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.1.2.3.8 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1	HbSAg			
	Negatif	23	21	24
	Positif	1	0	0
2	Sypilis			

Negatif	23	21	24
Positif	1	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan September 2024 ditemukan 1 pasien dengan HbSAg posiif. pada bulan oktober dan November 2024 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif

Rencana Tindak Lanjut :

- Pada pasien HbSAg

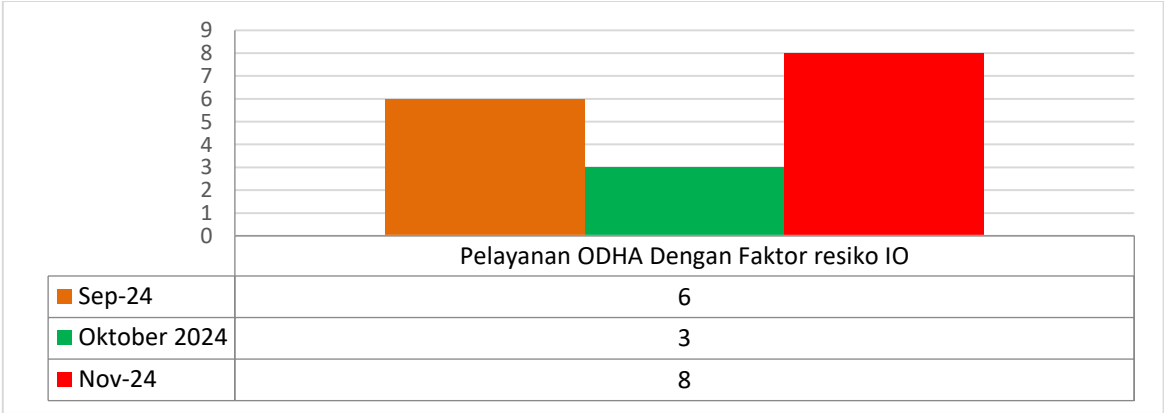
Saat kelahiran akan ada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
- Pada pasien Sypilis

Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.1.2.3.9 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	6	3	8

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan September 2024 didapatkan 6 pasien. pada bulan oktober 2024 didapatkan 3 pasien. sedangkan pada bulan November 2024 didapatkan 8 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO.
Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.1.2.3.10 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
1	Rawat Jalan	1	1	1
2	Rawat Inap	0	0	1

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan Hiv/Aids Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pada bulan September 2024 terdapat 1 pasien rawat jalan yang dilakukan rujuk yang berasal dari poli anak. pada bula oktober 2024 terdapat 1 pasien yang dilakuka rujuk yaitu dari rawat jalan poli anak. Sedangkan pada bulan November ada 2 pasien yang dilakukan rujuk yaitu dari rawat inap dan dari rawat jalan poli IPD
Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.
Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting November 2024

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Terdapat 1 Kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM. Pendampingan dilakukan Bersama Ahli Gizi Puskesmas, Bidan desa, dan Kader Posyandu.
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

- 1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas
Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting , makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	-	0	0	1

Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	0	0	1
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

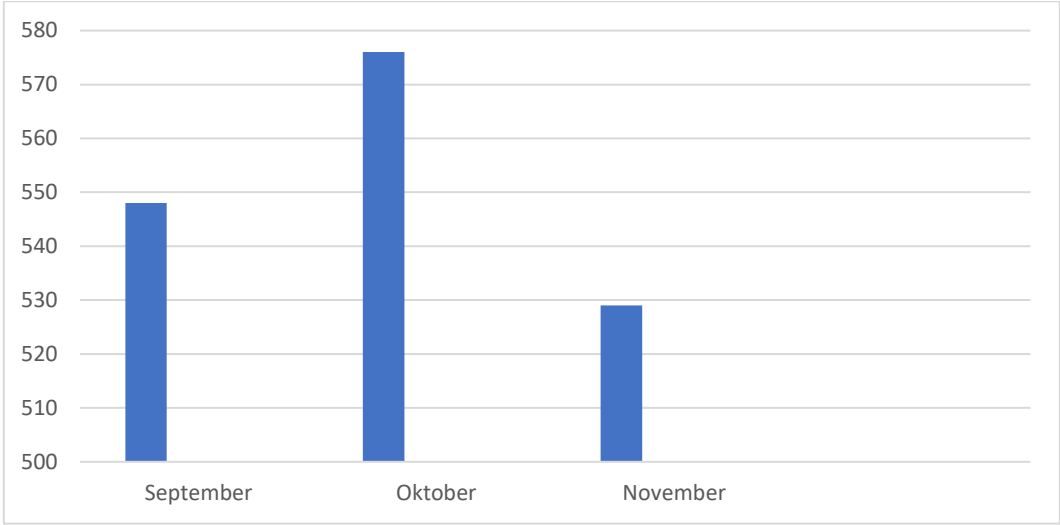
Analisis :
Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	548	576	529

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil Di RS Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat menurun pada bulan November yaitu 529 ibu hamil yang mendapat tablet besi folat.

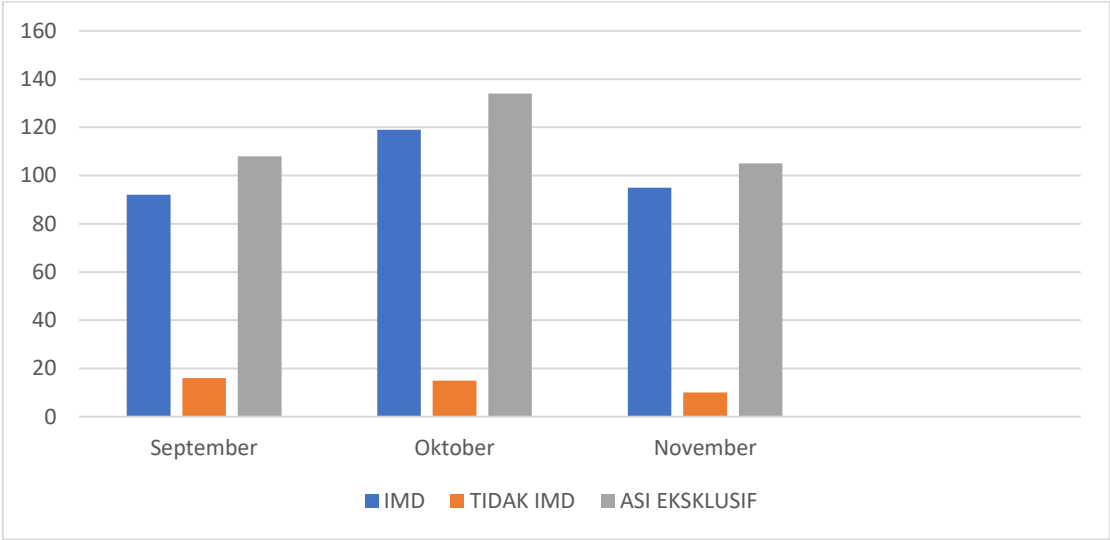
- Rencana Tindak Lanjut:**
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024
1	IMD	92	119	95
2	Tidak IMD	16	15	10
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	108	134	105

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif di RS Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan November 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 95 bayi.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan November 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif menurun pada bulan November 2024 yaitu sebanyak 105 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

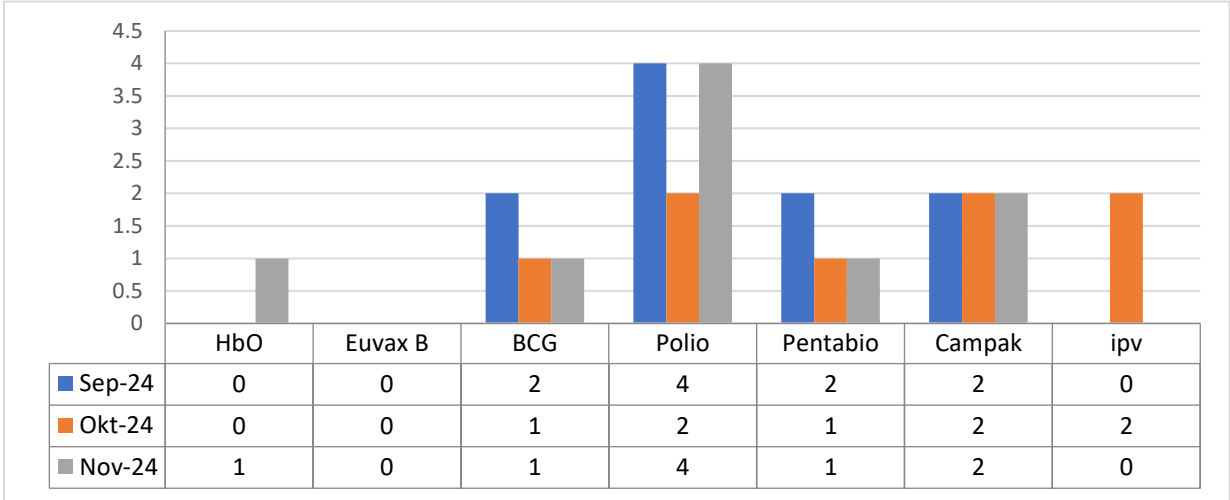
3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024
1	HbO	0	0	1
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	2	1	1

3	Polio	4	2	4
4	Pentabio	2	1	1
5	Campak	2	2	2
6	IPV	0	2	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2024



Analisis:

1. Terdapat 1 balita yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan November.
2. Terdapat 2 bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Oktober akan tetapi tidak ada bayi yang melakukan imunisasi IPV pada bulan November.
3. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan November 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 1 pasien.
4. Pada periode November 2024 terdapat bayi yang melakukan Imunisasi Campak yaitu 2 bayi.
5. Terdapat 4 bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan November 2024

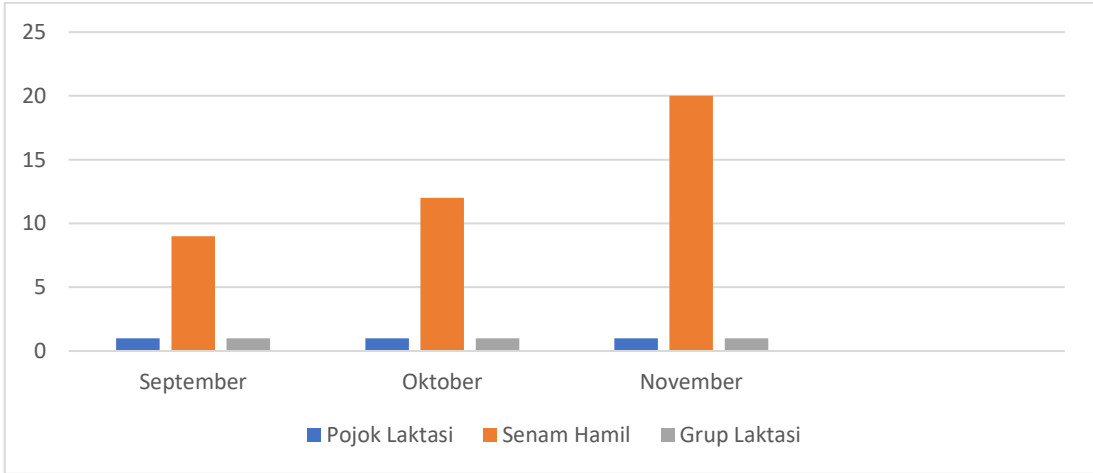
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
Ruang Pojok Laktasi	1	1	1
Senam Hamil	9	12	20
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2024



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Jumlah peserta edukasi pada bulan Oktober meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebanyak 20 orang
- 4.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

**3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi**

RUJUKAN MASUK				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
RUJUKAN KELUAR				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-



Analisis :

Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS

Rencana Tindak Lanjut:

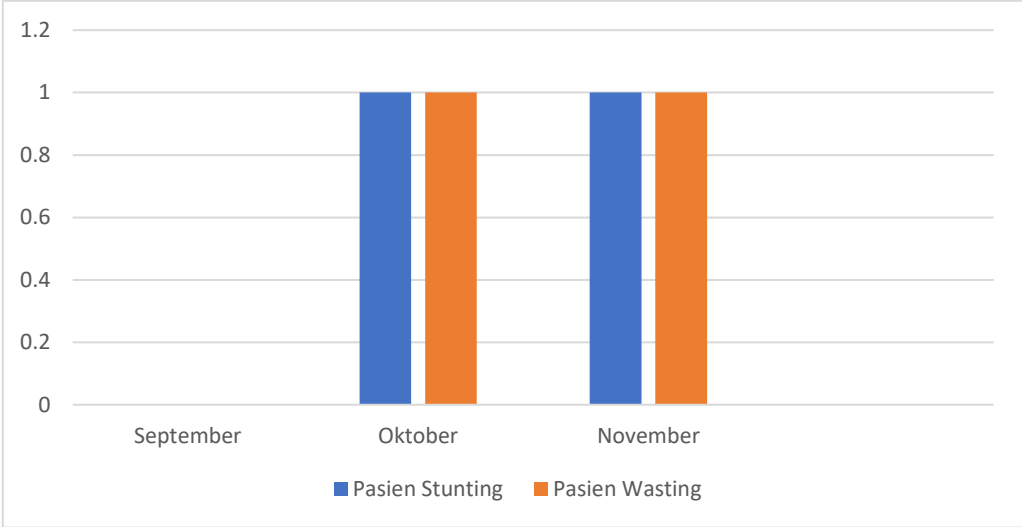
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjangring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	SEPTEMBER 2024	OKTOBER 2024	NOVEMBER 2024
Jumlah Pasien Stunting	0	1	1
Jumlah Pasien Wasting	0	1	1

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :

Terdapat 1 pasien stunting dan wasting pada bulan Oktober, dan 1 pasien stunting wasting di bulan November. Hal tersebut berkaitan dengan pola makan pasien yang terbilang kurang yaitu 2x sehari dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan.

Rencana Tindak Lanjut :

Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut. Edukasi pemberian intervensi lanjut dilakukan dengan cara mengunjungi kediaman

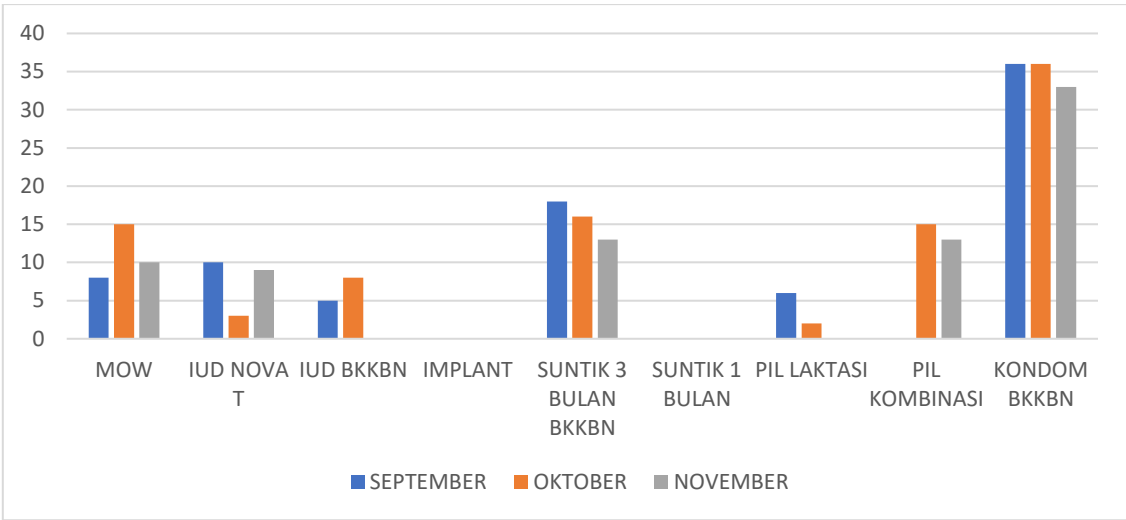
3.1.2.5 KBRs

3.1.2.6 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024
1	MOW	8	15	10
2	IUD Nova T	10	3	9
3	IUD BKKBN	5	8	0
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN	18	16	13

	BKKBN			
6	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
7	PIL KOMBINASI	2	15	13
8	PIL LAKTASI	6	2	0
9	KONDOM BKKBN	36	36	3

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

1. Peserta MOW pada bulan September naik (8) Oktober naik (15) November turun (10)
2. Peserta IUD Nova T pada bulan September (10) menurun Oktober (3) November naik (9)
3. Peserta IUD BKKBN, pada bulan September (5) Meningkat Oktober (8) menurun November (0)
4. Peserta KB suntik 3 bulan, pada bulan September (18) menurun Oktober (16) menurun November (13)
5. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Oktober meningkat (15) November menurun (13),Pil KB laktasi September (6) Oktober menurun (2) November dimusnahkan karena ED
6. Peserta KB Kondom pada bulan September (36) meningkat oktober (48) November menurun (36)

Analisis :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

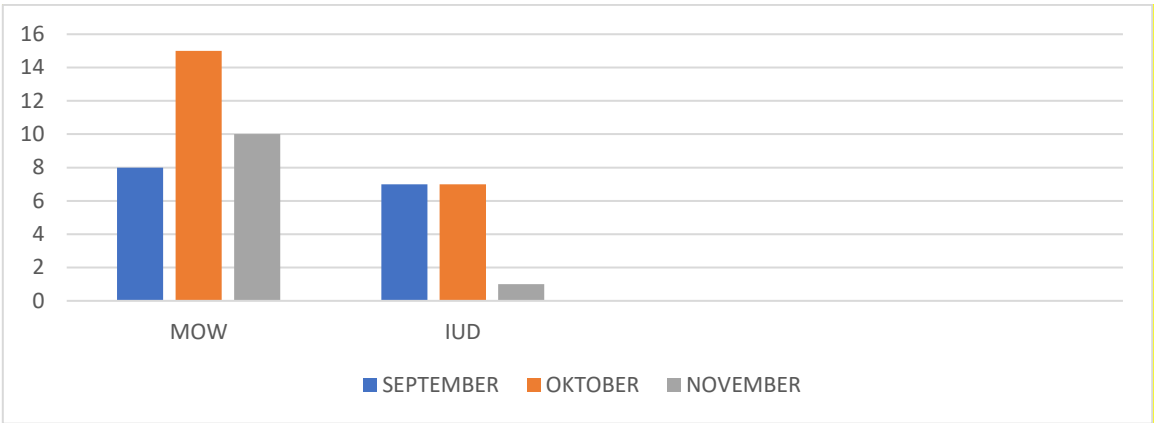
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

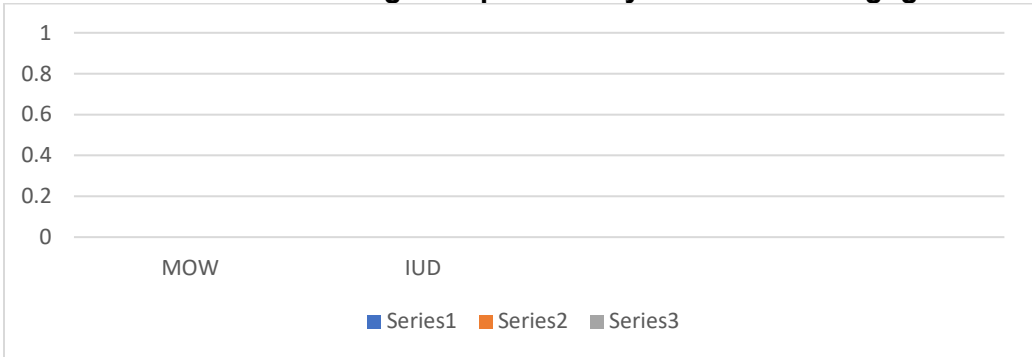
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024
1	MOW	8	15	10
2	IUD	7	7	1

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan September -Oktober - November menurun
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan September -Oktober – November menetap.

Analisis :

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2024

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan September 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Sutik	L/68	dr. Heri, Sp. Pd	219077	DM Type 2	30/08/2024	01/09/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Azitromycin po		1x0,5	1,5	0,3	5
2	Moch Lutfi	L/46	dr. Andy, Sp. P	175773	Acute respiratory failure	30/08/2024	07/09/2024	9	Ceftriaxone	3	2x1	5	2	0,5
									Cefoperazone sodium		2x1	5	4	1,25
									Meropenem		2x1	6	3	2
3	Joni Arifin	L/56	dr. Anton, Sp. B	218906	Other Hydrocele	03/09/2024	05/09/2024	3	Ceftizoxime	2	1x1	1	4	0,25
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
4	Arsita Fadillah	P/22	dr. Heri, Sp. Pd	185265	Gastroenteritis and colitis	03/09/2024	05/09/2024	3	Asam Pipemidat	1	2x1	2,4	0,8	3
5	Riyani	P/49	dr. Ardhi, Sp. Pd	201139	DM Hyperglikemi	04/09/2024	07/09/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Ciprofloxacin po		2x0,5	2	1	2
6	Sugeng Suyanto	L/57	dr. Anton, Sp.B	085988	Necrotizing fasciitis	06/09/2024	08/09/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
7	Muhammad Alif	L/18	dr. Zaki, Sp. B	114182	Abd. Pain	08/09/2024	10/09/2024	3	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
8	Yusnia Kosi P	P/29	dr. Aida, Sp. OG	118463	SC	09/09/2024	11/09/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
9	Moch Yusron	L/70	dr. Anton, Sp.B	219561	With peripheral circulatory	10/09/2024	12/09/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
10	Vicky Octavianto	L/28	dr. Anton, Sp.B	219500	Fistula perianal	11/09/2024	13/09/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Gentamycin		3x0,08	0,24	0,24	1

									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875
11	Daseno	L/57	dr. Heri, Sp. Pd	219685	Febris H-14	12/09/2024	15/09/2024	4	Levofloxacin po	1	1x0,75	2,25	0,5	4,5
12	Supriadi	L/71	dr. Andy, Sp. P	219809	COPD AE	15/09/2024	19/09/2024	5	Azithromycin	1	1x0,5	2,5	0,3	8,3
13	M Agus Salim	L/53	dr. Heri, Sp. Pd	219813	Sepsis	16/09/2024	21/09/2024	6	Ceftriaxone	3	2x1	7	2	3,5
									Metronidazole inf		3x0,5	8,5	1,5	5,6
									Levofloxacin inf		1x0,75	2,25	0,5	4,5
14	Suning	P/53	dr. Zora, Sp.Pd	125963	DM Hiperglikemi	16/09/2024	23/09/2024	8	Ceftraixone	2	2x2	24	2	12
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
15	M. Hadyan	L/16	dr. Edi, Sp. U	217145	Scrotal varices	17/09/2024	19/09/2024	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
16	Siti Nurrohmah	P/54	dr. Ardhi, Sp.Pd	160161	DM Type 2	23/09/2024	27/09/2024	5	Ceftraixone	2	2x1	8	2	4
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
17	Badariyah	P/54	dr. Yunita, Sp.P	220134	Obs Dyspneu + Pneumoni CAP	23/09/2024	28/08/2024	6	Levofloxacin inf	3	1x0,75	2,25	0,5	4,5
									Levofloxacin po		1x0,75	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
18	Dina Asma'ul	P/26	dr. Zora, Sp.Pd	220223	TF	24/09/2024	26/09/2024	3	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1	0,5	2
19	Yuni Anisa C	P/22	dr. Humairi, Sp.OG	220187	Prematur Rupture	24/09/2024	26/09/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
20	Teddi Hendrawan	L/49	dr. Oka, Sp.OT	220254	Dislocation of Wrist	25/09/2024	27/09/2024	3	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1

3.2.2.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Oktober 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Akhmah Yani	L/60	dr. Mira, Sp. JP	220451	Dyspnea	30/09/2024	02/10/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Azitromycin po		1x0,5	1,5	0,3	5
2	Abd. Fatah	L/55	dr. Edi, Sp. U	158634	Colic renal	03/10/2024	05/10/2024	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
3	Yuli Prawesti	P/53	dr. Mira, Sp. JP	073181	Syock cardiogenik	04/10/2024	16/10/2024	13	Ceftriaxone	3	2x1	20	2	10
									Levofloxacin inf		1x0,75	6	0,5	12
									Azitromycin po		1x0,5	1,5	0,3	5
4	Yuda Achadi	L/47	dr. Andi, Sp. B	220875	Apenddix	08/10/2024	12/10/2024	5	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	8	2	4
5	Lela Sulistiya	P/32	dr. Humaira, Sp. OG	063244	SC	09/10/2024	11/10/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
6	Nurizza Aroh	P/33	dr. Elvi, Sp. P	051685	Efusi Pleura	09/10/2024	12/10/2024	4	Ceftriaxone	3	2x1	7	2	3,5
									Levofloxacin inf		1x0,5	1	0,5	2
									Metronidazole inf		3x0,5	3	1,5	2
7	Rahayu	P/49	dr. Ardhi, Sp. Pd	197161	DM Hiperglikemi	09/10/2024	12/10/2024	4	Asam Pipemidat	2	1x0,4	2,4	0,8	3
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
8	Anis Suyanah	P/52	dr. Zora, Sp. Pd	062888	Febris + Hipertiroid	09/10/2024	12/10/2024	4	Levofloxacin inf	1	1x0,5	4	0,5	8
9	Hartono	L/65	dr. Anton, Sp. B	135321	Tumor Manus	10/10/2024	12/09/2024	3	Cefoperazone sodium	2	2x1	1	4	0,25
									Cefixime		2x0,1	0,5	4	0,125
10	Dwi Fransiska N	P/25	dr. Anton, Sp. B	184587	Necrotizing facitis	13/10/2024	15/10/2024	3	Ceftizoxime	2	1x1	1	4	0,25

									Clindamycin po		2x0,3	0,6	1,2	5
11	Djuman	P/65	dr. Andi, Sp. P	102264	Susp Pneumoni	15/10/2024	17/10/2024	3	Azithromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
12	Arofatul Magfiroh	P/29	dr. Humaira, Sp. OG	088305	PRM	15/10/2024	17/10/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
13	Supriyadi	L/42	dr. Pradana, Sp. U	221142	Injury of unspecified body region	15/10/2024	18/10/2024	4	Cefoperazone sodium	2	2x1	6	4	1,5
									Metronidazole inf		3x0,5	5,5	1,5	3,67
14	Kevin Dwi A	L/24	dr. Kuntadi, Sp. OT	221199	Superficial injury	16/10/2024	18/10/2024	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
15	Yunia Iffa	P/34	dr. Zaki, Sp.B	221194	CKR 456	17/10/2024	18/10/2024	2	Cefoperazone sodium	2	1x1	1	4	0,25
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
16	Moch Rupiono	L/68	dr. Edi, Sp.U	094231	Inflammatory Disorder	18/10/2024	21/10/2024	4	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Cefoperazone sodium		2x1	4	4	1
17	Ngaturi	L/53	dr. Anton, Sp.B	221207	Tumor rectum	19/10/2024	21/10/2024	3	Cefoperzone sodium	3	1x2	2	4	0,5
									Cefoperazone sodium		1x1	1	4	0,25
									Ciprofloxacin po		2x0,5	1	1	1
18	Ainun Purnomo	P/54	dr. Heri, Sp. Pd	170372	DM	19/10/2024	27/10/2024	9	Ceftriaxone	2	2x1	16	2	8
									Metronidazole po		2x0,5	5	2	2,5
19	Kusnadi	L/53	dr. Ardhani, Sp. Pd, K-GH	062270	TF, DF	21/10/2024	23/10/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Azitromycin po		1x0,5	1,5	0,3	5
20	Neny Lia	P/44	dr. Andy, Sp. P	221652	Dyspnea	27/10/2024	29/10/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	6	2	3
									Levofloxacin inf		1x0,75	2,25	0,5	4,5

3.2.2.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan November 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Istiqomah	P/58	dr. Ardhi, Sp.PD	221889	Dengue Fever (DF)	31/10/2024	05/11/2024	6	Ceftriaxone	2	2x1	12	2	6
									Levofloxacin inf		1x0,5	2	0,5	4
2	Eka Dia	P/20	dr. Aida, Sp.OG	207900	SC	03/11/2024	05/11/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
3	Wiwin	P/33	Dr. Ardhany, Sp.Pd,K-GH	222013	Gastroenteritis and colitis	03/11/2024	06/11/2024	4	Metronidazole inf	1	3x0,5	3,5	1,5	2,33
4	Samsuri	L/80	dr. Elvi, Sp.P	222055	COPD	04/11/2024	07/11/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Azitromycin		1x0,5	1,5	1,5	1
5	Erma Andriyanti	P/47	dr. Edi, Sp.U	185268	Unspecified Renal Colic	05/11/2024	07/11/2024	3	Meropenem	1	1x1	3	3	1
6	Muh Roji'in	L/53	dr. Anton, Sp.B	222172	Hernia Scrotalis (D)	07/11/2024	09/11/2024		Ceftizoxime	2	1x1	1	4	0,25
									Cefixime		2x0,1	0,4	2	0,2
7	Charlos J	L/21	dr. Anton, Sp.B	222271	Necrotizing Facitis	09/11/2024	11/11/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
8	Rachmah Dheny	P/46	dr. Ardhi, Sp.PD	174600	Nausea and Vomitinh	09/11/2024	12/11/2024	4	Asam Pipemidate	2	2x0,4	2,4	0,8	3
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
9	Yuniningtyas R	P/47	dr. Humaira, Sp.OG	098894	Kista Bartolinitis	11/11/2024	12/11/2024	2	Cefriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ciprofloxacin po		2x0,5	1	1	1
10	H. Hardjono	L/70	dr. Ardhi, Sp. Pd	075275	DM Hiperglikemi	13/11/2024	17/11/2024	5	Cefriaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Levofloxacin po		1x0,5	1,5	0,5	3
11	Khotima Nurlela	P/22	dr. Humaira, Sp.OG	210213	SC dalam keadaan emergency	14/11/2024	17/11/2024	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
12	Zainuddin	L/54	dr. Zaki, Sp.B	222651	Hemoroid, Anemia	17/11/2024	20/11/2024	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5

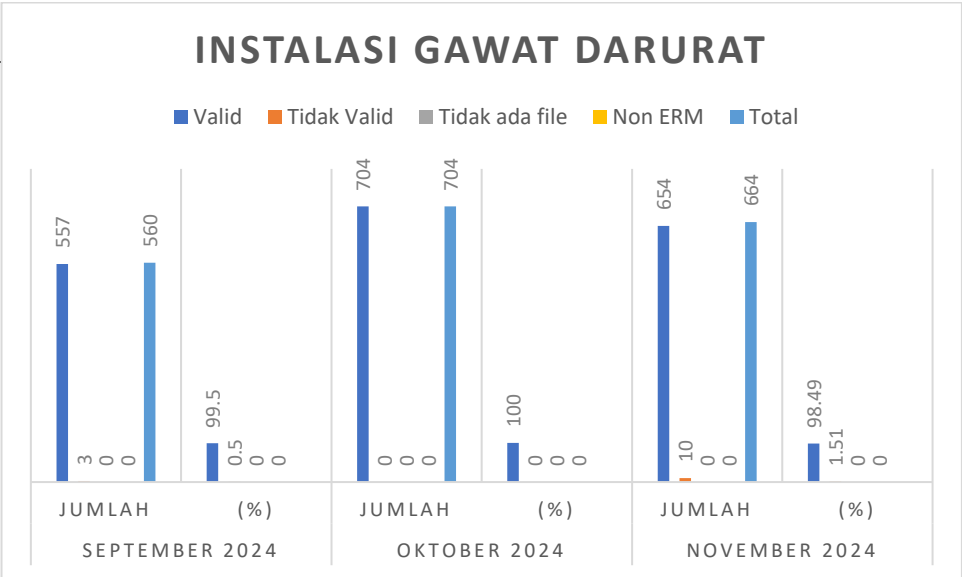
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
13	Rumakyah	P/61	dr. Zaki, Sp.B	079000	Necrotizing Facitis	17/11/2024	19/11/2024	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
14	Bagus Sulisty	L/26	dr. Arianto, Sp.OT	222669	Disorder of patella	18/11/2024	19/11/2024	2	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
15	Ridho Ardiansyah	L/38	dr. Andy, Sp.P	218504	Typhoid Fever	18/11/2024	22/11/2024	5	Ceftiaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Levofloxacin po		1x0,5	1,5	0,5	3
16	Muchamad Yusuf	L/76	dr. Elvi, Sp.P	209724	Obs Dyspnea	20/11/2024	22/11/2024	3	Levofloxacin inf	1	1x0,75	2,25	0,5	4,5
17	Dwi Erna	P/34	Dr. Heri, Sp.Pd	222833	Colic Abdomen	21/22/2024	23/11/2024	3	Asam Pipemidat	1	2x0,4	1,6	0,8	2
18	Marsiyah	P/62	dr.Andi, Sp.B	202411	Ascites	23/11/2024	25/11/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	4	2	2
									Metronidazole inf		3x0,5	3	1,5	2
19	Susanti	P/24	dr. Zaki, Sp.B	223100	Ileus obstruktif	27/11/2024	29/11/2024	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
10	Soerjati	P/79	dr. Anton, Sp.B	060759	Necrotizing Facitis	28/11/2024	30/11/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

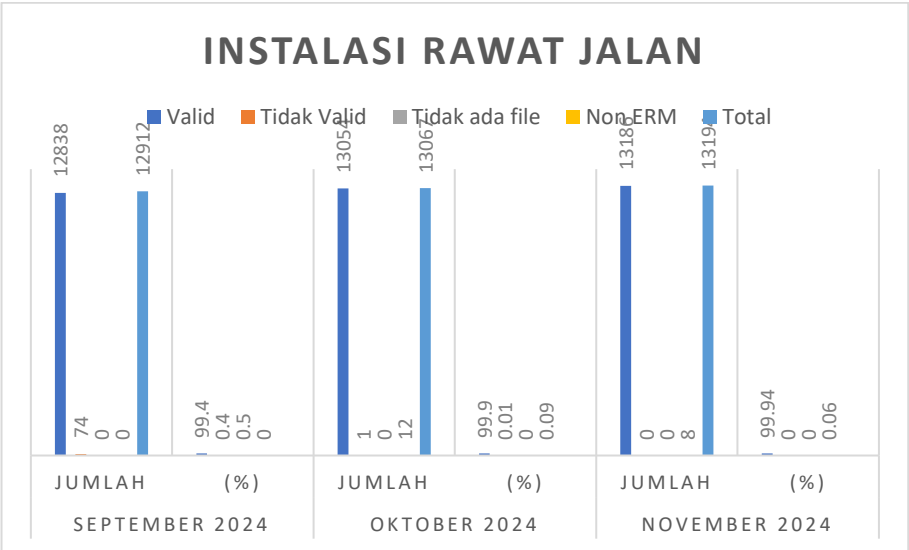
3.6.6.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan September-November 2024

NO	UNIT	KUALIFIKASI	BULAN					
			SEPTEMBER 2024		OKTOBER 2024		NOVEMBER 2024	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1.	IGD	Valid	557	99,5	704	100	654	98,49
		Tidak Valid	3	0,5	0	0	10	1,51
		Tidak ada file	0	0	0	0	0	0
		Non ERM	0	0	0	0	0	0
Total			560		704		664	
2.	IRJA/POLI	Valid	12838	99,4	13054	99,90	13186	99,94
		Tidak Valid	74	0,4	1	0,01	0	0
		Tidak ada file	0	0,5	0	0	0	0
		Non ERM	0	0	12	0,09	8	0,06
Total			12912		13067		13194	

3.6.6.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan September-November 2024



3.6.6.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan September-November 2024



Analisis :

- 1. Validasi Data E-RM di IGD sudah mencapai 98.49% dari 664 data yang diterima.
- 2. Terdapat penurunan capaian dari bulan sebelumnya, hal ini disebabkan skrining IGD tidak terbaca pada fitur e-rm di Rekam Medis.

3. Pada Bulan November 2024 tidak ditemukan tarikan data yang tidak ada file baik di IGD maupun di IRJA, yaitu 0%.
4. Masih ditemukan layanan IRJA yang belum E-RM, yaitu Poli KIA dan Poli Gizi.

Masalah :

1. Pengkajian awal medis gigi tidak bisa terbuka oleh rekam medis, sedangkan fitur tersebut muncul di SIMRS perawat.
2. Pencatatan Poli Gizi masih menggunakan lembar konsultasi manual, resiko hilang dan tidak terekap dengan baik pada system sehingga DPJP tidak bisa membaca hasil pada Billing E-RM.
3. Ditemukan kunjungan Poli KIA saat petugas RM melakukan review dan belum masuk kedalam E-RM.
4. Berikut link permasalahan yang ditemui

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455

Rencana Tindak Lanjut :

Ketidaklengkapan ERM sudah membaik dari pada bulan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan alur terkait penyetoran berkas pasien per hari, yaitu :

1. Alur sebelumnya perawat menyetor berkas casemix ke kasir jaminan, mulai awal Bulan Juni 2024 perawat menyetor berkas ke rekam medis untuk dilakukan cek kelengkapan ERM oleh tim rekam medis.
2. Petugas rekam medis menandatangani lembar casemix sebagaibukti bahwa sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap dan valid.
3. Setelah selesai dilakuan validasi oleh petugas rekam medis, perawat menyetorkan berkas ke kasir jaminan.
4. Pada akhir Bulan Oktober 2024 casemix yang disetor sudah tidak dicetak, RS sudah menerapkan E-Casemix.
5. Melakukan pencatatan kunjungan pasien harian setiap DPJP pada google spreadsheet untuk dilakukan cek kesesuaian dan kelengkapan data oleh Petugas RM dan Verifikator RS.
6. Flow Chart alur pelayanan Poli Gizi sudah diberikan kepada Programmer PT.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.1 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Kehabisan obat anestesi (Ketamin)	P	Menghitung stok di gudang dan stok di depo farmasi sesuai kebutuhan
		D	Koordinasi dengan pengadaan untuk selalu stok di gudang untuk obat anestesi dan jika cito di pinjamkan ke rumah sakit sukorejo
		S	Beberapa khusus di iko kehabisan obat anestesi (ketamin di bulan november)
		A	Membuat alur jika ada kekosongan obat di gudang
2	Penginputan sharing dose menimbulkan selisih	P	Mengurangi permasalahan selisih pada BMHP sharing dose
		D	Menjalankan kesepakatan atara unit iko dan

			farmasi untuk penginputan sharing dose
		S	Bulan november selisih 6 juta di sebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakpahaman perawat terhadap penginputan sharing dose
		A	Membuat alur untuk penginputan sharing dose yang sesuai dengan kondisi pasien

3.7.2 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	DPJP komplain terkait ketidaktepatan dokter IGD dalam pengisian rekam medis terutama pada pemeriksaan fisik yang tidak dilakukan dengan benar.	P	Mengoptimalkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter IGD
		D	Koordinasi dengan kains IGD terkait ketepatan pemeriksaan fisik dokter IGD
		S	Terkadang suasana IGD yang tidak kondusif menyebabkan dokter IGD tidak bisa mendengarkan dengan baik suara jantung dan paru
		A	Meminta dokter IGD untuk senantiasa mempertajam skill pemeriksaan fisik
2	Hasil Radiologi yang lama membuat pasien menunggu di IGD juga lama dan DPJP paru pun tidak mau jika belum jadi pembacaanya di IGD	P	Meningkatkan pelayanan dengan cara mempercepat pembacaan foto thorax
		D	Melakukan rapat kordinasi atau rapat komite medik untuk membahas kendala yang ada
		S	Kurangnya dokter radiologi dapat menjadi pemicu lambatnya pembacaan radiologi
		A	Melakukan close recruitment dokter spesialis radiologi

3.7.3 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Tidak ada jam pulang di resume pulang pasien sehingga tim asuransi center tidak dapat memastikan jam kepulangan pasien yang akan diinput di e-klaim	P	Menambahkan jam pulang di resume medis pasien
		D	Koordinasi dengan Manajer Mutu terkait penambahan jam pulang di resume
		S	Perubahan resume medis belum dapat dilaksanakan
		A	Menulis manual jam pulang di resume, koordinasi dengan sleuruh karu
2	Form kronologi untuk pemasangan ventilator	P	Koordinasi dengan asuransi center untuk membuat kronologi semua pasien yang menggunakan ventilator mulai awal
		D	Koordinasi dengan karu ICU untuk sosialisasi ke semua perawat ICU untuk pengisian form kronologi
		S	Ada beberapa kasus di ICU yang tidak memakai kronologi dan di mintak oleh BPJS
		A	Menjalankan sessuai dengan arahan kabid untuk pengisian form kronologi semua pasien yang menggunakan ventilator
3	Kelengkapan pengkajian awal IGD lebih teliti dalam pengisiannya	P	Mengadakan rapat karu IGD dan rawat inap membahas kelengkapan pengkajian awal IGD
		D	Membuat kesepakatan antara IGD dan rawat inap

			saat transfer ke rawat inap harus di cek untuk kelengkapan pengkajian awal IGD
		S	Menemukan beberapa kasus dr DPJP yang komplain dengan tidak lengkapnya pengisi
		A	Menjalankan sesuai dengan kesepakatan antara kepala ruangan dan di sosialisasikan kepada perawat pelaksana
4	Semua karu mengontrol jika ada pasien rawat inap hanya untuk ct scan saja	P	Melakukan sosialisasi ke semua karu untuk melaporkan jika ada pasien rawat inap hanya untuk ct scan
		D	Koordinasi dengan kbid pelayanan dan semua karu untuk mengontrol jika ada dpjp yang merawat inapkan pasien yang hanya membutuhkan ctscan
		S	Ada 1 kasus di kelas 3 djp yang merawat inapkan pasien yang membutuhkan CT scan saja
		A	Membuat kebijakan ke semua dpjp atau surat edaran pasien yang membutuhkan penunjang tidak boleh dirawat inapkan

3.7.4 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Penyesuaian surat kontrol	P	Koordinasi dengan pendaftaran untuk kie jika mundur kontrol harus konfirmasi terlebih dahulu
		D	Sosialisasi ke semua pasien lewat media sosial untuk kontrol mundur tidak bisa di layani
		S	Beberapa pasien komplain terkait tidak bisa di layani dengan tidak sesuai jadwal kontrol
		A	Berkoordinasi dengan asisten dan pendafran tentang sosialisasi ini
2	Penyesuaian E-casemix,ada beberapa anamnesa dan diagnosa yang kurang sesuai	P	Rapat antara unit irja dan asuransi center
		D	Koordinasi antara verifikasi dan karu untuk di lengkapi ulang
		S	Masih ada beberapa yang tidak lengkap di poli
		A	Feriv selalu mengingatkan ke bagian asisten perawat poli jika belum lengkap langsung bisa di lengkapi

3.7.5 Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Terdapat selisih stok opname yang fluktuatif.	P	Perencanaan scan barcode.
		D	1) Mengajukan proposal scan barcode dan mengajukan kebutuhan alat yang menunjang pelayanan. 2) Melakukan presentasi perencanaan scan barcode beserta tujuan dan manfaatnya.
		S	Scan barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengendalian stok yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya operasional, tindak lanjut yang lebih efisien, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan pelayanan pasien.
		A	Pengajuan software aplikasi barcode ke progamer dan pengajuan alat scanner

			barcode, barcode printer, thermal paper ke Pengadaan Umum PT. DPM.
2.	Ruang Pencampuran Obat (LAF) tidak sesuai standar akreditasi.	P	Melakukan renovasi LAF.
		D	Melakukan survey lokasi yang cocok untuk perpindahan ruangan LAF yang baru.
		S	Mengacu pada penilaian ruangan LAF pada akreditasi Tahun 2022 yang tidak sesuai dengan standar.
		A	1) Kolaborasi dengan PT untuk meminta tukang melakukan renovasi sesuai dengan standar akreditasi (denah sudah diberikan). 2) Penambahan 1 unit Laminar Air Flow (LAF) untuk dispensing sediaan steril dan 1 unit pass-box air lock untuk tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran. <i>Pass box</i> ini terletak di antara ruang persiapan dan ruang steril.
3.	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 76.95% dan waktu tunggu obat racikan 59.54%	P	Menggunakan KPO digital dalam pelayanan resep.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur KPO digital di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	1) Follow up ke Programmer. 2) Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang. KPO tertinggal ada 408 KPO.
4.	Selisih sediaan sharing dose antara fisik dengan monitoring stok pada sistem	P	Memperbaiki cara penginputan pada SIMRS.
		D	Melakukan rapat koordinasi dengan perawat anastesi bersama Kains Farmasi, Karu IKO dan Kabid Keperawatan.
		S	Penginputan penggunaan sediaan sharing dose seperti isonest yang tidak dipantau mengakibatkan selisih saat stok opname.
		A	1) Membuat satu pemahaman cara penginputan, kesepakatan minimal penginputan 0.1. 2) Membuat tabel penggunaan pada sediaan isonest untuk mempermudah perawat anastesi melanjutkan penginputan supaya menghasilkan jumlah pemakaian bulat 1 botol. 3) Monitoring dan Evaluasi setiap hari. 4) Supervisi oleh Kabid.
5.	Pending Resep meningkat dikarenakan ada hutang obat yang diakibatkan dari kekosongan obat.	P	Mengajukan substitusi obat.
		D	Melakukan koordinasi dengan DPJP dan Pengadaan terkait substitusi obat dan pelayanan resep.
		S	DPJP meminta obat tetap diberikan sehingga resep yang sudah masuk tetap

			dilayani, dan obat yang belum ready menjadi hutang farmasi sampai barang datang.
		A	1) Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk mencari ke seluruh distributor. 2) Membuatkan SE kekosongan obat dan dishare kepada seluruh DPJP. 3) Mengajukan pengadaan sediaan obat paten yang memiliki kandungan sama dengan obat yang kosong dan tidak ada substitusi, seperti spinorolactone.
6.	Waktu tunggu pelayanan farmasi rawat jalan lama sehingga banyak complain pasien.	P	Mengurangi waktu tunggu di Farmasi. Mendisiplinkan DPJP dalam penginputan e-resep per pasien (tidak dilakukan rapel).
		D	Koordinasi dengan Kabid Pelayanan untuk mengedukasi DPJP.
		S	Jumlah pasien rawat jalan per kunjungan tidak ada batasan sehingga terjadi penumpukan pasien di Poli sampai menunggu di Farmasi.
		A	1) Pasien ditawarkan PRIMANTARA agar tidak menunggu obat lama. 2) Resep obat diinput per pasien oleh DPJP. 3) Rencana diadakan nomor antrian untuk pasien yang menunggu obat.
7.	Sediaan vaksin yang tidak segera digunakan oleh pasien sejak tahun 2023, barang ada di Kulkas Depo Farmasi.	P	Memperbaiki pencatatan keluar masuknya inden vaksin. Memperbaiki kebijakan inden vaksin dari Poli Spesialis.
		D	Kolaborasi dengan Kains Farmasi, Gudang Farmasi, MOD, Kasir dan Karu IRJA.
		S	Pemesanan vaksin hexaxim an An Yahya Hermawan sejak Juli 2023 belum digunakan, inden vaksin menggunakan jaminan Asuransi.
		A	1) Membuatkan spreadsheet pemesanan vaksin dengan keterangan jadwal vaksin dan ED vaksin untuk memudahkan MOD menginformasikan kepada pasien. 2) Membuat kebijakan pembayaran penuh untuk inden vaksin meskipun jaminan asuransi, uang akan direture jika pasien datang untuk pelaksanaan vaksin. 3) Menghubungi pasien-pasien yang tidak datang sesuai jadwal untuk kepastian jadwal pelaksanaan, jika tidak ada DP maka dialihkan kebutuhannya untuk pasien lain.
8.	Kebutuhan tenaga di Gudang Farmasi	P	Menghitung ulang analisa beban kerja.
		D	Melakukan evaluasi kinerja dan melakukan rotasi petugas dari unit lain yang berkompetensi untuk dirotasi menjadi Admin Gudang Farmasi.
		S	Beban kerja berkurang, sesuai dengan job desk sehingga pelayanan optimal.
		A	Melakukan rotasi per tanggal 01 November 2024.

9.	Penambahan daftar obat near ED	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.
		D	Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi deathmoving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	1) Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 2) Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan. 3) Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur obat near ED kepada distributor.

3.7.6 Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS	P	Membuat target pelaksanaan LIS di Labortaorium RSPH Malang.
		D	Mengingatkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.
		S	LIS belum bisa diaplikasikam dikarenakan belum bridging dengan SIMRS.
		A	Follow up berkala ke Programmer.
2.	Petugas belum kompeten dalam pelaksanaan crossmatch labu darah	P	Mendaftarkan pelatihan/magang secara bergilir.
		D	1) Melakukan pendampingan terhadap petugas yang melakukan crossmatch. 2) Melakukan pelatihan dengan vendor.
		S	Hasil crossmatch menentukan apakah labu darah bisa diberika kepada pasien atau tidak, jika hasil aglutinasi positif maka tidak bisa diberikan.
		A	1) Melakukan pencatatan pengulangan kegiatan crossmatch. 2) Permintaan labu darah cito ketika malam hari sementara permintaan ke PMI Lawang terlebih dulu,
3.	Tidak ada fitur nilai normal pada Billing SIMRS sehingga petugas melakukan klik manual.	P	Mengajukan fitur pengisian nilai normal kepada Programmer PT.
		D	Membuat surat pengajuan fitur batas atas dan batas bawah nilai normal untuk dilakukan pengisian oleh petugas laboratorium.
		S	Dengan adanya batas atas dan batas bawah yang ditentukan, system akan membaca hasil laboratorium setiap pasien apakah berada pada nilai normal atau tidak.
		A	Follow up ke Programmer PT.
4.	Reagen kadaluarsa dan datang terlambat.	P	Memperbaiki pengadaan reagen di Laboratorium.
		D	Melakukan analisa keterlambatan. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan..
		S	Terdapat reagen yang kosong nasional seperti CKMB, DPJP memutuskan

			untuk menggunakan pemeriksaan Troponin.
		A	1) Melakukan perbaikan penataan FIFO FEFO pada kulkas Laboratorium. 2) Menjalankan kartu stok dan perencanaan SO. 3) Menentukan stok minimal untuk order reagen.

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Layanan Poli yang belum masuk kedalam E-RM -Poli KIA -Poli Gizi	P	Melakukan permintaan fitur kepada Programmer PT.
		D	Membuat flow chart alur pelayanan pada Poli KIA dan Poli Gizi untuk diterapkan pada E-RM.
		S	Kekurangan jika kunjungan Poli KIA dan Poli Gizi dilakukan pencatatan secara manual maka hasil konseling tidak terekap dengan baik dan tidak bisa diakses oleh DPJP, sehingga tidak bisa dilakukan tindakan lanjutan yang terintegrasi. Pencatatan manual resiko hilangnya sangat tinggi.
		A	Follow up ke Programmer PT. Hasil konseling disampaikan kepada asisten setiap DPJP.
2.	Kebijakan baru dari BPJS Kesehatan tentang Kunjungan Kontrol Poli Rawat Jalan	P	Menjalankan kebijakan baru dengan meminimalisir complain.
		D	Melakukan pemberitahuan melalui social media sebelum kebijakan dijalankan.
		S	Menertibkan pasien control sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
		A	1) Melakukan edukasi kepada pasien yang pulang rawat inap atau selesai control di IRJA untuk control sesuai dengan jadwal yang tertera di surat control, jika ingin mundur maka konfirmasi H-1 ke RS untuk dibantu edit surat control oleh petugas. 2) Melakukan edukasi berkala kepada pasien saat melakukan pendaftaran di Pendaftaran Central. 3) Membuat grup dengan unit-unit terkait untuk mendiskusikan masalah yang ditemui dan dikonsulkan dengan petugas verifikator supaya mendapatkan pemecahan masalah.

3.7.8 Permasalahan CSSD

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Kebutuhan mesin steam plasma belum terpenuhi.	P	Mengajukan kebutuhan mesin ke PT.
		D	Koordinasi dengan Vendor dan DPJP terkait kebutuhan mesin steam plasma.
		S	Instrument bedah saraf memerlukan perlakuan khusus terkait cara dekontaminasi dan sterilisasinya.
		A	1) Membuat telaah terkait mesin yang saat ini digunakan dan yang

			dianjurkan.
			2) Koordinasi dengan DPJP (dr Fachri, Sp.BS) bahwa sterilisasi alat bedah saraf menggunakan autoclave dengan cara alat dikemas satu persatu.

3.7.9 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil pencucian membuat kain terkena bercak putih.	P	Memperbaiki alur pencucian.
		D	Menerapkan alur baru.
		S	Monitoring dan evaluasi alur baru, mencari penyebab kerusakan.
		A	1. Melakukan pemilahan baju dan linen dari unit menggunakan handscoon baru (tidak terkena zak kimia). 2. Melakukan pemisahan pencucian antara linen dan baju IKO.
2.	Pencatatan jumlah linen tidak valid	P	Memperbaiki pencacatan menggunakan digital.
		D	Pencatatan jumlah linen menggunakan google spreadsheet.
		S	Pencatatan manual beresiko angka tidak terbaca dengan baik sehingga jumlah linen tidak valid.
		A	Pencatatan digital akan dimulai pada awal Bulan Januari 2025, sebelumnya akan dilakukan SO. Rencana dilakukan stok opname setiap bulan.

3.7.10 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Petugas melakukan double job di 2 RS yang berbeda.	P	Melakukan tindak lanjut terhadap petugas.
		D	Melakukan telusur dan konfirmasi kepada RS lain.
		S	Pelayanan terganggu karena petugas tidak datang sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Karu, selalu terlambat dalam 1 minggu akhir Bulan September 2024.
		A	Koordinasi dengan SDM untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib yang ada di RS Prima Husada Malang.
2.	Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan DPJP tidak tertera pada Billing SIMRS	P	Mengajukan review tarif CTA Cardiac.
		D	Mendata BHP yang dibutuhkan dan mengajukan review tarif ke Keuangan PT.
		S	Dengan adanya tarif baru CTA Cardiac di Billing SIMRS dapat mempermudah petugas saat konfirmasi petugas asuransi/jaminan yang dimiliki oleh pasien, apakah pemeriksaan tersebut tercover atau tidak.
		A	Memastikan nama dan tarif pemeriksaan penunjang sudah tertera pada Billing SIMRS.

3.8 Profil SDM
3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan Medis	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	7	7	0	7	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	S1 Apoteker	42	14	0	14	0
		S1 Farmasi		4	3	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	0	1	0
		D3 Farmasi		19	3	16	0
		SMK		4	0	8	0
		S1 Akuntansi		0	0	0	0
9	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	11	1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	0	8	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		1	1	0	0
10	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	0	1	0
		SMK		1	0	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	4	3	1	2	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	1
12	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	0	2	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	0	2	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		2	2	0	0
13	Humas & Marketng	Profesi Ners	2	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
14	ICU dan HCU	Profesi Ners	11	4	2	2	0

		D3 Keperawatan		7	0	7	0
15	IGD	Profesi Ners	26	11	1	10	0
		D3 Keperawatan		10	0	10	0
		D4 Kebidanan		3	0	3	0
		D3 Kebidanan		2	0	2	0
16	IKO	Profesi Ners	12	7	2	5	0
		D3 Keperawatan		4	1	3	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRs	S1 Teknik Elektro	6	1	0	1	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	0	3	0
19	IRJA	Profesi Ners	27	7	4	3	0
		D3 Keperawatan		15	5	10	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		4	3	1	0
20	IRNA 2C	Profesi Ners	7	4	1	3	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		2	0	2	0
21	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	20	16	1	15	0
		D3 Keperawatan		4	0	4	0
22	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	16	6	0	6	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		8	0	8	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
23	IRNA 5C Anak	Profesi Ners	9	2	0	2	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		6	0	6	0
24	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	24	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		D3 Keperawatan		12	0	12	0
25	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	0	2	0
		D3 Kebidanan		8	0	8	0
26	Neonatologi	Profesi Ners	8	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	1	4	0

		D3 Kebidanan		1	0	1	0
27	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		2	1	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		3	3	0	0
		SMA		1	0	1	0
28	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	0	2	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	0	8	0
29	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
30	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	4	6	0
31	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Ilmu Sosial		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	0	1	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	2	4	0
		SMK		5	0	5	0
		SMA		1	1	0	0
32	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	2	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1		1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
33	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
34	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
35	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
36	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0
37	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	0	3	0
38	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
39	Cleaning Service	SMK	45	25	5	20	0
		SMA		15	0	15	0
40	Security	SMK	12	7	4	3	0
		SMA		5	2	3	0
41	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	0	1	0
		SMA		2	0	2	0

		SMP		2	0	2	0
42	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
43	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
44	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
45	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
46	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
47	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis	Pendidikan Dokter	2	2	0	2	0

	Radiologi	Spesialis					
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			459				

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Oktober 2024 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan September 2024, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 Desember 2024
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	INSTANSI	NAMA PKS	NOMOR RS	NOMOR INSTANSI	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017	12 Desember 2017	Berlaku
2	PT. Global Asistensi Manajemen Indonesia (GAMI)	Perjanjian Layanan Kesehatan Rawat Jalan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku
3	PT. Fullerton Health Indonesia	Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan		640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku
4	PT Prudential Life Insurance	Surat Kesepakatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan		3143/PMN-PA/IV/2020	13 April 2020	Berlaku
5	PT AIA Financial	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	069/DPM/E-PKS/DIR/X/2020	639/AIA-DPM/XI/2020	4 November 2020	Berlaku
6	PT. Medlinx Asia Teknologi (Medlinx)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	150/ PKS-RSPRIMAHUSADA-MAT/DIR/XI/2016		28 November 2016	Berlaku
7	PT. Asuransi AA Internasional	Pelayanan Kesehatan	-	AAII/RS/E-384/PKS/Feb/2015	19 September 2019	Berlaku
8	PT. Suprima Mitra Adihusada	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan		640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019	26 agustus 2019	Berlaku
9	PT. Equity Life IND-Corporate	Perjanjian Pelayanan Kesehatan		091/ELI/LGL/X/19	14 Oktober 2019	Berlaku
10	PT. Axa Services Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	-	067/AGR-Leg/ASI/VII/2013	15 Agustus 2013	Berlaku
11	PT. Asuransi Jiwa	Perjanjian	-	063/PKS - AJSMSIG-Rs / IX/ 2012	9 Oktober 2012	Berlaku

	Sinarmas Msig	Kerjasama Pelayanan Kesehatan				
12	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	010/DPM/E-PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019	9 April 2019	Berlaku
13	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	-	0088/HLI-GH/ PKS-RS/03-2015	16 Maret 2015	Berlaku
14	PT. Equity Life IND-Cassles	Perjanjian Pelayanan Kesehatan		090/ELI/LGL/X/19	14 Oktober 2019	Berlaku
15	PT. Asuransi Adira Dinamika	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	PH/E-IKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013	24 Oktober 2013	Berlaku
16	PT. Prima Sarana Jasa	Pelayanan Kesehatan	735/E-PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018	17 September 2018	Berlaku
17	PT. BNI Life Insurance	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	082/RSPH/E-IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716	24 Juli 2019	Berlaku
18	Administrasi Medika (Admedika)	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	025/RSPH/E-PKS/DIR/IV/2015	141/PKS/ADMEDIKA/IV/2015	28 April 2018	Berlaku
19	Asuransi Jiwa Generali	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	070/DPM/E-PKS/DIR/IX/2019	109/GI/OPS/Prov-SK/IX/2019	10 Oktober 2019	Berlaku
20	PT. Aplikanusa Lintasarta (Owlexa Healthcare)	Nota Kesepakatan Layanan Pemeriksaan Kesehatan	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MoU/00300/2015	25 Februari 2015	Berlaku
21	PT. Asuransi Takaful Keluarga	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	508/RSPH/E-IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/II/2017	02 Januari 2017	Berlaku
22	PT. Asuransi Jiwa	Perjanjian	017/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	045-02/EB-CONT/2020	2 Maret 2020	Berlaku

	Manulife Indonesia	Pelayanan Kesehatan Peserta Individu				
23	PT. AJ Central Asia Raya (CAR)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	795/E-ADD/DIR/XI/2019	DIR/PKS-ADD/RS/154/XI/2019	29 November 2019	Berlaku
24	PT. Java Smartindo	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C	21 Agustus 2020	Berlaku
25	PT PLN Insurance	Asuransi Pelayanan Kesehatan	612/RSPHS/E-PKS/DIR/X/2019	300/PKS/TKI/X/2019	30 Oktober 2019	Berlaku
26	PT. Asuransi Jasa Indonesia	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	PKS.031/GHASKES/157-1/2020	053/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2020	28 Agustus 2020	Berlaku
27	PT. Asuransi Reliance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	490/RSPH/I-IKS/DIR/XI/2016	930.01/UM/ARI-RS/XI2016	7 September 2020	Berlaku
28	PT. Pan Pacific Insurance	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	017/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS-PHMS/VIII/2020	31 Agustus 2020	Berlaku
29	PT. Jasindo Health Care	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	-	-	4 Januari 2014	Berlaku
30	PT. International Services Pacific Cross	Asuransi Pelayanan Kesehatan	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022	10 maret 2022	Berlaku
31	PT. Asuransi Jiwa BCA	Asuransi Pemberian Pelayanan Kesehatan	149/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	286/PKS/BCAL-PHMS/2023	10 Oktober 2023	Berlaku
32	Klinik Husada Asih YPAC	Kerja sama Penunjang			11 September 2012	Berlaku
33	PT HM Sampoerna Tbk	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	-	55/Perj/HMS/IX/2014	1 Juni 2014	Berlaku
34	PT Adonai Manajemen Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama		055/PKS-PF/AMK/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku

		Pemeriksaan Medicak Chek Up				
35	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Pelayanan Kesehatan			1 April 2013	Berlaku
36	PT. Ajinomoto Sales Indonesia	Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Kesehatan	008/PERS/RSPH-I/2012	LEG/ASI/120510-85	5 Januari 2012	Berlaku
37	PT. Coca Cola Distribution Indonesia	PELAYANAN KESEHATAN	573/I-PKS/PMS/IV/2019	004/Perjanjian/HRSEJ/IX/2019	9 Januari 2019	Berlaku
38	PT. Indolakto Pandaan	Jasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja (PPK)			1 Oktober 2014	Berlaku
39	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Perjanjian Pelayanan Kesehatan			20 Maret 2015	Berlaku
40	Harris Hotel & Convotions Malang	Rujuka Pelayanan Kesehatan	308/E-PKS/PMS/V/2018	001/IKS/HR/V/2018	14 Oktober 2019	Berlaku
41	PT. Duha Mulya Abadi	Penyediaan paket BHP Operasi Katarac			11 Januari 2019	Berlaku
42	RS Sahabat Pasuruan	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	1097.1/E.PKS/DIR/VIII/2021		2 Desember 2016	Berlaku
43	PT. Asuransi Dayin Mitra TBK		003/MKT/HLT/PKS/II/2015	PH/IKS/269/XII/2014	1 Mei 2015	Berlaku
44	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022	4 Juli 2022	Berlaku
45	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang) (ADENDUM)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan			7 Februari 2023	Berlaku

		Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan				
46	Klinik Pratama Rawat Jalan Mawar Waskitha Husada	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024		23 Januari 2024	Berlaku
47	Klinik Losari Medika	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024		6 Februari 2024	Berlaku
48	PT. Samator	Operasional Pasokan Produk		DISTRIBUTIONAGREEMENT_LGL_1850	1 September 2022	Berlaku
49	RS Persada	Pelayanan Kesehatan, Rujukan, Laboratorium dan Radiolog	152.42/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.Hs/MOU/X/PH.2022	10 Oktober 2022	Berlaku
50	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	103.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	358/KBM-DPM/PKS/VI/2023	26 Juni 2023	Berlaku
51	ASABRI	PELAYANAN PENGOBATAN DAN PERAWATAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA ASABRI AKTIF	1902/E-PKS/DIR/XII/2023	PERJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023	13 Desember 2023	Berlaku
52	Klinik Rawat Inap Muslimat Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023	15 April 2023	Berlaku
53	Klinik Tirto Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023	18 September 2023	Berlaku
54	Klinik BLKI Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	108.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	150/0187B00/IV/23	24 April 2023	Berlaku
55	Klinik Brawijaya Lawang	Rujukan Asuhan Pasien	144.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PKS/115/VII/2023	3 Juli 2023	Proses di Pihak Kedua

56	Klinik Jantung Hasna Medika Malang	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR/HMMALANG/XII/2023	1 Desember 2023	Berlaku
57	Klinik Rawat Inap Wijaya Husada	Rujukan Asuhan Pasien	001/PKS/15/4/2023	113.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023	15 April 2023	Berlaku
58	Klinik Endisa Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	148.3/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH	21 Juli 2023	Berlaku
59	Klinik Siaga Medika	Rujukan Pelayanan Kesehatan	188/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	14.30/KSM/VII/2023	3 Oktober 2023	Berlaku
60	Klinik Garuda	Pelayanan Kesehatan	131.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023	B/25/VI/2023	31 Mei 2023	Berlaku
61	Laboratorium Panglima Sudirman	Pelayanan Rujukan Laboratorium	135.2/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	Q.0150/LKPS.VI/25.2023	5 Juni 2023	Berlaku
62	PT. Sumber Alfaria	Pelayanan Kesehatan	142.1/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	0002/SDM-MLG/VI/2023	22 Juni 2023	Berlaku
63	Solaris Hotel	Rujukan Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	108/HRD/SHM/X/2023	1 November 2023	Berlaku
64	PT. Arthawena Sakti Gemilang	Pelayanan Rujukan kesehatan	138.3/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	-	15 Juni 2023	Berlaku
65	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Kerjasama dalam proses akreditasi rumah sakit			22 April 2022	Berlaku
66	CV. Aumireta Anggun	Rujukan Pelayanan Kesehatan	164.1/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	-	28 Agustus 2023	Berlaku
67	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan	220.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023	30 Oktober 2023	Berlaku
68	RS Islam Unisma Malang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	222.11/DPM/E- PKS/DIR/XI/2023	MENUNGGU SEKRETARIAT	1 Januari 2024	Berlaku
69	RS Puri Bunda	Rujukan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024	6 Februari 2024	Berlaku

		Pelayanan Kesehatan dan Penunjang				
70	RSUD Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	245.1/E-PKS/DIR/II/2024	074.3/35.07.302.102/2024	1 Maret 2024	Berlaku
71	Avrist Assurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	951/PKS/PROV/IPOP/AVR-1494/VII/2023		24 Agustus 2023	Berlaku
72	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Pelayanan Kesehatan & pelayanan obat	028.2/DPM/E-PKS/DIR/II/2023	0.32/AJII/KOP-SBY/PKS/0123	30 Januari 2023	Berlaku
73	BPM Inung Indah sari	Rujukan Asuhan Pasien	004.1/DPM/E-PKS/DIR/I/2022	-	10 Januari 2022	Berlaku
74	Klinik Dokter 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang			2 Agustus 2022	Berlaku
75	Klinik Mutiara Sehat	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	200.11/DPM/I-PKS/DIR/I/2022		5 Januari 2022	Berlaku
76	Klinik 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	112.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2022	138/MOU/VIII/CSH.2022	2 Agustus 2022	Berlaku
77	PT. Jaya Obayashi	Rujukan Pelayanan Kesehatan	360/DPM/I-PKS/VIII/2020		1 Juli 2020	Berlaku
78	PT. Malang Intermedia Pers	Pelayanan Kesehatan	025/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020	1 Juli 2020	Berlaku
79	PT. Pancamas Elite	Rujukan Pelayanan Kesehatan	032/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020		1 Juli 2020	Berlaku
80	PT. Yamaha Musical Product Indonesia	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP BAGI KARYAWAN DAN KELUARGA	004/DPM/E-PKS/III/2020	452/YMPI/II/PKS/III/2020	1 Juni 2022	Berlaku
81	PT. Tirta Investama	PELAYANAN			31 Agustus 2020	Berlaku

		KESEHATAN KARYAWAN & KELUARGA				
82	PT. TASPEN	Perawatan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E-PKS/DIR/2023	JAN-01/DIR/2023	1 Januari 2023	Berlaku
83	PT. Kemas Super Indonesia (KSI)	Pelayanan Kesehatan				Berlaku
84	PT. Nayaka Era Husada	Pelayanan Kesehatan	143.1/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PKS/106/072023	30 Mei 2023	Berlaku
85	PMI Kabupaten Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	768/E-PKS/DIR/V/2023	#REF!	1 Juni 2023	Berlaku
86	PMI Kota Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	1790/E-PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023	20 November 2023	Berlaku
87	RS Lavalette	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	155.2/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	RSL-KONTR-PKS/VII/23.124	10 Agustus 2023	Berlaku
88	RS Prima Husada Sukorejo	Rujukan Asuhan Pasien	213/E-PKS/DIR/III/2019	126/RSPHS/E-PKS/III 2019	21 Februari 2022	Berlaku
89	RS Panti Nirmala	Kerjasama Pelayanan Rujukan	152.44/DPM/E-PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022	7 Oktober 2022	Berlaku
90	PT Kimberly Clark	Pasokan produk		106/KCS-PNS/MOU/II/2023	1 Januari 2024	BERLAKU
91	PT. Lippo General Insurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	267/RSPHS/E-PKS/DOR/VI/2019	1502/LI-HOSPT/VI/2019	18 September 2019	Berlaku
92	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG)	Fasilitas Rawat Inap dan Rawat Jalan	015/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2	28 Januari 2020	Perpanjang Otomatis
93	BPJS KESEHATAN	Pelayanan Penjamin Rujukan Tingkat Lanjutan	1879/E-PKS/DIR/XII/2023	602/KTR/VII-05/1223	1 Januari 2024	Berlaku

		Bagi Peserta Program JKN				
94	BPJS KETENAGAKERJAAN	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan	1571/E-PKS/DIR/XII/2022	PER/60/102022	1 Januari 2023	Berlaku
95	BPM Silvian Wulandari	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	031/DPM/E-PKS/DIR/III/2022		10 Maret 2021	Progres Pihak Kedua
96	Klinik Idamamuk	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	347/DPM/I-PKS/DIR/VII/2021	005/VI/2021	16 Juni 2021	Progres Pihak Kedua
97	PT. Etercon Pharma	Sponsorship Maternity Kit Free untuk pasien Maternitas	132.1/DPM/E-PKS/DIR/VI/2023	039/ETC-CBX/PKS/VII/2023	1 Juni 2023	Proses Pihak Kedua
98	PT. Kasoem Hearing	Pelayanan Pemasangan Alat Bantu Mendengar (ABM)	339.6/E-PKS/DIR/III/2022	002/KHC/KSO-SMAD/III/2022	1 Maret 2022	Proses Review Kabid
99	PT. Kencana Tiara Gemilang (KTG)	Pelayanan Kesehatan	174.1/DPM/E-PKS/DIR/XII/2021	017/KTG/HRGA.06/XII/2021	12 Desember 2021	Berlaku
100	PT. Rentokil	Pengendalian Hama dengan Program General Pest (GP)- Non Station	173.1/DPM/E-PKS/DIR/IX/2023	003/PT.RI/MLG-37/52400326/IX/2023	11 September 2023	Berlaku
101	PT. Pillar Utama Cortindo	Vendor Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Elevator	-	KS/PUCCSBY-1216/VII/2023	1 Juni 2023	Progres di PT
102	PT. Global Trans Jaya Mulia & PT Global Enviro Nusa	Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	115/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	044/SPK-T/DPM-GTJM/GEN/IV/2024	15 April 2024	Berlaku

103	PT. Uniplastindo Interbuana	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	302/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	001/PKS-IU-HRD/VI/2021	8 Juni 2023	Proses TTD Pihak Kedua
104	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang	Rujukan Asuhan Pasien	1562.1/e-pks/dir/xi/2022	116/302/2019	1 November 2022	Berlaku
105	RS. TK.II dr. SOEPRAOEN (RST)	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	152.40/DPM/E- PKS/DIR/X/2022	PKS/173/IX/2022	16 September 2022	Berlaku
106	RS Siti Miriam Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	151.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2022	810/HMS/RSSM/X/2022	4 Oktober 2022	Berlaku
107	RS Dr. SYAIFUL ANWAR (RSSA)	Rujukan Pekayanan Penunjang	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024	1 November 2024	Berlaku
108	RSU Muhammadiyah (RSUMM)	Pelayanan Rujukan Kesehatan, Laboratorium dan Radiologi	159.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	100/SK_PKS/RSU-UMM/VII/2023	21 Agustus 2023	Disposisi SIMRS
109	DINKES Kabupaten Malang	Pelaksanaan Kegiatan Skrining Tuberkulosis Pada Penyandang Diabetes Melitus Dengan Metode Radiologis	1183/E- PKS/DIR/VII/2023	415.4/61/35.07.103/2023		PROSES PERMOHONAN
110	PT. TSSA dan PT. Tenang Sejahtera	Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			23 Februari 2024	Berlaku
111	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan				PROSES TTD DILUAR

112	Asuransi Jiwa Generali	PKS Asuransi Kesehatan				PROSES DISPOSISI SIM
113	PT Teknologi Pamadya Analitika (Meditap)	Asuransi Pelayanan Kesehatan				PROSES PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN PKS
114	BKKBN	pelayanan keluarga berencana iud dan implant	294/E-PKS/DIR/I/2024		17 Januari 2024	Berlaku
115	CV. Galaxy Mulia Cahaya	PKS Alat Proteza Ortesa				PROSES DISPOSISI SIM
116	PT Pesta Pora Abadi	Rujukan Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024			Review Pihak kedua
117	Batas Media 99	Rujukan Pelayanan Kesehatan			5 Juni 2024	Berlaku
118	PT Yamaha Electronic Manufacturing Indonesia	Rujukan Pelayanan Kesehatan				TTD Dir PT
119	PT Tentrem Sejahtera	Rujukan Pelayanan Kesehatan	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024			Review Pihak kedua
120	Klinik Utana Rawat Jalan Akasia	Rujukan Pelayanan Kesehatan			25 April 2024	Berlaku
121	PT Ustegra	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
122	PT Pancamas Elite	Rujukan Pelayanan Kesehatan			12 Juni 2024	Berlaku
123	PT Unggul Anugerah Sejahtera	Rujukan Pelayanan Kesehatan			4 Juni 2024	Berlaku
124	PT Bestari Murni Anugerah	Rujukan Pelayanan Kesehatan			4 Juni 2024	Berlaku
125	PT Indonesian Marine	Rujukan				Review Pihak kedua

		Pelayanan Kesehatan Rujukan					
126	PT Randi Cones Indonesia	Pelayanan Kesehatan Rujukan					Review Pihak kedua
127	PT Indonesian Tobacco	Pelayanan Kesehatan Rujukan					Review Pihak kedua
128	PT Tonggak Ampuh	Pelayanan Kesehatan Rujukan					Review Pihak kedua
129	Klinik Beauty Medika	Pelayanan Kesehatan Rujukan	145/DPM/E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2004	25 Mei 2024		Berlaku
130	Ibazz Aesthetic and Medical Center	Pelayanan Kesehatan Rujukan	180/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024		14 Juni 2024		Berlaku
131	RS Universitas Brawijaya	Pelayanan Kesehatan Rujukan	178/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024				Review Pihak kedua
132	PT Citra Karsa Dinamika	Pelayanan Kesehatan Rujukan					Proses TTD Pihak Kedua
133	PT Moor Sukses Internasional	Pelayanan Kesehatan Rujukan	200/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	001/MSI/VI/2024	8 Juli 2024		Berlaku
134	BPM Nia Irawati	Pelayanan Kesehatan Rujukan	081/DPM/E-PKS/DIR/III/2024		7 Februari 2024		Berlaku
135	Instruktur Zumba	Instruktur Zumba			23 Februari 2024		Berlaku
136	Klinik Esweje	Pelayanan Kesehatan Rujukan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9120200211338	1 Maret 2024		Berlaku
137	PT Alfiza Medika Utama	Pelayanan Kesehatan Rujukan	090/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024	7 Maret 2024		Berlaku
138	PT Medilink Digital Medika	Pelayanan Kesehatan Rujukan	09/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024	22 Maret 2024		Berlaku

139	BPM Riza Khutmi	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
140	BPM Indah Maharany	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
141	PT Indostar Building Material	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
142	Rajawali Plastik	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Proses TTD Pihak Kedua
143	Green Mountain Natural Foods	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
144	PT Indonusa Algaemas Prima	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak Kedua
145	RSUD Bangil	Rujukan Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024	22 Juli 2024	Berlaku